



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2024**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II	6
GAMBARAN UMUM	6
BAB III.	8
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI.....	8
3.1 Sumber Daya Manusia :	8
3.2. Hasil dan Evaluasi Pengembangan Pelayanan.....	46
3.3. Kinerja Produktifitas Unit	49
3.3.1. Penunjang	49
A. Rekam Medis	49
B. Laboratorium	51
C. Radiologi.....	55
D. Instalasi Farmasi.....	57
E. Instalasi Gizi	60
F. Laundry	62
G. CSSD	63
3.3.2 PELAYANAN.....	65
A. Instalasi Rawat Jalan	65
B. INSTALASI GAWAT DARURAT	68
C. INTENSIVE CARE UNIT	72
D. MATERNITAS.....	76
E. INSTALASI RAWAT INAP	78
F. INSTALASI KAMAR OPERASI	79
3.3.3. UMUM dan KEUANGAN	83
A. Humas Marketing.....	83
B. ASURANSI CENTER.....	88
C. PIPP-MOD-MPP	89
D. IT/SIMRS	91
3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)	91

A. PONEK	91
B. HIV/AIDS	95
G. STUNTING dan WASTING.....	98
H. PKBRS.....	103
3.4. KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE MFK DAN K3.....	106
3.5. KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE MUTU.....	109
3.5.1 Mutu Nasional	109
3.5.2 MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT	132
3.5.3. MUTU PRIORITAS INTERNAL UNIT	180
3.6 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI.....	229
3.7. KINERJA PRODUKTIFITAS TIM PKRS.....	261
3.8 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPRA.....	263
3.9 Kinerja Produktifitas Komite keperawatan.....	267
3.10 Kinerja Produktifitas Komite Medis.....	267
3.11 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain.....	267
BAB IV.....	268
KINERJA KEUANGAN	268
4.1 PENDAPATAN TAHUN 2024	268
4.2 KINERJA PIUTANG RS PRIMA HUSADA SUKOREJO	270
4.3 FPK ATAS TAGIHAN BPJS KESEHATAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2024	270
BAB V.....	274
KESIMPULAN DAN SARAN	274
5.1 Kesimpulan	274
5.2 Saran	274
BAB VI.....	275
PENUTUP	275

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2005 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Salah satu jenis BLU diantaranya rumah sakit yang berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam Pasal 996 bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Inilah yang menjadi dasar/landasan hukum dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Laporan Tahunan berisi uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program pelayanan dan keuangan, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Laporan Tahunan diharapkan bersifat analitik, interpretative, disertai saran dan tindak lanjut. Laporan tahunan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan data dan masukan dari bagian/bidang dan instalasi-instalasi yang ada dilingkungan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Laporan Tahunan RS Prima Husada Sukorejo tahun 2024 disusun berdasarkan :
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan 2024 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan secara tertulis upaya pengelolaan rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana



fleksibilitas pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Laporan tahunan RS Prima Husada Sukorejo tahun 2024 merupakan rangkuman dari proses pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran di masing-masing unit kerja serta sebagai dasar perbaikan dan perencanaan pada waktu yang akan datang.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan Seluruh Lapisan Masyarakat

2.2. Misi

Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat

Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien

Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

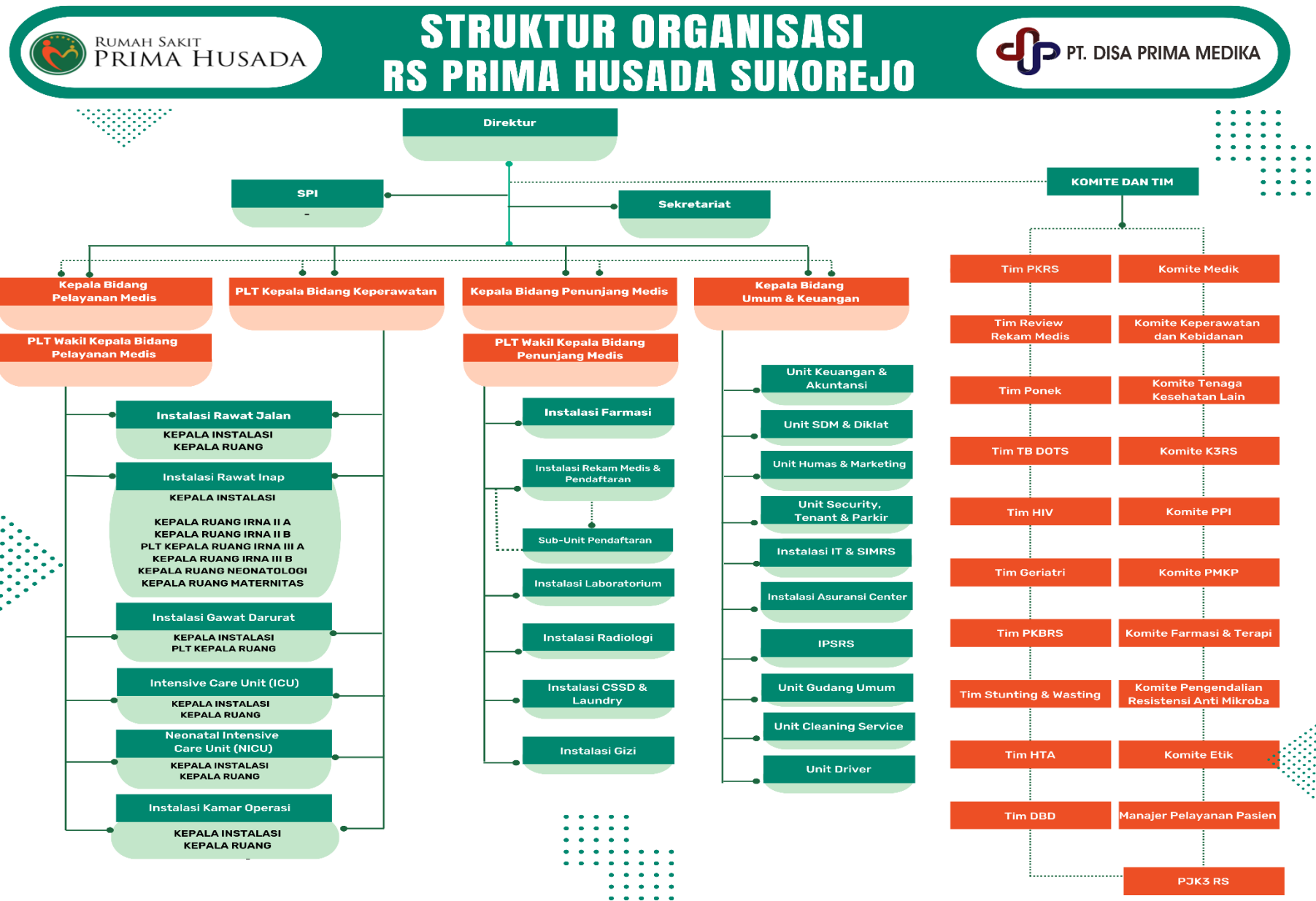
2.3. Motto

Motto kami adalah “**Sahabat Menuju Sehat**”, yang berarti berperan sebagai sahabat kepada pasien (sahabat) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menempatkan setiap pasien sebagai bagian keluarga, memposisikan diri kita sebagai pasien sehingga kami mengerti apa yang harus kami berikan kepada pasien

2.4. Tujuh Nilai Budi Utama

- 1 Jujur
- 2 Dipercaya
- 3 Tanggung Jawab
- 4 Visioner
- 5 Disiplin
- 6 Kerjasama
- 7 Adil
- 8 Peduli

2.5. SOTK



BAB III.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Sumber Daya Manusia :

3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Kebutuhan tenaga Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mempertimbangkan :

- 1 Misi Rumah Sakit
- 2 Populasi Pasien yang Dilayani dan Kompleksitas serta Kebutuhan Pasien
- 3 Layanan Diagnostic dan Klinis yang Disediakan Rumah Sakit
- 4 Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
- 5 Peralatan Medis yang digunakan untuk Pelayanan Pasien

Berikut data ketenagaan di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024 yang terhitung sampai 31 Desember 2024 dan yang telah terencana sesuai dengan perhitungan pola ketenagaan untuk Tahun 2024 yang telah terlaksana :

Tabel Pola Ketenagaan RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

No .	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Bar u	Resign/ Mutas i	Jumla h Akhir
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
	PLT Wakil Kepala Bidang Pelayanan Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0	0	0	1
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
	PLT Wakil Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
5	Kepala Bidang Umum & Keuangan	S1 Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	8	8	0	1	0	0	0	
		Dokter Umum MCU	7	7	0	7	0	1	1	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	3	3	0	2	1	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	4	0	3	1	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal-Hipertensi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan	3	3	0	3	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
		Traumatologi								61
		Dokter Spesialis Neurologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Paru	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Mata	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	1	0	0	1	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anastesiol ogi	3	3	0	3	0	0	0	
7	IRNA II A	D3 Keperawat an	23	12	0	11	1	0	2	21
		D4 Keperawat an		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	8	0	0	0	
8	IRNA II B	D3 Keperawat an	25	15	0	15	0	0	1	23
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	8	0	0	1	
9	IRNA III A	D3 Keperawat an	20	10	0	10	0	0	0	18
		D4 Keperawat an		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		7	0	1	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
10	IRNA III B	D3 Keperawat an	20	9	0	9	0	0	0	18
		D4 Keperawat an		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	8	0	0	0	
11	Neonatalogi	D3 Keperawat an	4	4	0	4	0	0	0	4
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		0	0	0	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	14	3	0	3	0	0	0	14
		D4 Kebidanan		9	0	7	2	0	0	
		S1 Kebidanan		2	0	2	0	0	0	
13	ICU	D3 Keperawat an	11	4	0	3	1	0	0	11
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		7	0	7	0	0	0	
14	NICU	D3 Keperawat an	9	5	0	5	0	0	0	9
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
		Profesi Ners		4	0	3	1	0	0	
15	IGD	D3 Keperawat an	28	13	0	12	1	0	1	26
		D3 Kebidanan		3	0	3	0	0	0	
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		9	0	9	0	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawat an	13	10	0	6	4	0	0	13
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		3	2	1	2	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawat an	26	16	0	15	1	0	2	26
		D3 Kebidanan		2	0	2	0	0	0	
		D4 Keperawat an		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		0	0	0	0	1	0	
		S1 Kebidanan		1	1	1	0	0	0	
		Profesi Ners		6	0	4	2	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
18	Klinik ATOM	D3 Keperawat an	2	2	0	2	0	0	0	
19	Klinik Nestle	D3 Keperawat an	1	1	0	1	0	0	0	1
20	Klinik Lyondelbas el	Profesi Ners	1	1	0	1	0	0	0	1
21	Klinik KT&G Purwosari	D3 Keperawat an	2	2	0	2	0	0	0	2
22	Klinik KT&G Singosari	D3 Keperawat an	1	1	0	1	0	0	0	1
		Psikologis Klinik	1	1	0	1	0	0	0	1
23	ORIENTASI	Profesi Keperawat an	30	26	4	26	0	26	0	29
		D4 Kebidanan	3	3	0	3	0	3	0	
24	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
25	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	6	6	0	5	1	0	0	52
		S1 Admin Farmasi / S1 Lainnya	2	2	0	2	0	0	0	
		D3 Farmasi	15	15	0	13	2	11	2	
		D3 Analisis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	5	5	0	5	0	0	1	
		Apoteker	12	12	0	11	1	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
26	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	0	7	1	1	1	11
		D4 RMIK		2	0	2	0	0	1	
27	Pendaftaran	SMA/SMK	19	2	0	2	0	0	0	20
		D1		3	0	3	0	0	0	
		D3		5	0	4	0	1	0	
		D4		2	0	2	0	0	0	
		S1		8	0	8	0	0	2	
28	Laboratorium	D3 Analisis Kesehatan	13	11	0	10	1	0	1	13
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0	0	0	
29	Radiologi	SMA/SMK	8	0	0	0	0	0	0	9
		D3 Radiologi		8	0	6	2	1	1	
30	CSSD	SMA/SMK	4	3	0	3	0	0	0	4
		D3 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	1	0	0	0	
31	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	5	0	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
32	Ahli Gizi	D3 Gizi	5	3	0	0	0	3	0	8
		D4 Gizi		2	0	2	0	0	0	
		S1 Gizi		3	0	2	1	0	2	
33	Dapur Penyaji & Pantry	SMA/SMK	10	10	0	10	1	1	0	14
		SMA/SMK	5	4	1	4	0	0	0	
34	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	10	0	0	0	0	0	0	10
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		0	0	0	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
		S1		9	0	9	0	0	0	
35	SDM & Diklat	S1 Psikologi	3	2	0	2	0	0	0	3
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	
36	Asuransi Center	SMA/SMK	14	1	0	1	0	0	0	13
		D3 RMIK		3	0	3	0	1	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		5	0	5	0	0	2	
		D4 RMIK		1	0	1	0	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		1	0	1	0	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		2	0	2	0	0	0	
37	Humas Marketing	S2 Manajemen Kesehatan	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Marketing		1	0	1	0	0	0	
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
38	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
39	Security	SMA/SMK	13	11	2	10	1	0	0	11
40	Parkir	SMA/SMK	13	12	0	12	0	2	0	13

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Teta p	Teta p	Baru	Resign/ Mutas i	Jumlah Akhir
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
41	Driver	SMA/SMK	7	7	0	7	0	0	0	7
42	Cleaning Service	SMA/SMK	42	36	5	35	1	0	0	37
		D3		1	0	1	0	0	0	
43	Tukang Operasional & Tukang Kebun	SMA/SMK	4	1	1	1	0	0	0	3
		SMP		1	0	1	0	0	1	
		SD		1	0	1	0	0	0	
44	IPAL/B3	SMA/SMK	3	3	0	3	0	0	0	3
45	IPSRS	SMA/SMK	5	5	0	3	1	1	1	8
		D3 ATEM	2	2	0	1	0	1	0	
		Admin IPSRS	1	1	0	1	0	0	0	
46	Gudang Umum	S1	1	1	0	1	0	0	0	1
47	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	3	0	0	0	0	0	0	3
		S1 Teknologi Informatika		2	0	2	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
48	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	1	1	0	0	0	1
49	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
50	PPI	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	1	2
		S1 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	

No .	Unit	Pendidika n	Kebutuh an	Kondi si Saat Ini	Kekurang an	Tida k Teta p	Teta p	Bar u	Resig n/ Mutas i	Jumla h Akhir
51	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	0	1	0	0	0	0	0
52	MOD/PIPP	D3 Keperawat an	5	2	0	2	0	0	0	5
		D3 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		1	1	1	0	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			562	532	22	486	35	54	26	558

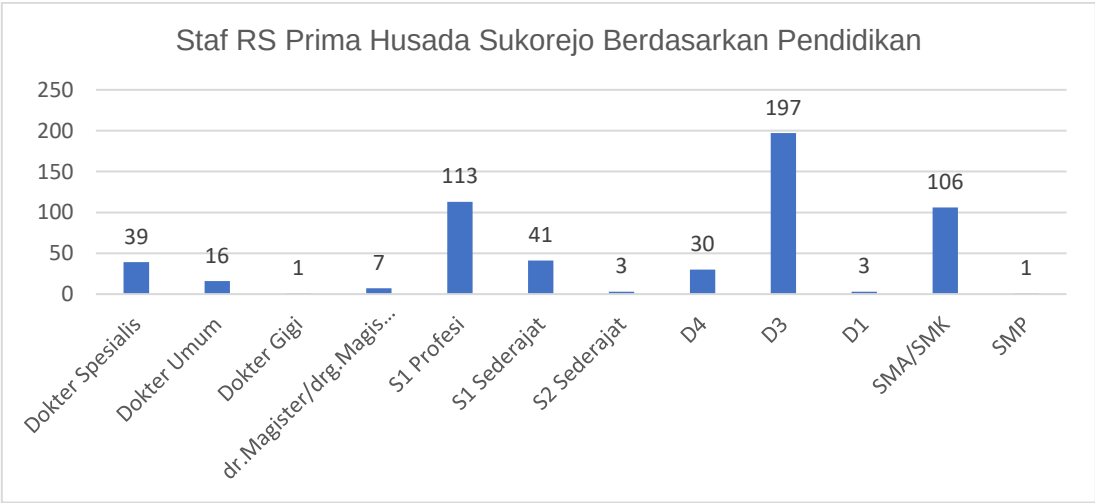
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah staf aktif sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah 558 orang. Jumlah tersebut belum dikurangi dengan staf yang resign per 31 Desember 2024 sejumlah 26 orang. Dengan demikian, jumlah staf yang aktif per 01 Januari 2025 baik dalam status kontrak, tetap maupun orientasi sejumlah 532 orang.

Tabel Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Pendidikan

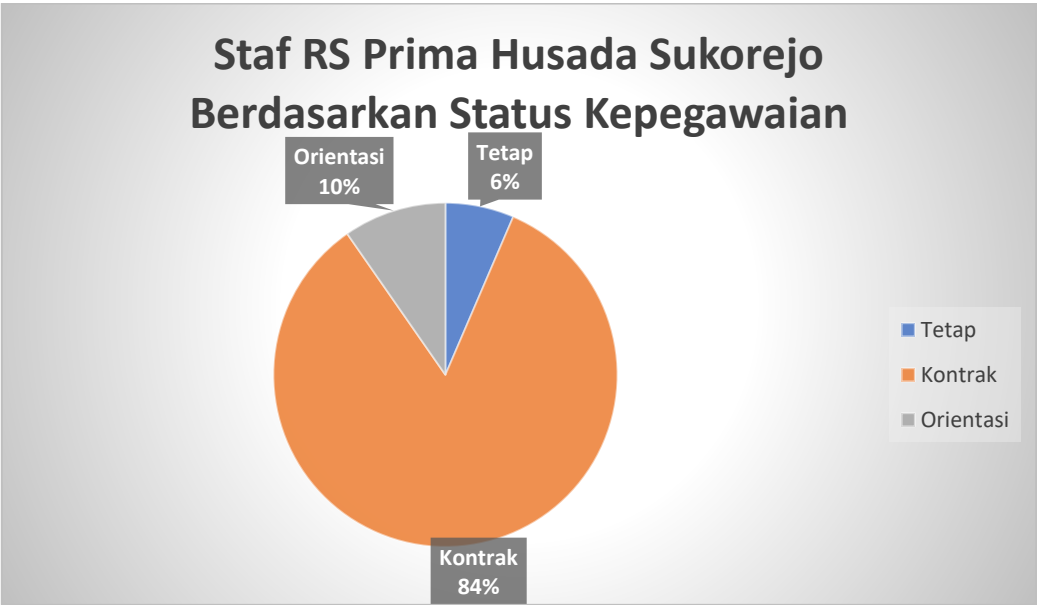
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	
		2023	2024
1	Dokter Spesialis	37	39
2	Dokter Umum	10	16
3	Dokter Gigi	2	1
4	dr.Magister/drg.Magister	6	7
5	S1 Profesi	94	113
6	S1 Sederajat	38	41
7	S2 Sederajat	1	3
8	D4	25	30
9	D3	171	197
10	D1	3	3
11	SMA/SMK	92	106
12	SMP	2	1
13	SD	1	1
TOTAL		482	558

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah karyawan per 31 Desember 2023 sejumlah 482 orang dan per 31 Desember 2024 sejumlah 558 orang. Dengan demikian, terdapat kenaikan jumlah karyawan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sejumlah 15,76%

Gambar Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Pendidikan



Gambar Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Status Kepegawaian



3.1.2 Orientasi

A. Daftar Staf Masuk Selama 2024

No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
1	Lidia Puspita Kencana, S.KM	MUTU	01 01 2024
2	Muhammad Nidhom Baihaqi, AMd.Kep	Perawat	01 01 2024
3	Anggun Den Ayu, AMd.Kep	Perawat	01 01 2024
4	Rizqi Gitari Fernanda, AMd.Kep	Perawat	01 01 2024
5	Adinda Ayu Shafira, AMd.Kep	Perawat	01 01 2024
6	Siti Kholifah, S.Kep.Ns	Perawat	01 01 2024
7	Dimas Kurniansyah, S.Kep.Ns	Perawat	01 01 2024
8	Nurul Almi Samsu Amd.Keb	Bidan	05 01 2024
9	Lolita Indriani Putri, S.Farm	TTK	05 01 2024
10	Neneng Anggraeni, S.Kep, Ns	Perawat	05 01 2024
11	Ivan Fadilla Amd. Farm	TTK	05 01 2024
12	Umus Salamah, AMd.Farm	TTK	05 01 2024
13	Miftahul Jannah, S. Farm	TTK	05 01 2024
14	Ayutya Helgayanti, S.Farm	TTK	05 01 2024
15	Khoirunnisai, S.Farm	TTK	05 01 2024
16	Della Ika Oktavia, AMd.Farm	TTK	05 01 2024
17	Iga Octanesya Iksahadi A.Md Keb	Bidan	05 01 2024
18	Eka Indah Restati Amd. Kep	Perawat	05 01 2024
19	Dhisma Fitri Rahmadhani Amd. Kep	Perawat	05 01 2024



No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
20	Aslah Fortuna Ramadhan, AMd. Kep	Perawat	05 01 2024
21	Anita Suprihatinigrum .,Amd.Kes	ATLM	05 01 2024
22	Dandi Agus Prasetyo A.md.Rad	Radiografer	05 01 2024
23	Windy Silegar Maelani, S. Kep., Ns	Perawat	05 01 2024
24	M. Ragil Zuli Walady.,Amd.Kep	Perawat	05 01 2024
25	Tansah Sinawang Sakinah, S.Tr.Kes	ATLM	05 01 2024
26	Rodeyah A.Md.Kep	Perawat	05 01 2024
27	Intania Cahya Andini, A.Md.Kep	Perawat	05 01 2024
28	Lianda Agnes Puspita Amd.Kep	Perawat	05 01 2024
29	Apt. Lilis Ika Kurniawati, S.Farm	TTK	05 01 2024
30	Yudita Anggraini Amd.Kep	Perawat	05 01 2024
31	Dilla Ika Virly Erlita S.Kes.,Ftr	Fisioterapis	05 01 2024
32	Yuyun Dianita, Amd. Kep	Perawat	05 01 2024
33	Rofi'atal Manzilah, S.Psi	Psikologi	27 12 2023
34	Tamara Putri Yunisma, S.Psi	Psikologi	27 12 2023
35	M Mujtaba	Parkir	01 01 2024
36	Muhammad Nasikhul Amin	Parkir	01 01 2024
37	M Rifki Dwi Cahyo	Parkir	01 01 2024
38	Slamet Budianto	Parkir	01 01 2024
39	Nauval Amirudin	Parkir	01 01 2024
40	Andhy Akhmad Putra Jaya	Parkir	01 01 2024
41	Juan Abdi Restanti, S.E.	Kasir	23 01 2024
42	Abd Rohman	Cleaning Service	23 01 2024
43	Agung Dwi Saputro	Cleaning Service	23 01 2024
44	Syaifulloh Nasih	Cleaning Service	23 01 2024
45	Wahyu Agung Nurcahyo, S.Kom	IT	23 01 2024
46	Agustin Rahmawati, A.Md.RMIK	Asuransi Center	23 01 2024
47	Rizki Agung Yulianto	Cleaning Service	23 01 2024
48	Adek Satura Fibia Amarylis, A.Md., Keb	Bidan	23 01 2024
49	Fauzi Nur Sandi	Cleaning Service	23 01 2024
50	Putri Eka Pratiwi A.Md.RMIK	Asuransi Center	23 01 2024
51	Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes	PKRS	23 01 2024
52	Sumikatul Zanah, A.Md.Kep	Perawat	23 01 2024
53	Putri Aliviah Kurniawati, A.md.,Kep	Perawat	23 01 2024
54	Della Susanti, A.Md. Kep	Perawat	23 01 2024
55	Ns. Dewi Muslimatul Qorin, S.Kep	Perawat	23 01 2024
56	Ns. Rita Amalia Karyow S.Kep	Perawat	23 01 2024
57	Tulus Yoga Suseno	Cleaning Service	23 01 2024
58	Mukhammad Fakhrizal Baihaqi, A.Md.Kes	Radiografer	23 01 2024
59	Naufal Kamil, A.Md.RMIK	Perekam Medis	23 01 2024
60	Muhammad Din Syamsudin, A.Md.Kep	Perawat	23 01 2024
61	Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep	Perawat	23 01 2024
62	Niken Dewi Hastuti, S.Farm	TTK	23 01 2024
63	Ns Siti Rahmawati, S.Tr Kep	Perawat	23 01 2024
64	David Pamungkas Aprilindo Amd.Kep	Perawat	23 01 2024
65	Dewi Shinta Bela Amd.RMIK	Perekam Medis	23 01 2024
66	Yahya Al Farizi	Parkir	23 01 2024
67	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	26 02 2024
68	dr. Zaki Yamani, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	27 02 2024
69	dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	27 02 2024
70	dr. Fina Jazilah Rizqiyah	Dokter Umum	28 02 2024
71	Sheila Luthfi Sabrina,A.Md.Farm	TTK	04 03 2024

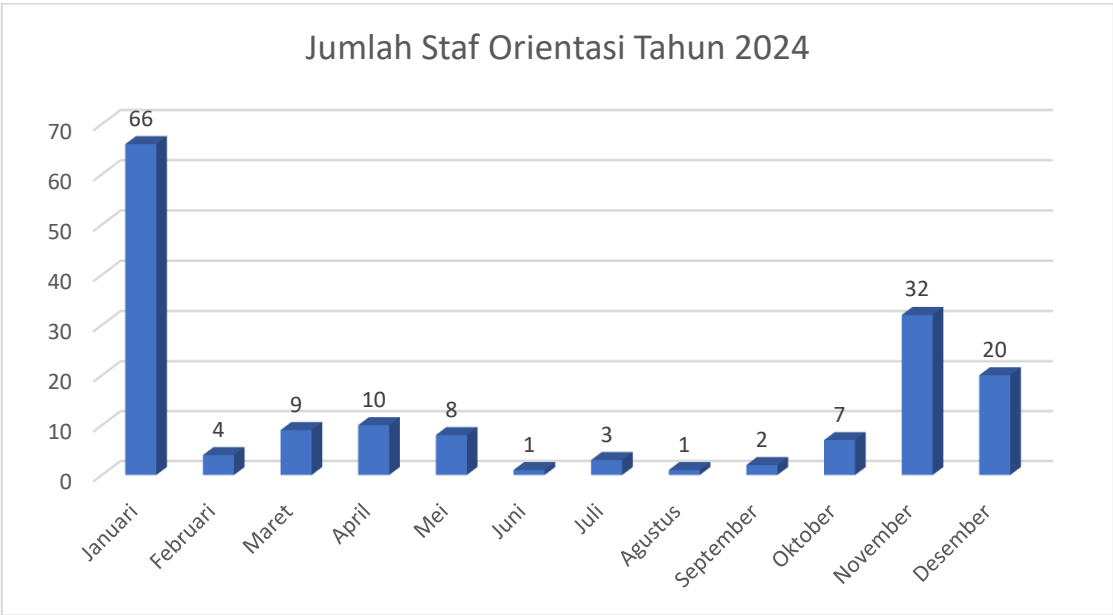


No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
72	Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	Humas & Marketing	04 03 2024
73	Agistia Zalfa Nasihah, S.M	Admin Humas	04 03 2024
74	Siti Fatimah Dwi Agustin	Admin Farmasi	12 03 2024
75	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	18 03 2024
76	Mukhammad Yusuf Efendy	Parkir	25 03 2024
77	Indra Dwi Priyantoko	Parkir	25 03 2024
78	Mustainul Arifin	Parkir	25 03 2024
79	Muchamad Setiyohadi	Parkir	25 03 2024
80	Fitri Eka Setyawati, A.Md.RMIK	Pendaftaran	01 04 2024
81	Arni Budi Winarty, S.Tr.Par	Pendaftaran	01 04 2024
82	Melinda Dwi Lestari, S.Kep	CSSD	01 04 2024
83	dr. Nejoa Ermaq Fatreciano	Dokter Umum	02 04 2024
84	Andhika Nur Hidayat, S.Kes.Ftr	Fisioterapi	25 04 2024
85	Alfi Afrida, S.Tr.Kes.Ftr	Fisioterapi	25 04 2024
86	Alfan Setyadi	TTK	25 04 2024
87	Putri Ayu Lestari	TTK	25 04 2024
88	Andini Aulia Mawardah	TTK	25 04 2024
89	Chela Meidita Elsa Putri	TTK	25 04 2024
90	Arifah'tus Soleha, A.Md.Kep	Perawat	01 05 2024
91	Anisa Fiatul Karimah, S.Kep., Ns	Perawat	01 05 2024
92	Ari Nita Pramesti, A.Md.Kep	Perawat	01 05 2024
93	Tatan Lestari, S.Kep., Ns	Perawat	01 05 2024
94	Nur Aini, S.Kep., Ns	Perawat	01 05 2024
95	Amelia Agnes Kartika, A.Md.Kep	Perawat	01 05 2024
96	dr. Adni Kautsari Ismini	Dokter Umum	15 05 2024
97	dr. Reka Vikaria Anggreli	Dokter Umum	27 08 2024
98	drg. Rhena Reifa Hariadi, Sp.KGA	Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak	06 05 2024
99	dr. Eko Nugroho, Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	10 Juni 2024
100	Bd. Yunita Wijayanti, S.Tr.Keb	Bidan	01 Juli 2024
101	dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal-Hipertensi	01 Juli 2024
102	dr. Siti Nafisatul Yasmine Azzackiyah	Dokter Ruangan	23 Juli 2024
103	Anisah Kurniawati, A.Md.Farm	TTK	24 09 2024
104	Khoirun Najwa Abidah, A.Md.Farm	TTK	24 09 2024
105	Eka Kurnia Oktaviani, A.Md.Kep	Perawat	08 10 2024
106	Muhammad Rifki Andika, A.Md.Kep	Perawat	08 10 2024
107	Dia Ayu Wulandari, A.Md.Kep	Perawat	08 10 2024
108	Mariatul Qiftiyah, S.Tr.Kep., Ns	Perawat	08 10 2024
109	Risma Amelia Widyawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog	11 10 2024
110	dr. Khurrotul A'yuni	Dokter Umum	14 10 2024
111	dr. Rohmatul Hidayati Ningsih	Dokter Umum	14 10 2024
112	Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz	Ahli Gizi	01 11 2024
113	Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz	Ahli Gizi	01 11 2024
114	Syauqi Ferdiana Ellya, A.Md.Gz	Ahli Gizi	01 11 2024
115	Bd. Devi Puspita Sari S.Tr.Keb	Bidan	01 11 2024
116	Hanifah Ummu Choir, S.Tr.Keb	Bidan	01 11 2024
117	Kitfiyatul Hasanah, S.Tr. Keb	Bidan	01 11 2024



No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
118	Farid Saifudin	IPSRS	01 11 2024
119	Mukhamad Anang Ma'ruf	IPSRS	01 11 2024
120	Mochamad Samsul Huda	Parkir	01 11 2024
121	Sutoko	Parkir	01 11 2024
122	Annisak Khoiru Nurjannah, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
123	Elia Huatika Adyrah, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
124	Elli Yanti Ayu Anggraini, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
125	Ila Sabkliaretna, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
126	Nabila Fina Mafaza, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
127	Asma Yudhi Efendi, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
128	Dani Saputra, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
129	Lilis Setiyowati, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
130	Rachmad Noer Saputra, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
131	Windy Audia Conita, S.Kep., Ns	Perawat	01 11 2024
132	Rekha Himarodianti, A.Md.RMIK	Perekam Medis	01 11 2024
133	Vany Nur Awaln, A.Md.RMIK	Perekam Medis	01 11 2024
134	Yuli Ferian Nanda, A.Md.RMIK	Perekam Medis	01 11 2024
135	Adelia Maharani, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
136	Agrita Cyndia Ayu Kirana, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
137	Anggun Salsabila Sugiyono, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
138	Chessia Jeseloy Cahya Putri, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
139	Della Anasya Nandita, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
140	Dimastika Purihita, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
141	Intan Larasati, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
142	Nurfitriyani, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
143	Putri Oktavia Larasati, A.Md.Farm	TTK	01 11 2024
144	Rena Harnadia, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
145	Khisbiyah, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
146	Ermawati Srilestari, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
147	Siti Aisyah, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
148	Arfa Faisza Almaera, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
149	Shalu Nafisah Aldini, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
150	Veni Febriyanti Arifin, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
151	Hilda Tanti Yuliana, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
152	Muhammad Revan Amrizal Naufalda, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
153	Meutia Hasya Namira, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
154	Hasyim Asyari, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
155	Bahrul Efendi, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
156	Umar Al Faruq, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
157	Maulana Anang Ramadhan, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
158	Walidatush Sholicha, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
159	Citra Intan Pratiwi, S.Kep., Ns	Perawat	01 12 2024
160	Adinda Riza Febrianti, A.Md.Kes	Radiografer	01 12 2024
161	Ervinda Arieska Rachmawati, A.Md.Kes	ATEM	01 12 2024
162	Diva Yulia Sari	Penyaji	09 12 2024
163	dr. Kurnia Ariya Dinata, Sp.OG	Dokter Spesialis Obgyn	18 12 2024

Data Staf Orientasi 2024



Kegiatan orientasi umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo terlaksana pada :

Periode Awal Tahun (Januari)

Periode Pertengahan tahun dalam proses pemenuhan kebutuhan unit

Periode Akhir Tahun (November dan Desember)

Kegiatan orientasi khusus telaksana dan terhitung 3 bulan sejak staf masuk rumah sakit. Terlihat dari diagram diatas bahwa staf baru dengan jumlah paling besar adalah di Bulan Januari 2024 tersebut dapat terjadi karena Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah membuat pola ketenagaan untuk proses pemenuhan kebutuhan pelayanan dan juga penggantian staf yang resign di tahun 2023 (31 Desember 2023).

B. Data Dtaf Resign Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun	No	Unit	Jumlah Staf Resign	Total Staf Resign
2023	1	Security	1	84 staf
	2	Cleaning Service	5	
	3	Pendaftaran	2	
	4	Tukang	1	
	5	Rawat Inap	14	
	6	Farmasi	25	
	7	Driver	1	
	8	IGD	4	
	9	Manajemen	2	
	10	Dokter	4	
	11	Rawat Jalan	5	
	12	Verifikator	4	
	13	Kasir	2	
	14	Laboratorium	2	
	15	Radiologi	1	
	16	Gizi Dapur	1	
	17	Rekam Medis	2	
	18	Parkir	8	
2024	1	Dokter	3	68 staf
	2	IGD	4	
	3	Rawat Inap	17	
	4	Farmasi	11	
	5	Pendaftaran	3	

	6	Humas Marketing	1	
	7	Manajemen	3	
	8	IT	2	
	9	Radiologi	2	
	10	Parkir	2	
	11	Rawat Jalan	3	
	12	Rekam Medis	3	
	13	Rehab Medik	1	
	14	Tukang	3	
	15	CSSD Laundry	1	
	16	IKO	1	
	17	Gizi Dapur	3	
	18	Laboratorium	1	
	19	Asuransi Center	2	
	20	IPSRs	1	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah turn over staf pada tahun 2023 sejumlah 84 orang. Sedangkan pada Tahun 2024 sejumlah 68 orang. Dengan jumlah staf pada tahun 2023 sejumlah 482 orang dan tahun 2024 sejumlah 558 orang maka besaran turn over pada kedua tahun itu sebesar 17.42% pada tahun 2023 dan 12.81 pada tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat angka penurunan turn over staf dari tahun 2023 ke 2024 sejumlah 4.61%.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

a. Daftar Diklat Internal Tahun 2024

Tabel Daftar Diklat Internal Tahun 2024

No	Tema/Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
1	Pelatihan Jurnalistik Gel. 1 Batch 1	SDM PHS	18 Januari 2024	4	Staf Terpilih	20	11	9	Kholid Amrullah - Radar Malang	Ceramah, Praktek	-	-
2	Pelatihan Jurnalistik Gel. 1 Batch 2	SDM PHS	31 Januari 2024	2	Staf Terpilih	11	6	5	Kholid Amrullah - Radar Malang	Ceramah, Praktek	-	-
3	Analisis dan Manajemen Data Mutu 1	Komite Mutu	23 Januari 2024	2	PIC Mutu Unit	18	14	4	Bening Sekar, S.KM	Ceramah, Praktek	-	-
									Lidia Puspita Kencana, S.K.M			
4	SKP Batch 1	IRNA 3A	15 Februari 2024	4	Perawat dan Bidan	166	90	76	Fefi Rita, S.Kep	Ceramah, Praktek	-	-
									Siti Maysaroh, S.Kep.,Ns			
5	Pengenalan Ukuran dan Pemasangan Kateter pada Anak	Komite Mutu	16 Februari 2024	2	IRNA 3A	17	14	3	Siti Maysaroh, S.Kep.,Ns	Ceramah	-	-
6	Penggunaan Alat Spirometry	IRNA 2A	17 Febaruari 2024	4	IRNA 2A dan perwakilan IRJA	58	33	25	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P, M.MRS	Ceramah, Praktek	-	-
									Ns. Izzaty Amalina R., S.Kep			
7				4		428	301	127	Restu Kurniawati, S.KM			

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
	MFK (Manajemen Fasilitas Keselamatan)	Komite K3RS	23-24 Februari 2024		All Staf (non Direksi dan dokter)				Erwan Saputra	Pitstop, Ceramah	103.4/195	121.67/195
									Suliyanto, Amd.Tekmed.			
									Zainul Azhari			
									Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep.,Ns			
8	Pelatihan Jurnalistik Gel. 2 Batch 1	SDM PHS	29 Februari 2024	2	Staf Terpilih	9	6	3	Kholid Amrullah - Radar Malang	Ceramah, Praktek, Diskusi, Demonstrasi	-	-
9	PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)	Komite Mutu	01-02 Maret 2024	4	All Staf (non Direksi dan dokter)	428	320	108	Lidia Puspita Kencana, S.KM	Grup Discussion	49.34/100	76/100
									Bening Sekar Tanjung, S.KM			
10	Pelatihan Jurnalistik Gel. 2 Batch 2	SDM PHS	07 Maret 2024	4	Staf Terpilih	11	5	6	Kholid Amrullah - Radar Malang	Ceramah, Praktek	-	-
11	Penanganan Sampel Pasien Laboratorium dan BDRS	Unit Laboratorium	08 Maret 2024	3	Perawat dan Bidan Orientasi	31	23	8	Elza Safarina Ulfa, A.Md.AK	Ceramah, Praktek, Demonstrasi	68.4/140	96.19/140
12	Observasi TURP (Transurethral Resection of The Prostate)	IRNA 3B	18 Maret 2024	2	Perawat	174	102	72	Ns Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	Ceramah	-	-

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
13	Analisis dan Manajemen Data Mutu 2	Mutu	20 Maret 2024	3	PIC Mutu Unit	23	14	9	Lidia Puspita Kencana, S.KM	Ceramah, Praktek		
14	Kodefikasi Diagnosa dan Tindakan Berdasarkan ICD 10 dan ICD 9 CM	Asuransi Center	06 April 2024	7	Staf Asuransi Center	11	14	0	Puguh Priyo Widodo, Amd. RMIK, S.Si, SKM, MMRS, AAK,M. AK,CHIA	Ceramah, Demonstrasi	-	-
15	Tatalaksana Awal Acute Heart Failure	SDM/ dr. Adhika Sp.JP	20 April 2024	3	Dokter IGD, Staf IGD, Staf ICU	46	31	15	dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP	Ceramah, Demonstrasi	-	-
16	SKP 2 (Sasaran Keselamatan Pasien)	PJ SKP	23-24 April 2024	2	All Staf	449	255	194	Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns	Ceramah, Praktek, Demonstrasi		
									Siti Maysaroh, S.Kep.,Ns			
17	MFK Susulan	K3RS	04 Mei 2024	3	Absen MFK 1 + Staf Orientasi	157	53	104	Restu Kurniawati, S.KM	Pitstop, Ceramah	103.4/195	121.67/195
									Erwan Saputra			
									Suliyanto, Amd.Tekmed.			
									Zainul Azhari			
18	Refresh Training Alat Ventilator - PT. Andson Sarana Bagus	SDM/ ATEM PHM	06 Mei 2024	7	ATEM, IKO, ICU (PJ Alat, KARU, dan KaTim)	23	18	5	PT. Andson Sarana Bagus	Ceramah, Demonstrasi	-	-

No	Tema/Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
19	Pemeliharaan dan Pengoperasian Genset dan Panel Listrik	SDM/ IPSRS	15 Mei 2024	4	IPSRS	4	3	1	M. Arifin	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
20	Refreshment Training Bank Mandiri	SDM PT DPM	21 Mei 2024	5	KABID, KARU, PJ Gudang Farmasi	37	31	6	Bank Mandiri	Ceramah, Demonstrasi	-	-
21	Pelatihan Eco Enzyme 1	PT DPM / dr. Aslichah	24 Mei 2024	6	Tim Eco Enzyme	5	5	0	Universitas Brawijaya	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
22	Training of Trainer (TOT)	PT DPM	5 Juni 2024	3	Kepala Bidang dan Kepala Instalansi	10	8	2	Ibu Endang Susilowati	Ceramah	-	-
23	PPI Dasar (All Staf)	Komite PPI	7 Juni 2024	3	Janmed dan Umum Keu	199	101	98	Dinnya Yesica Tandy, S.KM	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	101.43 / 160	144.32 / 160
			8,11 Juni 2024	4	CS	42	37	5			65.37/100	97.89/100
			10 Juni 2024	4	Yanmed	202	141	61			61.72 / 100	86.42 / 100

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
24	Aseptic Dispensing Workshop dan Patient Safety & Medication Error	Kains Farmasi - Rama	12 Juni 2024	5	Apoteker, Karu IRNA, Katim IRNA	39	18	21	Mr. Rully Adriansyah PT. Otsuka Indonesia	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	100/130
									Mega Muchzalita PT. Otsuka Indonesia			
									Ramadhan Rizki P., S.Farm., Apt			
25	Pelatihan Hydrant	Tim MFK	23 Juni 2024	6	Security, CS, IPSRS	47	32	15	Erwan Saputra	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	55.63/100	72.5/100
									Zainul Azhari			
									Syafi'i			
26	Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk Staf Klinis / BLS	Tim BHD	29 Juni 2024	9	Perawat dan Bidan	145	130	15	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	51.03/100	74.16/100
27	Early Warning System (EWS)	EWS - Debi	6 Juli 2024	5	Perawat dan Bidan	195	81	114	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	51,03/100	85.65/100
28	Penyiapan Obat Intravena & Teknik Aseptik	PT DPM	16 Juli 2024	4	Apoteker dan Perawat IRNA	17	15	2	PT Otsuka Indonesia	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-

No	Tema/Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
29	Maintenance Mesin HD dan RO	SDM PHS	17 Juli 2024	8	ATEM, Perawat HD, IPAL/B3, IPSRS	13	20	3	PT Sinar Roda Utama / Nipro	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
30	PPI Dasar Kloter 2	PPI	25 Juli 2024	3	Janmed dan Umum Keu	146	43	103	Tim PPI	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
			26 Juli 2024	4	Yanmed							
31	Jurnalistik Dasar 2 (Batch 1)	SDM PHS	29 Juli 2024	5	PJ PKRS	21	16	5	Kholid Amrullah - Radar Malang	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	86.52/100
32	Pelatihan SITB	PJ TB	3 Agustus 2024	3	Tim TB, KARU (IGD, IRNA, IRJA)	17	16	1	Irawati, Amd.Kep	Demonstrasi, Diskusi	47,5 / 100	93,75 / 100
									Ana Nurul, Amd.Kep			
33	Asistensi Jantung dan Pembuluh Darah	Asist JP - Mami	12-14 Agustus 2024	1	KARU + KaTim IRNA	24	20	4	Mami Susanti	Demonstrasi, Praktik	-	-
34	Training Laser Nd YAG	SDM PHS	14, 16, 19, 24, Agustus 2024	2	Sp.M, ATEM, Asis Poli Mata	6	5	1	Vendor Zeiiss	Demonstrasi, Praktik	-	-
35	Doa Kesembuhan Pasien	Tim Doa RSPHS	21 Agustus 2024	3	Tim Program Doa	-	8	-	ust. Indah (Malang)	Demonstrasi, Diskusi, Praktik	-	-

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
36	Komunikasi Efektif (Agustus: 1)	PKRS	22, 24, 28 Agustus 2024	2	Umum dan Keuangan, TTK, IPAL/B3	148	85	63	Dr. dr. Aslichah, AFP	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	93,72 / 100	93,11 / 100
			28 Agustus 2024	3	Klinis, Apoteker	211	22	189	Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes		91,33 / 100	98,14 / 100
37	Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	SDM PHS dan Tim MFK	29 Agustus 2024	7	All Staf	443	288	155	BMKG Pasuruan	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	3081,52 / 734	2952,7 / 3999
38	Pemeriksaan ECG	SDM PHS	30 Agustus 2024	2	Laboratorium	13	13	0	dr. Cynthia Mustika Anggraini	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	66,15 / 120	92,31 / 120
									Izzaty Amalina Rasyadi, S.Kep., Ns			
39	Komunikasi Efektif (September: 2)	PKRS	2 September 2024	3	All Staf (gel 2)	338	220	118	Dr. dr. Aslichah, AFP	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	89,85 / 100	96,36 / 100
40	Hipnoterapi Batch 1	SDM PT DPM	6 September 2024	8	Kabid Keperawatan, Mutu, PPI, SDM, KARU (IRNA,	15	12	3	Dr. dr. Aslichah, AFP	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
					MATER, NICU, ICU)							
41	Jurnalistik Dasar 2 (Batch 2)	SDM PHS	12 September 2024	4	Peserta Pelatihan Jurnalistik Dasar 2 (Batch 1)	27	7	20	Radar Malang	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
42	Hipnoterapi Batch 2	SDM PT DPM	14 September 2024	7	Kabid Keperawatan, Mutu, PPI, SDM, KARU (IRNA, MATER, NICU, ICU)	15	13	2	Dr. dr. Aslichah, AFP	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
43	Refreshment Training The Power of Communication for Marketing	SDM PT DPM	18 September 2024	4	MOD dan Humas Marketing	7	5	2	Bu Endang Sadi	Ceramah, Diskusi	-	-
44	Refreshment Training Management Stress	SDM PT DPM	20 September 2024	5	Direksi, Komite, Karu, Kainst, SDM	39	31	8	Bank Mandiri + CEO UMM	Ceramah, Demonstrasi	-	-

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
45	Mantoux Test	Dinkes + Tim Coaching TB + SDM PHS	26 September 2024	4	Asisten Poli Anak, perawat, bidan, lab, apoteker	31	20	11	Dinas Kesehatan Pasuruan	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
46	Jurnalistik - Event Management	SDM PHS	27 September 2024	4	Sekretaris, SDM, Komite (PKRS, PMKP, PPI, K3RS)	11	11	0	Radar Malang	Ceramah, Demonstrasi	71,76 / 100	88,7 / 100
47	Pemakaian Infus	SDM PHS	2 Oktober 2024	2	Kepala Ruang RI, IGD	12	10	2	PT. Satoria Aneka Industri	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	-	-
48	Mantoux Test	Poli Anak	16 November 2024	3	All Perawat dan Bidan Pelayanan	193	46	147	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed	Ceramah, Demonstrasi, Praktik	81 / 100	91 / 100
49	Safety Medication	Mutu	26 November 2024	3	Perawat, Bidan, Farmasi	256	187	69	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	Ceramah, Demonstrasi	48,95 / 100	72,82 / 100
									Lidia Pupita Kencana, S.k.M.			
50	BHD Umum	SDM PHS	28 November 2024	2	Bidang Penunjang	261	117	144	Debi Firmanasia, Amd.Kep		72 / 100	82 / 100

No	Tema>Nama Diklat	PIC	Tgl. Pelaksanaan	JP	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta			Pemateri	Metode	Skor	
						UND	Hadir	Tidak Hadir			Pre	Post
					Medis, Bidang Umum dan Keuangan				Bagas Surya Purwono, Amd.Kep Lillo Palupi Armaidah, Amd.Kep	Ceramah, Demonstrasi, Praktik		
51	Achievment Motivation	SDM PHS	16 Desember 2024	4	Manajemen, Karu, KaTim	80	62	18	Fernando Wahyu S. (KALBE)	Ceramah, Demonstrasi	51/100	87/100
52	Service Excellent	SDM PHS	17 Desember 2024	4	Manajemen, Karu, KaTim	80	52	28	Fernando Wahyu S. (KALBE)	Ceramah, Demonstrasi	55/100	90/100
53	Jurnalistik Advance 1	SDM PHS	19 Desember 2024	2	Tim Jurnalistik (Dasar 1 &2)	18	7	11	Kholid Amrullah - Radar Malang	Demonstrasi, Diskusi, Praktik	-	-
54	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	Tim HPK	20 Desember 2024	1	All Staf	481	226	255	Dita Pratria Permatasari	Ceramah	82.08 / 100	92.38 / 100
									Khotimah, S.Tr.Keb			
									Suci Anda Risky			

Gambaran Jumlah Diklat Internal Perbulan Th 2024



Tabel Rekapitulasi Klasifikasi PIC Rumah Sakit dan PT DPM

No	PIC Diklat (PT DPM / RS)	Jumlah	Persentase
1.	PT Disa Prima Medika	8	14.82%
2.	RS Prima Husada Sukorejo	46	85.18%
Total		54	100%

2. Daftar Diklat Eksternal Tahun 2024

Tabel Daftar Diklat Eksternal Tahun 2024

No.	Tema Diklat	Penyelenggara	Nama Peserta	Unit	Tgl. Pelaksanaan	Biaya Diklat	Kontrak Dinas
1	Kelas Web PPI Dasar 2-3	IPKP Training Kelas Web PPIRS	Dhea Ayu Puspita Sari., S. Kep., Ns	NICU	07/01/2024	Rp260.000	5 bulan

No.	Tema Diklat	Penyelenggara	Nama Peserta	Unit	Tgl. Pelaksanaan	Biaya Diklat	Kontrak Dinas
2	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	RSSA	Allamul Angga Gilang Nishvu Ramadhan., S. Kep, Ns	IKO	22/01/2024 - 17/05/2024	Rp20.000.000	5 tahun
3	Pelatihan Keperawatan Intensif (ICU) 2024	RSSA	Refi Andi Alamsyah, S.Kep., Ns	ICU	26/02/2024 - 28/06/2024	Rp12.000.000	4 tahun
4	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Unit Donor Darah (UDD)	IPPII (Ikatan Professional Pencegahan Infeksi Indonesia)	Aulya Wahyuningrum Rena Dumilah, Amd.Kes	Lab	16/02/2024 - 17/02/2024	Rp500.000	6 bulan
5	Webinar Peningkatan Kapasitas Komunikasi Efektif pada Upaya Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur	FKM UNAIR	Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes	PKRS	19-20 Maret 2024	Rp0	0 bulan
6	Seminar dan Workshop 4 - PERSI	PERSI	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	Manajemen	15-17 Mei 2024	Rp3.504.000	2 tahun
7	Seminar dan Workshop 2 - PERSI	PERSI	Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns., M.Kep	Manajemen	15-17 Mei 2024	Rp3.502.000	2 tahun
8	Workshop Nego Mediasi & Kesepakatan Perdamaian Sengketa Medik	RSO Suharso	Nur Aini Izzah, S.Kep., Ns	MOD	27-28 April 2024	Rp1,500,000	2 tahun
9	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	RSSA	Linda Saputri, Amd.Kep	IGD	29 April - 09 Agustus 2024	Rp18.000.000	5 tahun
10	Pelatihan Keperawatan Neonatus Level 2	RSUD Dr. Soetomo	Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns	NICU	14 Mei – 19 Juli 2024	Rp15,000,000	4 tahun

No.	Tema Diklat	Penyelenggara	Nama Peserta	Unit	Tgl. Pelaksanaan	Biaya Diklat	Kontrak Dinas
11	Bimtek Khusus Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (IPCN)	RSSA	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns	IRNA 3A	4 - 6 Juli 2024	Rp5,500,000	3 tahun
12	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	RSSA	Wijaya Risky Ramadhan, A.Md.Kep	IGD	15 Juli - 25 Oktober 2024	Rp20.000.000,00	5 tahun
13	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	RSSA	Shenfi Ken Rilla, S.Kep., Ns	IGD	15 Juli - 25 Oktober 2024	Rp20.000.000,00	5 tahun
14	Pelatihan & Sertifikasi Hiperkes Paramedis	HSE prime	Rizqi Gitari Fernanda, AMd.Kep	Humas & Marketting	19 - 23 Agustus 2024	Rp5,500,000	2 tahun
15	Daring Workshop Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan	Siloam Training Center	Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes	PKRS	13-14 Agustus 2024	Rp500,00	6 bulan
16	Workshop Penyusunan Dokumen Regulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KARS	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	Manajemen	13-14 September 2024	Rp4.500.012,00	2 tahun
17	Workshop Pelayanan Hemodialisis yang Aman di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KARS	Siti Maysaroh, Amd.Kep	Manajemen	24-25 September 2024	Rp4.500.040,00	2 tahun
18	Pembelajaran "Service Quality" dan Sertifikasi kompetensi	BPKS Kesehatan	Nuri Aini Izzah, S.Kep., Ns	MOD	24-25 September 2024	Rp3.528.000,00	2 tahun
19	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	RSSA	M. Galih Adiwibowo, S.Kep., Ns	IGD	14 Oktober 2024 - 24 Januari 2025	Rp20.000.000,00	5 tahun
20	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Operator Mesin Diesel (Genset)	PT. Lintas Pengembangan	Saifuddin	IPSRS	10-14 Oktober 2024	Rp5.750.000,00	3 tahun

No.	Tema Diklat	Penyelenggara	Nama Peserta	Unit	Tgl. Pelaksanaan	Biaya Diklat	Kontrak Dinas
		Manajemen Indonesia					
21	Pelatihan Resusitasi Neonatus	Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA)	Deva Afridiani, Amd Kep	NICU	23-24 November 2024	Rp4.250.000,00	2 tahun
22	<i>Certified Emergency Department Manager</i> – Workshop Pengelolaan Instalansi Gawat Darurat (IGD) yang Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien	KARS	Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep., Ns	Manajemen	19-20 November 2024	Rp4.500.000,00	2 tahun
23	Kelas Online Fraud dan Kredensialing BPJS Sesuai Standar Akreditasi RS KEMENKES Terbaru (2024)	KARS	Rhizqita Julian Eka Rahmanda, Amd.PK., S.KM	Manajemen	15 November 2024	Rp700.000,00	1 tahun
24	Pelatihan Dokter Jaga di Unit Dialisis	RSUP Dr. Sardjito	dr. Siti Nafisatul Yasmine Azzackiyah	Dokter Ruangan	28 November - 31 Desember 2024	Rp15.000.000,00	4 tahun
25	Indikator Mutu Klinis dan Audit Medis dan Audit Klinis Sesuai Standar Akreditasi RS Kemenkes Terbaru (2024)	KARS	Lidia Puspita Kencana, S.K.M.	Manajemen	13 Desember 2024	Rp700.000,00	1 tahun

Gambaran Jumlah Diklat Eksternal Perbulan Th 2024



3. Perbandingan kebutuhan diklat TNA dengan Diklat Internal dan Eksternal Tahun 2024

a. Perbandingan TNA dengan Diklat Internal

Tabel Perbandingan TNA dengan Diklat Internal 2024

No.	Tema Diklat Internal TNA	2024
Hasil Pengukuran dan Keselamatan		
	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	Terlaksana
	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Terlaksana
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Terlaksana
	Komunikasi Efektif	Terlaksana
	Pelatihan Pengisian Dokumen Rekam Medis	Tidak Terlaksana
	Pelatihan SIMRS	Tidak Terlaksana
	Pelatihan PPK-CP	Tidak Terlaksana
	Peatihan RISTI (Pengisian NEWS)	Terlaksana
	Pelatihan Kriteria Keluar Masuk ICU	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Penanganan Pasien Perdarahan Post Partum	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Manajemen Persalinan	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Manajemen Eklamsia pada Ibu	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Manajemen Laktasi	Tidak Terlaksana
Hasil Pemantauan Program Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK)		
	Manajemen Stress	Terlaksana
	Peningkatan Kemampuan Leader dalam Teknik Couching & Counseling	Tidak Terlaksana
	Diklat pengaturan pola makan dan pemenuhan gizi seimbang	Tidak Terlaksana
	PHBS	Tidak Terlaksana
	Penggunaan APD di Lingkungan Kerja	Terlaksana
	Safety rider, alur pelaporan kecelekaan	Tidak Terlaksana
	Penggunaan APD di Lingkungan Kerja	Terlaksana
	Resosialisasi dan Refreshing Diklat APAR untuk staf	Terlaksana
	Manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terlaksana
	Manajemen Utilitas	Terlaksana
	Manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terlaksana
	Manajemen Bencana di RS (Praktik Langsung)	Terlaksana
Usulan Unit Internal		

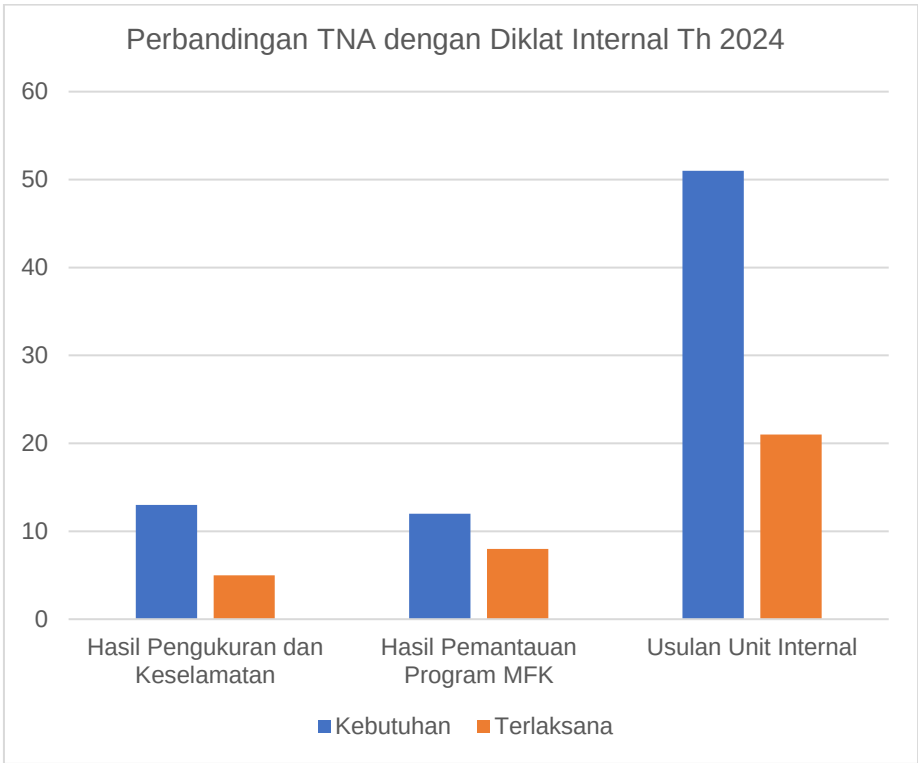
No.	Tema Diklat Internal TNA	2024
	Asuhan Pasien (PAP)	Tidak Terlaksana
	Character Building (SKP)	Tidak Terlaksana
	Drug Medication Error (PKPO)	Terlaksana
	Identifikasi Pasien (SKP, PMKP)	Terlaksana
	Inhouse Training Pelatihan Asisten Orthopedi (PAB)	Tidak Terlaksana
	Inhouse Training Pelatihan Asisten Urologi (PAB)	Tidak Terlaksana
	Kegawatan Neonatus	Tidak Terlaksana
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KPS)	Tidak Terlaksana
	Kriteria Keluar Masuk ICU (PP)	Tidak Terlaksana
	Manajemen Bangsal	Tidak Terlaksana
	Manajemen Nyeri (PAP)	Tidak Terlaksana
	Manajemen Pasien Terminal (AKP, PP)	Tidak Terlaksana
	Manajemen Restrain (PAP)	Tidak Terlaksana
	Manajemen Risiko Jatuh (SKP, PMKP)	Terlaksana
	Pelatihan Dispensing Obat Steril (PKPO)	Terlaksana
	Pelatihan Fluid Manajemen (PAP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Injeksi Anestesi dan Sedasi di Luar Kamar Operasi (PKPO, PAB)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan IPCLN AdTerlaksanaance (PPI)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Komunikasi Efektif (KE, SKP)	Terlaksana
	Pelatihan Komunikasi Efektif Semua Karyawan Rumah Sakit (KE,SKP)	Terlaksana
	Pelatihan Mutu Rekam Medis (Tindak Lanjut Kejadian RM Double) (PMKP, MRMIK)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Pelaporan Reaksi Transfusi (PP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Pencampuran dan Pengelolaan Obat High Alert (PKPO)	Terlaksana
	Pelatihan Pengelolaan Obat-Obat yang Patut di Waspada / Disinfentasi (PKPO)	Terlaksana
	Pelatihan Pengisian RM Persiapan Pasien Operasi (PAB, SKP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Penulisan SBAR (KE)	Terlaksana
	Pelatihan Perawatan CTERLAKSANAC di Ruangan ICU dan Rawat Inap (PP, PAP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Plebotomi dan Penanganan Sample (PP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan PPI Dasar Cleaning SerTerlaksanaice (PPI)	Terlaksana
	Pelatihan PPI Dasar Staf Pelayanan (PPI)	Terlaksana
	Pelatihan PPI Dasar Staf Penunjang dan Umum (PPI)	Terlaksana
	Pelatihan PPI Dasar untuk Staf Orientasi(PPI)	Terlaksana
	Pelatihan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Rumah Sakit (PKPO)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan ReTerlaksanaiew Pemasangan Infus (PAP, PP, PPI dan AKP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Titrasi Obat (PKPO)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Triase bagi Dokter Umum, Perawat dan Bidan Instalasi Gawat Darurat (IGD) (AKP)	Tidak Terlaksana
	Penanganan Bayi Asfiksia (PP, PAP, SKP)	Tidak Terlaksana
	Penanganan Bencana (SKP, MFK)	Terlaksana
	Pengelolaan dan Pemberian Produk Darah (PP)	Terlaksana
	Pengelolaan Limbah B3 (MFK)	Terlaksana
	Penyiapan Obat dan Teknik Aseptik (PKPO)	Terlaksana

No.	Tema Diklat Internal TNA	2024
	Pertolongan Pertama untuk Luka Bakar (SKP, PAP, PP)	Tidak Terlaksana
	Program MFK - Staf Orientasi (MFK)	Terlaksana
	Proteksi Kebakaran (MFK)	Terlaksana
	Rawat Luka (CWCCA)	Tidak Terlaksana
	Sistem Utilitas (MFK)	Terlaksana
	Transportasi Pasca Resusitasi Neonatus	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Keluar Masuk ICU, NICU (PP, SKP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Transfer pasien (AKP, PP, PAP)	Tidak Terlaksana
	Pelatihan Triage (AKP)	Tidak Terlaksana
	ReTerlaksanaiew Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	Terlaksana
Diklat Internal Sesuai TNA yang Terlaksana		34
Persentase Diklat Internal Sesuai TNA yang Terlaksana		44.74%

Tabel Rekapitulasi Perbandingan TNA dengan Diklat Internal Th 2024

No.	Kategori Kebutuhan Diklat Internal (TNA)	Jumlah	Terlaksana	Persentase Terlaksana
1.	Hasil Pengukuran dan Keselamatan	13	5	38.46%
2.	Hasil Pemantauan Program Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK)	12	8	66.67%
3.	Usulan Unit Internal	51	21	41.18%

Gambaran Perbandingan TNA dengan Diklat Internal Th 2024



Tabel Diklat Internal yang dilaksanakan diluar TNA

No.	Tema Diklat Internal	PIC
	Pelatihan Jurnalistik Gel. 1 Batch 1	SDM PHS
	Pelatihan Jurnalistik Gel. 1 Batch 2	SDM PHS
	Analisis dan Manajemen Data Mutu (2 pertemuan)	PJ Mutu
	Pengenalan Ukuran dan Pemasangan Kateter pada Anak	PJ Mutu
	Penggunaan Alat Spirometry	IRNA 2A
	Pelatihan Jurnalistik Gel. 2 Batch 1	SDM PHS
	Pelatihan Jurnalistik Gel. 2 Batch 2	SDM PHS
	Observasi TURP (<i>Transurethral Resection of The Prostate</i>)	IRNA 3B
	Kodefikasi Diagnosa dan Tindakan Berdasarkan ICD 10 dan ICD 9 CM	Asuransi Center
	Tatalaksana Awal Acute Heart Failure	SDM PHS + dr. Adhika Sp.JP
	Refresh Training Alat Ventilator - PT. Andson Sarana Bagus	SDM PHS
	Pemeliharaan dan Pengoperasian Genset dan Panel Listrik	SDM PHS + IPSRS
	Refreshment Training Bank Mandiri	SDM PT DPM
	Pelatihan Eco Enzyme 1	SDM PT DPM
	Training of Trainer (TOT)	SDM PT DPM
	Maintanance Mesin HD dan RO	SDM PHS
	Jurnalistik Dasar 2 (Batch 1)	SDM PHS
	Pelatihan SITB	PJ TB - Ira dan Ana
	Asistensi Jantung dan Pembuluh Darah	Asist Poli Jantung - Mami
	Training Laser Nd YAG	SDM PHS
	Doa Kesembuhan Pasien	SDM PHS
	Pemeriksaan ECG	SDM PHS
	Hipnoterapi Batch 1	SDM PT DPM
	Hipnoterapi Batch 2	SDM PT DPM
	Jurnalistik Dasar 2 (Batch 2)	SDM PHS
	Refreshment Training The Power of Communication for Marketing	SDM PT DPM
	Mantoux Test	Dinkes + Tim Coaching TB + SDM PHS
	Jurnalistik - Event Management	SDM PHS + PHM
	Pemakaian Infus	SDM
	Mantoux Test	Poli Anak
	Achievment Motivation	SDM PHS
	Service Excellent	SDM PHS
	Jurnalistik Advance 1	SDM PHS
	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	Tim HPK
Jumlah Diklat Internal yang dilaksanakan diluar TNA		34

Perbandingan TNA dengan Diklat Eksternal

No.	Jenis Layanan	Tema Diklat Eksternal TNA	Jumlah Sasaran	2024
Rencana Penyediaan Layanan Baru				
	NICU	Pelatihan NICU	3	1 (Tidak Terpenuhi)
	Dialisis	Pelatihan Dialisis bagi Perawat	4	Terpenuhi
	Dialisis	Pelatihan Dialisis bagi Dokter Jaga	1	Terpenuhi
	C-Arm	Pelatihan C-Arm	1	Tidak Terpenuhi

No.	Jenis Layanan	Tema Diklat Eksternal TNA	Jumlah Sasaran	2024
	Hiperkes	Pelatihan Hiperkes bagi Tenaga Kesehatan	2	Terpenuhi
Sertifikasi Wajib yang Belum Terpenuhi				
	ICU	Pelatihan ICU Dasar	3	1 (Tidak Terpenuhi)
	Instrumen	Pelatihan Instrumen Dasar bagi Perawat Bedah	1	Terpenuhi (Bedah Saraf)
	Instrumen	Re-Sertifikasi Instrumen	3	Tidak Terpenuhi
	Audiometri	Pelatihan Audiometri & Spirometri	2	Tidak Terpenuhi
	K3RS	K3 Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
	K3 Listrik	Sertifikasi Ahli K3 Listrik	1	Tidak Terpenuhi
	Hygiene Sanitasi	Hygiene Sanitasi (Penjamah Makanan)	3	Tidak Terpenuhi
	BDRS	BDRS	1	Tidak Terpenuhi
	Safety Driving	Defensive Driving	6	Tidak Terpenuhi
	ESQ	ESQ	50	Terpenuhi
	CSSD	CSSD Tingkat Lanjut	1	Tidak Terpenuhi
	CSSD	CSSD Tingkat Dasar	1	Tidak Terpenuhi
	PIPP	PIPP	1	Terpenuhi
	PHACO	Pelatihan PHACO	1	Terpenuhi
	Neonatus	Resusitasi Neonatus	2	Tidak Terpenuhi
	Laboratorium	Plebotomi	1	Tidak Terpenuhi
Usulan Unit Eksternal				
	IKO	Pelatihan Manajemen Kamar Bedah	1	Tidak Terpenuhi
	IGD	PPGD	2	Tidak Terpenuhi
		PPGDON	2	Tidak Terpenuhi
	IRJA	CWCCA (Certified Wound Care Clinician Associate)	1	Tidak Terpenuhi
	IRNA II A	Manajemen Bangsal	1	Tidak Terpenuhi
	IRNA II B	Workshop Peningkatan Kapasitas Kepala Ruang	1	Tidak Terpenuhi
		Manajemen Bangsal	1	Tidak Terpenuhi
	IRNA III B	Workshop Peningkatan Kapasitas Kepala Ruang	1	Tidak Terpenuhi
	NICU	PELS (Pediatric Emergency Life Support)	1	Tidak Terpenuhi
	Rehab Medik	Manajemen Pelayanan Fisioterapi	1	Tidak Terpenuhi
	Rekam Medis	Pelatihan Kelengkapan Dokumen Rekam Medis dan Pengisian Dokumen RM untuk Menunjang Klaim	1	Terpenuhi
	Farmasi	Pelatihan Dispensing Obat Steril	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Manajerial Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
		Manajemen Logistic Gudang Farmasi	1	Tidak Terpenuhi
		Management Inventory	1	Tidak Terpenuhi
	Ahli Gizi	Nutrition Care Process (NCP)	2	Tidak Terpenuhi

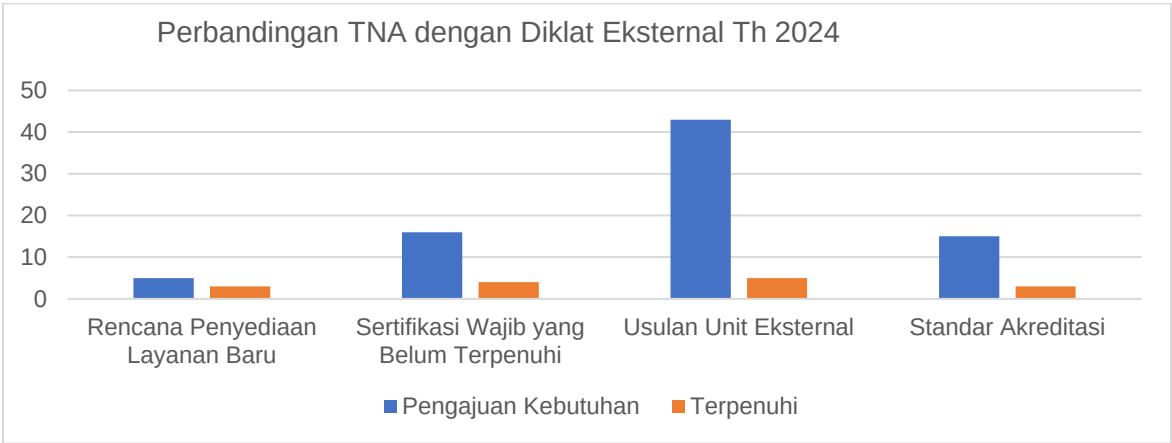
No.	Jenis Layanan	Tema Diklat Eksternal TNA	Jumlah Sasaran	2024
	Laboratorium	K3 Laboratorium	1	Tidak Terpenuhi
	Asuransi Center	Pelatihan Kodefikasi Diagnosa dan Tindakan Berdasarkan ICD 10 dan ICD 9	1	Tidak Terpenuhi
		Bedah Berita Acara Dispute Klaim dan Berita Acara Kesepakatan Klaim	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Pencegahan Kecurangan Klaim (FRAUD)	1	Terpenuhi
		Pelatihan Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB)	1	Terpenuhi
	CSSD & Laundry	Manajemen Laundry	1	Tidak Terpenuhi
	ATEM	Ahli Teknik Pelayanan Kesehatan (ATEM)	1	Tidak Terpenuhi
	Manajemen	Pelatihan Leadership Rumah Sakit	35	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Patient Safety dan Penerapan Manajemen Resiko di Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
		Management Strategic Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
	SDM	Pelatihan Manajemen SDM Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Sertifikasi Trainer of Trainer BNSP	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan TNA (Training Need Assessment) Pegawai Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
	Keuangan & Akuntansi	Pelatihan Laporan Keuangan	1	Tidak Terpenuhi
	IT & SIMRS	Tata Kelola Jaringan Pelayanan RS	1	Tidak Terpenuhi
	Cleaning Service	Training Manajemen Pelayanan Cleaning Service	3	Tidak Terpenuhi
	Komite Medik	Workshop Evaluasi Praktik Profesional bagi Tenaga Medis, Keperawatan dan Nakes Lain	1	Tidak Terpenuhi
	Komite Keperawatan	Pelatihan Etika dan Mutu Keperawatan	1	Tidak Terpenuhi
		Workshop Evaluasi Praktik Profesional bagi Tenaga Medis, Keperawatan dan Nakes Lain	1	Tidak Terpenuhi
	Komite Tenaga Kesehatan Lain	Pelatihan Kredensial Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
		Workshop Evaluasi Praktik Profesional bagi Tenaga Medis, Keperawatan dan Nakes Lain	1	Tidak Terpenuhi
	Komite PPI	Pelatihan IPCD	1	Tidak Terpenuhi
		Kelas Web PPI Dasar 2-3	1	Terpenuhi
	Komite Mutu	Penyusunan Program dan Laporan Kegiatan PMKP	1	Terpenuhi

No.	Jenis Layanan	Tema Diklat Eksternal TNA	Jumlah Sasaran	2024
		Berbasis Manajemen Risiko Terintegrasi		
	Tim PKRS	Pelatihan pengembangan media PKRS dan Digital Marketing	1	Tidak Terpenuhi
		Pelatihan Puclic Relation (PR) di Rumah Sakit	1	Tidak Terpenuhi
Standar Akreditasi				
		TKRS	1	Tidak Terpenuhi
		KPS	1	Tidak Terpenuhi
		MFK	1	Tidak Terpenuhi
		PMKP	1	Terpenuhi
		PPI	-	1
		PPK	1	Tidak Terpenuhi
		AKP	1	Tidak Terpenuhi
		HPK	1	Tidak Terpenuhi
		PP	1	Tidak Terpenuhi
		PAP	1	Tidak Terpenuhi
		PAB	1	Tidak Terpenuhi
		PKPO	1	Tidak Terpenuhi
		KE	1	Terpenuhi
		SKP	1	Tidak Terpenuhi
		PROGNAS	1	Tidak Terpenuhi
Diklat Eksternal Sesuai TNA yang Terlaksana				15
Persentase Diklat Eksternal Sesuai TNA yang Terlaksana				18.99%

Tabel Rekapitulasi Perbandingan TNA dengan Diklat Eksternal Th 2024

No.	Kategori Kebutuhan Diklat Eksternal (TNA)	Jumlah	Terpenuhi	Persentase Terlaksana
1.	Rencana Penyediaan Layanan Baru	5	3	60%
2.	Sertifikasi Wajib yang Belum Terpenuhi	16	4	25%
3.	Usulan Unit Eksternal	43	5	11.63%
4.	Standar Akreditasi	15	3	20%

Gambaran Perbandingan TNA dengan Diklat Eksternal Th 2024



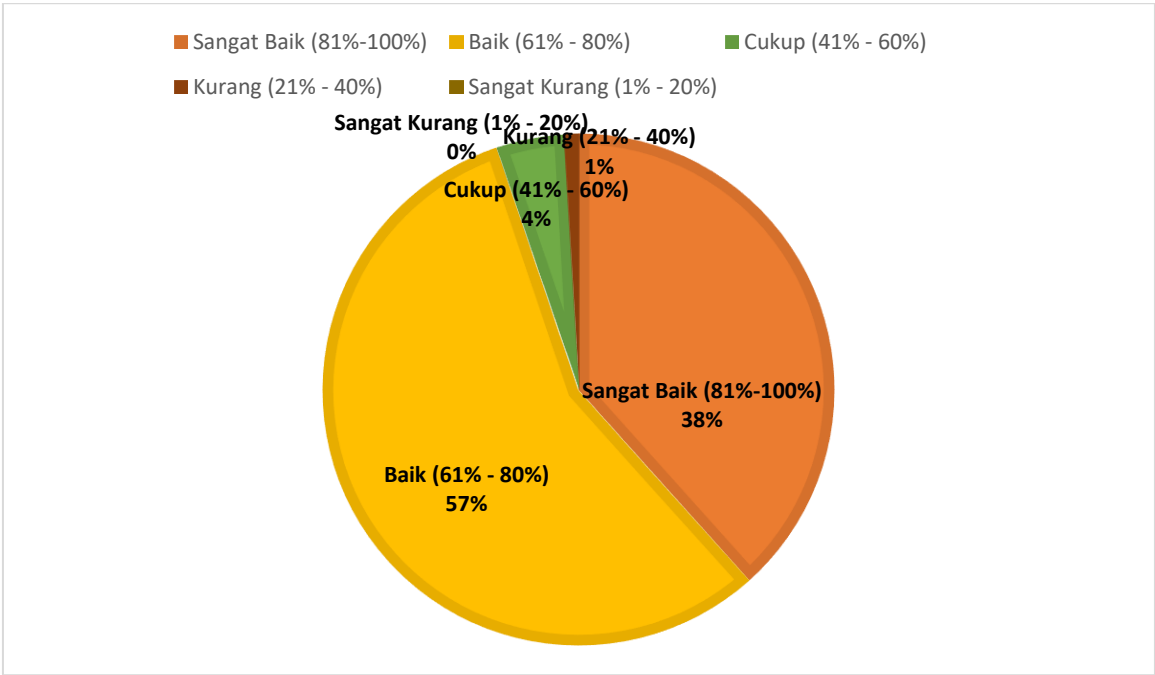
3.1.4 Terlaksana Evaluasi Kinerja Staf

Terlaksana evaluasi kinerja di tahun 2024 berjalan dan terbagi menjadi dua periode:

Periode Semester I (Januari – Juni)

Periode Semester II (Juli – Desember)

Pengumpulan evaluasi kinerja kepada SDM pada tanggal 30-31 periode semester berakhir. Adapun berikut rata-rata nilai staf :



Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa hasil kategori terlaksana evaluasi kinerja staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tergolong Baik.

Adapun tindak lanjut dari SDM perihal staf dengan catatan atau staf dengan penilaian kategori cukup dan kurang adalah pemanggilan staf serta monitoring eTerlaksanaaluasi kinerja selama beberapa bulan kedepan. Jika tidak ada perubahan maka akan dipertimbangkan kembali untuk kelanjutan kontrak kerja.

Sedangkan untuk staf dengan penilaian sangat kurang dan telah menjalani pemanggilan oleh SDM maka dikeluarkanlah surat rekomendasi tidak dilanjutkan kontrak ataupun surat peringatan sesuai dengan kendala atau masalah yang ditimbulkan dari hasil evaluasi kinerja tersebut.

3.2. Hasil dan Evaluasi Pengembangan Pelayanan

No	Unit	Recana Pengembangan	Keterangan		Target Pelaksanaan
			Tercapai	Belum Tercapai	
1	IGD	Pelebaran ruang IGD yang sesuai dengan standart dengan dipenuhi 3 bed PONEK	√		Desember 2024 selesai dengan gedung baru
2	ICU	Penambahan ruang tunggu bagi keluarga pasien ICU Melengkapi kebutuhan ICU isolasi yang sesuai standart Ruang ICU yang standart dengan alat observasi yang mendukung Diadakannya ruang PICU	√		PICU belum terpenuhi di tahun 2024
3	IKO	Pelayanan Kamar Operasi dengan C-Arm	√		
4	IRJA	Pelayanan Poli Eksekutif		√	Masih dalam perencanaan ulang. Target tahun 2025
		Penambahan layanan poli mata yaitu YAG laser	√		Pengajuan penambahan layanan di Hfis

					BPJS bulan Januari
5	Maternitas	Pembukaan layanan Mom SPA untuk ibu hamil dan pasca melahirkan		√	Masuk dalam pengembangan pelayanan Tahun 2025
6	Neonatologi	Layanan photo new born 	√		
7	NICU	Ruang tunggu untuk ibu yang bayinya sakit dengan dilengkapi fasilitas untuk memompa ASI (ruang ibu menyusui)	√		Ruang laktasi menjadi satu dengan ruang neonatologi
8	IRNA 2A	Adanya smart lock door untuk ruang isolasi Ruang KIE yang nyaman untuk keluarga pasien yang privasi		√	
9	IRNA 2B	Nurse station yang layak dan nyaman disertai dengan ruang edukasi yang nyaman bagi keluarga pasien yang privasi	√		
10	IRNA 3A	Membuat playground untuk pasien anak 	√		
11	Hemodialisis	Penambahan pelayanan unit hemodialisa di lantai 2		√	Sudah memiliki dokter KGH Sudah memiliki 1 dokter umum Sudah memiliki 5 perawat tersertifikasi HD Alat HD sudah datang

					Pemasangan instalasi air RO sudah Perijinan layanan target 2025
--	--	--	--	--	---

NO	UNIT	RENCANA PENGEMBANGAN	realisasi		keterangan
			terlaksana	belum terlaksana	
1	Farmasi	Gratis pengantaran atau maksimal Rp5.000,00 atau Promo Beetu di hari-hari kesehatan.		√	
2	Radiologi	PACS (<i>Picture Archieving Communicating System</i>)		√	
3	Laboratorium	a) LIS (<i>Laboratory Information System</i>)		√	
		b) <i>Pneumatic Tube</i>		√	
		c) Paket “Catin”			
		d) Mengadakan kerjasama penerimaan pemeriksaan Troponin, FT4 dan TSH dari RS atau klinik rawat inap terdekat.			
4	Rekam Medis	a) RM-elektronik	√		rawat jalan rawat inap belum terlaksana
5	Sterilisasi	a) Mesin plasma untuk sterilisasi alat semikritikal		√	
6	Laundry	a) Mesin Cuci Infeksius dengan kapasitas 15 kg.	√		
		b) Mesin Jahit untuk perbaikan linen rusak secara mandiri		√	
		c) Printer Linen		√	
7	Gizi	a) Variasi menu anak	√		
		b) Konsultasi gizi melalui WA personal ataupun komunitas seperti Diabetes, Hipertensi dan Gagal Ginjal.		√	

3.3. Kinerja Produktifitas Unit

3.3.1. Penunjang
A. Rekam Medis

Tabel Kinerja Produktifitas Rekam Medis

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
BOR	79.21	81.81	90.77	93.05	97.87	83.4	83.32	71.72	72.9	80	78.75	75.15
TOI	0.62	0.54	0.25	0.19	0.05	0.45	0.46	0.9	0.85	0.58	0.6	0.79
ALOS	3.3	3.32	3.43	3.46	3.39	3.3	3.33	3.26	3.28	3.31	3.34	3.45
BTO	10.46	10.13	11.48	11.05	12.78	10.97	11.16	9.74	9.58	10.7	10.56	9.76
NDR	11.24	9.68	9.68	7	9.71	5.36	7.94	8.75	9.49	10.62	8.07	9.9
GDR	18.74	18.71	21.06	17.75	19.94	13.71	18.14	16.92	17.2	20.18	16.68	20.95

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024
1	BOR	76.14 %	75.86 %
2	ALOS	3.62 hari	3.35 hari
3	TOI	0.80 hari	0.75 hari
4	BTO	108.25 kali	118.51 kali
5	NDR	9.66 ‰	9.01‰
6	GDR	19.38 ‰	18.41‰

Problem	Capaian indikator kinerja rumah sakit pada tahun 2024 BOR sudah sesuai standar, namun ALOS, TOI, dan BTO belum mencapai standar Depkes RI 2005.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi kinerja rumah sakit.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab tidak tercapainya ALOS, TOI dan BTO sesuai standar. Harapan : Peningkatan indikator kinerja rumah sakit yang sesuai dengan standar pada Tahun 2025 Tindakan : Mengevaluasi jumlah kunjungan rawat inap di Rumah Sakit Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Melakukan penambahan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah kunjungan rawat inap di Rumah Sakit.
Study	Apa yang anda pelajari ? Capaian indikator kinerja rumah sakit pada tahun 2024 yaitu BOR 75.86% sudah mencapai standar yaitu 60-85%. Namun untuk indikator ALOS, TOI dan BTO masih di bawah standar ALOS 6-9 hari, TOI 1-3 hari, dan BTO 40-50 kali menurut standar Depkes RI 2005.

	Nilai LOS, TOI dan BTO belum memenuhi standar hal ini dikarenakan adanya perputaran pasien cukup cepat di rawat inap sehingga rata-rata nilai LOS, TOI dan BTO tidak memenuhi standar selain itu indikator BOR, LOS, TOI dan BTO adlah jumlah kunjungan pasien rawat inap
Action	Apa yang anda pelajari ? Mempertahankan capaian BOR yang sudah memenuhi standar, hal ini menggambarkan pemanfaatan tempat tidur untuk di gunakan di Rumah Sakit. ALOS secara standar Depkes RI belum terpenuhi, namun bila menggunakan Barber-Jhonson ALOS sudah mencapai standar yaitu 3-12 hari. Hal ini adalah gambaran tentang efesiensi dan menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. TOI belum memenuhi standar hal ini dikarenakan cepatnya perputaran tempat tidur di rawat inap. BTO yang tidak sesuai standar dikarenakan jumlah kunjungan pasien yang mengalami naik turun. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025

10 Diagnosa terbesar kunjungan rawat jalan pada tahun 2024

No	ICD-10	Deskripsi	Jumlah
1	Z50.1	Other physical therapy	8630
2	Z09.8^E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	7911
3	Z09.8^I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	6491
4	Z09.0	Follow-up examination after surgery for other conditions	5433
5	Z09.8^I69.3	Sequelae of cerebral infarction	3896
6	Z09.8^M17.9	Gonarthrosis, unspecified	3222
7	Z09.8^J43.9	Emphysema, unspecified	3055
8	Z48.0	Attention to surgical dressings and sutures	3035
9	Z09.3	Follow-up examination after psychotherapy	2513
10	Z09.8^H25.9	Senile cataract, unspecified	2266

Problem	Kunjungan kontrol rehab medik yang tinggi
Step	Analisa kunjungan rehab medik merupakan kunjungan baru atau kunjungan lama
Plan	Rencana : Analisa kunjungan rehab medik Harapan : Kunjungan rehab medik dapat dipertahankan Tindakan : Evaluasi diagnose rawat jalan Melakukan koordinasi dengan pelayanan terkait dengan kunjungan pasien di rawat jalan merupakan kunjunga baru atau kunjungan lama
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 10 besar diagnosa rawat jalan
Study	Apa yang anda pelajari ? Diagnosa rawat jalan sudah sesuai dengan diagnosa non spesliasitik dan kunjungan pasien dirawat jalan lebih banyak jumlah kunjungan pasien kontrol hal ini dapat terjadi karena masih berlakunya rujukan faskes 1 yang dapat digunakan untuk beberapa dokter melalui rujuk internal
Action	Apa yang anda pelajari ? Adanya aturan baru dari BPJS kesehatan terkait dengan pengaturan rujukan internal dan konsul internal di rumah sakit sehingga rumha sakit dapat menyesuaikan dengan aturan tersebut mengingat kunjungan pasien di rumah sakit dominan dalah pasien BPJS kesehatan Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi terkait dengan 10 besar penyakit rawat jalan Koordinasi dengan pelayanan terkait dengan penyakit rawat jalan

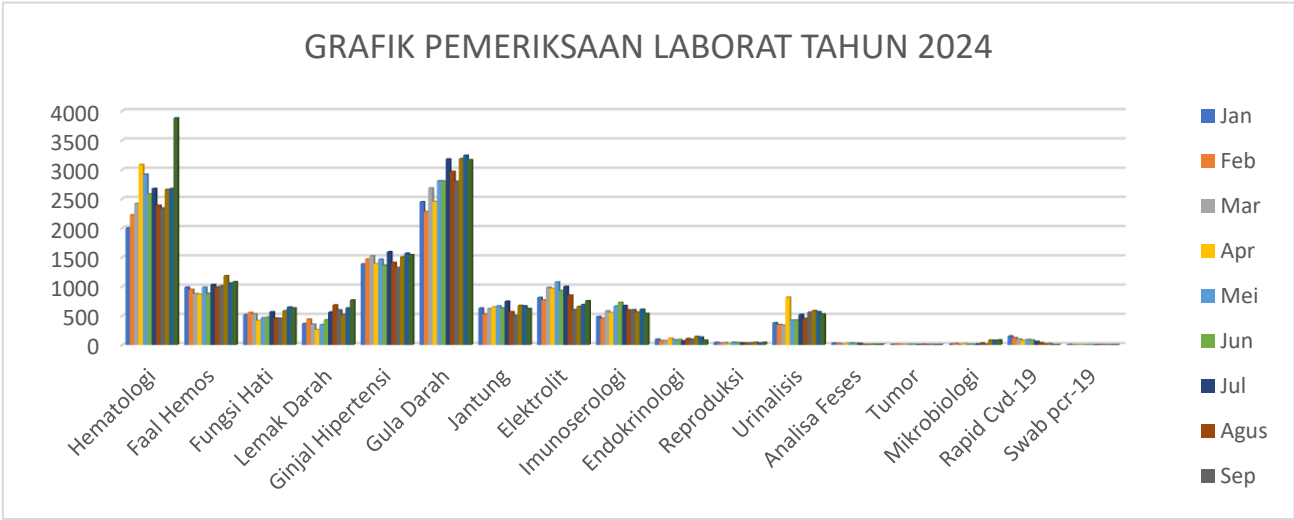
B. Laboratorium

Daftar pemeriksaan lab yang dilakukan di dalam rumah sakit tahun 2024

Jenis pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Hematologi	1998	2222	2417	3082	2916	2577	2672	2383	2337	2655	2670	3879
Faal Hemos	985	945	874	864	984	877	1030	986	1007	1180	1055	1076
Fungsi Hati	514	551	525	413	460	468	563	453	452	580	643	628
Lemak Darah	361	438	352	258	343	426	559	679	594	515	628	764
Ginjal Hipertensi	1383	1466	1520	1385	1464	1361	1591	1405	1320	1502	1565	1539
Gula Darah	2445	2277	2679	2449	2803	2800	3176	2962	2795	3181	3240	3162

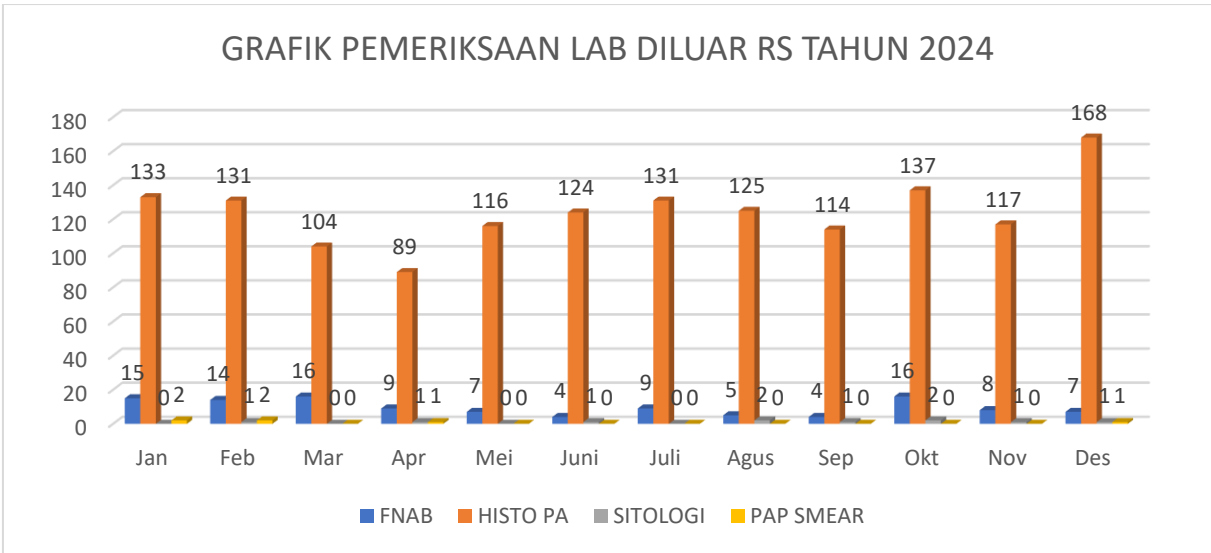
Jantung	626	524	619	648	664	628	743	563	499	671	663	618
Elektrolit	808	764	979	964	1073	927	997	846	597	654	687	751
Imunoserologi	480	452	578	549	662	724	670	593	597	559	605	536
Endokrinologi	95	72	70	111	84	88	65	105	93	141	128	77
Reproduksi	39	27	34	21	43	36	31	28	33	40	28	40
Urinalisis	376	343	332	814	419	422	518	450	557	584	564	524
Analisa Feses	26	22	11	21	30	24	21	4	3	7	5	8
Tumor	6	9	6	6	7	6	2	5	4	4	2	4
Mikrobiologi	11	23	5	17	7	6	12	28	7	78	75	81
Rapid Cvd-19	149	120	96	77	88	80	56	34	14	19	0	1
Swab pcr-19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total	20408	10255	11097	11679	12047	11450	12706	11524	10909	12370	12558	12492

Grafik Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2024



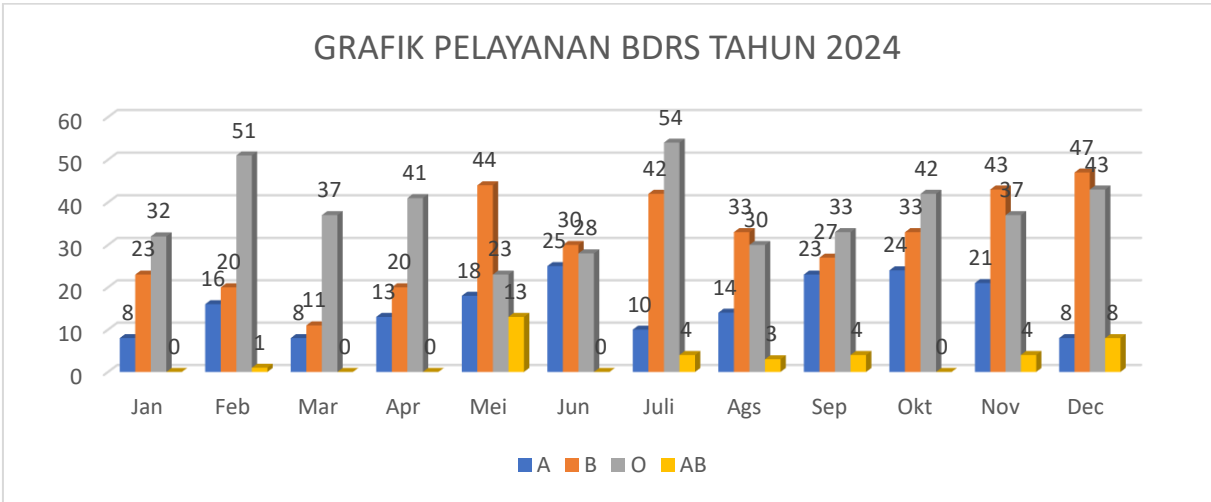
Daftar pemeriksaan lab yang dilakukan di luar rumah sakit tahun 2024

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	FNAB	15	14	16	9	7	4	9	5	4	16	8	7
2	HISTO PA	133	131	104	89	116	124	131	125	114	137	117	168
3	SITOLOGI	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	1
4	PAP SMEAR	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		150	148	120	100	123	129	140	132	119	155	126	177



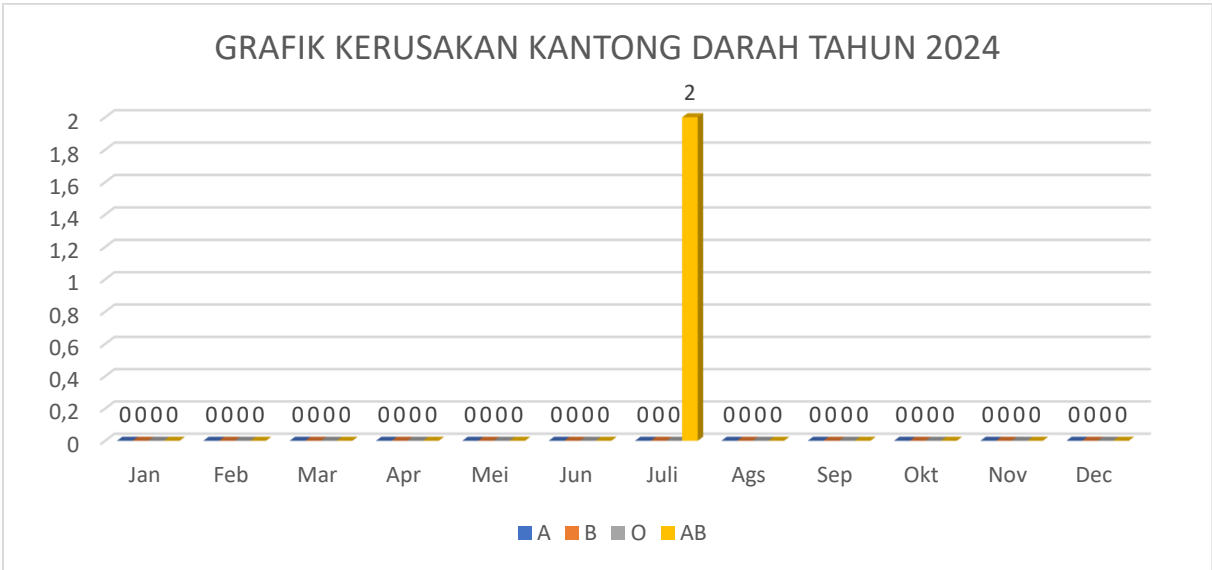
Daftar Pelayanan darah di BDRS tahun 2024 (PRC Packed Red Cell)

Jenis Golda	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Dec
A	8	16	8	13	18	25	10	14	23	24	21	8
B	23	20	11	20	44	30	42	33	27	33	43	47
O	32	51	37	41	23	28	54	30	33	42	37	43
AB	0	1	0	0	13	0	4	3	4	0	4	8
Jumlah	63	88	56	74	98	83	110	80	87	99	105	105



Daftar kerusakan / expired kantong darah di BDRS tahun 2024

Jenis Golda	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Dec
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0



Analisis Layanan

Problem	Jumlah permintaan pemeriksaan laboratorium selama 2024 mengalami fluktuatif
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium di tahun 2024
Plan	Rencana : Evaluasi penyebab penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium di tahun 2024 Harapan : Adanya kenaikan pasien sehingga pelayanan laborat dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan pasien Tindakan : Mengevaluasi jumlah stok reagen di Laboratorium Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan pemeriksaan laboratorium. Melakukan penambahan fasilitas pemeriksaan pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit. Berkoordinasi dengan humas dan marketing terkait dengan peningkatan kunjungan pasien dan kerjasama dengan fasyankes lainnya
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah stok reagen di Laboratorium.
Study	Apa yang anda pelajari ? Penyebab terjadinya tren penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium berkaitan dengan jumlah kunjungan baik terutama kunjungan rawat inap. Namun salah satu yang berdampak pada permintaan pemeriksaan laboratorium adalah penerapan sistem proporsi dari DPJP dimana DPJP sudah mulai melakukan efisiensi dan lebih selektif dalam pemeriksaan penunjang yang diperlukan oleh pasien
Action	Apa yang anda pelajari ? Jumlah permintaan pemeriksaan laboratorium paling rendah didapatkan pada bulan februari 2024, hal ini berkaitan dengan jumlah kunjungan yang juga menurun Setelahnya sempat mengalami kenaikan pada bulan Mei 2024. OPO BEGINI?

	Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 Menambah jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan laborat keluar
--	--

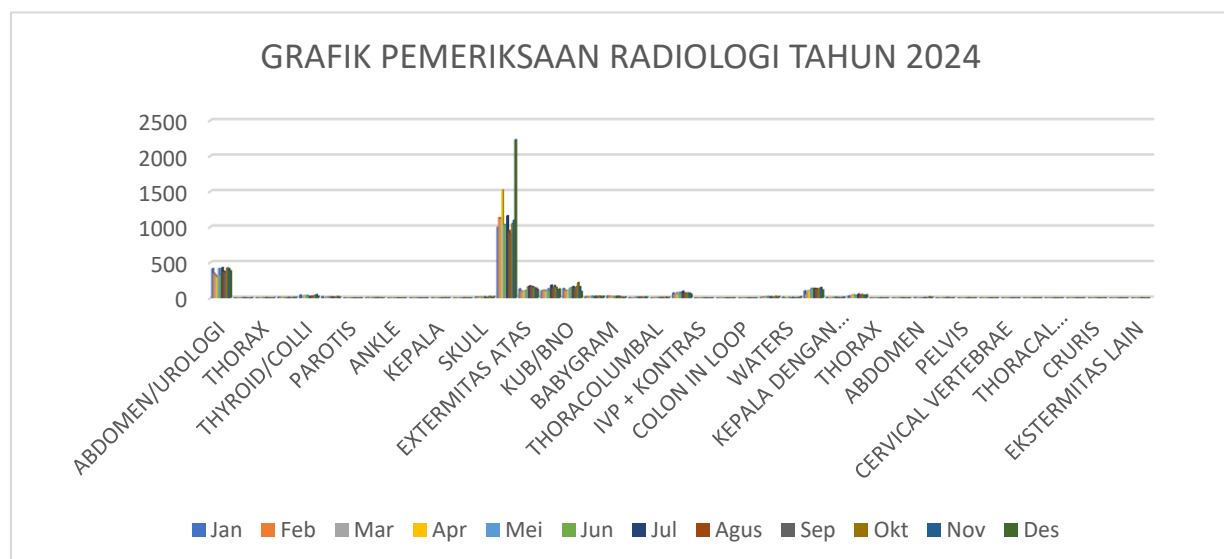
C. Radiologi

Pemeriksaan radiologi di dalam rumah sakit

Jenis Pemeriksaa		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
USG	ABDOMEN/UROLOGI	414	347	320	296	416	325	428	375	358	423	414	382
	ABDOMEN CITO	2	0	0	0	2	4	3	1	1	1	4	2
	THORAX	2	0	2	3	4	4	4	1	3	0	2	5
	MAMMAE	10	8	6	7	4	3	8	4	4	9	8	6
	THYROID/COLLI	41	0	32	31	38	25	25	27	30	40	48	23
	TESTIS	17	0	12	8	16	12	16	13	11	20	16	7
	PAROTIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VASKULER	3	6	2	3	4	2	2	5	2	3	1	4
	ANKLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FEMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	KEPALA	3	0	1	1	1	0	1	1	4	1	2	1
	MANDIBULA	0	1	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0
TOTAL		492	362	376	350	485	375	489	427	416	498	496	430

RADIO DIAGN OSTIK	SKULL	12	13	13	14	8	18	9	3	21	19	8	20
	THORAX	99 8	11 33	11 15	15 21	10 34	10 28	11 58	95 0	90 6	10 48	10 96	22 30
	EXTERMITAS ATAS	12 9	98	96	10 3	10 2	15 8	17 0	16 5	16 0	14 6	13 9	12 2
	EXTERMITAS BAWAH	10 3	11 2	10 8	98	13 1	10 5	18 0	14 1	17 5	15 0	12 0	12 7
	KUB/BNO	13 4	11 2	10 5	10 8	14 2	14 7	16 2	14 5	15 9	21 7	15 8	91
	PELVIS	17	18	15	16	27	16	25	20	24	26	18	24
	BABYGRAM	27	25	23	19	19	23	24	25	15	10	9	12
	CERVICAL	4	1	3	1	10	10	10	10	9	9	14	6
	THORACOLUMBAL	2	3	4	3	8	5	6	7	3	12	5	7
	LUMBOSACRAL	70	55	74	55	82	70	97	72	68	72	68	55
	IVP + KONTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

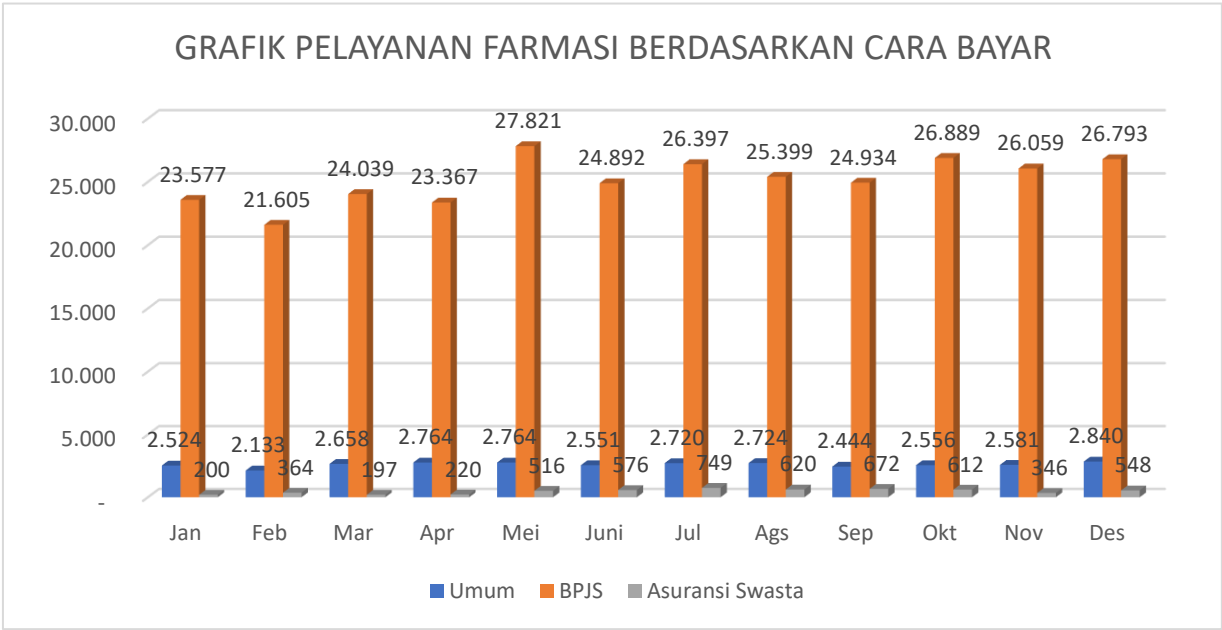
	URETROGRAFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COLON IN LOOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PANORAMIC	8	13	14	13	20	15	18	10	12	25	10	21
	WATERS	11	3	1	7	7	0	7	3	3	5	5	18
TOTAL		15 15	14 33	15 71	14 62	15 85	15 27	17 96	15 51	15 54	17 39	16 50	15 37
CT SCAN	KEPALA	10 1	57	10 2	10 6	13 5	13 6	13 5	13 3	12 6	13 7	14 9	11 3
	KEPALA DENGAN KONTRAS	6	1	4	4	7	11	6	6	2	6	10	8
	KEPALA TRAUMA	30	10	42	47	37	33	55	45	49	42	40	46
	THORAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THORAX DENGAN KONTRAS	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0
	ABDOMEN	4	0	1	1	0	0	4	2	2	15	9	8
	ABDOMEN DENGAN KONTRAS	1	0	0	1	3	1	4	5	2	1	2	2
	PELVIS	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	VERTEBRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CERVICAL VERTEBRAE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	LUMBOSACRAL	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	THORACAL VERTEBRAE NON KONTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THORAX VERTEBRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CRURIS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	LUMBOSACRAL VERTEBRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EKSTERMITAS LAIN	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	0
TOTAL		14 2	68	14 9	15 9	18 7	18 5	21 3	19 1	18 2	20 1	21 2	17 7
TOTAL KESELURUHAN		21 49	18 63	20 96	19 71	22 57	20 87	24 98	21 69	21 52	24 38	23 58	21 44



Problem	Jumlah permintaan pemeriksaan radiologi selama tahun 2024 terjadi penurunan dan kenaikan di setiap bulannya.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak penurunan permintaan pemeriksaan radiologi di tahun 2024
Plan	Rencana : Melakukan evaluasi penyebab penurunan permintaan pemeriksaan radiologi di tahun 2024 Harapan : Adanya kenaikan pasien sehingga pelayanan radiologi dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan pasien Tindakan : Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan pemeriksaan radiologi Berkoordinasi dengan humas dan marketing untuk peningkatan angka kunjungan dan Kerjasama dengan faskes lainnya Penambahan fasilitas pelayanan di radiologi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian permintaan pemeriksaan radiologi.
Study	Apa yang anda pelajari ? Penyebab terjadinya tren penurunan permintaan pemeriksaan radiologi berkaitan dengan jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan selain itu penerapan sistem proporsi dari DPJP dimana DPJP sudah mulai melakukan efisiensi penunjang yang diperlukan oleh pasien sehingga pasien dilakukan pemeriksaan berdasarkan kondisi klinis pasien saat di rawat
Action	Apa yang anda pelajari ? Penurunan angka kunjungan radiologi yang sangat drastis adalah bulan februari dibandingkan dengan bulan-bulan selanjutnya Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025

N o	Jenis Resep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Umum	2,52 4	2,13 3	2,65 8	2,76 4	2,76 4	2,55 1	2,72 0	2,72 4	2,44 4	2,55 6	2,58 1	2,84 0

2	BPJS	23,577	21,605	24,039	23,367	27,821	24,892	26,397	25,399	24,934	26,889	26,059	26,793
3	Asuransi Swasta	200	364	197	220	516	576	749	620	672	612	346	548
Total		26,301	24,102	26,894	26,351	31,101	28,019	29,866	28,743	28,050	30,057	28,986	30,181



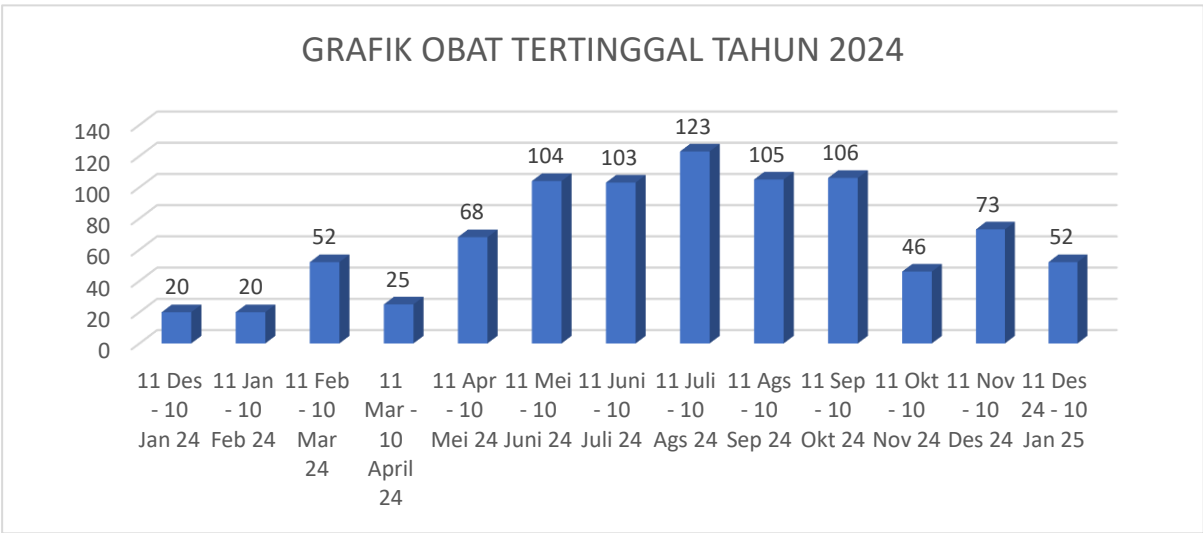
Analisis Layanan

Problem	Jumlah pelayanan resep mengalami fluktuatif pada tahun 2024
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak jumlah pelayanan resep yang fluktuatif
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab jumlah pelayanan resep yang fluktuatif di tahun 2024 Harapan : Adanya peningkatan permintaan resep di Tahun 2025 Tindakan : Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai peresepan. Berkoordinasi dengan Gudang Farmasi terkait ketersediaan stock. Berkoordinasi dengan humas dan marketing terkait angka kunjungan dan kerjasama dengan pihak external
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian jumlah pelayanan resep.
Study	Apa yang anda pelajari ?

	Jumlah pelayanan resep di Instalasi Farmasi fluktuatif. Pada bulan februari 2024 jumlah pelayanan resep mengalami penurunan dari bulan sebelumnya namun pada bulan selanjutnya menunjukkan adanya kenaikan resep
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan permintaan resep mengalami fluktuatif mengikuti jumlah pasien setiap bulannya . Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 Evaluasi persediaan stock Gudang dan Depo Farmasi.

Pelayanan Obat tertinggal tahun 2024

NO	PERIODE	JUMLAH
1	11 Des - 10 Jan 24	20
2	11 Jan - 10 Feb 24	20
3	11 Feb - 10 Mar 24	52
4	11 Mar - 10 April 24	25
5	11 Apr - 10 Mei 24	68
6	11 Mei - 10 Juni 24	104
7	11 Juni - 10 Juli 24	103
8	11 Juli - 10 Ags 24	123
9	11 Ags - 10 Sep 24	105
10	11 Sep - 10 Okt 24	106
11	11 Okt - 10 Nov 24	46
12	11 Nov - 10 Des 24	73
13	11 Des 24 - 10 Jan 25	52



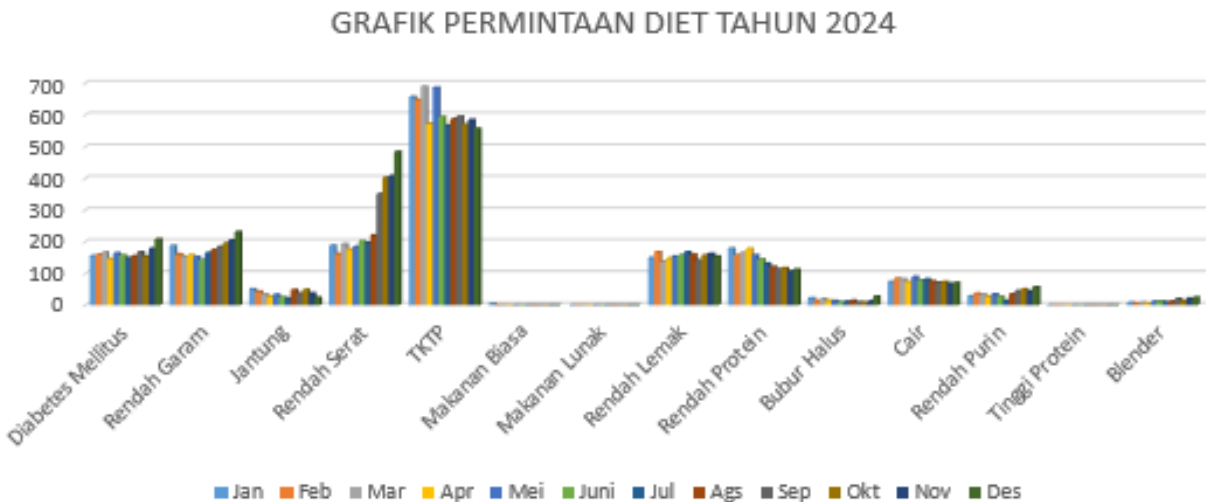
Problem	Adanya obat yang tidak diambil oleh pasien setelah pemeriksaan
Step	Evaluasi dan Analisa terkait dengan jumlah obat tertinggal
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab obat tertinggal Harapan : Meminimalisir adanya obat tertinggal di rumah sakit Tindakan : Melakukan evaluasi dan supervisi terkait dengan obat yang tidak diambil oleh pasien Koordinasi dengan pelayanan dalam penyampaian obat pulang setelah dilakukan pemeriksaan di poli Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman bagi pasien dengan obat tertinggal tersebut
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi jumlah obat tertinggal setiap bulannya
Study	Apa yang anda pelajari? Obat tertinggal yang tidak diambil oleh pasien setelah periksa di poli terdapat beberapa faktor pendukung yaitu pasien tidak dieduksai bahwa terdapat obat pulang sehingga pasien langsung meninggalkan rumah sakit tanpa ke farmasi, selain itu terdapat pasien yang meminta obat akan diambil dihari berikutnya namun tidak diambil keesokan harinya
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan jumlah tertinggalnya obat di farmasi fluktuatif namun pada akhir tahun mengalami penurunan dikarenakan adanya admin tersendiri yang menangani masalah obat tertinggal Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi obat tertinggal disetiap bulannya

E. Instalasi Gizi

Permintaan diet tahun 2024

No	Jenis Diit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Diabts Mellits	156	159	167	147	164	158	149	155	168	154	179	208
2	Rndah Garm	187	161	154	158	152	143	165	174	184	195	205	231
3	Jantng	51	43	34	28	33	25	22	48	38	49	38	24
4	Rndah Serat	188	162	193	176	184	201	197	220	350	402	407	484
5	TKTP	657	648	689	573	686	594	567	587	595	570	584	557
6	Maknn Biasa	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Maknn Lunak	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rendah Lemak	149	168	137	148	154	158	168	159	142	158	162	154

9	Rendh Prtein	179	158	165	178	158	145	132	121	114	117	107	112
10	Bubur Halus	22	15	19	15	14	10	12	15	10	9	12	28
11	Cair	74	84	82	74	89	78	82	76	72	74	68	71
12	Rendh Purin	29	37	34	28	35	27	15	35	45	51	44	57
13	Tinggi Prtein	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Blnder	8	6	8	6	12	13	10	12	20	15	21	25
Total		1520	1705	1641	1682	1531	1681	1558	1602	1740	1794	1827	1851



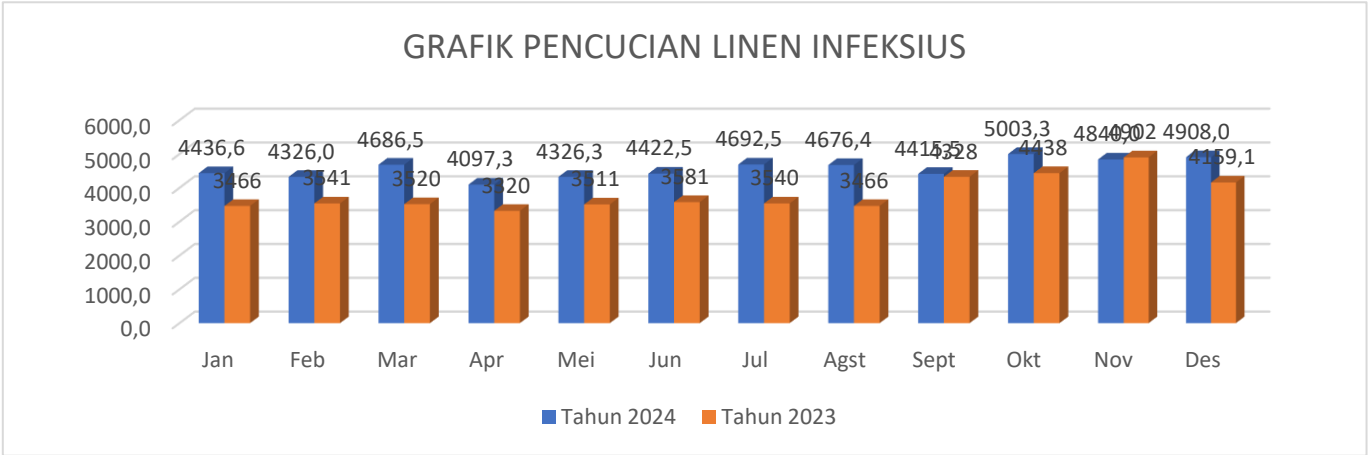
Analisis Layanan

Problem	Jumlah permintaan pemberian diit pada pasien mengalami peningkatan pada tahun 2024
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak peningkatan permintaan diit.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab peningkatan permintaan diit apa saja di 2024 Harapan :Peningkatan permintaan diit di Tahun 2024. Tindakan :Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan diit.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian permintaan diit kepada instalasi gizi.
Study	Apa yang anda pelajari ? Permintaan pemberian diit kepada instalasi gizi secara umum trennya fluktuatif pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan jumlah kunjungan pasien rawat inap yang fluktuatif
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan permintaan pemberian diit mengalami peningkatan Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 Menambah jenis pelayanan oleh instalasi gizi.

F. Laundry

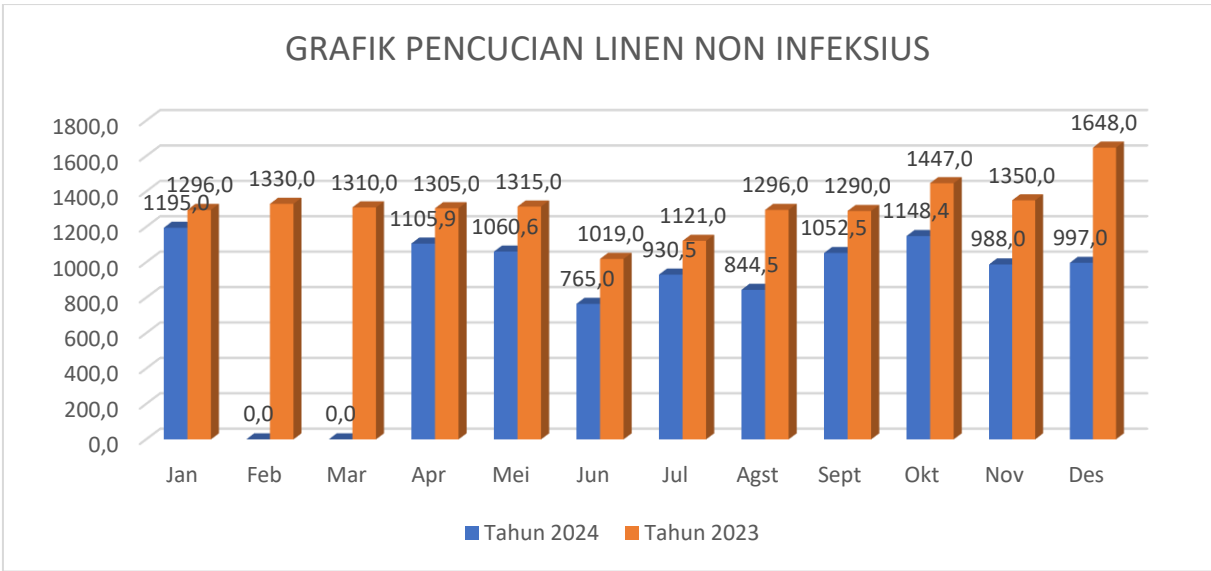
Kinerja Unit pencucian linen infeksius

Jenis Linen	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total	Rata rata
Pencucian Linen Infeksius	Tahun 2024	4436.6	4326.0	4686.5	4097.3	4326.3	4422.5	4692.5	4676.4	4415.5	5003.3	4840.0	4908.0	50394.3	4569.2
Pencucian Linen Infeksius	Tahun 2023	3466	3541	3520	3320	3511	3581	3540	3466	4328	4438	4902	4159.1	42306.1	3814.3



Kinerja Unit pencucian linen Non infeksius

jenis linen	tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total	Rata rata
Pencucian Linen Non infeksius	Tahun 2024	1195.0	866.5	1114.8	1105.9	1060.6	765.0	930.5	844.5	1052.5	1148.4	988.0	997.0	10087.4	1008.7
Pencucian Linen Non infeksius	Tahun 2023	1296.0	1330.0	1310.0	1305.0	1315.0	1019.0	1121.0	1296.0	1290.0	1447.0	1350.0	1648.0	15727.0	1310.6



Analisis Layanan

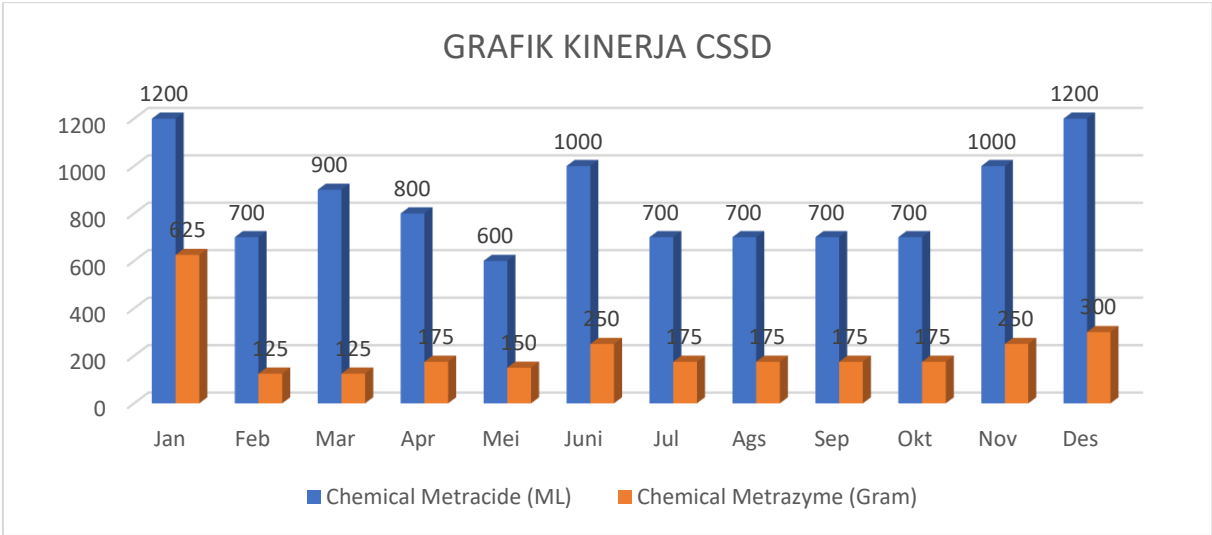
Problem	Jumlah Linen Infeksius dan Non Infeksius yang dilayani oleh unit laundry memiliki tren yang fluktuatif pada tahun 2024
Step	Melakukan evaluasi terkait dengan naik dan turunnya linen disetiap bulannya
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab terjadinya pola yang fluktuatif pada pengelolaan linen di tahun 2024 Harapan : Pengelolaan linen memiliki grafik yang stabil di tahun 2024. Tindakan : Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan linen secara teratur.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi hasil pencatatan pengelolaan linen.
Study	Apa yang anda pelajari ? Jumlah linen infeksius dan non infeksius yang masuk ke unit laundry sesuai dengan jumlah kunjungan dan pelayanan pada unit IKO. Hal ini lah yang mempengaruhi naik turunnya pengelolaan linen.
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan pengelolaan linen infeksius mengalami kenaikan dari tahun 2023 Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025

G. CSSD

Kinerja CSSD tahun 2024

No	Jenis Chemical	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

1	Chemical Metracide (ML)	1200	700	900	800	600	1000	700	700	700	700	1000	1200
2	Chemical Metrazyme (Gram)	625	125	125	175	150	250	175	175	175	175	250	300



Analisis Layanan

Problem	Jumlah chemical yang digunakan fluktuatif.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak pola yang fluktuatif pada jumlah chemical yang digunakan.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab terjadinya pola yang fluktuatif pada penggunaan chemical di tahun 2024 Harapan : Pengelolaan linen memiliki grafik yang stabil di tahun 2025 Tindakan : Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan chemical secara teratur disetiap bulannya
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi hasil pencatatan penggunaan chemical.
Study	Apa yang anda pelajari ? Jumlah penggunaan chemical di Unit CSSD dipengaruhi oleh jumlah alat yang telah digunakan oleh Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit terkait
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan penggunaan chemical mengalami kenaikan Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi penggunaan pada periode tahun 2025

3.3.2 PELAYANAN

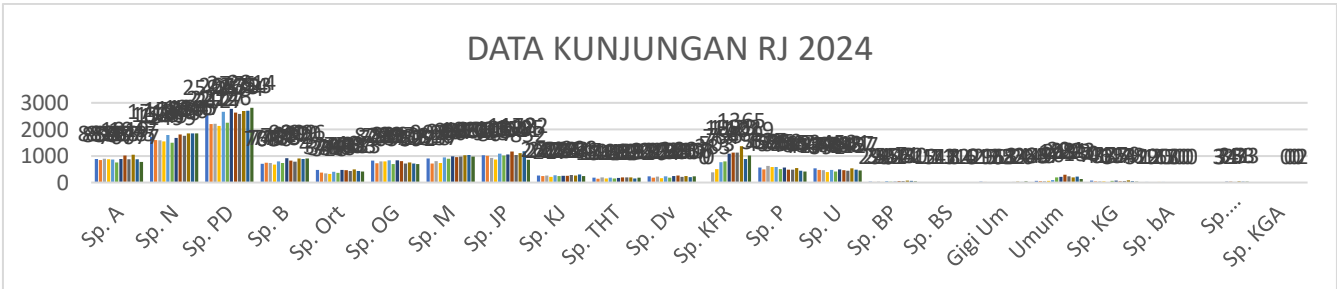
A. Instalasi Rawat Jalan

Tabel Kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024 berdasarkan kunjungan

No	Nama Poli	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des
1	Anak	800	888	850	894	876	867	760	888	1019	878	1047	875	777
2	Saraf	1000	1719	1603	1588	1549	1787	1499	1676	1810	1760	1846	1845	1847
3	Penyakit Dalam	2000	2599	2202	2212	2127	2667	2246	2775	2635	2584	2694	2703	2814
4	Bedah Umum	700	705	745	740	680	797	733	921	827	782	909	890	906
5	Orthopedi	300	477	379	341	328	408	363	476	460	438	497	433	413
6	Kandungan	500	822	728	796	799	836	695	837	810	712	759	715	692
7	Mata	500	902	718	810	737	944	900	986	957	980	1023	1038	981
8	Jantung	600	1025	1005	925	867	1082	1012	1058	1172	1041	1105	1182	852
9	Jiwa	200	260	240	262	217	274	242	254	258	283	264	303	247
10	THT	150	181	147	194	149	186	154	173	192	189	198	152	183
11	Kulit Dan Kelamin	200	230	185	228	164	236	186	239	266	210	240	207	230
12	Rehab Medik	200	0	0	383	503	764	795	1091	1123	1122	1365	889	1019
13	Paru	400	567	492	627	589	585	501	562	480	489	547	446	417
14	Urologi	400	534	478	468	391	473	411	494	463	442	531	487	457
15	Bedah Plastik	25	29	24	34	20	55	32	31	52	48	71	62	40
16	Bedah Syaraf	10	12	5	14	7	11	17	3	8	12	14	10	6
17	Gigi Umum	10	29	25	12	15	6	15	11	8	22	34	20	38
18	Umum Dan MCU	30	63	49	49	67	90	198	211	294	231	193	223	130
19	Konservasi Gigi	30	77	41	41	38	3	62	75	47	54	79	48	32
20	Bedah Anak	10	19	17	16	20	25	13	7	-	-	-	-	-
21	Gigi Anak	20	-	-	-	-	3	7	31	35	27	41	33	33
22	Penyakit Dalam SUBKGH	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		8065	11138	9933	10634	10143	12100	10834	12799	12919	12306	13460	12561	12116

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan mulai bulan Januari 2024. Kunjungan terbanyak pada Tahun 2024 terjadi pada bulan Oktober yakni sebanyak 13460. Pada bulan ini kunjungan terbanyak terdapat pada poli penyakit dalam yaitu 2694. Pada Bulan November dan Desember terjadi penurunan kunjungan poli. Penurunan ini disebabkan karena banyaknya tanggal merah pada bulan tersebut.

Grafik.Kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024



Berdasarkan grafik grafik bahwa kunjungan Rawat Jalan pada Tahun 2024 paling banyak pada poli penyakit dalam dibanding poli yang lain. Kunjungan Rawat Jalan tertinggi terjadi pada Bulan Oktober 2024.

Tabel PDSA Kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan rawat jalan
Step	Open recrutmen dokter THT dan dokter Jantung
Plan	Rencana : Membuka open rekrutmen dokter THT dan dokter Jantung Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan periode tahun 2025 Tindakan : Open rekrutmen dokter THTH dan Jantung dan di share melalui medsos Koordinasi dengan ketua kolegium jantung dan THT untuk mendapatkan dokter THTH dan jantung baru Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis, dokter jantung, dan THT
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Membuka lowongan pekerjaan dokter THT, dan jantung
Study	Apa yang anda pelajari ? Menyiapkan sloting dokter THT dan Jantung
Action	Apa yang anda pelajari ? Open rekrutmen ndokter jantung dan THT Koordinasi dengan ketua kolegium jantung dan THT untuk mendapatkan dokter THTH dan jantung baru Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis, dokter jantung, dan THT Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025

Tabel Rencana Tindak Lanjut Rawat Jalan

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Open rekrutmen ndokter jantung dan THT disebabkan melalui media social												
2	Koordinasi dengan ketua kolegium jantung dan THT untuk mendapatkan dokter THT dan jantung baru												
3	Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter												

	gigi spesialis, dokter jantung, dan THT												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

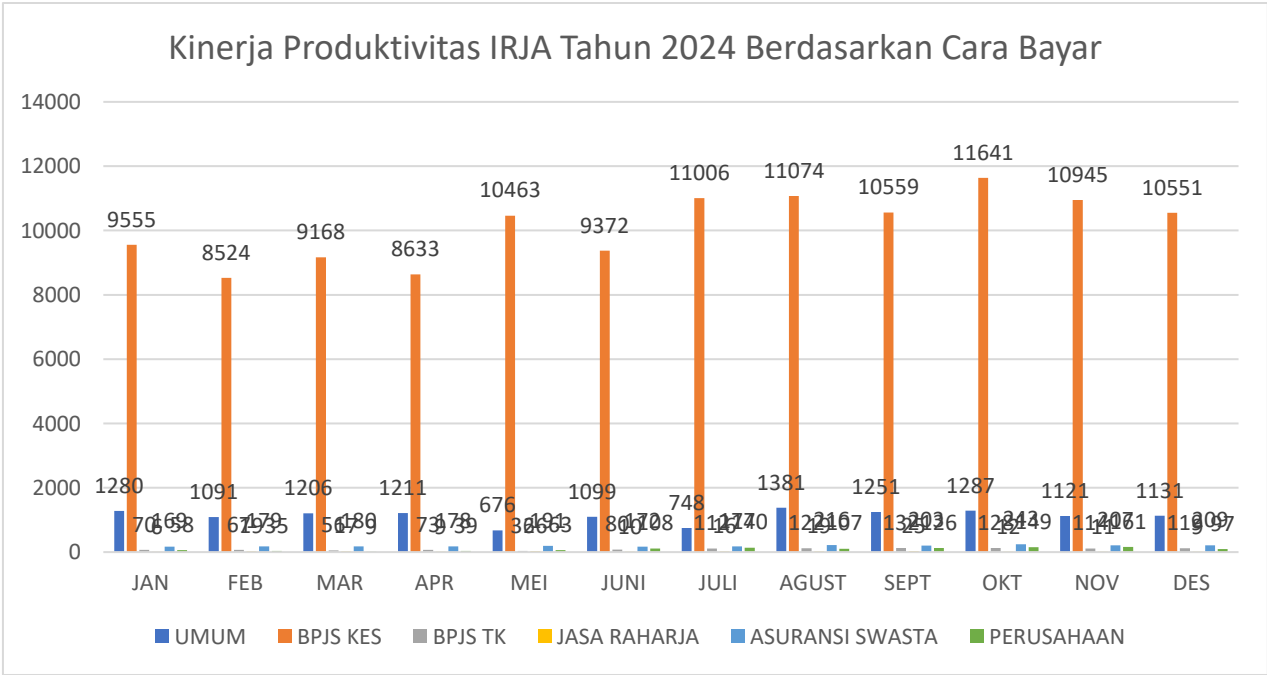
Kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024 berdasarkan cara bayar

Tabel Rawat jalan Per Cara Bayar Bulan Januari - Desember

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus t	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1	Umum	1280	1091	1206	1211	676	1099	748	1381	1251	1287	1121	1131	13482
2	BPJS Kes	9555	8524	9168	8633	10463	9372	11006	11074	10559	11641	10945	10551	121491
3	BPJS TK	70	67	56	73	36	80	112	122	132	128	114	119	1139
4	Jasa Raharja	6	19	17	9	26	10	16	19	25	12	11	9	179
5	Asuransi Swasta	169	179	180	178	191	172	177	216	203	243	207	209	2324
6	Perusahaan	58	35	9	39	63	108	140	107	126	149	161	97	1092
TOTAL		11138	9933	10634	10143	12100	10834	12799	12919	12306	13460	12561	12114	139707

Berdasarkan tabel Menunjukkan bahwa 86,1% kunjungan Irja berdasarkan cara bayar menggunakan BPJS Kesehatan, 9.5 % kunjungan menggunakan umum, 1.6% kunjungan menggunakan Asuransi Swasta , 0.7% kunjungan menggunakan BPJS TK dan perusahaan, 0.1% kunjungna menggunakan Jasa Raharja.

Grafik kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar



Analisa :

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa 86.1% cara bayar di Rs Prima Husada Sukorejo periode tahun 2024 menggunakan BPJS Kesehatan. Kunjungan paling sedikit yakni 0.1% menggunakan cara bayar Jasa Raharja

Tabel PDSA Kinerja produktivitas IRJA Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dengan menggunakan BPJS
Step	Penyediaan APM (Anjungan {Asien Mandiri) pasien BPJS Kesehatan
Plan	Rencana : Menyediakan APM untuk pasien BPJS kesehatan Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan periode tahun 2025 dengan menggunakan BPJS Kesehatan Tindakan : Koordinasi dengan programmer terkait penyediaan APM di Rs Prima Husada Sukorejo Pembuatan SP untuk mesin APM Sosialisasi kepada petugas pendaftaran dan security terkait penggunaan APM
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Menyediakan APM untuk pasien BPJS kesehatan
Study	Apa yang anda pelajari ? Berkoordinasi dengan programmer dan menentukan tempat diletakkannya mesin APM
Action	Apa yang anda pelajari ? Koordinasi dengan programmer terkait penyediaan APM di Rs Prima Husada Sukorejo Pembuatan SP untuk mesin APM Sosialisasi kepada petugas pendaftaran dan security terkait penggunaan APM Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi penggunaan APM pada periode tahun 2025

Tabel Rencana Tindak-Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Koordinasi dengan programmer terkait penyediaan APM di Rs Prima Husada Sukorejo												
2	Pembuatan SP untuk mesin APM												
3	Sosialisasi kepada petugas pendaftaran dan security terkait penggunaan APM												

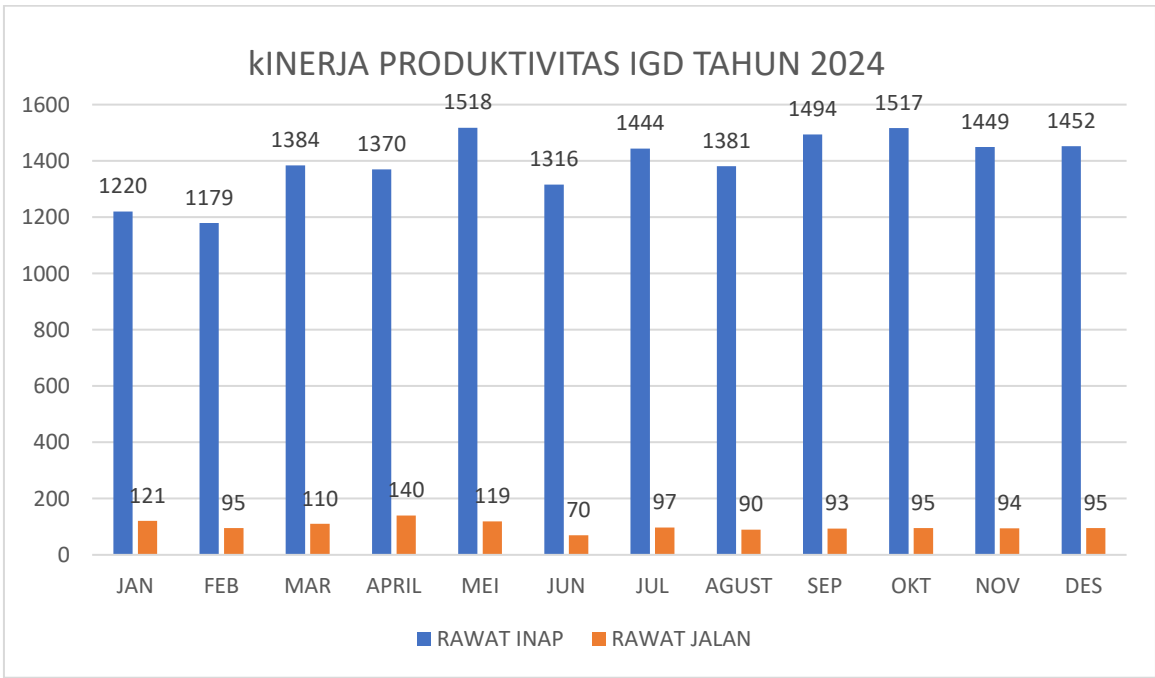
B. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel Kinerja produktivitas IGD Tahun 2024

No	Status Pasien	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rawat Inap	1220	1179	1384	1370	1518	1316	1444	1381	1494	1517	1449	1452
2	Rawat Jalan	121	95	110	140	119	70	97	90	93	95	94	95
TOTAL		1.341	1.274	1.494	1.510	1.637	1.386	1.541	1.471	1.587	1.612	1.543	1.547

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kunjungan IGD terjadi pada bulan Oktober yakni 1612 pasien dan kunjungan paling rendah terjadi pada bulan Februari yaitu 1274, Hal ini terjadi karena jumlah hari pada Bulan Februari adalah 28 hari. Mayoitas pasien datang ke IGD adalah pasien rawat inap dibanding Rawat Jalan.

Grafik Kinerja produktrivitas IGD Tahun 2024



menunjukkan bahwa kunjungan paling banyak di IGD adalah pasien rawat inap dibanding rawat jalan. Pasien IGD yang menjadi pasien rawat inap sebanyak 93 % dan 6.7% pasien IGD menjadi pasien rawat jalan.

Tabel PDSA Kinerja produktrivitas IGD Tahun 2024

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan pasien IGD
Step	Penyediaan admin khusus untuk penerimaan pasien rujukan
Plan	Rencana : Menyediakan admin khusus untuk penerimaan pasien rujukan Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan igd melalui pasien rujukan Tindakan : Koordinasi dengan SDM untuk pemenuhan tenaga admin khusus pasien rujukan

	Membuat sistem percepatan penerimaan rujukan Monev system penerimaan rujukan baru
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Menyediakan SDM untuk admin rujukan
Study	Apa yang anda pelajari ? Sistem rujukan tepat cepat
Action	Apa yang anda pelajari ? Koordinasi dengan SDM untuk pemenuhan tenaga admin khusus pasien rujukan Membuat sistem percepatan penerimaan rujukan Monev system penerimaan rujukan baru Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi sistem rujukan baru

Tabel Rencana Tindaklanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Koordinasi dengan SDM untuk pemenuhan tenaga admin khusus pasien rujukan												
2	Membuat sistem percepatan penerimaan rujukan												
3	Monev system penerimaan rujukan baru												

Tabel Kinerja produktivitas IGD

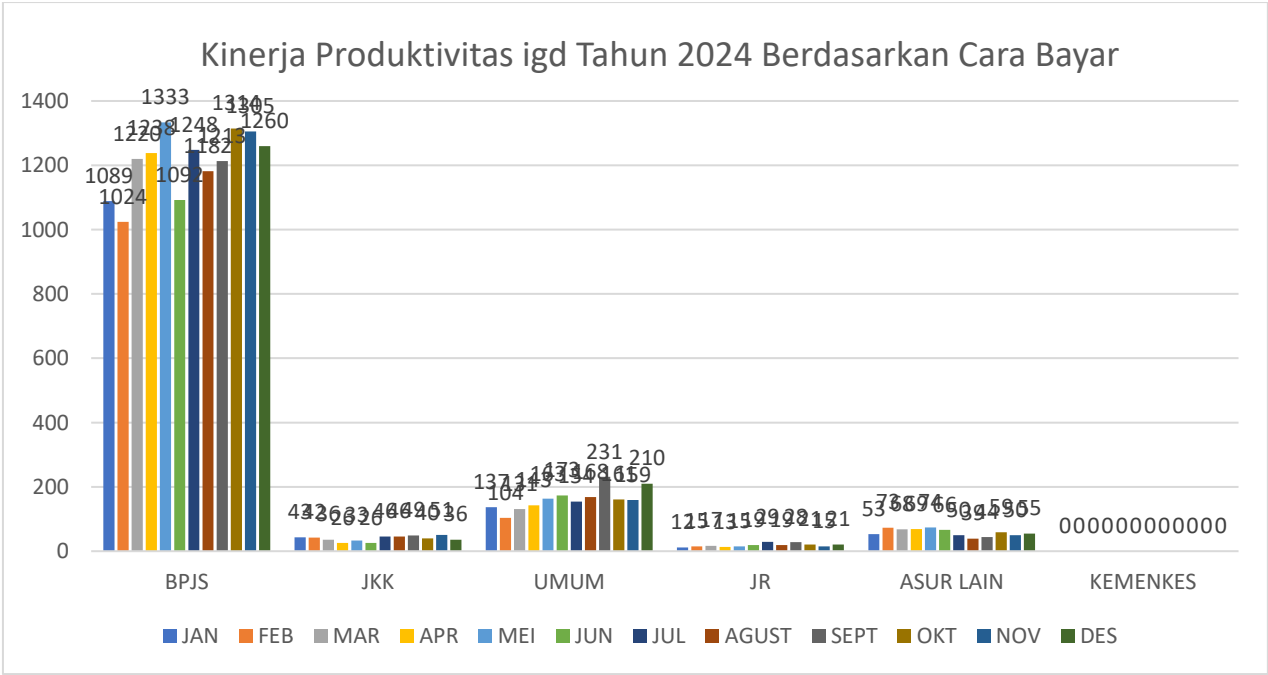
N o	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu st	Sep t	Okt	Nov	Des	Tota l
1	BPJS	1089	1024	1220	1238	1333	1092	1248	1182	1213	1314	1305	1260	14518
2	JKK	43	42	36	26	33	26	46	46	49	40	51	36	474
3	UMUM	137	104	131	143	163	173	154	168	231	161	159	210	1934
4	Jasa Raharja	12	15	17	13	15	19	29	19	28	21	15	21	224
5	Asurans i Lain	53	73	68	69	74	66	50	39	44	59	50	55	700
6	Kemenk es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL	1.334	1.258	1.472	1.489	1.618	1.376	1.527	1.454	1.565	1.595	1.580	1.582	17850
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Analisa Tabel Kinerja produktivitas IGD Tahun 2024 berdasarkan cara bayar

Berdasarkan table 3.5 Menunjukkan bahwa 81,3% kunjungan IGD berdasarkan cara bayar menggunakan BPJS Kesehatan, 10.8 % kunjungan menggunakan umum, 3.9% kunjungan menggunakan Asuransi Swasta , 2.8% kunjungan menggunakan BPJS TK, 1.21% kunjungan menggunakan Jasa Raharja.

Grafik kinerja produktivitas IGD Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar



Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa 81.3% cara bayar di Rs Prima Husada Sukorejo periode tahun 2024 menggunakan BPJS Kesehatan. Kunjungan paling sedikit yakni 1.2% menggunakan cara bayar Jasa Raharja .

Tabel PDSA Kinerja produktivitas IGD Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan pasien IGD menggunakan BPJS Kesehatan
Step	Pelaksanaan regulasi BPJS terbaru 144 penyakit di IGD lebih fleksibel
Plan	Rencana : Melaksanakan regulasi BPJS terbaru 144 penyakit di IGD lebih fleksibel Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien IGD periode tahun 2025 dengan menggunakan BPJS Kesehatan Tindakan : Rapat koordinasi dengan seluruh dokter IGD dan konsultan BPJS PT terhadap regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit Membuat surat edaran terkait pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit

	Sosialisasi kepada dokter IGD terkit pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit yang lebih fleksibel
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Membuat surat edaran terkait pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit
Study	Apa yang anda pelajari ? Berkoordinasi dengan seluruh dokter IGD dan konsultan BPJS PT terhadap regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit
Action	Apa yang anda pelajari ? Memahami regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit Rapat koordinasi dengan seluruh dokter IGD dan konsultan BPJS PT terhadap regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit Pembuatan surat edaran terkait pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit Sosialisasi kepada dokter IGD Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi kebijakan BPJS pada periode tahun 2025

Tabel Rencana Tindaklanjut IGD

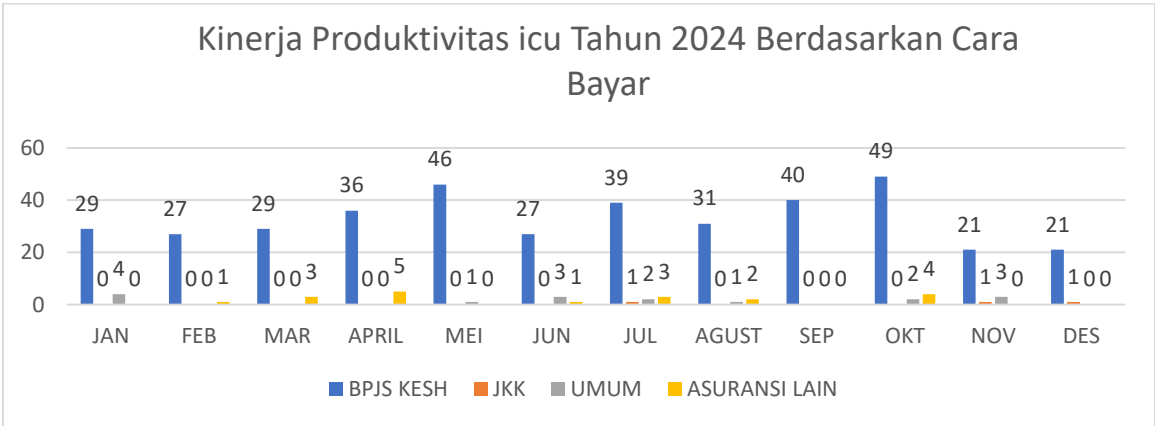
No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat koordinasi dengan seluruh dokter IGD dan konsultan BPJS PT terhadap regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit												
2	Membuat surat edaran terkait pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit												
3	Sosialisasi kepada dokter IGD terkit pelaksanaan regulasi kebijakan baru BPJS teerkait 144 penyakit yang lebih fleksibel												

C. INTENSIVE CARE UNIT

Cara Bayar	Jan	Feb	Mar et	April	Mei	Jun i	Juli	Agu st	Sep	Okt	Nov	Des
BPJS	29	27	29	36	46	27	39	31	40	49	21	21
JKK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
UMUM	4	0	0	0	1	3	2	1	0	2	3	0
Asuransi lain	0	1	3	5	0	1	3	2	0	4	0	0
Total Pasien	33	28	32	41	47	31	45	34	40	55	25	22

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah pasien terbanyak di ICU ada Bulan Mei yakni sejumlah 47 pasien. Pada tahun 2024 jumlah pasien ICU mayoritas menggunakan BPJS Kesehatan yaitu 91.2%, 4.3% menggunakan asuransi lain, 3.6% menggunakan umum, dan 0.6% menggunakan JKK.

Grafik Kinerja Produktivitas ICU berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024



Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa jumlah pasien terbanyak di ICU ada Bulan Mei yakni sejumlah 47 pasien. Pada tahun 2024 jumlah pasien ICU mayoritas menggunakan BPJS Kesehatan yaitu 91.2%, 4.3% menggunakan asuransi lain, 3.6% menggunakan umum, dan 0.6% menggunakan JKK.

Tabel PDSA Kinerja produktivitas ICU Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan pasien ICU
Step	Penambahan ruang ICU isolasi
Plan	Rencana : Penyediaan ruang isolasi ICU Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien ICU periode tahun 2025 Tindakan : Rapat koordinasi dengan PPI dan IPSRS terkait penyediaan kelengkapan ruang isolasi Revisi SK TT terkait penambahan ruang ICU isolasi

	Penyediaan APD untuk ruang isolasi ICU
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Penyediaan ruang isolasi ICU
Study	Apa yang anda pelajari ? Pelayanan pasien isolasi di ICU
Action	Apa yang anda pelajari ? Rapat koordinasi dengan PPI dan IPSRS terkait penyediaan kelengkapan ruang isolasi Revisi SK TT terkait penambahan ruang ICU isolasi Penyediaan APD untuk ruang isolasi ICU Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi penyediaan dan pelayanan pasien ICU isolasi

Tabel Rencana Tindaklanjuti

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat koordinasi dengan PPI dan IPSRS terkait penyediaan kelengkapan ruang isolasi												
2	Penyediaan APD untuk ruang isolasi ICU												
3	Penyediaan APD untuk ruang isolasi ICU												

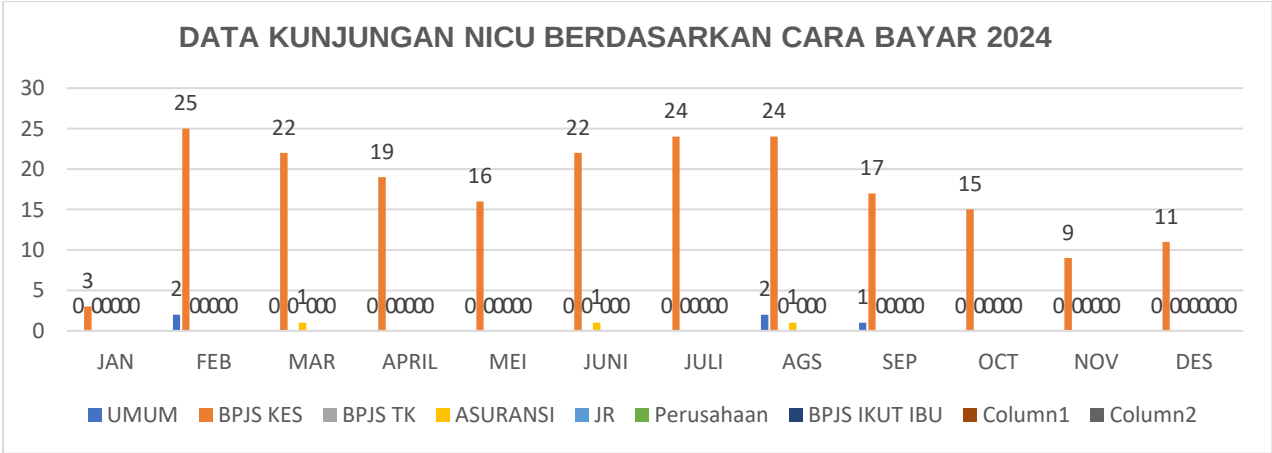
PERINATOLOGI

Tabel Kinerja Produktivitas Perina berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024

Cara BAYAR	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Prese
BPJS ikut Ibu	89	83	91	91	119	68	82	94	84	110	84	80	↑1%
JKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umum	3	1	0	2	0	2	1	0	2	3	1	0	↓1%
Asuransi Lain	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Total	92	84	91	94	121	70	83	94	87	113	85	80	2%

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa kunjungan di unit Perina paling tinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sejumlah 119 pasien . Cara bayar paling tinggi di unit Perina dimana masih menggunakan BPJS Kesehatan karena BPJS yang masih bergabung dengan Ibu.

Grafik Kinerja Produktivitas Perina berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa kunjungan di unit Perina paling tinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sejumlah 119 pasien . Cara bayar paling tinggi di unit Perina dimana masih menggunakan BPJS Kesehatan karena BPJS yang masih bergabung dengan Ibu.

Tabel PDSA Kinerja produktivitas Perina Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan kunjungan yang disebabkan oleh maternitas yang berpengaruh pada kunjungan Maternitas
Step	Peningkatan mutu SDM pada perawat perina dengan mengikuti pelatihan
Plan	Rencana : Peningkatan mutu Perawat Perina Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien pada Perina periode tahun 2025 Tindakan : Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan perawat Perina Rapat koordinasi dengan PKRS terkait promosi foto pada bayi baru lahir
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Peningkatan mutu SDM dengan mengikuti pelatihan
Study	Apa yang anda pelajari ? Peningkatan mutu perawat perina dalam mengikuti pelatihan
Action	Apa yang anda pelajari ? Rapat koordinasi dengan SDM terkait staff yang akan berangkat pelatihan Rapat koordinasi dengan PKRS terkait dengan promosi foto pada bayi baru lahir Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait staff yang akan memberangkatkan pelatihan

Tabel 3.5 Rencana Tindak-Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat koordinasi dengan SDM terkait staff yang akan berangkat pelatihan												
2	Rapat koordinasi dengan PKRS terkait dengan promosi foto pada bayi baru lahir												

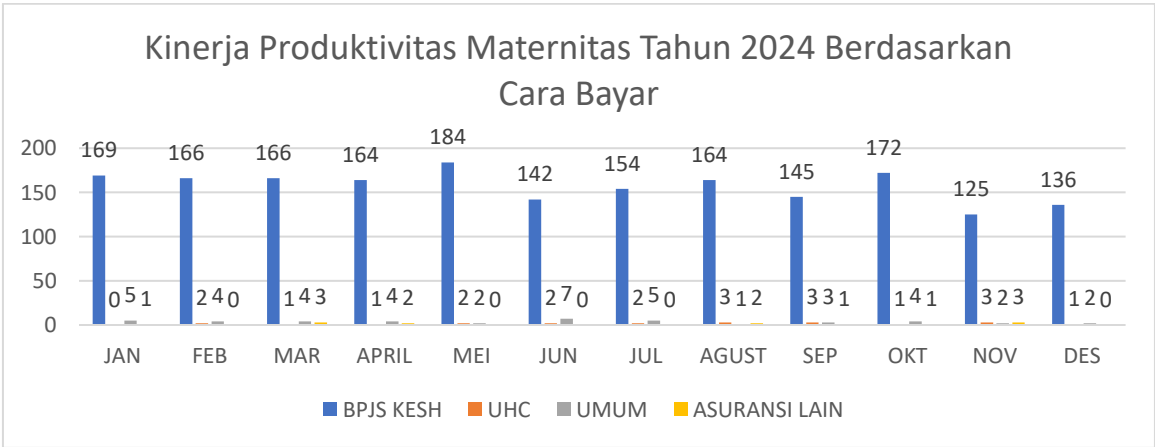
D. MATERNITAS

Tabel Kinerja Produktivitas Maternitas berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024

Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
BPJS	169	166	166	164	184	142	154	164	145	172	125	136
UHC	0	2	1	1	2	2	2	3	3	1	3	1
UMUM	5	4	4	4	2	7	5	1	3	4	2	2
Asuransi lain	1	0	3	2	0	0	0	2	1	1	3	0
Total Pasien	175	172	174	171	188	151	162	170	152	152	133	138

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kunjungan di unit maternitas paling tinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sejumlah 188 pasien. Cara bayar pasien di unit Maternitas 97.3% menggunakan BPJS Kesehatan, 2.2% menggunakan Umum, 1.08% menggunakan UHC dan 0.67% menggunakan Asuransi lain.

Grafik Kinerja Produktivitas Maternitas berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa 97.3 % pasien unit Maternitas adalah pasien dengan menggunakan BPJS kesehatan. Peningkatan jumlah kunjungan di Unit tersebut terjadi pada Bulan Mei 2024 sejumlah 184 pasien pada Bulan ini merupakan bulan dengan kunjungan paling banyak sepanjang tahun 2024.

Tabel PDSA Kinerja produktivitas Maternitas Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan pasien Maternitas
Step	Peningkatan mutu SDM bidan Maternitas dengan dril emergency serta mengundang jejaring
Plan	Rencana :

	Peningkatan mutu SDM bidan Maternitas Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien Maternitas periode tahun 2025 Tindakan : Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan maternitas terkait pelaksanaan dril emergency dengan mengundang jejaring Rapat koordinasi dengan PKRS untuk dimasukkan di media social terkait pelaksanaan dril emergency dengan jejaring
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Peningkatan mutu SDM bidan Maternitas dengan dril emergency serta mengundang jejaring
Study	Apa yang anda pelajari ? Peningkatan mutu SDM dan peningkatan rujukan dari jejaring
Action	Apa yang anda pelajari ? Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan maternitas terkait pelaksanaan dril emergency dengan mengundang jejaring Rapat koordinasi dengan PKRS untuk dimasukkan di media social terkait pelaksanaan dril emergency dengan jejaring Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dril emergency dan peningkatan rujukan dari jejaring

Tabel Rencana Tindaklanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan maternitas terkait pelaksanaan dril emergency dengan mengundang jejaring												
2	Rapat koordinasi dengan PKRS untuk dimasukkan di media social terkait pelaksanaan dril emergency dengan jejaring												

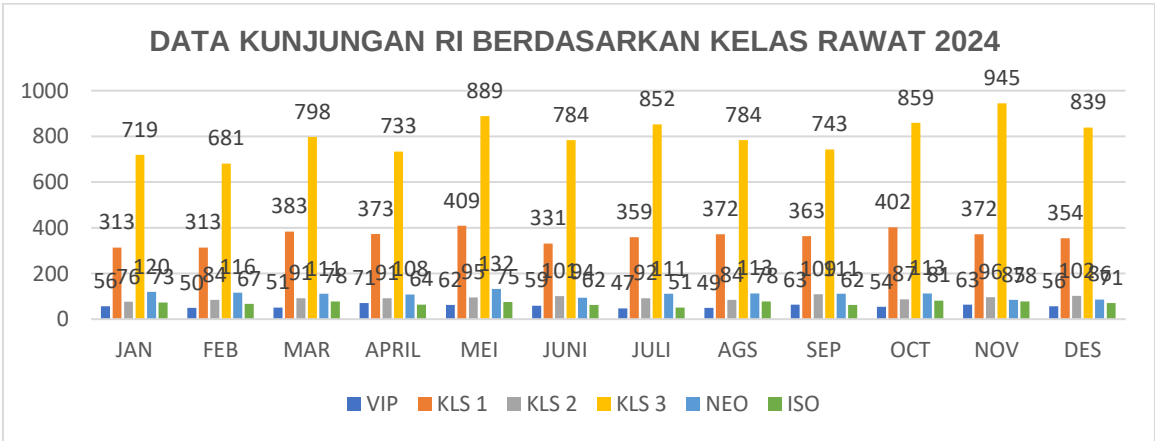
E. INSTALASI RAWAT INAP

Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar Januari-Desember 2024

Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
VIP	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Kelas 1	313	76	719	120	73	313	76	719	120	73	313	76
Kelas 2	313	84	681	116	67	313	84	681	116	67	313	84
Kelas 3	383	91	798	111	78	383	91	798	111	78	383	91
Neonatalogi	373	91	733	108	64	373	91	733	108	64	373	91
Isolasi	409	95	889	132	75	409	95	889	132	75	409	95

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan jumlah pasien di bulan Desember hampir pada setiap kelas rawat dibanding dengan bulan November . Jumlah Pasien Rawat Inap pada bulan November ini sejumlah 1822 pasien dan pada bulan Desember sebanyak 1669 pasien. Adanya penurunan jumlah kunjungan di Rawat Inap di pengaruhi kenaikan kunjungan permintaan hak kelas 1 dan 3 dipengaruhi dengan muncul nya berita acaranya BPJS yang terkait ketentuan 144 diagnose yang dapat ditangani di FKTP.

Grafik Kinerja Produktivitas Rawat Inap berdasarkan Cara Bayar Tahun 2024



Berdasarkan Jumlah kunjunga pasien Rawat Inap masih di dominasi pada kunjungan pasien menggunakan BPJS kelas 3 tertinggi pada pada bulan November 945 dan terjadi penurunan terjadi pada bulan Desember dengan 839 karena pada bulan Desember terjadi aturan baru sehingga berdampak pada jumlah kunjungan .

Tabel Perbandingan BOR tahun 2023 dan 2024

TAHUN	2023	2024
BOR	76,14	75,86 %
ALOS	3,62	3,35 hari
TOI	0,80	0,75 hari
BTO	108.25	118,51 kali
NDR	9,66	9.01 %
GDR	19,38	18,41

Tabel PDSA Kinerja produktivitas Rawat Inap Januari - DesemberTahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi peningkatan pelayanan dengan jumlah peningkatan pasien
Step	Peningkatan mutu SDM staff untuk pelayanan kualitas staff
Plan	Rencana : Peningkatan mutu SDM staff rawat inap Harapan : Peningkatan jumlah pasien di rawat inap untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap Tindakan : Rapat koordinasi dengan SDM terkait pelatihan untuk kualitas pelayanan di rawat inap
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Peningkatan mutu SDM staff di rawat inap
Study	Apa yang anda pelajari ? Peningkatan mutu SDM staff ?
Action	Apa yang anda pelajari ? Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat untuk mengikuti pelatihan kualitas pelayanan di rawat inap Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait pelatihan pelayanan staff di rawat inap

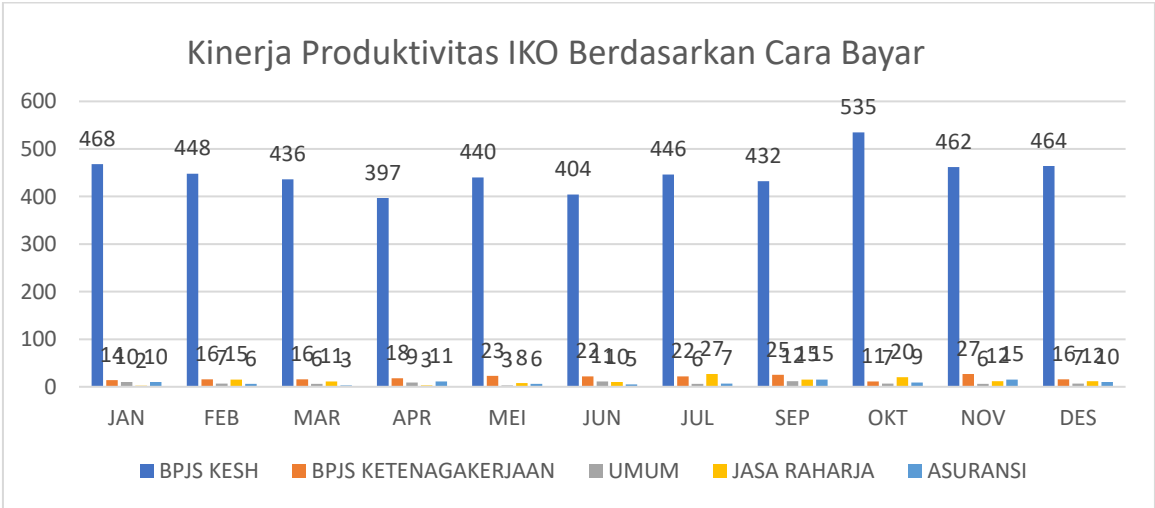
F. INSTALASI KAMAR OPERASI

Tabel Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Cara Bayar

Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Juni	Juli	Ag t	Sep	Okt	Nov	Des
BPJS Kesehatan	468	448	436	397	440	404	446	431	432	535	462	464
BPJS Ketenagakerjaan	14	16	16	18	23	22	22	18	25	11	27	16
Umum	10	7	6	9	3	11	6	12	12	7	6	7
Jasa Raharja	2	15	11	3	8	10	27	17	15	20	12	12
Asuransi lain	10	6	3	11	6	5	7	4	15	9	15	10
Total Pasien	504	492	472	438	480	452	508	482	499	582	522	509

Berdasarkan tabel 3.14 diatas menunjukkan bahwa berdasarkan cara bayar di Unit IKO 90.2% menggunakan cara bayar BPJS Kesehatan, 3.86% menggunakan BPJS ketenagakerjaan, 2.5% menggunakan Jasaraharja, 1.7% menggunakan asuransi lain, dan 1.6% menggunakan umum. Peningkatan jumlah kunujungan pasien operasi terjadi pada bulan Oktober sejumlah 582 pasien operasi.

Grafik Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Cara Bayar



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa berdasarkan cara bayar di Unit IKO 90.2% menggunakan cara bayar BPJS Kesehatan, 3.86% menggunakan BPJS ketenagakerjaan, 2.5% menggunakan Jasaraharja, 1.7% menggunakan asuransi lain, dan 1.6% menggunakan umum. Peningkatan jumlah kunujungan pasien operasi terjadi pada bulan Oktober sejumlah 582 pasien operasi

Tabel PDSA Kinerja produktivitas IKO Tahun 2024 Berdasarkan Cara Bayar

Problem	Potensi penambahan jumlah pasien operasi
Step	Meningkatkan mutu pelayanan kamar operasi melalui
Plan	Rencana : Peningkatan mutu SDM bidan Maternitas Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien Maternitas periode tahun 2025 Tindakan : Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan maternitas terkait pelaksanan dril emergency dengan mengundang jejaring Rapat koordinasi dengan PKRS untuk dimasukkan di media social terkait pelaksanaan dril emergency dengan jejaring
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Peningkatan mutu SDM bidan Maternitas dengan dril emergency serta mengundang jejaring
Study	Apa yang anda pelajari ?

	Peningkatan mutu SDM dan peningkatan rujukan dari jejaring
Action	Apa yang anda pelajari ? Rapat koordinasi dengan SDM bagian diklat dan maternitas terkait pelaksanaan dril emergency dengan mengundang jejaring Rapat koordinasi dengan PKRS untuk dimasukkan di media social terkait pelaksanaan dril emergency dengan jejaring Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dril emergency dan peningkatan rujukan dari jejaring

Tabel LAPORAN TERBANYAK

Tabel APS Pasien Bulan Januari- Desember 2024

No	UNIT	BULAN JANUARI-DESEMBER												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	IGD	5	6	5	5	6	6	5	6	5	6	3	3	61
2	IRNA 2A	8	3	5	8	6	8	3	5	2	1	4	0	53
3	IRNA 2B	7	4	7	5	7	7	3	8	7	3	3	7	68
4	IRNA 3A	8	1	1	2	2	3	1	1	3	1	1	3	31
5	IRNA 3B	-	2	2	3	3	3	3	2	4	3	4	4	33
6	ICU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NICU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		28	16	20	23	24	17	15	22	21	14	15	17	246

Tabel RUJUK Pasien Bulan Januar- Desember 2024

No	Unit	Bulan JANUARI-DESEMBER												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	IGD	25	16	17	11	17	14	30	24	22	23	33	26	248
2	IRNA 2A	24	19	20	17	23	21	24	15	17	13	14	9	219
3	IRNA 2B	24	16	28	20	22	28	20	20	12	15	15	24	244
4	IRNA 3A	2	1	1	2	2	3	1	1	1	2	6	0	22
5	IRNA 3B	-	7	7	7	7	7	11	8	3	5	6	7	75
6	ICU	-	4	8	5	7	6	5	6	7	7	5	5	65
7	NICU	6	5	7	7	4	5	4	5	6	6	4	6	65
8	MTS	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
TOTAL		82	68	88	83	83	84	95	79	70	71	83	77	942

Tabel MENINGGAL Pasien Bulan Januari - Desember 2024

No	Unit	Bulan JANUARI-DESEMBER												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	IGD	22	19	19	17	11	8	14	16	16	14	11	19	186

2	IRNA 2A	4	6	8	8	6	4	6	2	7	8	6	14	79
3	IRNA 2B	10	5	11	10	12	7	10	7	5	13	5	10	105
4	IRNA 3A	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4
5	IRNA 3B	-	4	4	3	2	2	2	3	3	4	4	5	36
6	ICU	14	12	12	7	18	15	16	15	14	13	13	14	163
7	NICU	-	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	7
8	MTS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL		50	47	57	47	49	38	48	43	43	52	40	62	581

3.3.3. UMUM dan KEUANGAN

A. Humas Marketing

Data Pelayanan MCU pihak eksternal

Pencapaian MCU Pihak Eksternal pada Tahun 2024 di RSPHS

No	Bulan	Jumlah Pasien
1	Januari	104
2	Februari	290
3	Maret	65
4	April	540
5	Mei	104
6	Juni	146
7	Juli	116
8	Agustus	174
9	September	115
10	Oktober	117
11	November	140
12	Desember	1.386
	JUMLAH	3297
	RATA-RATA	274.75
Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up Meningkat di bulan desember dari PT ISS yaitu sejumlah 1034 peserta. Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan Mempromosikan program MCU Mereview tarif/biaya pemeriksaan Meningkatkan pelayanan MCU Do Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Memperbaiki alur pelayanan MCU Study Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Peningkatan pelayanan MCU mempengaruhi loyalitas perusahaan Action Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan Memperbaiki alur pelayanan MCU dengan membuat SPO Mereview ulasan kepuasan terkait pelayanan MCU		

Progres IKS Baru di RSPHS Pada Bulan Desember Tahun 2024

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Cheiljedang	Review pihak eksternal	Masih proses review
2	PT Duta Beton	Review pihak eksternal	Masih proses review

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
3	Klinik Kesira Warablas	Review pihak eksternal (November-Desember)	Masih proses review
4	PT Widatra Bhakti	Review pihak eksternal	Masih proses review
5.	PT Antarmitra Sembada	Evaluasi Penandatanganan Direktur Utama (Laporan Nov)	Rapat Evaluasi belum terlaksana
6.	PKM Pandaan	Review pihak eksternal	Masih proses review
7.	RS Mitra Sehat Medika	TTD PT DPM TTD Pihak Eksternal (Laporan November)	Direktur Utama perjalanan LN
8.	PT Prodia Lab	Review pihak eksternal	Masih proses review
9.	Asuransi Manulife	TTD PT DPM (Tidak ada di laporan November)	Direktur Utama perjalanan LN
10.	PT Aneka Tuna Indoneisa	Evaluasi (Tidak ada di laporan November)	Rapat Evaluasi belum terlaksana

Progres IKS Baru di RSPHS Pada Bulan Desember Tahun 2024

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Antarmitra Sembada	Evaluasi Penandatanganan Direktur Utama (Laporan November)	Rapat Evaluasi belum terlaksana
2	PT Aneka Tuna Indonesia	Evaluasi	Rapat Evaluasi belum terlaksana
3	PT Asuransi Multi Artha guna	Evaluasi (Oktober) Finalisasi Draft (November) Proses Review Pihak External (Desember)	Rapat Evaluasi belum terlaksana
4	PT Equity Life Indonesia	Evaluasi (Oktober) Revisi (November) Revisi External (Desember)	Rapat Evaluasi belum terlaksana
5.	PT Jasa Raharja	Proses TTD Pihak Eksternal	Masih proses
6.	PT Allianz	Proses TTD Pihak Eksternal (Mulai Oktober-November)	Masih proses
7.	PT Prodia Wdyahusada	Proses review pihak eksternal (Mulai Oktober-November, Desember)	Masih proses review
8.	RS Mitra Sehat Medika	Proses TTD pihak eksternal (Mulai Oktober-November sama)	Masih proses
9.	PT Gwenelda prima Makmur	PT DPM (Mulai Oktober-November)	Masih proses review
10.	RS Graha Sehat Medika	Pengajuan ke PT (Mulai Oktober dan November)	Masih proses review
11.	PT Cheiljedang	Review Pihak Eksternal	Pihak Eksternal

12.	Lippo General Insurance	Evaluasi (Oktober) Revisi (November) Proses Review Pihak Eksternal (Desember)	Rapat Evaluasi belum terlaksana
13	PT Asuransi Reliance	Proses Cetak Pihak Eksternal (November)	Masih proses pihak eksternal

Jumlah Kunjungan Pasien ke RSPHS Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pasien			
		Rawat Inap	Rawat Jalan	IGD	Rata-rata px RI/ hari
Januari	1555	12304	1328	50,16	396,9
Februari	1508	11041	1252	52	380,72
Maret	1714	12099	1464	55,29	390,29
April	1627	11439	1489	54,23	381,3
Mei	1891	13628	1611	61	439,61
Juni	1615	12206	1365	53,83	406,86
Juli	1719	14091	1516	55,45	454,54
Agustus	1668	14344	1448	53,8	462,70
September	1632	13631	1563	54,4	454,36
Oktober	1820	13460	1611	58,7	434,2
November	1819	14155	1591	60,63	471,83
Desember	1663	13712	1595	53,64	442,32
Total	20.231	156.110	17.833	50,76	426,3

Analisis : Berdasarkan data diatas Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan Agustus 2024 adalah spesialis anak sejumlah 399 pasien diikuti dengan spesialis penyakit dalam sejumlah 397 pasien. Kunjungan pasien rawat jalan di agustus ke September 2024 mengalami penurunan, dan untuk semua poli yang mengalami kenaikan tertinggi poli penyakit dalam sebesar 4.13%, tetapi ada poli yang mengalami penurunan yaitu bedah plastic, bedah syaraf, gigi umum dan bedah anak Review hasil kunjungan pasien. Plan Melakukan promosi kepada faskes pertama,Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik Mandiri dan instansi Perusahaan. Membuat digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS Melakukan marketing internal kepada pasien, keluarga pasien dengan metode penyuluhan kesehatan berbasis promosi Do Meningkatkan kinerja Humas Marketing ke FKTP, BPM/DPM, dan instansi Perusahaan dalam mempromosikan dan melayani para perujuk. Melakukan digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS Kolaborasi dengan kepala bidang terkait dalam pengkondisian DPJP, pelayanan, dan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Study Keterlambatan DPJP dalam melakukan praktek akan mempengaruhi kinerja pelayanan di Rumah Sakit. Ketidakhadiran dokter di Rumah Sakit akan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien. Pelayanan yang kurang baik akan memunculkan komplain dari pasien. Action Perbaiki pelayanan di IGD dan rawat inap

Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg IGD
Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perujuk
Meminta Umpan Balik dari perujuk atas Pelayanan yang telah diterima
Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perusahaan

Pencapaian hasil Kinerja Pasien Baru (OB) yang berkunjung ke RSPHS pada Tahun 2024

NO	POLI	Jumlah Pasien Baru	Jumlah Pasien Lama	Jumlah Pasien Klinik
1	Instalasi Gawat Darurat	12950	5077	18027
2	Klinik Anak	3004	7619	10623
3	Klinik Bedah	2537	7098	9635
4	Klinik Bedah Anak	57	60	117
5	Klinik Bedah Plastik	187	311	498
6	Klinik Bedah Syaraf	86	33	119
7	Klinik Gigi Anak	61	154	215
8	Klinik Gigi Umum	110	127	237
9	Klinik Jantung	1584	10743	12327
10	Klinik Jiwa	372	2733	3105
11	Klinik Kandungan	2649	6553	9202
12	Klinik Komplementer	1	1	2
13	Klinik Konservasi Gigi	248	349	597
14	Klinik Kulit dan Kelamin	865	1756	2621
15	Klinik Mata	1752	9224	10976
16	Klinik Orthopedi	1217	3796	5013
17	Klinik Paru	1257	5045	6302
18	Klinik Penyakit Dalam	4519	25741	30260
19	Klinik Penyakit Dalam Sub KGH	3	0	3
20	Klinik Rehab Medik	809	8244	9053
21	Klinik Syaraf	2254	18275	20529
22	Klinik THT	994	1106	2100
23	Klinik Umum	1497	299	1796
24	Klinik Urologi	1258	4371	5629
TOTAL		40271	118715	158986
Rata – rata Pasien per Bulan		3355,917	9892,917	13248,83

Pencapaian hasil Kinerja Pasien Rawat Inap yang berkunjung ke RSPHS Pada Tahun 2024

NO	POLI	Jumlah Pasien Baru	Jumlah Pasien Lama	Jumlah Pasien Klinik
1	Klinik Anak	3513	1455	4968
2	Klinik Bedah	1814	551	2365
3	Klinik Bedah Plastik	165	43	208
4	Klinik Bedah Syaraf	74	9	83
5	Klinik Jantung	431	244	675
6	Klinik Jiwa	1	2	3
7	Klinik Kandungan	1508	474	1982
8	Klinik Kulit dan Kelamin	16	8	24
9	Klinik Mata	131	100	231
10	Klinik Orthopedi	557	263	820
11	Klinik Paru	881	436	1317
12	Klinik Penyakit Dalam	3238	1324	4562

13	Klinik Syaraf	1353	468	1821
14	Klinik THT	120	48	168
15	Klinik Urologi	561	451	1012
TOTAL		14363	5876	20239
Rata – rata Pasien per Bulan		1196,9	489,7	1686,6

Pencapaian hasil Kinerja Pasien yang berkunjung ke RSPHS Pada Tahun 2024

NO	POLI	Jumlah Pasien Baru	Jumlah Pasien Lama	Jumlah Pasien Klinik
1	Instalasi Gawat Darurat	12950	5077	18027
2	Klinik Anak	6517	9074	15591
3	Klinik Bedah	4351	7649	12000
4	Klinik Bedah Anak	57	60	117
5	Klinik Bedah Plastik	352	354	706
6	Klinik Bedah Syaraf	160	42	202
7	Klinik Gigi Anak	61	154	215
8	Klinik Gigi Umum	110	127	237
9	Klinik Jantung	2015	10987	13002
10	Klinik Jiwa	373	2735	3108
11	Klinik Kandungan	4157	7027	11184
12	Klinik Komplementer	1	1	2
13	Klinik Konservasi Gigi	248	349	597
14	Klinik Kulit dan Kelamin	881	1764	2645
15	Klinik Mata	1883	9324	11207
16	Klinik Orthopedi	1774	4059	5833
17	Klinik Paru	2138	5481	7619
18	Klinik Penyakit Dalam	7757	27065	34822
19	Klinik Penyakit Dalam Sub KGH	3	0	3
20	Klinik Rehab Medik	809	8244	9053
21	Klinik Syaraf	3607	18743	22350
22	Klinik THT	1114	1154	2268
23	Klinik Umum	1497	299	1796
24	Klinik Urologi	1819	4822	6641
TOTAL		54634	124591	179225
Rata – rata Pasien per Bulan		4552,8	10382,6	14935,4

Analisis :

Kunjungan pasien pada tahun 2024 terbanyak di poli penyakit dalam yaitu sebanyak 22350 pasien, dan diikuti oleh IGD sebanyak 18027 pasien.

RTL : Promosi terkait layanan poli subspesialis KGH kepada perusahaan, FKTP dan juga media sosial

B. ASURANSI CENTER

Angka Kepatuhan Penyetoran Berkas ke Verif

Bulan	Indikator	IRNA 2A	IRNA 2B	IRNA 3A	IRNA 3B	Mater	Perina	ICU	IGD
Mei 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	6.65 %	17.53 %	2.01 %	5.43%	0%	0%	2.70%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	1.61 %	0.90 %	1.61%	1.81%	1.60%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.38%	1.35%	0%	2.90%	0%	4.07%	27.03%	3.70%
Juni 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	4.03%	21.59%	1.67%	4.12%	1.89%	1.10%	15.00%	6.25%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	2.02%	2.57%	2.51%	1.23%	0%	1.10%	5.0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	2.31%	2.57%	0.42%	0.82%	0.63%	10.99%	30.0%	6.25%
Juli 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	4.35%	19.33%	1.56%	9.19%	0%	0.89%	3.33%	7.69%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	1.90%	1.29%	2.72%	0.37%	0.59%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.36%	1.29%	0.39%	1.47%	0%	4.46%	43.33%	19.23%
Agustus 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	7.37%	17.05%	3.78%	5.18%	0%	0%	0%	11.76%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	5.26%	1.27%	1.68%	1.20%	0.62%	0%	9.09%	11.76%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	0.79%	1.02%	0%	0.40%	0%	17.70%	45.45%	8.82%
September 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	5.97%	24.38%	2.36%	11.81%	0.65%	0%	8%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	6.82%	3.60%	1.18%	1.97%	0%	0%	0%	23.08%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.70%	0.55%	0%	2.36%	0%	13.46%	48%	0%
Oktober 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	9.64%	22.08%	3.91%	13.90%	0.55%	0%	3.13%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	2.41%	1.49%	1.17%	0.34%	0%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	2.17%	2.48%	0%	3.05%	0%	11.50%	37.50%	46.67%
November 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	6.97%	21.60%	4.17%	8.19%	0%	0%	0%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	0.75%	0%	1.14%	0.36%	0%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.74%	0.53%	0%	1.42%	0%	4.42%	29.41%	10.34%
Desember 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	9.07%	23.14%	1.61%	8.44%	0%	0%	0%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	1.42%	0.80%	0.80%	0.42%	0%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.42%	17.02	0%	3.8%	1.55%	8.57%	91.67%	32%
Rata-Rata Mei-Desember	Ketidaklengkapan Resume (%)	6.76	20.83	2.63	8.28	0.39	0.25	4.02	3.21
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	2.77	1.59	1.60	0.96	0.35	0.13	1.76	4.35
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.61	3.35	0.10	2.02	0.27	9.40	44.05	15.88

1. Hasil tindak lanjut terkait data kepatuhan penyetoran berkas ke verifikator yaitu berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis terkait angka kepatuhan dari kepatuhan penyetoran berkas untuk penunjang klain baik ke BPJS maupun kepada pihak Asurans

C. PIPP-MOD-MPP

Angka Kepuasan Pasien

Berdasarkan data kepuasan pasien pada Oktober 2024, didapatkan bahwa dari 129 pengaduan terdapat 14 orang yang tidak puas (10.85%) dan 115 pengaduan (89.15%) menyatakan puas.

Bulan / 2024	Total Pengaduan	Pengaduan yang Puas	Pengaduan yang Tidak Puas
September	129 / 100%	115 / 89.15%	14 / 10.85%
Oktober	94 / 100%	92 / 97.87%	2 / 2.13%
November	78 / 100%	68 / 87.18%	10 / 12.82%
Desember	58 / 100%	47 / 81.03%	11 / 18.97%
Total September-Desember	359 / 100%	322 / 89.69%	37 / 10.31
Rata-Rata / Bulan	89.75	80.5	9.25

Saran Pengaduan November 2024 :

No	Rincian Pengaduan	Unit
1	Pelayanan di ruang IGD dan waktu tanggungan masih cukup lama	IGD
2	Kamar mandi harusnya ada untuk menanggalkan pakaian, jika tersumbat harus segera diperbaiki, diberi cermin	Umum
3	Kebersihan tempat tidur pasien harus diperbaiki	CS
4	Ada pemeriksaan tengah malam, mungkin operan jaga, saat pasien lagi pulas-pulasnya tidur, jadi terbangun	IRNA 3A
5	Petugas parkir pelayanannya sangat buruk, enggan menolong saat kesusahan mengeluarkan motor dari tempat parkir, tidak mambantu mengarahkan ke area parkir yang masih kosong. Kerjanya terkesan ogah-ogahan, cuma mau ambil biaya oarkirnya saja. Jangan sampai citra rumah sakit jatuh hanya karena pelayanan petugas parkir yang sangat buruk. Kalau suruh rating dari 1-4, saya kasih -1(minus satu)	Parkir
6	Sudah bilang pilek tp obat d kasih vitamin aja	DPJP Anak
7	Semua perawat rawat inap anak harap diperbaiki kompetensi untuk infus dan pengambilan sampel darah bayi dan ba lita	IRNA 3A
8	Mood Swing Perawat yg jaga malam, Kamar mandi sudah tau kotor keset basah dan bau tidak diganti	IRNA 2A, CS
9	Ruangannya agak panas karena suhu AC nya tinggi	IPSRS
10	Mohon dibedakan pembayaran parkir mobil inap pasien rawat inap dan pasien umum	Parkir

Saran Pengaduan Desember 2024 :

No	Rincian Pengaduan	Unit
1	Parkir diperlebar atau diperluas karena sering kehabisan tempat	Umum

No	Rincian Pengaduan	Unit
2	Pengering kaki dari toilet kamar harus sering diganti	CS IRNA 3A
3	Dalam pengambilan darah dan pemasangan infus untuk bayi tolong petugas yg sudah ahli saja, jangan coba"	IRNA 3A
4	Kasir agak lama	Kasir
5	Awal masuk rawat inap Kamar mandi nya kotor	CS Maternitas
6	Minta tolong untuk pasien yang baru masuk IGD jangan terlalu lama masuk k kamar dengan alasan masih menunggu komunikasi dengan dokter karena pasien juga butuh untuk segera istirahat. Jika lama d IGD sangat menakutkan mendengar ada yang kecelakaan bahkan bertaruh nyawa d ruang IGD itu membuat pasien takut. Tidak jarang beberapa pasien harus menunggu d IGD hingga 6-8 jam karena menunggu kontak dg dokter. Ini mengakibatkan pasien juga keluarga yang menunggu lelah dan tertekan. Mohon maaf semoga aspirasi saya ini Bu dapat menjadikan koreksi dan saya yakin rsph semakin baik dalam melayani pasien. Sejauh ini saya puas akan pelayanan kesehatan rsph seluruh dokter perawat dan tenaga lain sangat baik etos kerjanya bagus semoga rsph semakin berprestasi dan menjadi RS yang dibanggakan oleh masyarakat	IGD
7	Reponsipnya lebih ditingkatkan lagi	IRNA 3B
8	Pelayanan melalui chat wa yang lama kalau membalas hampir 3 jam baru d blas	CSO
9	Ada perawat yang kurang halus saat mencabut kateter pasien	IRNA 3B
10	Proses perpindahan kamar dari IGD ke kamar perawatan Pasien yg di nyatakan rawat inap prosesnya terlalu lama	IGD
11	Sandaran bed kamar anggrek 3.3 tidak dapat di naikan. Shower kamar mandi 1 skrup nya terlepas.	IRNA 3A

D. IT/SIMRS

Angka Pemeliharaan Sarana IT
Dari 146 PC yang ada, terdapat pemeliharaan PC oleh Tim IT

Bulan / 2024	Pemeliharaan		Jumlah Pemeliharaan
	A	W	
Juni	5	3	8 / 146 = 5.48%
Juli	12	10	22 / 146 = 15.06%
Agustus	7	21	28 / 146 = 19.18 %
September	11	14	25 / 146 = 17.12%
Oktober	11	5	16 / 146 = 10.96 %
November	9	9	18 / 146 = 12.33%
Desember	6	0	6 /146 = 4.11%
Total Juni- Desember	61	62	123
Rata-Rata/Bulan	17.57 pemeliharaan / bulan		

Angka Perbaikan Sarana IT
Data Kerusakan Sarana IT di Gudang IT
Pada Bulan Juni – Desember terdapat 123 pemeliharaan PC di semua unit di RS.

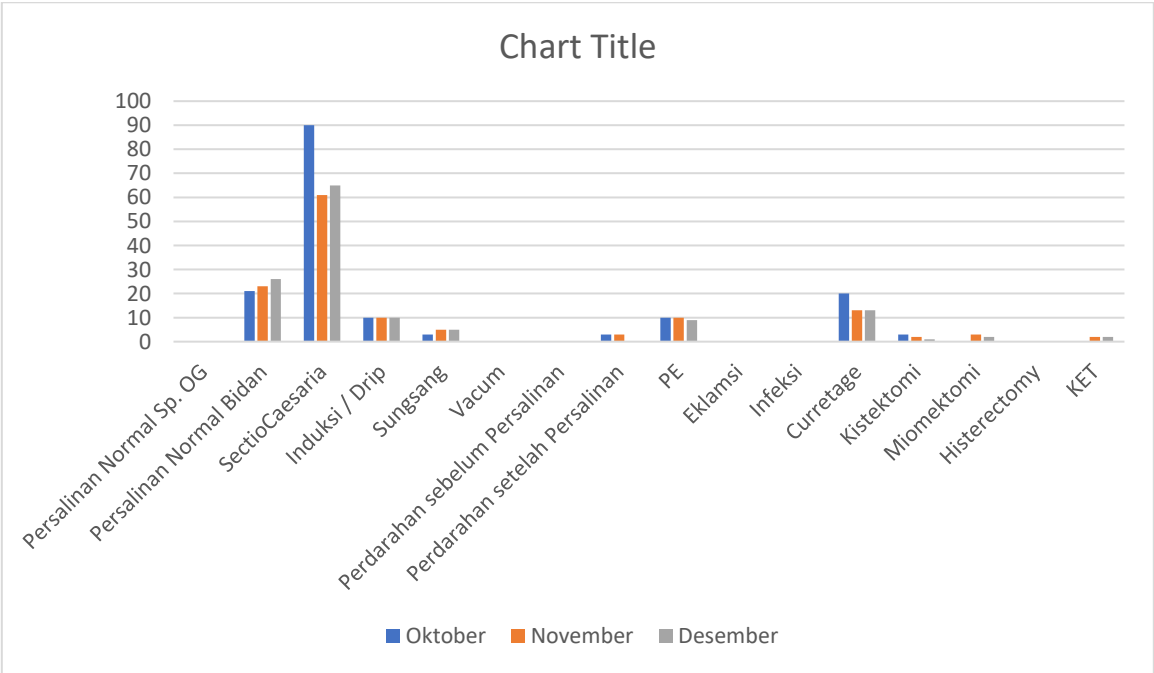
3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)

A. PONEK
Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	0	0	0
	b. Persalinan Normal Bidan	21	23	26
	c. <i>SectioCaesaria</i>	90	61	65
2	Persalinan dengan tindakan			
	a. Induksi / Drip	10	10	10
	b. Sungsang	3	5	5
	c. Vacum	0	0	0
3	Persalinan dengan Komplikasi			
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	3	0
	c. PE	10	10	9
	e. Eklamsi	0	0	0
	f. Infeksi	0	0	0

4	Kebidanan :			
	a. Curretage	20	13	13
	b. Kistektomi	3	2	1
	c. Miomektomi	0	3	2
	d. Histerectomy	0	0	0
	e. KET	0	2	2

GRAFIK 1JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN MATERNAL DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA BULAN DESEMBER 2024



Evaluasi :

Persalinan normal dengan Sp.Og untuk bulan desember tidak ada sama sekali

Untuk jumlah persalinan dengan bidan bulan ini naik dari bulan sebelumnya dikarenakan jumlah persalinan bulan ini naik.

Untuk kasus persalinan sc dalam bulan ini naik dari bulan kemarin, karena rujukan emergency dari IGD dan lodingan dari poli juga naik

Persalinan dengan induksi untuk bulan ini jumlahnya sama dengan bulan kemarin . Untuk induksi sendiri di berikan kalau benar-benar ada indikasi yang sesuai dengan kriteri dilakukan induksi supaya pasiennya aman

Kasus persalinan sungsang bulan ini lebih sama dengan bulan kemarin, dan rata-rata adalah pasien dari rujukan.

Tidak ada kasus persalinan dengan tindakan vacum

Kasus perdarahan sebelum persalinan untuk bulan ini tidak ada.

Kasus perdarahan setelah melahirkan pada bulan desember tidak ada

Pasien dengan Preeklampsia bulan ini sama dengan bulan sebelumnya dan kebanyakan pasien rujukan dari bidan atau klinik.

Infeksi pada bulan ini tidak ada.

Tindakan curretage bulan ini sama dari bulan sebelumnya dengan diagnose terbanyak AUB

Tindakan miomektomi pada bulan ini turun dari bulan sebelumnya

Tindakan kistektomi pada bulan ini ada 1 pasien dan pasien tersebut datang dari poli dengan keluhan awal nyari perut

Kasus histerektomi untuk bulan ini tidak ada

Kasus KET pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut:

Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit untuk melakukan promosi dan mengenalkan dokter-dokter obgyn yang ada di prima husada sukorejo

Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya kehamilan di trimester 1, 2 dan 3 kehamilan.

Mengadakan kelas ibu hamil dan memberi materi dan edukasi terkait kehamilan dan persalinan

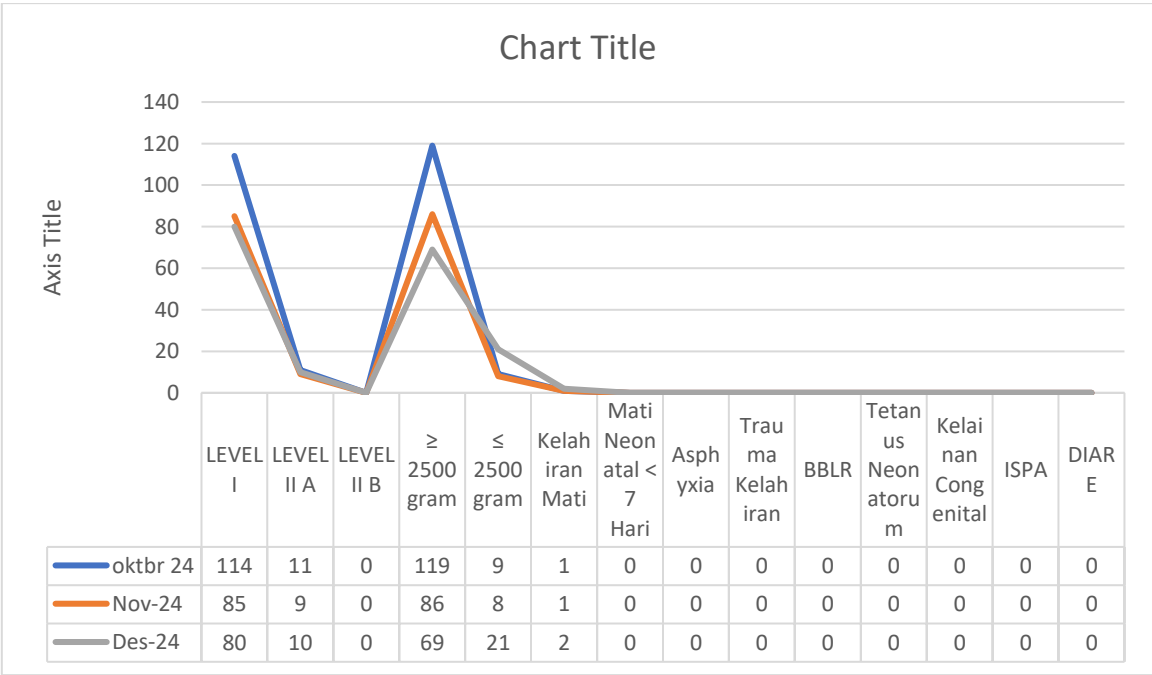
Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024
1	Jumlah pasien neonatal			
	d. Level 1	114	85	80
	e. Level II A	11	9	10
	f. Level II B	0	0	0
2	Bayi Lahir Hidup			
	c. ≥ 2500 gram	119	86	69
	d. ≤ 2500 gram	9	8	21
3	Kematian neonatal			
	c. Kelahiran Mati	1	0	2
	d. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	0
4	Sebab Kematian Neonatal			
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	0	0	0
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0

	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

GRAFIK 2

JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN NEONATAL DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN DESEMBER 2024



Evaluasi

Untuk perawatan bayi level 1 bulan ini turun dari bulan sebelumnya karena jumlah persalinan bulan ini juga mengalami penurunan

Perawatan bayi level II A naik dari bulan sebelumnya dan bayi hanya membutuhkan incubator saja. Hal ini di karenakan rata-rata bayi sehat dan Sebagian besar rawat gabung.

Perawatan bayi level II B tidak ada

Terdapat penurunan jumlah bayi dengan BB lebih dari 2500 karena banyak bayi yang lahir dengan keadaan yang sehat

Untuk bulan ini jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan ≤ 2500 gram jumlahnya naik dari bulan sebelumnya.Hal ini dikarenakan banyaknya kasus partus prematurus imminens (PPI) pada ibu hamil dan ada dengan gemeli 2 pasien.

Untuk kelahiran mati bulan ini ada 2 kasus dengan pasien tiba-tiba datang ke IGD dengan

Untuk kematian neonatal < 7 hari pada bulan ini tidak ada

Bayi yang meninggal dengan sebab lain untuk bulan ini tidak ada.

Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.

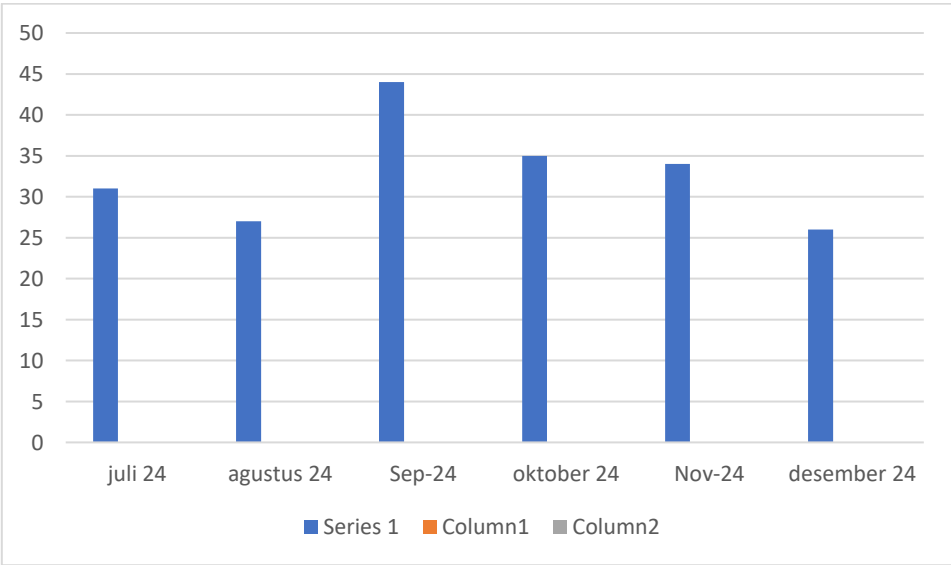
Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi dan persiapan persalinan agar tidak terjadi infeksi neonatus karena ketuban mekoni

B. HIV/AIDS

Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024
1	Permintaan Test HIV/AIDS	35	34	26

GRAFIK 1 JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Pada bulan Juli 2024 terdapat 31 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 27 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan September 2024 terdapat 44 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 35 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan November 2024 terdapat 34 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Desember 2024 terdapat 26 permintaan testing HIV/AIDS.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- 4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
- 5. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
- 6. Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Juli 2024	Agustus 2024	September 2024
1	Poli IPD	1	0	2
2	Poli Paru	0	3	5
3	Poli Obgyn	3	1	0
4	IGD	5	10	20
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	2	2	1
7	Instalasi Rawat Inap	14	9	13
8	Poli syaraf	0	0	0
9	Poli orthopedic	0	0	0
10	Laboratorium	6	2	3
11	Poli anak	0	0	0

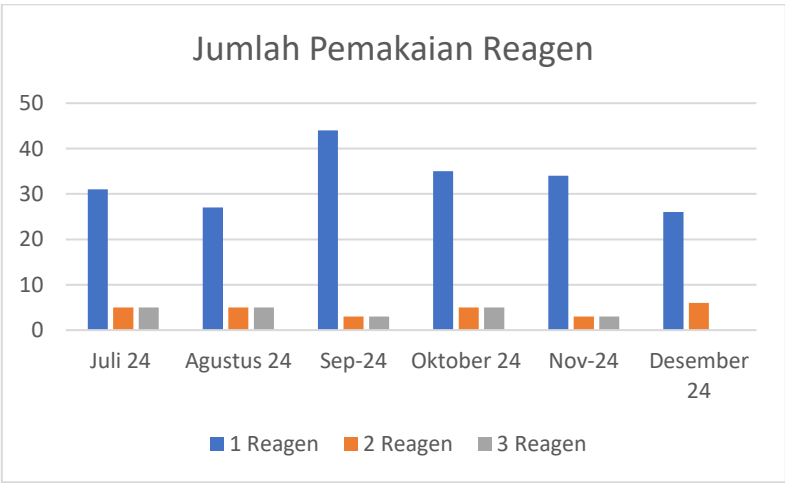
No	URAIAN	BULAN		
		Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
1	Poli IPD	2	1	2
2	Poli Paru	2	2	0
3	Poli Obgyn	0	2	0
4	IGD	11	12	10
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	1	2	3
7	Instalasi Rawat Inap	18	12	10
8	Poli syaraf	0	0	0
9	Poli orthopedic	0	0	0
10	Laboratorium	1	3	1
11	Poli anak	0	0	0

JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

No	URAIAN	BULAN		
		Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
1	1 Reagen	35	34	26
2	2 Reagen	5	3	6
3	3 Reagen	5	3	6

GRAFIK 4 JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

BULAN DESEMBER 2024



Analisis jumlah pemakaian reagen:

Pada bulan Juli 2024 terdapat 31 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 5 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 5 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 27 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 5 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 5 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan september 2024 terdapat 44 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 3 pasien menggunakan jenis reagen 2, dan 3 pasien menggunakan pemeriksaan reagen 3. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 35 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 5 pasien menggunakan jenis reagen 2, dan 5 pasien menggunakan pemeriksaan reagen 3. Pada bulan November 2024 terdapat 34 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 3 pasien menggunakan jenis reagen 2, dan 3 pasien menggunakan pemeriksaan reagen 3. Pada bulan Desember 2024 terdapat 26 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 6 pasien menggunakan jenis reagen 2, dan 6 pasien menggunakan pemeriksaan reagen 3.

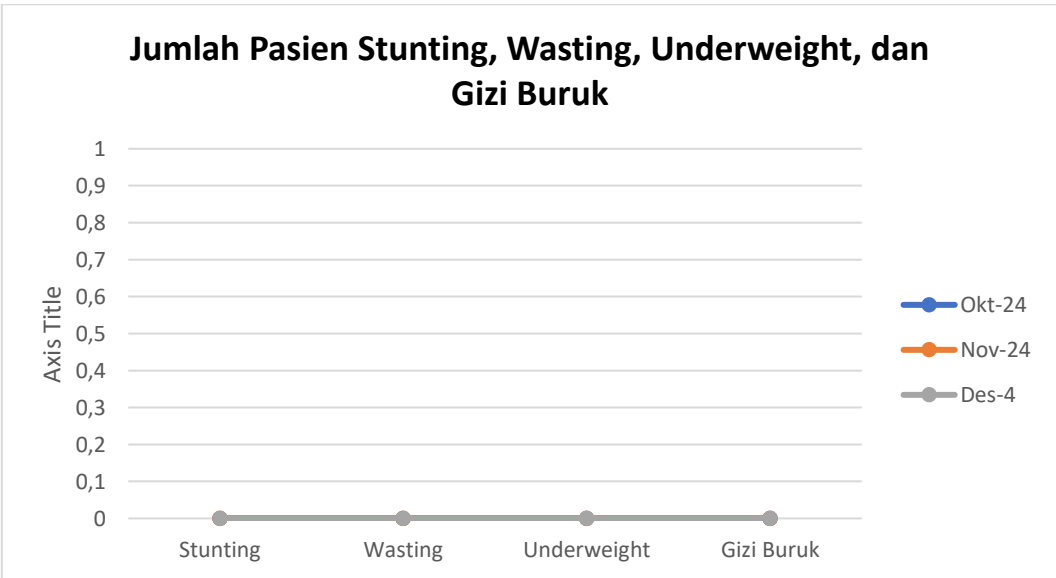
Rencana tindak lanjut:

1. Pemeriksaan dilakukan secara serial dengan menggunakan 3 jenis reagen yang berbeda sesuai dengan pedoman nasional.
2. Penyimpanan reagen HIV dilakukan sesuai dengan instruksi yang tertera dilembar informasi dan digunakan sebelum tanggal kedaluwarsa.

G. STUNTING dan WASTING

Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk Rawat Inap

No	Masalah Gizi	BULAN		
		Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
1	Stunting	0	0	0
2	Wasting	0	0	0
3	Underweight	0	0	0
4	Gizi Buruk	0	0	0



Analisis Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Pada bulan Oktober, November, Desember tidak terdapat pasien anak yang mengalami masalah gizi.

Rencana Tindak Lanjut Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Petugas medis melakukan pemantauan asupan makan pasien, perubahan berat badan selama rawat inap dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi fisik klinis pasien.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staff, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting

Kegiatan	Oktober	November	Desember
Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting	Pemberian edukasi tentang pemberian ASI Eksklusif untuk Ibu Menyusui di ruang maternitas sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	Pemberian edukasi tentang diet yang tepat selama kehamilan di kelas ibu hamil DOLINA sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	Pemberian edukasi tentang diet yang tepat selama kehamilan di kelas ibu hamil DOLINA sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting

Analisis :

Penyuluhan diadakan di ruang maternitas yang ditujukan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia anak 2 tahun sebagai salah satu upaya pencegahan penanganan stunting

Rencana Tindak Lanjut :

Sosialisasi tentang stunting dan wasting perlu terus ditingkatkan dengan disertai pemberian contoh makanan untuk ibu menyusui, ibu hamil dan MPASI untuk baduta. Pemberian sosialisasi menggunakan media edukasi yang menarik sehingga kelompok sasaran dapat memahami materi yang akan disampaikan.

Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Lokasi	Oktober	November	Desember
Program 1000 HPK	Penyuluhan terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan	Poli Anak dan Poli Kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
Suplementasi asam folat pada ibu hamil	Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Kelas Bumil Dolina Poli Kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil yang terindikasi KEK	Kelas Bumil Dolina	Belum dilakukan penyuluhan	Telah dilakukan penyuluhan	Telah dilakukan penyuluhan
Promosi dan Konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Poli Kandungan dan Poli Anak, Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita Pembagian PMBA	-	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan PMT bagi balita yang memiliki



			kurang di wilayah rumah sakit	kurang di wilayah rumah sakit	berat badan kurang di wilayah rumah sakit
Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu
Pemberian Makanan Tambahan Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Rumah Sakit	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Oktober selama rawat inap.	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan November selama rawat inap.	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Desember selama rawat inap.
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing

	pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hami		pada ibu hamil	pada ibu hamil	pada ibu hamil
--	---	--	----------------	----------------	----------------

Analisis :

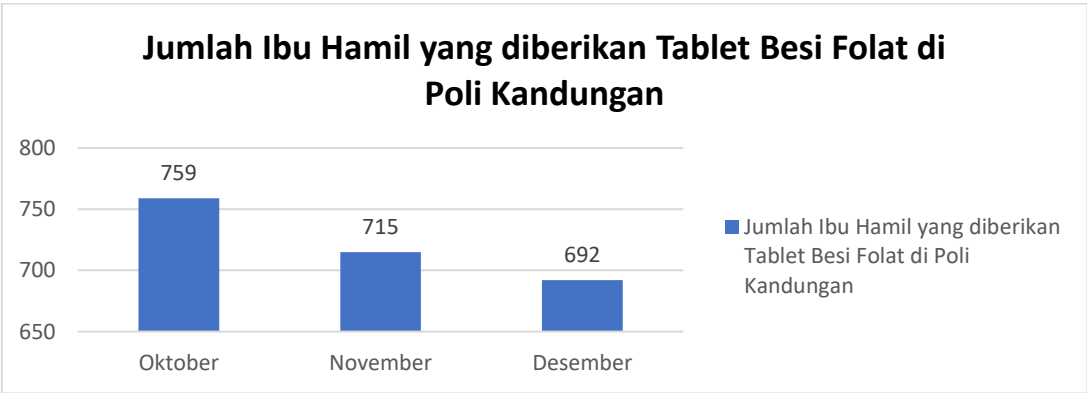
Sebagian besar intervensi gizi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi pada intervensi gizi spesifik berupa pemberian taburia dan vitamin A pada balita, pemberian obat cacing pada ibu hamil masih belum dilakukan karena ketresediaan taburia, obat cacing, dan vitamin A terdapat pada faskes 1. Pemberian edukasi kepada ibu hamil di kelas Ibu Hamil DOLINA dilaksanakan sebagai Upaya pencegahan stunting sejak dini.

Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit.

Pemberian Tablet Besi Folat bagi Ibu Hamil

Bulan	Oktober	November	Desember
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli Kandungan	759	715	692



Analisis:

Seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan di poli kandungan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah mendapat tablet tambah darah. Terutama pada kehamilan trimester pertama. Jumlah distribusi tablet besi folat pada bulan Oktober 759, November 715, dan Desember 692.

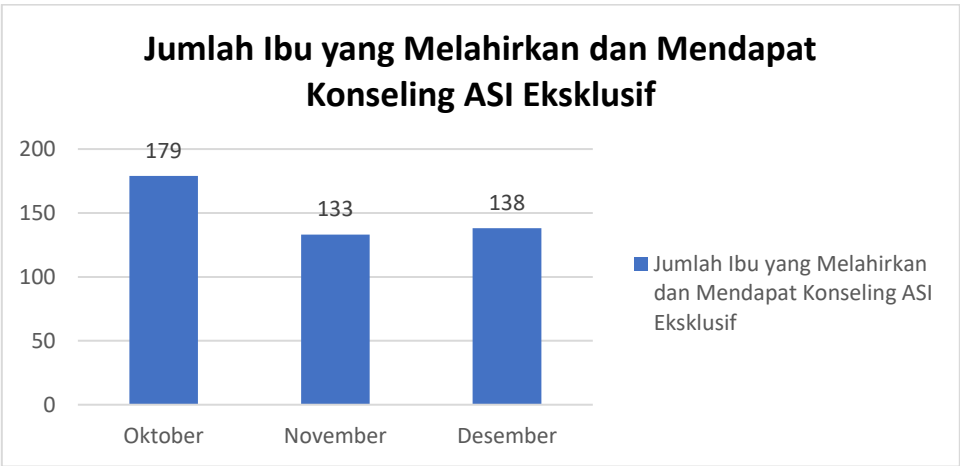
Rencana Tindak Lanjut:

Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut

Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

Angka Capaian Ibu yang melakukan IMD dan Mendapat Konseling ASI Eksklusif

Bulan	Oktober	November	Desember
Jumlah Ibu yang melahirkan dan mendapat konseling ASI Eksklusif	179	133	138



Analisis :

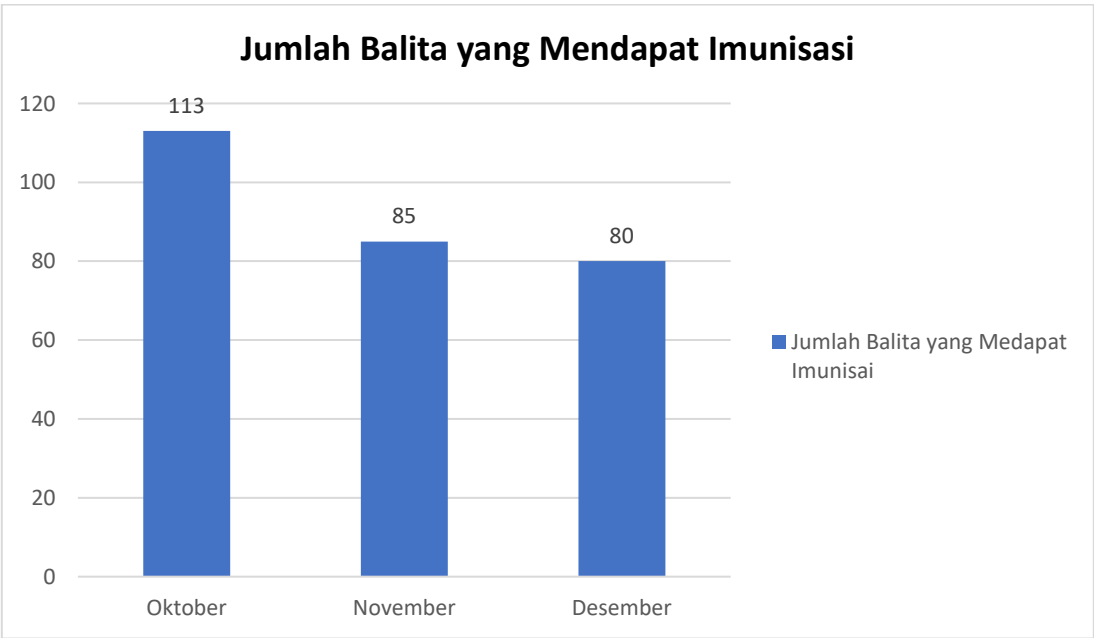
100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif.

Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi

Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

Bulan	Oktober	November	Desember
Jumlah balita yang mendapat imunisasi	113	85	80



Analisis:

Balita yang datang untuk melakukan imunisasi adalah balita yang telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya imunisasi oleh dokter anak dan perawat pada saat kunjungan sebelumnya. Balita yang datang telah mendapat imunisasi lengkap meliputi imunisasi BCG, DPT 1-3, POLIO 1-3, IPV, dan Campak yang merupakan imunisasi lengkap dasar yang wajib diberikan kepada setiap balita.

Rencana Tindak Lanjut :

Memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi kepada keluarga pasien agar jumlah balita yang datang untuk imunisasi di poli anak terus meningkat untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian imunisasi lengkap sebagai upaya pencegahan stunting.

Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu dan Bayi

Mendukung pemeliharaan ruangan (pojok laktasi) agar memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu menyusui.

Analisis :

Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Rencana Tindak Lanjut :

Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

Pelayanan Rujukan Pasien Stunting dan Wasting

Bulan	Oktober	November	Desember
Jumlah baduta stunting dan wasting yang dirujuk di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Oktober sampai Desember tidak ada pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi

Rencana Tindak Lanjut :

Tetap memberikan asuhan gizi yang baik pada pasien dengan masalah gizi Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk serta melakukan monitoring dan evaluasi asupan makan pasien.

H. PKBRS

Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Alat Kontrasepsi	Jumlah Alat Kontrasepsi	Jumlah Alat Kontrasepsi
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	MOW	12	9	6
2.	IUD NOVA T	3	1	-
3.	IUD BKKBN (Andalan)	22	12	16
4.	IMPLANT BKKBN	8	1	-
5.	SUNTIK KB 3 BULAN BKKBN	-	-	-

6.	PIL BKKBN	-	-	-
7.	KONDOM BKKBN	-	-	-

II. Evaluasi :

1. Peserta MOW meningkat dari bulan oktober dan mengalami penurunan sebesar 1,6 % pada bulan desember
2. Peserta KB IUD Andalan menurun 0,003 dari jumlah 22 pasien menjadi 16 pasien
3. Peserta KB Implan menurun pada bulan juni sebesar 90 % menjadi 1 peserta
4. Peserta KB IUD nova T mengalami penurunan peserta dari oktober yakni menurun sebanyak 7 pasien

III. Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien yang akan bersalin dan pasca keguguran tentang pelayanan KB
5. mengadakan safari KB yang bekerja sama dengan BKKBN cabang pasuruan

IV. Rencana Tindak Lanjut :

Dengan adanya persiapan jika ada keterlambatan stok alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN maka Rumah sakit menyediakan obat kontrasepsi dari pihak swasta demi mencegah terjadinya kekosongan stok alat dan obat kontrasepsi

B. PELAYANAN KB PASCA SALIN DAN PASCA KEGUGURAN

I. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pasien	Jumlah Pasien
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	MOW	0	0	0
2.	IUD	0	0	0
3.	IMPLAN	0	0	0

II. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pasien	Jumlah Pasien
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	MOW	0	0	0
2.	IUD	0	0	0

IV. Evaluasi :

Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada triwulan kedua mengalami penurunan pada satu bulan terakhir. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada triwulan kedua mengalami penurunan dari triwulan pertama .

V. Analisis :

Penurunan jumlah sasaran pada triwulan kedua meningkat kemungkinan dikarenakan sasaran Kb sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan. Capaian

pelayanan KB pasca keguguran menurun dikarenakan peserta belum mengetahui pentingnya KB pasca keguguran.

VI. Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. melakukan safari KB secara menyeluruh dan mewajibkan bagi peserta mengikuti KB

3.4. KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE MFK DAN K3

3.4.1. Fasilitas Kesehatan

Peralatan Medis (Pemeliharaan, Perbaikan, Kalibrasi dan Recall Alkes)

Tabel Data Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Januari	305	112/ 36.72%	9/ 2.95%	267/ 87.54%	0	-
Februari	314	110/ 35.03%	10 / 3.18%	267/ 85.03%	0	Penambahan Alkes : Suction Pump, ENT Chair, Pasien Monitor (3); ENT treatment Unit ; Laringoskopi (3)
Maret	317	183 / 57.72 %	6 / 1.89%	267/ 84.22%	0	Penambahan 3 unit Alkes : Pasien Monitor (3A-2 unit) Nebulizer (3B-1 unit)
April	318	234 / 73.58 %	8 / 2.15 %	267/ 83.96%	0	Mikroskop Lab
Mei	328	104 / 31.70 %	4 / 1.22 %	267/ 81.40%	0	Infuse Pump (5 buah) Pasien Monitor (2 buah) Suction Pump (2 buah) USG (1 buah)
Juni	334	88 / 26.35 %	7 / 2.10%	267/ 79.94%	0	Infus Pump Maternitas (1 buah) Pasien Monitor IGD (4 buah) ECG IRNA 3B (1 buah)
Juli	334	309 / 92.51%	5 / 1.49%	267/ 79.94%	0	0
Agustus	334	249 / 74.55%	6 / 1.79%	267/ 79.94%	0	0

Bulan	Jumla h Alkes	Jumlah Pemeliharaa an Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentas e	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentas e	Jumla h Recall Alkes	Keterangan
Septembe r	342	38 pemeliharaan / 11.11% 302 kalibrasi / 88.30%	4 / 1.17%	293/ 85.67%	0	0
Oktober	351	141 / 40.17%	2 / 0.57%	293 /83.47%	0	0
November	351	71 / 20.23%	0 / 0%	293/ 85.67%	0	0
Desember	356	149 / 41.85%	5 / 1.40%	293/ 82.30%	0	0
Total	3984	1788	66	293/ 82.30%	0	0
Rata-Rata /Bulan	332	149 / 44.87	5.5	293/ 82.30%	0	0

Pada Januari 2024, dilakukan 2 uji fungsi alat yaitu USG Convex dan Linear di Poli Urologi dan Spirometry di IRNA 2A.

3.4.2. Gedung & bangunan

Konstruksi dan Renovasi dilakukan dengan Pembangunan Gedung IGD baru dan IKO 4 serta RO (Reserve Osmosis)

3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tabel Hasil Pelaksanaan MCU SDM per Unit di RSPHS

No.	Unit	JML staf di MCU sebelum nya	Persentase %	JML staf di MCU Bulan ini	%	Kesimpulan hasil		
						Sehat	Tdk	Konseling
Bidang Pelayanan Medis/Klinis								
	IGD	25/27	92.59%	0				
	IKO	6/11	54.54%	0				
	IRJA	25/29	86.21%	0			1	
	IRNA II A	23/23	100%	0				
	IRNA II B	21/21	100%	0				
	IRNA III A	20/20	100%	0				
	IRNA III B	20/20	100%	0				
	Maternitas	13/13	100%	0				
	NICU & Neonatologi	14/14	100%	0				
	ICU	11/13	84.62%	0				
	MOD	4/5	80%	0				
	Perawat Baru	10/10	100%	16/16	100%			
	Bidan Baru	3/3	100%					
Bidang Penunjang								
	Farmasi	17/41	41.46%	0				
	Laboratoirum	13/13	100%	0	0%			
	Radiologi	6	75%	0	0%			

No.	Unit	JML staf di MCU sebelum nya	Persentase %	JML staf di MCU Bulan ini	%	Kesimpulan hasil		
						Sehat	Tdk	Konseling
	Gizi dan Dapur	10/15	66.67%	0	0%			
	CSSD dan Laundry	10	100%	0	0%			
	Pendaftaran & CSO	17/19	89.47%	0	0%			
	Rekam Medis	9/10	90%	0	0%			
	Penyaji / Gizi Baru	3/3	100%	1/1	100%			
	Rekam Medis / PDF Baru	3/3	100%	0	0%			
	TTK Baru	9/9	100%	0	0%			
	Radiologi			1/1	100%			
Bidang Umum dan Keuangan								
	IPAL / B3	3	100%	0	0%	2	1	
	Asuransi Center	14/14	100%	0	0%			
	Cleaning Service	25/42	59.52%	0	0%			
	Driver	2/7	28.57%	0	0%			
	Gudang Umum	1/1	100%	0	0%			
	Humas dan Marketing	4/4	100%	0	0%			
	IPSRS	0/4	0%	0	0%			
	IT dan SIMRS	3/3	100%	0	0%			
	Kasir	10/10	100%	0	0%			
	Parkir	5/10	50%	0	0%			
	Security	4/11	36.37%	0	0%			
	SDM	3/3	100%	0	0%			
	Manajemen	3/9	33.33%	0	0%			
	IPSRS Baru	2/2	100%	1/1	100%			
	Parkir Baru	2/2	100%	0	0%			

Analisis : Terlaksananya MCU staf pada tahun 2024 pada terlaksana

RTL : Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan program kesehatan seperti olahraga atau program diet untuk staf kategori obesitas

N O	Unit	Juml ah Per Unit	% Me i	% Ju ni	% Jul i	% Agust us	% Septem ber	Oktob er %	Novem ber %	Desem ber %
Bidang Pelayanan										
	IGD	27	26	26	27	28	28	28	27	27
	IKO	13	12	12	13	12	12	13	13	13
	IRJA	33	26	27	28	28	28	28	29	29
	IRNA II A	22	23	23	24	23	23	22	22	22
	IRNA II B	23	21	21	23	23	23	23	23	23
	IRNA III A	18	19	19	20	20	18	18	18	18
	IRNA III B	18	19	19	21	21	21	20	18	18
	Maternitas	14	14	14	13	13	13	13	14	14
	NICU & Neonatologi	13	13	13	13	13	13	13	13	13

N O	Unit	Juml ah Per Unit	% Me i	% Ju ni	% Jul i	% Agust us	% Septem ber	Oktob er %	Novem ber %	Desem ber %
	ICU	11	13	13	13	12	12	12	11	11
	MOD	5	4	4	4	4	5	5	5	5
	Rehab Medik	5	3	3	5	5	5	5	5	5
Bidang Penunjang										
	Farmasi	53	37	36	41	41	41	42	42	41
	Laboratoir um	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Radiologi	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Gizi dan Dapur	18	15	15	15	15	15	15	15	14
	CSSD dan Laundry	10	10	10	11	10	10	10	10	10
	IPAL / B3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Pendaftar aran & CSO	19	17	17	19	19	19	19	19	19
	Rekam Medis	11	10	10	10	10	10	10	10	10
Bidang Umum dan Keuangan										
	Admin Jaminan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Cleaning Service	41	42	42	41	41	42	42	41	41
	Driver	7	6	6	7	7	7	7	7	7
	Gudang Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Humas dan Marketing	3	1	3	3	3	3	3	3	3
	IPSRs	7	4	4	4	4	4	4	5	5
	IT dan SIMRS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kasir	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Parkir	13	11	11	11	11	11	11	11	11
	Security	11	11	11	10	10	10	11	11	11
	Tukang	3	4	4	4	3	3	3	3	3
	Verifikator	12	11	11	12	12	12	11	10	10
	SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Analisis : Dari Total staf 494, diketahui bahwa staf yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 437 orang. Dimana selesai diantara keduanya adalah staf orientasi yang belum didaftarkan dalam jaminan Kesehatan.

RTL :

Mendaftarkan staf yang telah lepas masa orientasi dalam jaminan Kesehatan baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

3.5. KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE MUTU

3.5.1 Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024.

Tabel Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	≥80%
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

Tabel Capaian Indikator Mutu Nasioanl RSPH Sukorejo tahun 2024

No	Judul Indikator	Bulan												Std	Ra-ta-rata	Ket
		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1	Kepat uhan identifi kasi pasie n	96, 16 %	99, 42 %	99, 66 %	99, 85 %	99, 86 %	99, 61 %	99, 66 %	99, 51 %	99, 65 %	99, 52 %	99, 62 %	99, 62 %	10 0%	99, 35 %	Tid ak Ter cap ai
2	Wakt u Tung gu opera si Seksi o Sesar ea emer gency ≤ 30 menit	92, 86 %	10 0%	93, 33 %	10 0%	97, 37 %	90, 91 %	92, 31 %	92, 86 %	94, 12 %	82, 00 %	83, 33 %	10 0%	≥8 0%	93, 26 %	Ter cap ai
3	Wakt u Tung gu Rawa t Jalan	61, 60 %	49, 52 %	53, 64 %	50, 43 %	63, 46 %	65, 22 %	59, 68 %	69, 11 %	73, 20 %	56, 30 %	51, 20 %	52, 44 %	≥8 0%	58, 82 %	Tid ak Ter cap ai

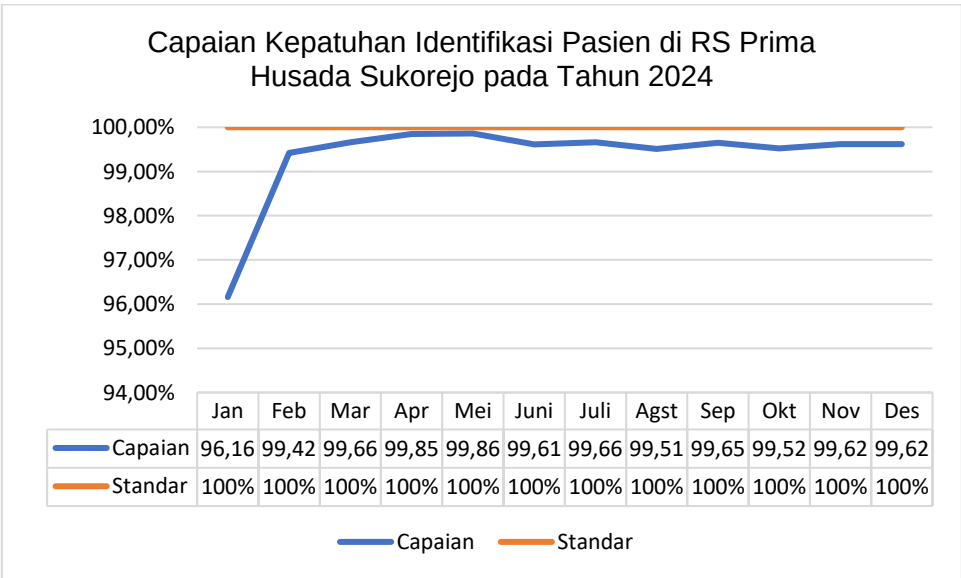


No	Judul Indikator	Bulan												Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktober	Nov	Des			
	≤ 60 menit															
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,17%	0,97%	0%	0,68%	0%	1,27%	2,23%	2,34%	2,25%	2,26%	4,52%	3,83%	≤5%	1,88%	Ter cap ai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	73,96%	73,15%	79,48%	71,27%	71,09%	71,32%	70,25%	69,09%	68,23%	71,45%	67,44%	69,55%	≥80%	71,36%	Tid ak tercap ai
6	Waktu Laporan Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ter cap ai
7	Kepatuhan Penggunaan Formulir Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Ter cap ai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	75,36%	73,57%	73,20%	73,23%	67,79%	78,3%	77,18%	71,97%	74,54%	69,79%	77,63%	69,57%	≥85%	73,51%	Tid ak tercap ai
9	Kepatuhan Upaya Pencegah	92,43%	94,12%	97,11%	97,76%	96,39%	97,26%	99,02%	97,15%	97,56%	97,92%	98,16%	98,81%	100%	96,97%	Tid ak tercap ai

No	Judul Indikator	Bulan												Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktober	Nov	Des			
	an Resiko Ceder a Akibat Pasien Jatuh															
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	88 %	90 %	63 %	72 %	67,03 %	90,45 %	82,14 %	84,85 %	89,53 %	93,75 %	95,76 %	93,18 %	≥80 %	84,14 %	Ter cap ai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	82,26 %	75,61 %	61,11 %	80,19 %	80,61 %	96,18 %	97,30 %	86,92 %	89,15 %	97,87 %	96,15 %	89,66 %	≥ 76.61 %	86,08 %	Ter cap ai
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	≥80 %	100 %	Ter cap ai
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	91,78 %	95,56 %	93,68 %	96,37 %	90,09 %	90,88 %	96,59 %	93,86 %	93,13 %	90,83 %	93,68 %	91,40 %	100 %	93,15 %	Tid ak tercap ai

Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 mencapai 99,35%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Desember Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2024 adalah 99,35% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian kepatuhan petugas terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ?

	Cara petugas mengidentifikasi pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Tahun 2024 yakni 99,35% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Terdapat 5 unit yang belum patuh terhadap kepatuhan identifikasi pasien Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A), Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B), Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A), Neonatologi dan Maternitas.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada tahun 2024 mencapai 99,35%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A Neonatologi & Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan Rapat Mutu dengan karu Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

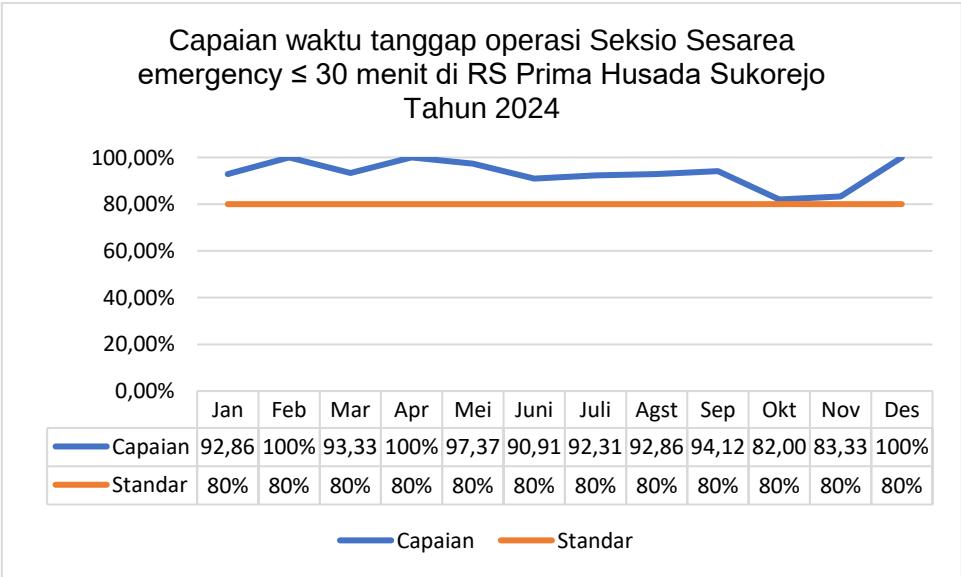
N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan



2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM.	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Catatan Khusus staff yang tidak patuh	SDM	Satu bulan
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani staf yang bersangkutan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan

7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajara n yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakuka n identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajara n	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh terhadap identifikasi pasien	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan	Satu bulan

Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit

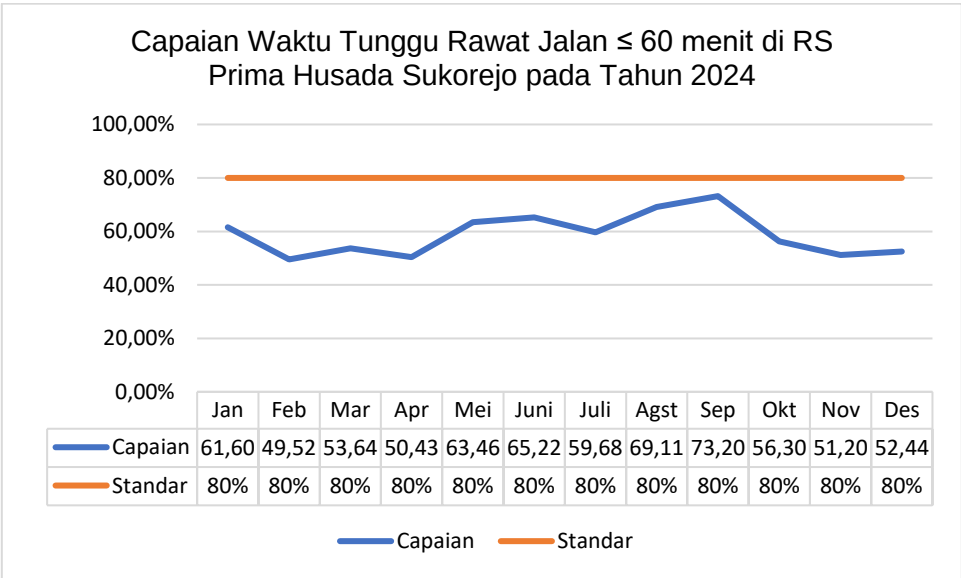


Gambar Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 93,26%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan pada Tahun 2024 rata-rata capaiannya yaitu 58,82%. Adapun rata- rata waktu tunggu rawat jalan pada Tahun 2024 yakni 104 menit atau 1 jam 44 menit.

Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit pada Tahun 2024 adalah 58,82%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana : Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan : Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian yakni 58,82%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target ≥ 80%. Adapun rata- rata waktu tunggu rawat jalan pada

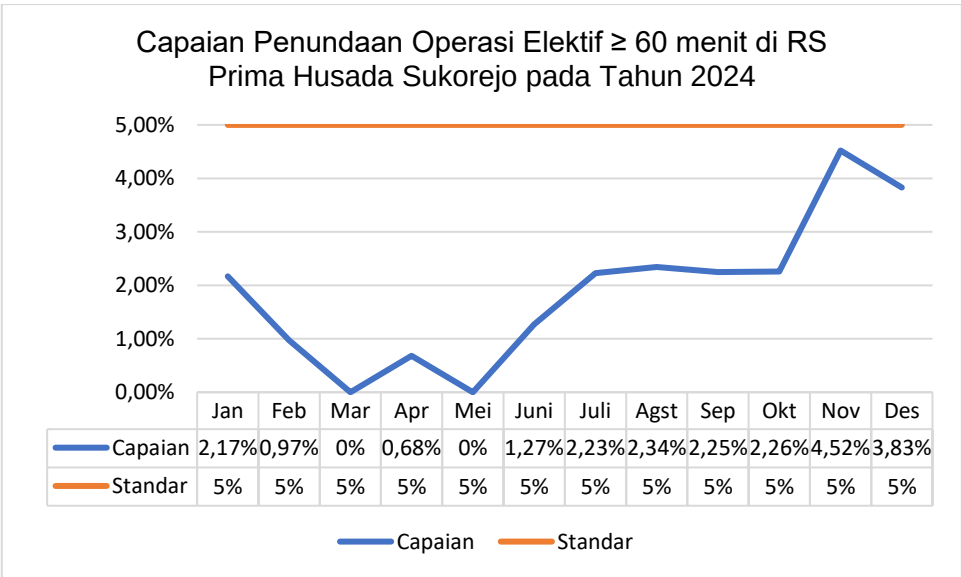
	Tahun 2024 yakni 104 menit atau 1 jam 44 menit. Hal ini disebabkan karena: Adanya pasien yang meninggalkan ruang tunggu pelayanan poli sehingga ketika dilakukan pemanggilan pasien tidak langsung menemui dokter Adanya pasien yang daftar di ruang pendaftaran sebelum jadwal poli Adanya dokter poli yang terlambat melebihi 30 menit Adanya dokter poli yang merubah jadwal
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian yakni 58,82%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Adapun rata- rata waktu tunggu rawat jalan pada Tahun 2024 yakni 104 menit atau 1 jam 44 menit Follow-Up dan Rencana Lanjutan Mengingatkan petugas Pendaftaran untuk mengKIE pasien Rawat Jalan SDM dan Kabid Pelayanan mengKIE dokter yang terlambat dan yang merubah jadwal h-1 Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien Monev khusus progress tiap minggu

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi Petugas Pendaftaran dan CSO untuk mengKIE Pasien Rawat Jalan	Semua Pasien mendapatkan KIE terkait ketentuan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Kepala Ruang Pendaftaran, Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan,	Satu bulan
2	Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan
3	SDM dan Kabid Pelayanan	Meningkatkan kepatuhan dokter yang	Seluruh pasien dapat	MengKIE dokter yang terlambat	SDM, Kepala	Satu Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	mengKIE dokter yang terlambat dan dokter yang sering merubah jadwal	terlambat dan yang sering merubah jadwal	mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	dan dokter yang sering merubah jadwal oleh SDM dan Kabid Pelayanan	Bidang Pelayanan	
4	Monitoring dan evaluasi terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Supervisi yang dilakukan oleh Komite Mutu	Komite Mutu	Satu bulan

Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

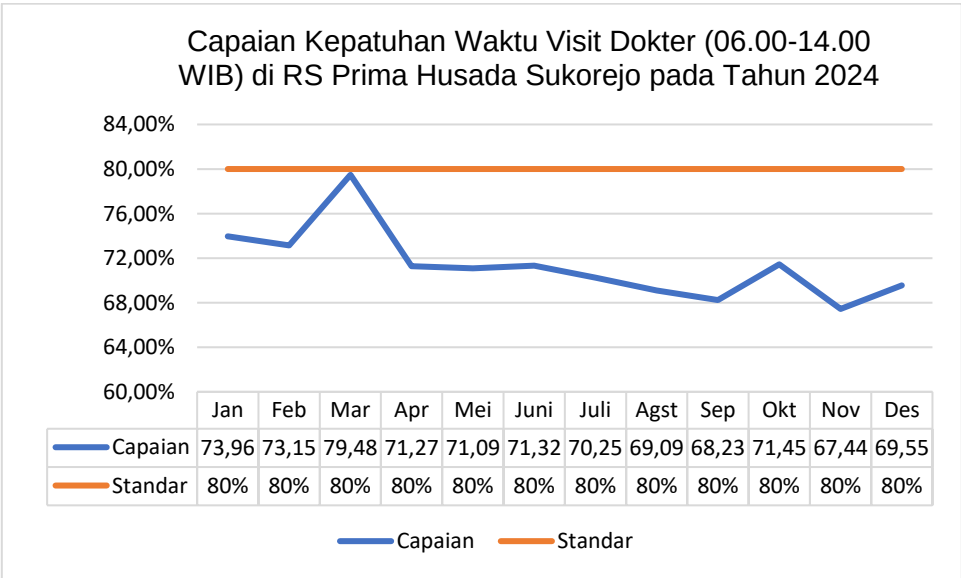


Gambar Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2024 yakni 1,88% sedangkan capaian di Bulan Desember 2024 yakni mencapai 3,83% mencapai standar kurang dari 5%.

Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)



Gambar Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap pada Tahun 2024 mencapai 71,36%. Capaian tersebut belum mencapai standar $\geq 80\%$.

Tabel PDSA Capaian Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB) pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Tahun 2024 adalah 71,36%, belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu visite dokter kepada pasien rawat inap Harapan : Semua pasien rawat inap dapat tervisite oleh dokter Tindakan : Koordinasi dengan kabid pelayanan dan komite medik Koordinasi dengan SDM terkait dokter yang tidak visite sehingga mempengaruhi evaluasi kinerja Pemaparan jumlah dokter yang visite lebih dari jam 14.00 WIB dan dokter yang titip visit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kesesuaian waktu visite dokter kepada pasien

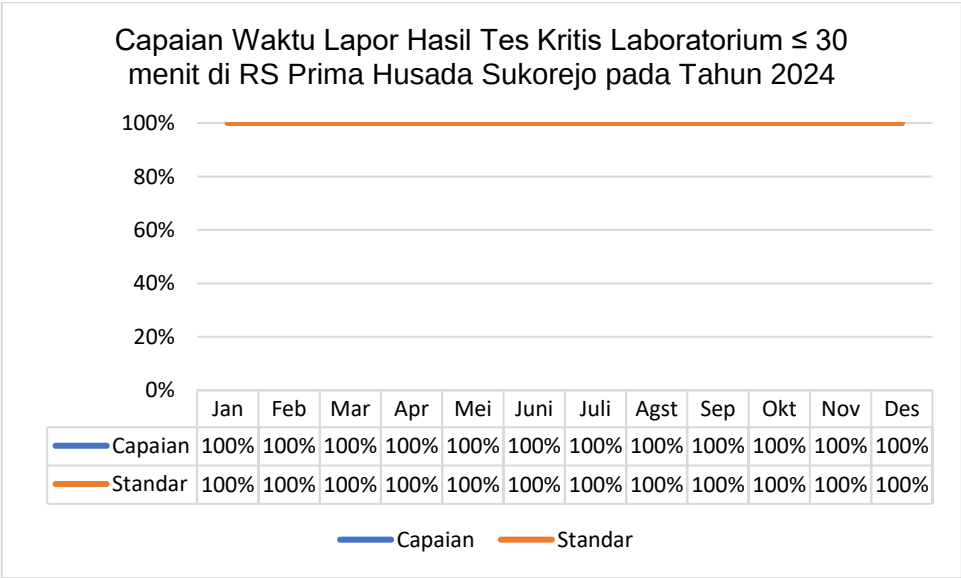
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 yakni 71,36%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini dikarenakan: Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB Pasien masuk ke ruang ICU pada malam hari, sehingga visit dilakukan oleh dokter jaga dan di visit oleh DPJP di kemudian hari
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 yakni 71,36%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik terkait kepatuhan waktu visit dokter konfirmasi ke dokter jaga. Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite IRNA, jam Operasi adakah yg beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain Koordinasi dengan asisten dokter terkait pasien yang harus di visit oleh DPJP Koordinasi dengan pihak SDM terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien Merekrut Home doctor

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk mengingatkan visit ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan
2	Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yang beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain.	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan Dokter, Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Satu bulan
3	Koordinasi dengan asisten dokter terkait	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam	Dokter yang	Rapat koordinasi dengan	komite medik	Satu bulan

	pasien yang harus di visit oleh DPJP	memvisite pasien	tidak visit ke pasien	komite medik		
4	Koordinasi dengan pihak SDM terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan SDM	SDM	Satu bulan
5	Merekrut Home Dokter	Semua pasien rawat inap dapat tervisite	Home Dokter	Koordinasi dengan SDM terkait dokter yang tidak bisa visit	SDM	Satu bulan

Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit

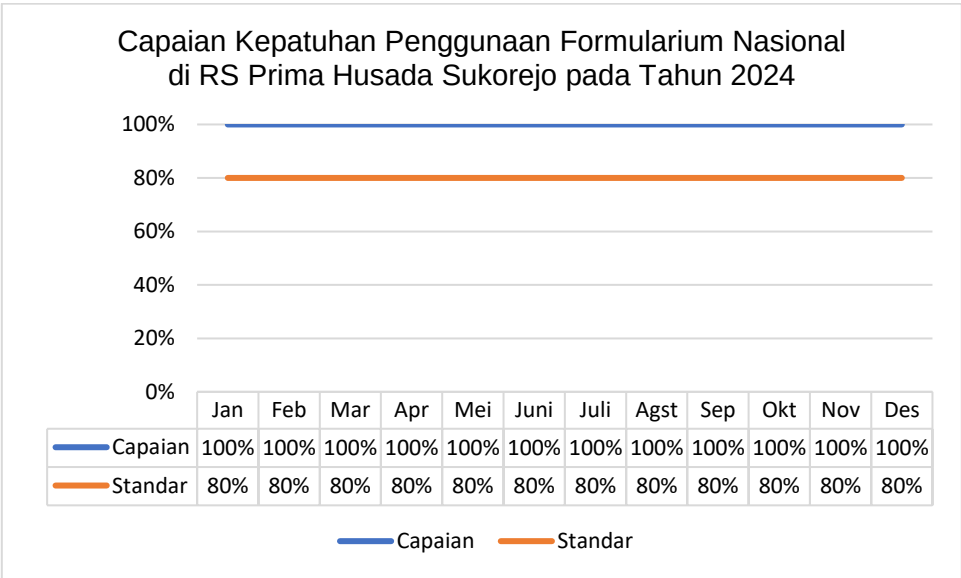


Gambar Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Tahun 2024 yakni 100% sesuai standar. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

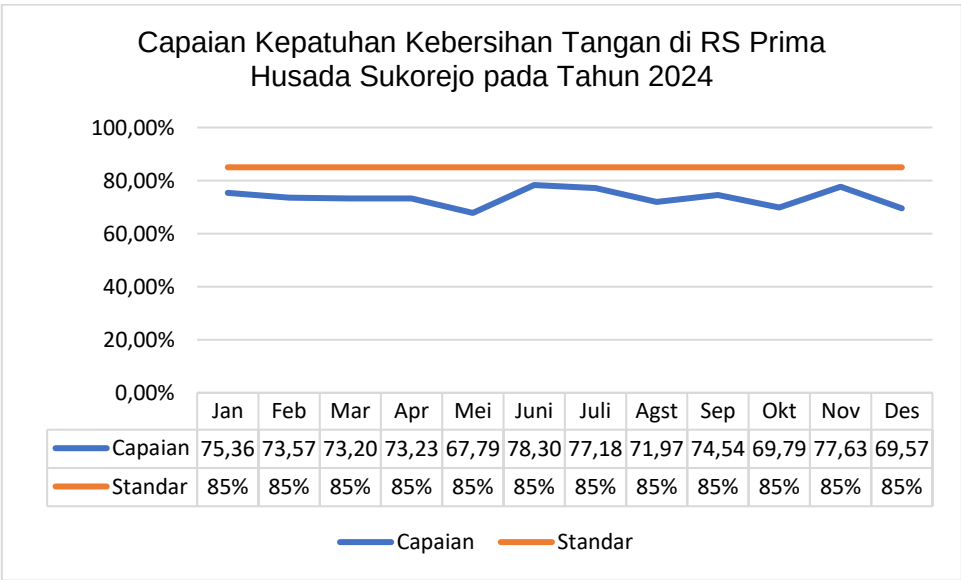


Gambar Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional.

Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Gambar Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Tahun 2024 memiliki rata-rata 73,51%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Tahun 2024

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2024 kurang dari 85% yakni 73,51%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medis di unit secara berkesinambungan. Kolaborasi dengan kepala ruang terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan Membuat rencana metode role play kebersihan tangan untuk staff dengan masa kerja lebih dari 1 tahun
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: Sebelum kontak dengan pasien Sebelum tindakan aseptik Setelah terkena cairan tubuh pasien Setelah kontak dengan pasien Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	Berdasarkan hasil capaian Kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2024 yakni 73,51% dan belum mencapai standar yang ditetapkan. Ini dikarenakan: Ditemukan petugas yang tidak patuh dalam mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. Handwash dan tissue paper towel dijumpai dalam keadaan kosong Ditemukan tidak melakukan kebersihan tangan sebelum memasang handscoon saat akan Tindakan aseptik. Selain itu petugas yang akan kontak dengan pasien, Terdapat petugas yang tidak paham gerakan 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar faktor dari perilaku kebiasaan petugas yakni kurangnya kesadaran/kepatuhan petugas dalam melaksanakan HH Kurangnya pengetahuan petugas terhadap pentingnya kepatuhan HH untuk memutuskan mata rantai penularan kuman

Action	Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub ditiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tisu paper towel dan sabun. Membuat jadwal edukasi rutin setiap bulannya ke ruangan Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan. Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas Berkoordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.
--------	---

Tabel Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Umum	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
2	Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub ditiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tisu paper towel dan sabun.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	Setiap tempat memiliki air yang lancar, handrub, tissue paper towel dan sabun	Koordinasi dengan Kabid Umum, Komite PPI, Gudang Umum, dan CS	Komite PPI, Kabid Umum, Gudang Umum & CS	Satu bulan
3	Membuat jadwal edukasi rutin setiap	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan	Semua petugas terutama	Monitoring dan	Komite PPI	Satu bulan



	bulannya ke ruangan	tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	petugas medis	evaluasi berkala		
4	Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah termonitoring semua di setiap ruangan	IPCN dapat memonitoring di setiap ruangan	Monitoring dan evaluasi berkala	IPCN & Komite PPI	Satu bulan
5	Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	Kepala Ruang dapat memonev petugas di setiap unit terkait kepatuhan kebersihan tangan	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruang, IPCN & Komite PPI	Satu bulan
6	Melakukan koordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Monitoring dan evaluasi berkala	SDM, IPCN & Komite PPI	Satu bulan
7	Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Pemberian Reward dan punishment terhadap kepatuhan <i>hand hygiene</i>	SDM, Kabid Pelayanan, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang & Kabid Umum	Satu bulan

Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2024 adalah 96,97%. Adapun capaian rata-rata Tahun 2024 belum mencapai target 100%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasien jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal pasien Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap

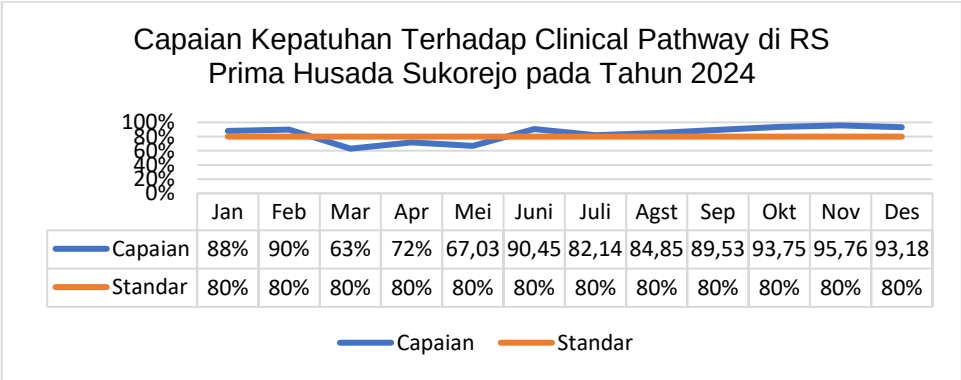
	Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: Asuhan skrining resiko jatuh pasien di poli tidak dilakukan Tidak terpasang hand rail di bed pasien Tidak edukasi pencegahan resiko jatuh
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun tindakan yang diberikan yakni: Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Nama-nama staff yang tidak patuh diberlakukan proses pembelajaran dengan mengerjakan soal yang terkait resiko jatuh dan pembacaan SPO terkait tatalaksana SKP di Unit nya setiap handover. Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan , SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan , SDM	Satu Bulan
2	Monitoring dan Evaluasi terkait nama	Meningkatkan kepatuhan petugas	Nama-nama staff yang tidak	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan, Komite Mutu	Satu Bulan

	staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh			
--	--	--	---	--	--	--

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

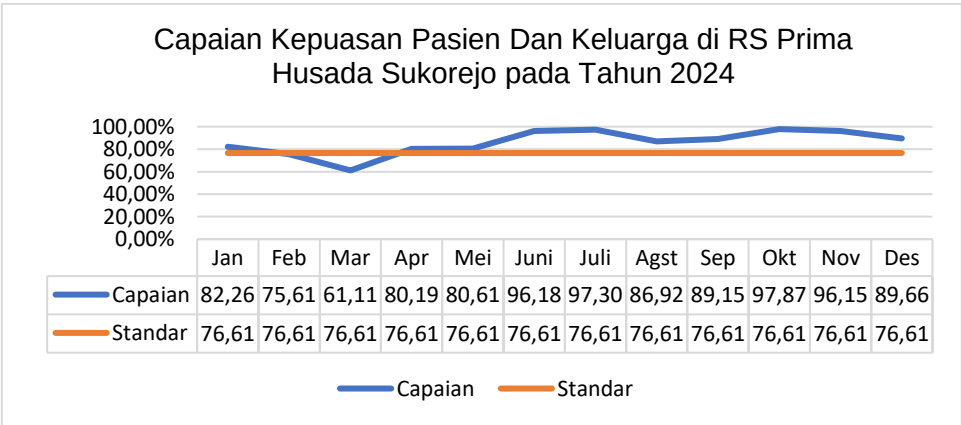


Gambar Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian kepatuhan terhadap clinical pathway di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 84,14%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%.

Kepuasan Pasien dan Keluarga

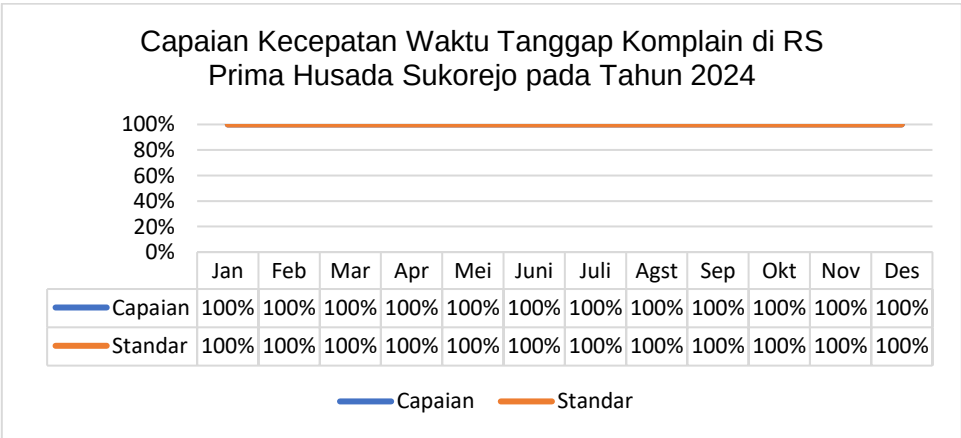


Gambar Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 sudah mencapai standar yakni 86,08%. Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Pasien Tahun 2024 dari 600 pasien yang menyecan survey kepuasan terdapat 45 pasien yang tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit.

Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

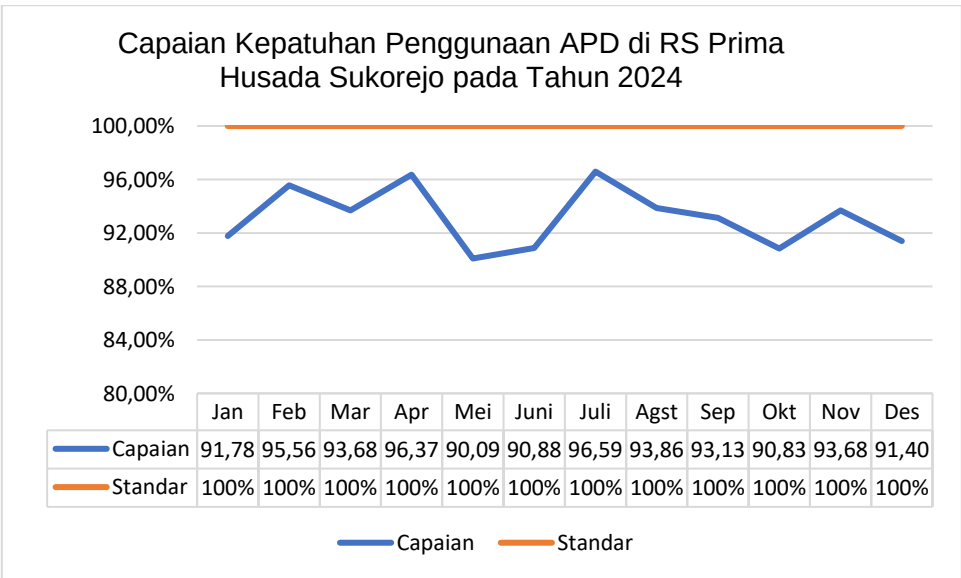


Gambar Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Tahun 2024 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2024 adalah 93,15% dan belum mencapai standar 100%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2024 yaitu 93,15%, angka tersebut tidak mencapai standar 100%.
---------	--

Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di RS Prima Husada Sukorejo Harapan: Seluruh staf pelayanan patuh dalam penggunaan APD sehingga target kepatuhan dapat dicapai Tindakan Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD Koordinasi dengan Komite PPI untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2024 mencapai 93,15% yang belum mencapai standar 100%. Ditemukan petugas yang menggunakan handscoon sebelum melakukan tindakan ke pasien namun menyentuh troli dan bed pasien Ditemukan petugas CS tidak menggunakan sarung tangan rumah tangga saat melakukan pemerasan alat pel di ruangan pasien Ditemukan petugas CS masih menggunakan sarung tangan medis saat melakukan pembersihan ruangan pasien dikarenakan tidak tersedianya sarung tangan rumah tangga Petugas laboratorium tidak patuh menggunakan gown di area tindakan sampling Petugas laundry tidak menggunakan <i>handscoon</i> saat melakukan pengambilan linen kotor
Action	Review dan evaluasi penggunaan APD pada staf. Beri feedback pada hasil temuan. Kolaborasi dengan komite PPI untuk monitoring penggunaan APD di unit. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu



1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Komite PPI	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Komite PPI	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebutuhan penggunaan APD	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Komite PPI dan komite keperawatan	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan

3.5.2 MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT

1. Mutu Sasaran keselamatan Pasien /SKP
2. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
5. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert
6. Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Pasien Operasi
7. Kepatuhan Kebersihan Tangan
8. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
9. Mutu Pelayanan Klinis Prioritas
10. Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas
11. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit
12. Waktu tunggu pelayanan Racikan ≤ 60 menit
13. Mutu Terkait Tujuan Strategis Rumah Sakit .
14. Indikator berdasarkan Renstra RS
15. Kepuasan Pelanggan
16. Mutu Terkait Perbaikan Sistem
17. Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi
18. Mutu Terkait Manajemen Risiko
19. Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi
20. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - a) CVA
 - b) Batu Ureter
 - c) Diabetes Millitus
 - d) GEA

- e) HIV
- f) Hipertensi
- g) TB
- h) Keganasan (Ca Mammae)
- i) Pneumonia
- j) SC
- k) Partus Normal
- l) BPH
- m)Hydronefrosis
- n) PPOK
- o) Fraktur terbuka
- p) Stroke hemoragik
- q) Stroke Trombosis

Capaian Indikator Mutu Prioritas di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

No.	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dest			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	Kepatuhan Identifikasi Pasien	96,16%	99,42%	99,66%	99,85%	99,86%	99,61%	99,66%	99,51%	99,65%	99,52%	99,62%	99,62%	100%	99,35%	PD SA
		Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	84,36%	89,92%	99,15%	99,49%	99,55%	97,74%	97,51%	97,62%	97,95%	98,41%	98,13%	95,56%	100%	96,28%	PD SA
		Kejadian Ketidaktepatan Penerimaan Label Obat High Alert	0	2	3	8	8	1	0	1	0	0	0	0	0	2 kejadian	PD SA
		Kejadian tidak dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercaipai

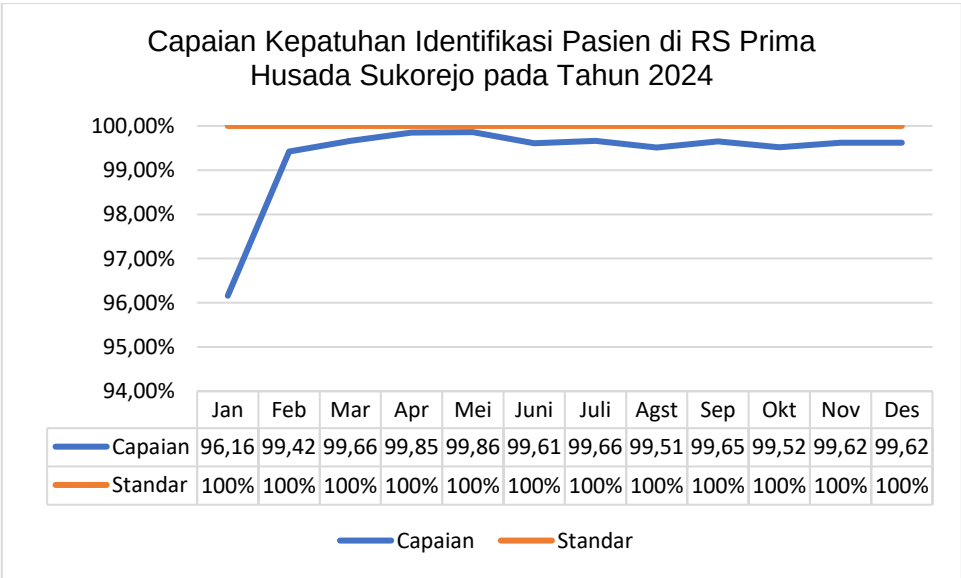


No.	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dess			
		nyapendaanlokasi pasien operasi															
		Kepatuhan Kebersihan Tangan	75,36%	73,57%	73,20%	73,23%	67,79%	78,30%	77,18%	71,97%	74,54%	69,79%	77,63%	69,57%	100%	73,51%	PD SA
		Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	92,43%	94%	97,11%	97,76%	96,39%	97,26%	99,02%	97,15%	97,56%	97,92%	98,16%	98,81%	100%	96,96%	PD SA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	-	-	77,67%	65,64%	65,88%	89,25%	87,04%	68,42%	56%	73,98%	56,80%	69,03%	100%	70,97%	PD SA
		waktu tunggu pelayanan Racikan ≤ 60 menit	-	-	91,67%	80%	85%	95,45%	87,5%	90,91%	90%	91,67%	80%	91,67%	100%	88,39%	PD SA
3	Restrukturisasi	Kepuasan pelanggan	82,26%	75,61%	61,11%	80,19%	80,61%	96,18%	97,30%	86,92%	89,15%	97,87%	96,15%	89,66%	≥76,61%	86,08%	Tercaipai
4	Perbaikan Sistem	Kejadian pemberian antibiotik profil	0 kejadian	32 kejadian	11 Kejadian	32 kejadian	26 kejadian	19 kejadian	30 Kejadian	13 Kejadian	7 Kejadian	13 Kejadian	3 Kejadian	51 kejadian	0 kejadian	20 kejadian	PD SA

No.	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des			
		aksis < 60 menit sebelum insisi															
5	Manajemen Resiko	Kejadian kekesong an obat di Instalasi Farmasi	0 kejadian	42 kejadian	15 kejadian	89 kejadian	191 kejadian	68 kejadian	62 kejadian	2 Kejadian	0 kejadian	3 kejadian	38 kejadian	31 kejadian	0 kejadian	45 kejadian	PD SA

Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 mencapai 99,35%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2024 adalah 99,35% dan belum mencapai target 100%
---------	--

Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian kepatuhan petugas terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh Koordinasi dengan kbid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara petugas mengidentifikasi pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Tahun 2024 yakni 99,35% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Terdapat 5 unit yang belum patuh terhadap kepatuhan identifikasi pasien Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A), Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B), Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A), Neonatologi dan Maternitas.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada tahun 2024 mencapai 99,35%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A Neonatologi & Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan Rapat Mutu dengan karu

	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.
--	--

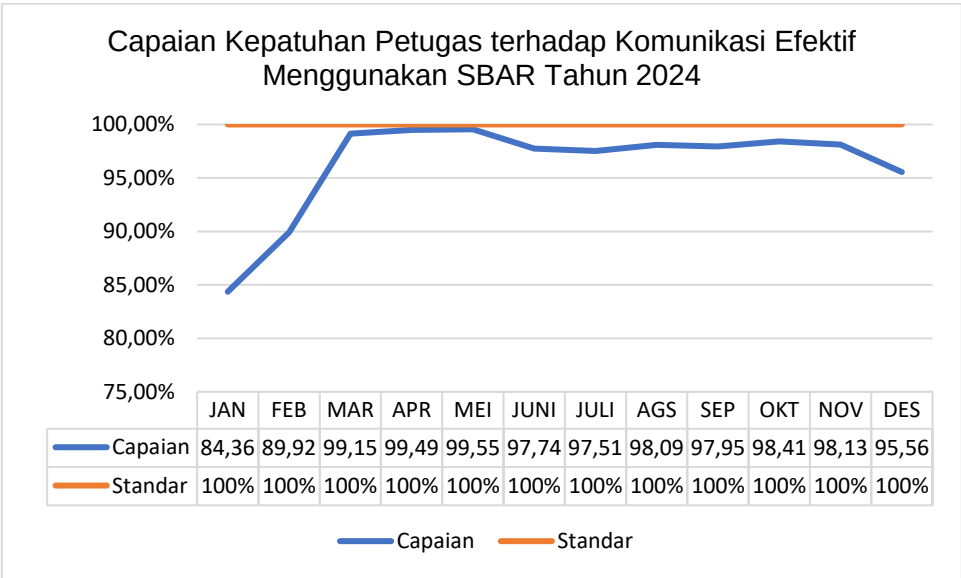
Tabel Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan
2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan , SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM.	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Catatan Khusus staff yang tidak patuh	SDM	Satu bulan
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan



	staf yang bersangkutan					
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan
7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajaran yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajaran	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh terhadap identifikasi pasien	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan	Satu bulan

Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR



Gambar Capaian Kepatuhan Petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 mencapai 96,28%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Tahun 2024

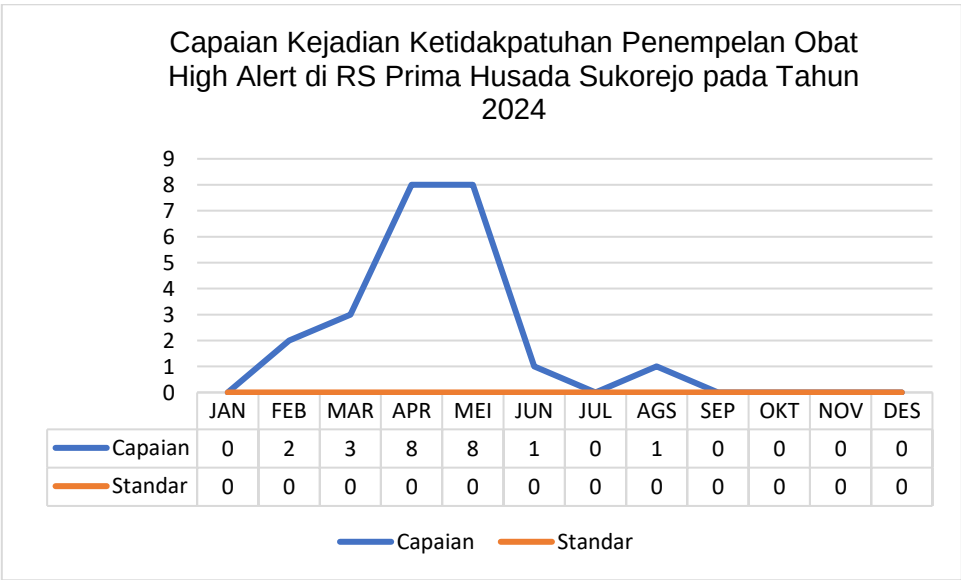
Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 96,28%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	Rencana: Meningkatkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR Harapan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dapat tercapai 100% Tindakan Peningkatan supervisi SBAR oleh PKRS & Mutu Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Unit Rawat Inap terkait kelengkapan SBAR
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pengisian SBAR oleh petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ?

	Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 96,28% belum mencapai standar 100%.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar disebabkan adanya form SBAR yang tidak terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi kepatuhan dan peneguran staff secara langsung	Agar kepatuhan PPA dalam mengisi SBAR dapat meningkat	Kelengkapan SBAR dapat terisi 100%	Supervise dan peneguran secara langsung	PKRS	1 minggu

Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Gambar Capaian Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kejadian tidak adanya label high alert di di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 yaitu 2 kejadian.

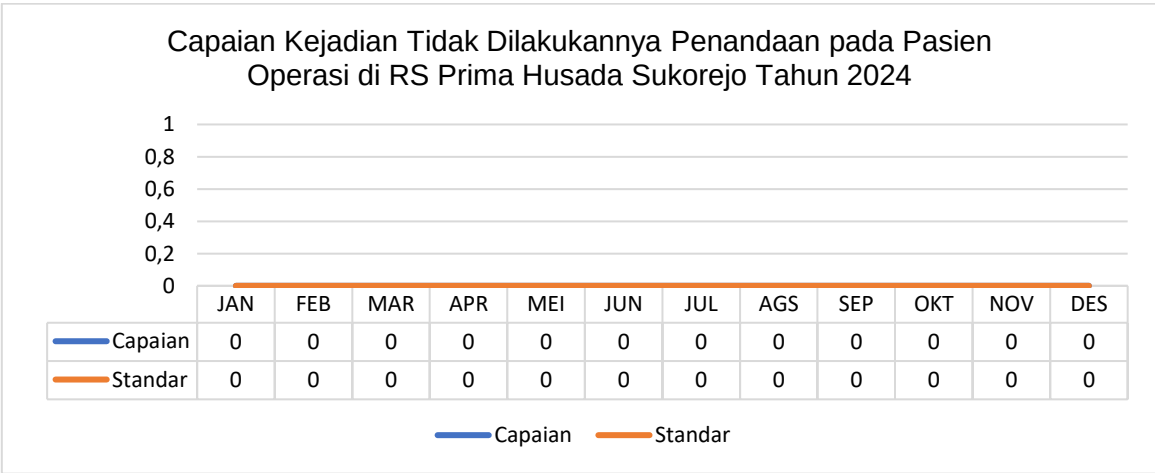
Tabel PDSA Capaian Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 adalah 2 kejadian, angka tersebut belum mencapai target 0 kejadian
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo
Plan	Rencana : Meningkatkan kepatuhan petugas mengenai penempelan label obat high alert di Unit Farmasi Harapan : Kepatuhan petugas dalam penempelan obat high alert mencapai target Tindakan : Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? Stiker High Alert Pada Obat High Alert
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2024 adalah 2 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh pada saat serah terima barang ada obat high alert yang belum tertempel.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2024 adalah 2 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh pada saat serah terima barang ada obat high alert yang belum tertempel Follow-up dan Rencana Lanjutan Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert	Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap stiker obat high alert	Seluruh petugas dalam penempelan obat high alert	Koordinasi dengan Karu mengenai obat high alert dan stiker pada obat	Karu Farmasi, Mutu	Satu bulan

Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi

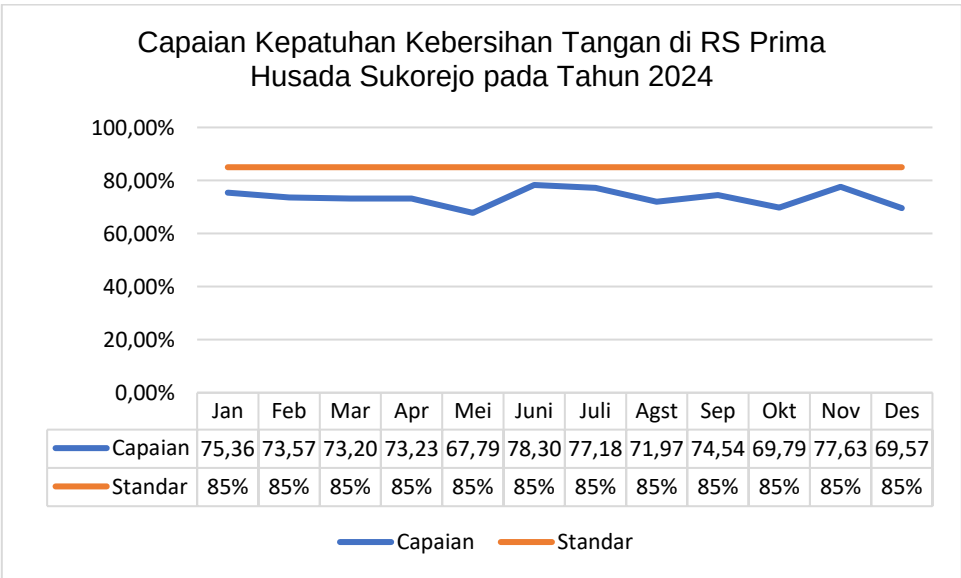


Gambar Capaian Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 yaitu 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai standar yakni 0 kejadian. Ini disebabkan setiap pasien operasi telah dilakukan penandaan pada tubuhnya.

Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Tahun 2024 memiliki rata-rata 73,51%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Tahun 2024

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2024 kurang dari 85% yakni 73,51%.
---------	--

Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medis di unit secara berkesinambungan. Kolaborasi dengan kepala ruang terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan Membuat rencana metode role play kebersihan tangan untuk staff dengan masa kerja lebih dari 1 tahun
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: Sebelum kontak dengan pasien Sebelum tindakan aseptik Setelah terkena cairan tubuh pasien Setelah kontak dengan pasien Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	Berdasarkan hasil capaian Kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2024 yakni 73,51% dan belum mencapai standar yang ditetapkan. Ini dikarenakan: Ditemukan petugas yang tidak patuh dalam mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. Handwash dan tissue paper towel dijumpai dalam keadaan kosong Ditemukan tidak melakukan kebersihan tangan sebelum memasang handscoon saat akan Tindakan aseptik. Selain itu petugas yang akan kontak dengan pasien, Terdapat petugas yang tidak paham gerakan 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar faktor dari perilaku kebiasaan petugas yakni kurangnya kesadaran/kepatuhan petugas dalam melaksanakan HH Kurangnya pengetahuan petugas terhadap pentingnya kepatuhan HH untuk memutuskan mata rantai penularan kuman

Action	Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub ditiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tisu paper towel dan sabun. Membuat jadwal edukasi rutin setiap bulannya ke ruangan Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan. Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas Berkoordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.
--------	---

Tabel Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan koordinasi dengan bidang penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Umum	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
2	Mengupayakan ketersediaan sarana kebersihan tangan seperti handrub ditiap bed tempat tidur pasien, air lancar, tersedianya tisu paper towel dan sabun.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	Setiap tempat memiliki air yang lancar, handrub, tissue paper towel dan sabun	Koordinasi dengan Kabid Umum, Komite PPI, Gudang Umum, dan CS	Komite PPI, Kabid Umum, Gudang Umum & CS	Satu bulan
3	Membuat jadwal edukasi rutin setiap	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan	Semua petugas terutama	Monitoring dan	Komite PPI	Satu bulan



	bulannya ke ruangan	tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	petugas medis	evaluasi berkala		
4	Meningkatkan kembali jumlah kunjungan dari IPCN ke ruangan.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah termonitoring semua di setiap ruangan	IPCN dapat memonitoring di setiap ruangan	Monitoring dan evaluasi berkala	IPCN & Komite PPI	Satu bulan
5	Melibatkan kepala ruangan untuk sering memonev kepatuhan HH terhadap petugas	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan	Kepala Ruang dapat memonev petugas di setiap unit terkait kepatuhan kebersihan tangan	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruang, IPCN & Komite PPI	Satu bulan
6	Melakukan koordinasi dengan SDM terkait kepatuhan kebersihan tangan staff saat audit yang termasuk dalam evaluasi kinerja	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Monitoring dan evaluasi berkala	SDM, IPCN & Komite PPI	Satu bulan
7	Melibatkan manajemen untuk memberikan perhatian dalam bentuk punishment dan reward terhadap petugas yang patuh dan tidak terhadap kepatuhan hand hygiene.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan mendapat perhatian khusus dari petugas	Semua petugas terutama petugas medis mendapatkan perhatian dari manajemen RS	Pemberian Reward dan punishment terhadap kepatuhan <i>hand hygiene</i>	SDM, Kabid Pelayanan, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang & Kabid Umum	Satu bulan

Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2024 adalah 96,97%. Adapun capaian rata-rata Tahun 2024 belum mencapai target 100%.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan risiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasien jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal pasien Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap

	Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: Asuhan skrining resiko jatuh pasien di poli tidak dilakukan Tidak terpasang hand rail di bed pasien Tidak edukasi pencegahan resiko jatuh
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2024 adalah 96,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun tindakan yang diberikan yakni: Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Nama-nama staff yang tidak patuh diberlakukan proses pembelajaran dengan mengerjakan soal yang terkait resiko jatuh dan pembacaan SPO terkait tatalaksana SKP di Unit nya setiap handover. Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

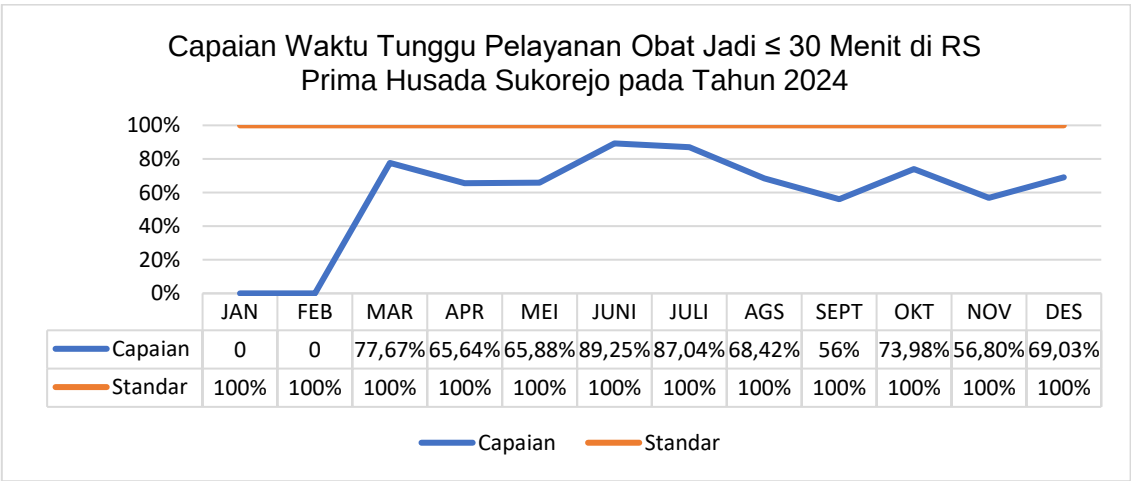
Tabel Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan , SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan , SDM	Satu Bulan

2	Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan, Komite Mutu	Satu Bulan
---	---	---	--	---------------------------------	-----------------------------	------------

Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit

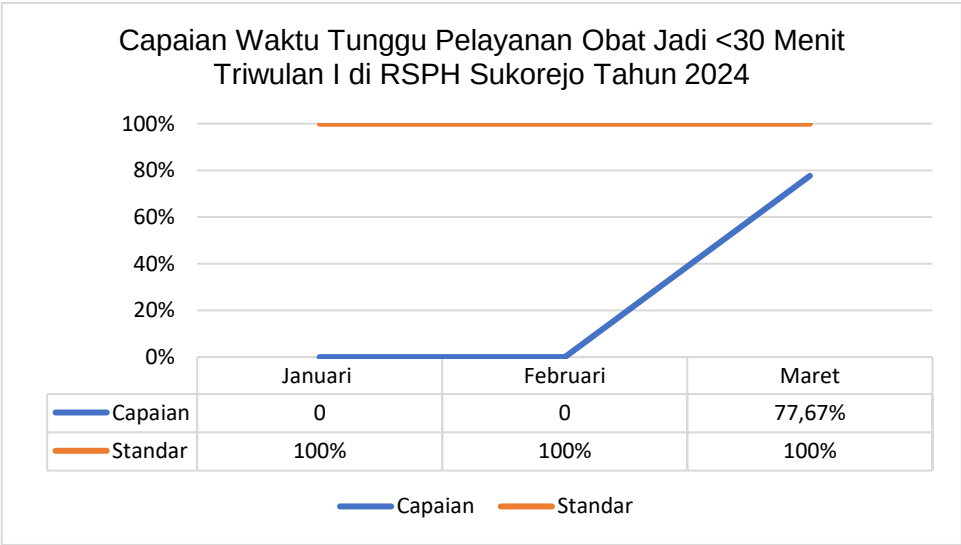


Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit di RS

Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu tunggu pelayanan obat jadi Obat Jadi ≤ 30 Menit pada tahun 2024 adalah 70,97%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan I di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan I di RSPH Sukorejo Tahun 2024

Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi < 30 Menit Triwulan I pada Tahun 2024

LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan I	SIKLUS: Ke 1
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi	PENANGGUNG JAWAB: dr. Ham Dwika Putri ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
PLAN		
a. Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.		
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat		

Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Penyebab Masalah

Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani

Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus

Jumlah SDM belum terpenuhi

Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan

Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan

d. Tujuan Perbaikan

Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi

Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian

Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan

Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi

Do

No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se	V	V	V	Ramadhan Rizki	

	efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).						
INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke I ini yakni 77,67% PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 50 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	v			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	v			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	v	v	v	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LOWONGAN KERJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Tenaga Teknik Kefarmasian

D3 Farmasi

Administrasi Kefarmasian

SMK Farmasi

Fisioterapis

D3/S1 Fisioterapi

Kualifikasi :

Pendidikan sesuai bidang

Memiliki STR aktif *Wajib bagi nakes

Siap bekerja dalam waktu dekat

Bersedia ditempatkan di Sukorejo Pasuruan

Berdomicil di Jawa Timur

Lampiran :

Surat Lamaran Kerja

Curriculum Vitae

Ijazah Terakhir & Transkrip Nilai

Pas foto berwarna

Fotocopy KTP

Fotocopy STR aktif *Wajib bagi nakes

Kirim melalui email resmi :

rsphs.rekrutmen@gmail.com

dengan subjek NAMA _ POSISI YANG DILAMAR

Note: Upload berkas lamaran pekerjaan menjadi 1 file pdf

Batas Akhir Lamaran : 31 Maret 2024



Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan II di RSPH Sukorejo Tahun 2024

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit
Triwulan II di RSPH Sukorejo Tahun 2024

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Capaian

Standar

	April	Mei	Juni
Capaian	65,64%	65,88%	89,25%
Standar	100%	100%	100%

Capaian

Standar

Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan II di RSPH Sukorejo Tahun 2024

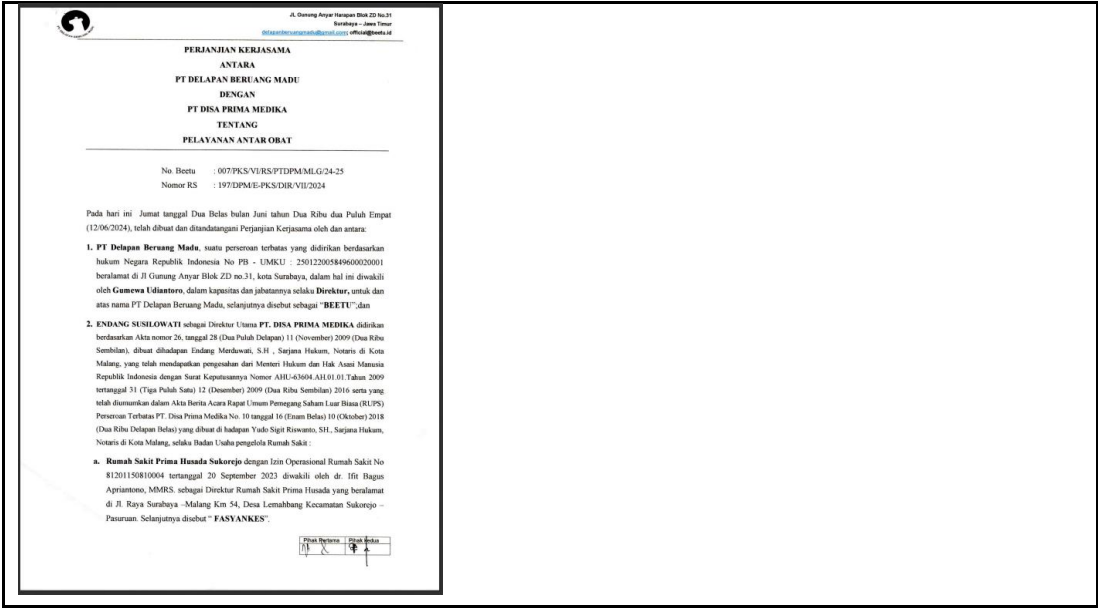
Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi < 30 Menit Triwulan II 2024

LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan II	SIKLUS: Ke 2
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi	PENANGGUNG JAWAB: dr. Ham Dwika Putri ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt

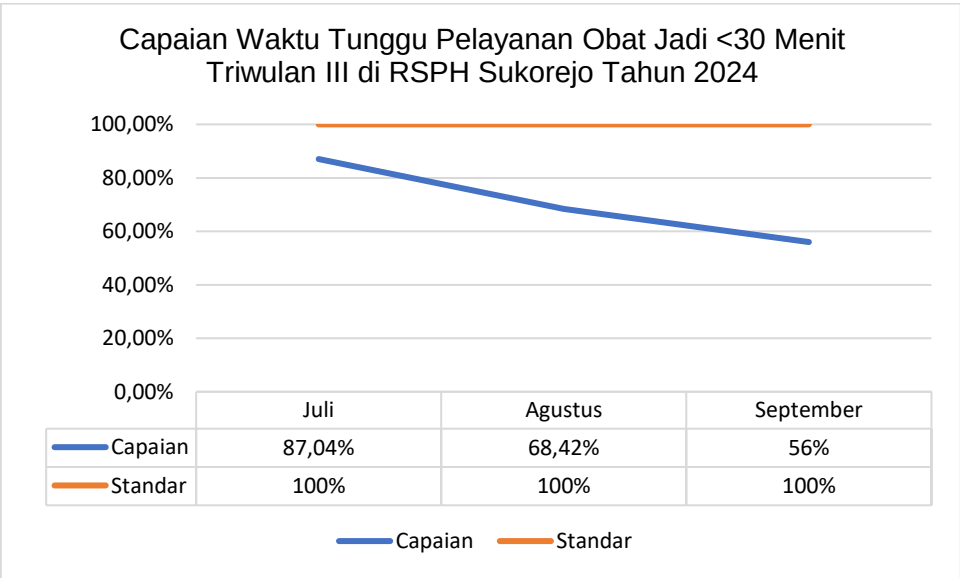
Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

		Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS				
PLAN						
Latar Belakang						
Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai.						
Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.						
Rumusan Masalah						
Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat						
Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit						
Penyebab Masalah						
Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan persepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir						
Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual						
Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering eror						
Tujuan Perbaikan						
Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi						
Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi						
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah						
Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu						
Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk						
Do						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024		
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	v			Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	

2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke II ini yakni 73,59% PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 42 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024		
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt	



Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan III di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan III di RSPH Sukorejo Tahun 2024

Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi < 30 Menit Triwulan III pada Tahun 2024

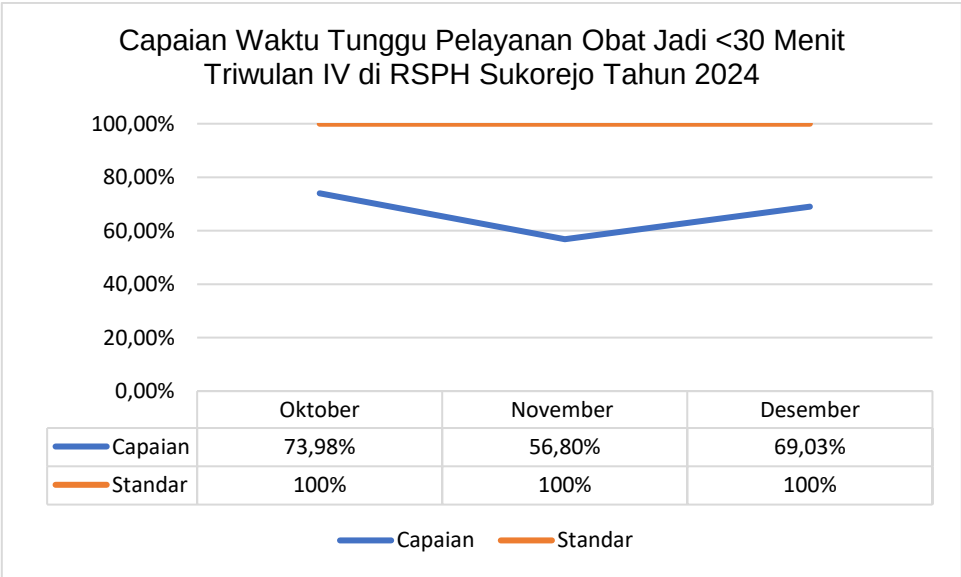
LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK:	BULAN:	SIKLUS:
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	Triwulan III	Ke 3
UNIT KERJA:	MENGETAHUI	PENANGGUNG JAWAB:
Instalasi Farmasi	Kepala Instalasi Farmasi	Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes
		ANGGOTA TIM :

		Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
PLAN		
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.		
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		
Penyebab Masalah Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.		
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi		
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi		
Do		

No	Pelaksanaan/Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Septem ber	Oktober	Novemb er		
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).						
INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke III ini yakni 70,49%						
PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem						
OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	
		Septem ber	Oktober	Novemb er		

1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadh n Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadh n Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  PT. DISA PRIMA MEDIKA LOWONGAN KERJA RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK) D3 Farmasi Administrasi Kefarmasian SMK Farmasi Kualifikasi : Pendidikan sesuai bidang Memiliki STR aktif *(Wajib bagi nakes) Siap bekerja dalam waktu dekat Bersedia ditempatkan di Sukorejo Pasuruan Berdomisili di Jawa Timur Lampiran : Surat Lamaran Kerja Curriculum Vitae Ijazah Terakhir & Transkrip Nilai Pas foto berwarna Fotocopy KTP Fotocopy STR aktif *Wajib bagi nakes Kirim melalui email resmi : rsphs.rekrutmen@gmail.com dengan subjek NAMA_POSISI YANG DILAMAR Note: Upload berkas lamaran pekerjaan menjadi 1 file pdf Batas Akhir Lamaran : 7 September 2024 						

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan IV di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi <30 Menit Triwulan IV di RSPH Sukorejo Tahun 2024

Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi < 30 Menit Triwulan IV pada Tahun 2024

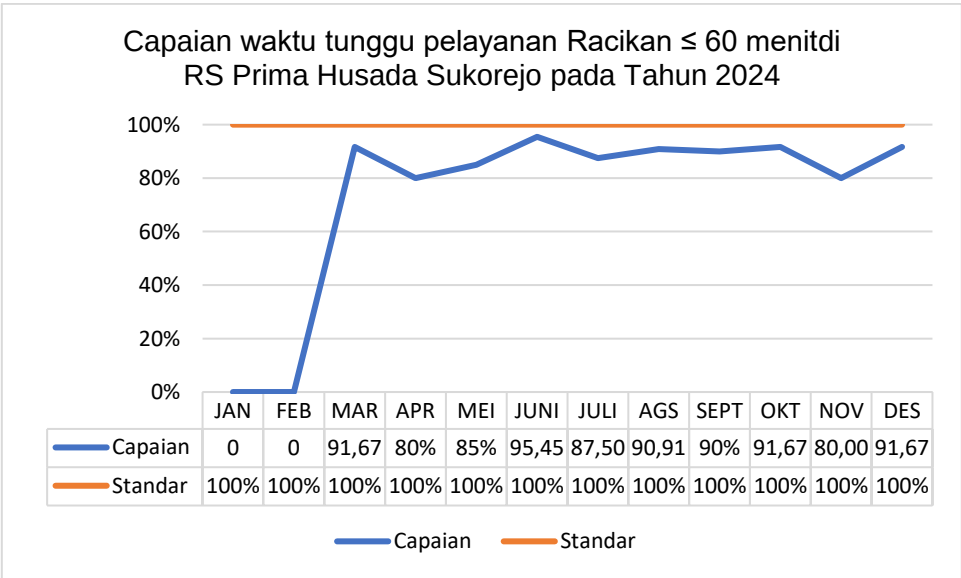
LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan IV	SIKLUS: Ke 4
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi	PENANGGUNG JAWAB: Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.
PLAN		
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.		
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		

Penyebab Masalah Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.						
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi						
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi						
Do						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025		
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan			V	Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan	V	V	V	Ramadhan Rizki	

	seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,A pt.	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke IV ini yakni 66,60% PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penangg ung jawab	
		Desemb er 2024	Januari 2025	Februar i 2025		
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadha n Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,A pt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan			V	Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien	V	V	V	Ramadha n Rizki Putranto,	

	mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,A pt	
--	--	--	--	--	--	--

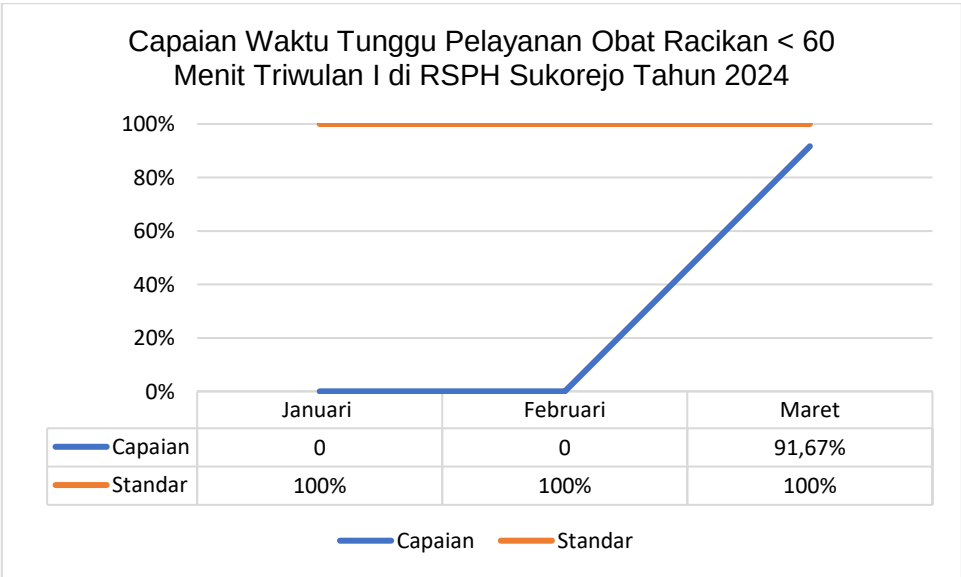
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit



Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit pada Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 Menit pada tahun 2024 adalah 88,39%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan I di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan I

di RSPH Sukorejo Tahun 2024

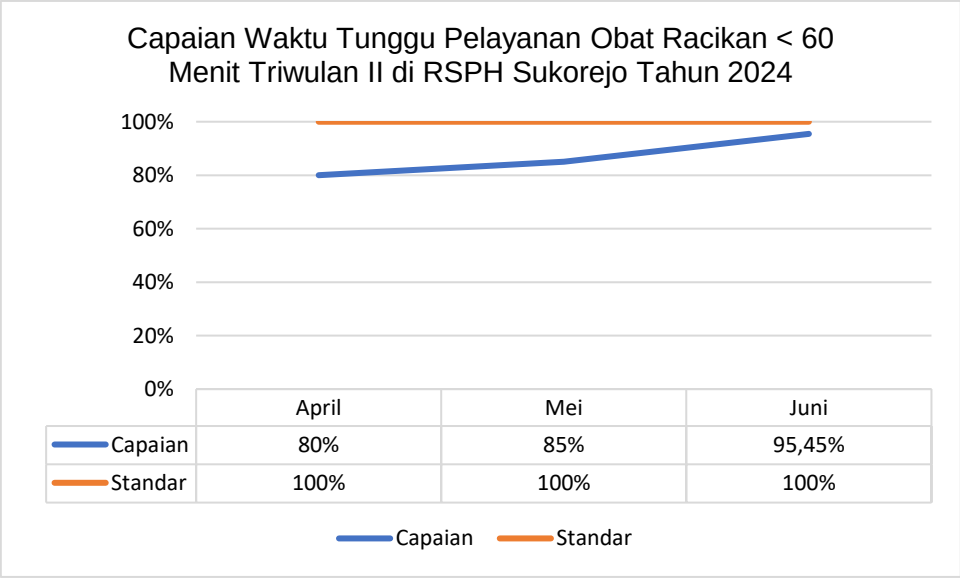
Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan < 60 Menit Triwulan I pada Tahun 2024

LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan I	SIKLUS: Ke 1
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi	PENANGGUNG JAWAB: dr. Ham Dwika Putri ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
PLAN		
a. Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.		
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		
Penyebab Masalah Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus Jumlah SDM belum terpenuhi Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan		
d. Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi		

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah						
Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian						
Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan						
Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi						
Do						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).						
INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke I ini yakni 91,67%						
PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.						

OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 37 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penangg ung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadh a Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	v	Ramadh a Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
 PRIMA HUSADA  PT. DISA PRIMA MEDIKA LOWONGAN KERJA RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Tenaga Teknik Kefarmasian D3 Farmasi Administrasi Kefarmasian SMK Farmasi Fisioterapis D3/S1 Fisioterapi Kualifikasi: Pendidikan sesuai bidang Memiliki STR aktif *Wajib bagi ners Siap bekerja dalam waktu dekat Bersedia ditempatkan di Sukorejo Ponorogo Bersedia di Jawa Timur Lampiran: Surat Lamaran Kerja Curriculum Vitae Daftar Terevisi & Transkrip Nilai Pas foto berwarna Fotocopy KTP Fotocopy STR aktif *Wajib bagi ners Kirim melalui email resmi: ngpita.rekrutmen@gmail.com dengan subjek NAMA_POSISI YANG DILAMAR Note: Upload berkas lamaran pekerjaan menjadi 1 file pdf Batas Akhir Lamaran: 31 Maret 2024						

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan II di RSPH Sukorejo Tahun 2024

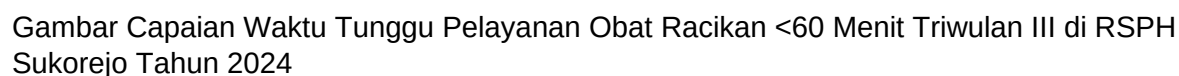


Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan II di RSPH Sukorejo Tahun 2024

LEMBAR KERJA PDSA						
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit		BULAN: Triwulan II		SIKLUS: Ke 2		
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi		MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi		PENANGGUNG JAWAB: dr. Ham Dwika Putri ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS		
PLAN						
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.						
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit						
Penyebab Masalah Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering error						
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi						
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk						
Do						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penangg ung jawab	Kendala
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024		
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadha n Rizki Putranto, S. Farm., Apt	

3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadh an Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke II ini yakni 86,82% PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 11 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penang gung jawab	Kendala
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024		
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk	V	V	V	Ramadh an Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadh an Rizki Putranto, S. Farm., Apt	

Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan III di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan < 60 Menit Triwulan III pada Tahun 2024

LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK:	BULAN:	SIKLUS:
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	Triwulan III	Ke 3

UNIT KERJA:	MENGETAHUI	PENANGGUNG JAWAB:
Instalasi Farmasi	Kepala Instalasi Farmasi	Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes
		ANGGOTA TIM :
		Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt
		Novia Ainur Pratiwi, S.KM.

PLAN

Latar Belakang

Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai.

Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.

Rumusan Masalah

Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat

Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Penyebab Masalah

Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir

Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual

Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani

Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus

Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.

Tujuan Perbaikan

Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan

Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu

Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan

Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi

Do

No	Rencana Waktu Kegiatan	Kendala
----	------------------------	---------



	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Septem ber	Oktober	Novemb er	Penangg ung jawab	
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadh an Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadh an Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
Study						
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat racikan ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke III ini yakni 89,47% PROSES PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat racikan masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 23 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penangg ung jawab	
		Septem ber	Oktober	Novemb er		

1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhana Rizki Putranto, S. Farm., Apt



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LOWONGAN KERJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK)

D3 Farmasi

Administrasi Kefarmasian

SMK Farmasi

Kualifikasi:

Pendidikan sesuai bidang

Memiliki STR aktif *Wajib bagi nakes

Siap bekerja dalam waktu dekat

Bersedia ditempatkan di Sukorejo Pasuruan

Berdomisili di Jawa Timur

Lampiran:

Surat Lamaran Kerja

Curriculum Vitae

Ijazah Terakhir & Transkrip Nilai

Pas foto berwarna

Fotocopy KTP

Fotocopy STR aktif *Wajib bagi nakes

Kirim melalui email resmi :

rsphs.rekrutmen@gmail.com

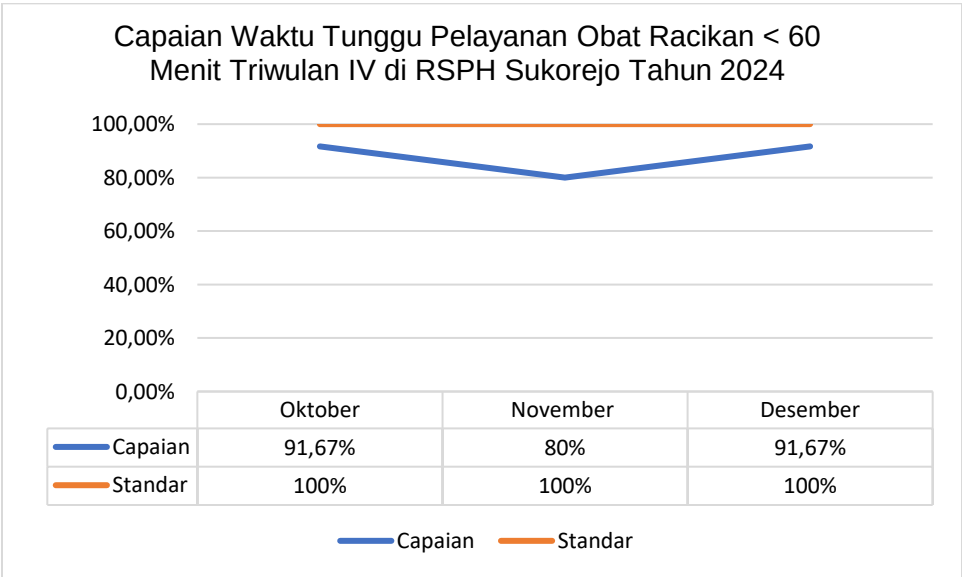
dengan subjek NAMA_POSISI YANG DILAMAR

Note: Upload berkas lamaran pekerjaan menjadi 1 file pdf

Batas Akhir Lamaran : 7 September 2024



Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan IV di RSPH Sukorejo Tahun 2024



Gambar Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan <60 Menit Triwulan IV di RSPH Sukorejo Tahun 2024

Tabel PDSA Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan < 60 Menit Triwulan IV pada Tahun 2024

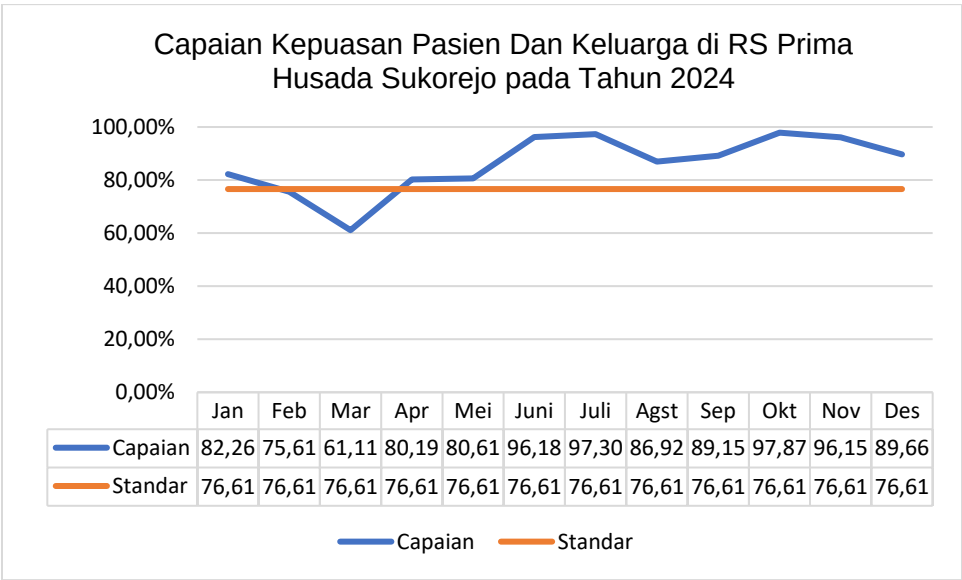
LEMBAR KERJA PDSA		
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan IV	SIKLUS: Ke 4
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi	PENANGGUNG JAWAB: Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes ANGGOTA TIM : Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.
PLAN		
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.		
Rumusan Masalah Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		
Penyebab Masalah Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.		
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi		

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah							
Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu							
Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan							
Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi							
Do							
No	Pelaksanaan / Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala	
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025			
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.		
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan			V	Novia Ainur Pratiwi, S.KM.		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.		
Study							
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).							
INPUT Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat racikan ini adalah 100% Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke IV ini yakni 87,78% PROSES							

PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat racikan masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 12 menit.					
Action					
No	Pelaksanaan / Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025	
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan			V	Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt

Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis

Kepuasan pelanggan



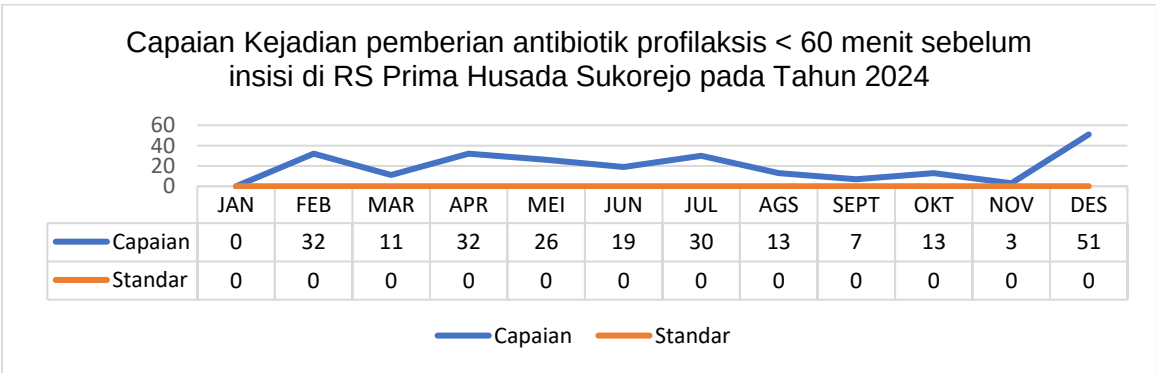
Gambar Capaian Kepuasan Pelanggan di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024 sudah mencapai standar yakni 86,08%. Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Pasien Tahun 2024 dari 600 pasien yang menyecan survey kepuasan terdapat 45 pasien yang tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit.

Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi



Gambar Capaian Kejadian Pemberian Antibiotik Profilaksis <60 menit sebelum insisi pada Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada tahun 2024 adalah 20 kejadian, angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian. Kejadian ini disebabkan 2 faktor yakni kejadian yang diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan Unit tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien.

Tabel PDSA Capaian Kejadian Pemberian Antibiotic Profilaksis < 60 Menit Sebelum Insisi Di Unit Farmasi pada Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada Tahun 2024 adalah 20 kejadian, dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi
Plan	Rencana : Menurunkan capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi Harapan : Kepatuhan kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi dapat tercapai 0 kejadian. Tindakan : Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar keterlambatan pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. Koordinasi dengan Unit dalam kelengkapan penulisan di Rekam Medik terkait jadwal pasien Operasi Koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. Supervisi terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis 2. Melihat penulisan RM terkait jadwal pasien Operasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 20 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi & Unit tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 20 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi & Unit tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel Rencana Tindak Lanjut

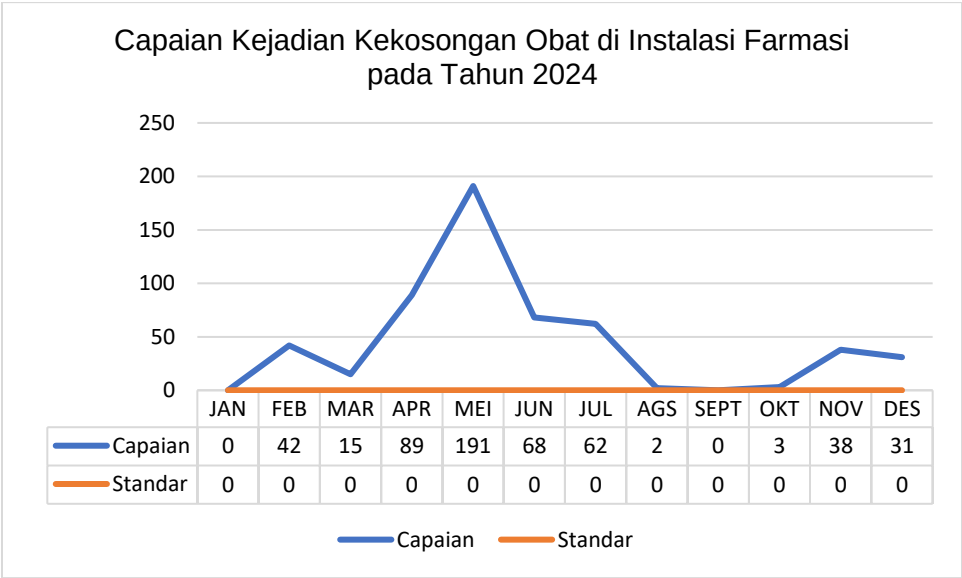
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------



1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi dalam kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Rapat koordinasi dengan kabid pelayanan, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan
2.	Koordinasi dengan kepala bidang keperawatan kepala ruang farmasi dan kepala Rawat Inap dalam kelengkapan penulisan jadwal pasien operasi di RM	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Perawat yang tidak lengkap dalam penulisan jadwal pasien operasi di RM	Rapat koordinasi dengan kabid keperawatan, karu farmasi dan karu Rawat Inap	Kabid Keperawatan, Karu Farmasi, dan Karu Rawat Inap	Satu bulan
3.	Supervisi terkait kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Memastikan bahwa petugas patuh dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Monitoring dan Evaluasi berkala	Karu Farmasi, Komite PMKP	Satu bulan

Analisis Capaian Indikator Manajemen Risiko

Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi



Gambar Capaian Kejadian Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi pada 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada tahun 2024 adalah 45 kejadian. angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian.

Tabel PDSA Capaian Kejadian Kekosongan Obat Di Instalasi Farmasi pada Bulan Agustus Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada bulan tahun 2024 adalah 45 kejadian dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi
Plan	Rencana : Menurunkan capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi Harapan : Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi dapat tercapai 0 kejadian. Tindakan : Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Daftar Obat yang mengalami kekosongan di Instalasi Farmasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ?

	Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 45 kejadian. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 45 kejadian. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.39. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.	Menurunkan kejadian kekosongan obat di Unit Farmasi	Daftar obat yang kosong dari depo dan Gudang Farmasi	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang dan kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

3.5.3. MUTU PRIORITAS INTERNAL UNIT
INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Tahun 2024

N o	Judul Indikat or	Bulan												Sta nd ar	Ra ta- rat a	Kete rang an
		Ja n	Fe b	M ar	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatu han identifikasi pasien	99, 31 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	99, 3%	99, 35 %	98, 71 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	100 %	99, 72 %	PDS A
2	Kepatu han upaya penceg ahan resiko pasien jatuh	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	98, 06 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	99, 35 %	100 %	99, 78 %	PDS A
3	Kepuas an pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80 %		PDS A

N o	Judul Indikat or	Bulan												Sta nd ar	Ra ta- rat a	Kete rang an
		Ja n	Fe b	M ar	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Waktu tangga p pelayan an dokter <5 menit setelah pasien datang	96, 49 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0%	90, 97 %	10 0%	10 0%	10 0%	96, 77 %	10 0%	10 0%	100 %	98, 69 %	PDS A
2	Kemati an pasien < 24 jam (sebelu m 8 jam)	7/ 13 41	6/ 12 74	4/ 14 84	0/ 15 10	12/ 16 37	12/ 13 95	10/ 15 41	16/ 14 71	16/ 15 24	14/ 16 12	11/ 15 91	13/ 15 91	≤ dua per seri bu	0,6 7%	PDS A
3	Kema mpua n mena ngani lifesav ing anak dan dewas a	10 0%	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0%	10 0%	10 0%	80, 97 %	10 0%	80, 97 %	80, 97 %	10 0%	100 %	95, 24 %	PDS A
4	Ketidak lengkap an pengisi an pengkaj ian medis IGD	0%	0 %	0 %	0 %	0,6 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0 5%	PDS A
5	Ketidak lengkap an pengisi an pengkaj ian kepera watan IGD	0%	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0 0%	Terc apai

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
6	Ketidak lengkap an formulir rujukan pasien	0%	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0 0%	Tercapai
7	Ketidak lengkap an dokum en casemi x BPJS	0%	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	20 %	0%	20 %	20 %	0%	0%	5%	PDS A

INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	94,81 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,57 %	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	64,17 %	67,62 %	100 %	77,5 %	73,73 %	77,39 %	-	76,15 %	85,58 %	85,19 %	87,20 %	86,67 %	100 %	80,11 %	PDSA
3	Kepuasan pasien	-	-	-	50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80 %	50,00 %	PDSA
4	Waktu tunggu rawat jalan	61,60 %	49,52 %	53,64 %	77,5 %	63,46 %	65,22 %	59,68 %	69,11 %	73,20 %	56,30 %	51,20 %	52,44 %	≥ 80 %	61,07 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	25,26 %	18,95 %	12,50 %	20 %	26,89 %	29,82 %	32,58 %	21,54 %	15,96 %	22,39 %	20,93 %	33,71 %	0%	23,38 %	PDSA
2.	Ketidakiengkapan pengisian pengkaj	13,85 %	0%	0%	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,15%	Tercapai

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	ian awal medis RJ															
3.	Ketidakl engkap an pengisi an pengkaj ian awal kepera watan RJ	9,2 3%	0%	0%	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7 7%	Tercapai
4.	Ketidakl engkap an PRMRJ pasien	10 0%	10 0%	10 0%	10 0 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	20 %	0%	93, 33 %	PDSA

INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepa tuhan identi fikasi pasie n	64, 35 %	7 8 %	80 %	93, 64 %	96, 19 %	96, 25 %	89, 52 %	91, 30 %	97, 00 %	83 ,4 8 %	87 ,2 7 %	91, 82 %	100 %	8 7, 4 0 %	PDSA
2	Kepa tuhan upay a penc egah an resik o pasie n jatuh	66, 96 %	7 3 %	93, 64 %	97, 14 %	66, 67 %	98, 75 %	81, 90 %	85 %	80 %	85 ,2 2 %	80 ,9 1 %	90, 91 %	100 %	8 3, 3 4 %	PDSA
3	Kepu asan pasie n	-	-	-	68, 75 %	47 %	100 %	100 %	92, 59 %	100 %	10 0 %	10 0 %	10 0%	≥ 80 %	8 9, 8 2 %	Tercapai
4	Kepa tuhan wakt u visite dokte r (06.0	47, 96 %	4 3 %	45, 45 %	51, 43 %	51, 43 %	52, 50 %	44, 78 %	45, 22 %	61 %	45 ,2 2 %	47 ,2 7 %	55, 45 %	≥ 80 %	4 9, 2 3 %	PDSA



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	0 – 14.00)															
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	50 %	-	-	-	75 %	-	-	-	-	≥ 80 %	62,5 %	Tidak ada pasien dengan diagnosis tunggal
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Kemampuan pasien < 48 jam	0,87 %	1 %	0%	0%	0,64 %	0%	1,9 %	0%	0%	1 %	0,54 %	2,97 %	≤ 0.24 %	0,74 %	PDSA
2	Kejadian pengalihan paksa	3 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	3 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	PDSA
3	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	35,34 %	36,00 %	14,55 %	4,4 %	22,86 %	5%	5,71 %	14,78 %	25 %	17,39 %	16,36 %	12,73 %	0%	17,51 %	PDSA
4	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	61,54 %	75 %	93,59 %	100 %	100 %	100 %	79,17 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92,44 %	PDSA
5	Terlaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinke s)		0 %												0 %	

INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93,79 %	96,13 %	95,48 %	96,67 %	95,48 %	96 %	94,84 %	100 %	97,37 %	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercaipai
3	Kepuasan pasien	-	-	-	100 %	-	100 %	-	84,62 %	100 %	100 %	83 %	100 %	≥ 80%	95,37 %	Tercaipai
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	65,71 %	56,14 %	81,51 %	50,68 %	55,48 %	48,30 %	43,87 %	45,39 %	45,33 %	45,81 %	56 %	47,10 %	≥ 80%	53,44 %	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada Pasien dengan diagn

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	Des			
	pathway)															ose Tung gal
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Kemati an pasien < 48 jam	0 %	2,5 4 %	4,2 %	30 %	22, 22 %	1,3 3%	0,65 %	2,6 3%	1,9 4%	1,4 6%	0 %	0,5 1 %	≤ 0.24 %	5, 6 2 %	PDS A
2.	Kejadi an pulang paksa	5 ke ja di an	3 ke j adi an	7 ke j adi an	5 ke j adi an	0 Ke jad ian	7 ke j adi an	10 keja dian	7 ke j adi an	1 ke j adi an	3 ke j adi an	0 ke j adi an	2 ke j adi an	0 keja dian	4 k e j a di a n	PDS A
3.	Kepatu han pengisi an pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	10 0, 00 %	73, 33 %	70, 27 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99, 13 %	10 0 %	99, 13 %	0%	9 5, 1 6 %	PDS A
4.	Kepatu han petuga s terhad ap komuni kasi efektif mengg unaka n SBAR	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	96, 55 %	92,9 0%	94, 84 %	94, 19 %	95, 48 %	95 ,3 3 %	96, 13 %	100 %	9 7, 1 2 %	PDS A

INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhanidentifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	95,33%	96,77%	96,77%	96,67%	97,42%	98,67%	97,42%	100%	98,25%	PDSA
2	Kepatuhanupaya	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%	97,42%	95,48%	93,55%	97,42%	100%	98,06%	100%	97,94%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Oktober	Nov	Des			
	pencegahan resiko pasien jatuh															
3	Kepuasan pasien	-	-	-	75 %	82 %	95,45 %	96,15 %	83,78 %	89,53 %	98,21 %	96,55 %	87,80 %	≥ 80 %	89,39 %	Dipertahankan
4	Kepuasan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	64,52 %	66,21 %	87,74 %	76 %	82,58 %	85,33 %	80,65 %	81,29 %	85,33 %	85,16 %	72 %	89,03 %	≥ 80 %	79,65 %	PDSA
5	Kepuasan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	75 %	75 %	50 %	70,83 %	50 %	52,78 %	75 %	75 %	91,67 %	≥ 80 %	68,36 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Kematian pasien < 48 jam	0 %	0 %	0 %	0,67 %	0 %	0,67 %	0 %	0,64 %	0 %	0 %	0,25 %	0 %	≤ 0,24 %	0,19 %	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	8 Kejadian	5 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kepuasan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	90,13 %	93,79 %	98,71 %	96,66 %	96,77 %	97,33 %	98,06 %	99,97 %	98 %	97,42 %	96,52 %	97,42 %	100 %	96,73 %	PDSA
4.	Kepuasan petugas	84,67 %	76,55 %	100 %	100 %	98,8 %	96,67 %	97,42 %	99,97 %	98,0 %	98,06 %	97,33 %	98,71 %	100 %	95,52 %	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des			
	as terhadap komunikasi efektif menggunakan SBA R									6 %						

INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	99,32%	100%	99,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,89%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	-	-	-	77,78%	92%	97,14%	100%	93,75%	95%	93%	100%	83%	≥ 76,61%	92,41%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	68,75%	70,34%	67,74%	58,11%	63,87%	52,67%	53,55%	64,43%	47,33%	73,91%	53,33%	60,65%	≥ 80%	61,22%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	≥ 80%	100%	

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des			
	palur klinis (clinical pathway)															
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Kematian pasien > 48 jam	0,65%	0%	1,29%	1,33%	1,29%	1,33%	0,65%	0%	0%	0,4%	0%	0,36%	≤ 0.24%	0,61%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 Kejadian	1 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	2 Kejadian	4 kejadian	5 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	40,41%	77,94%	73,43%	74,82%	79,05%	85%	94,19%	88,89%	97,90%	100%	96,64%	97,92%	100%	83,85%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komposisi efektif menggunakan SBA R	78,08%	88,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,19%	Dipertahankan

INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Tahun 2024



No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,72%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	2,26%	0%	0%	0,68%	0%	1,27%	2,23%	2,34%	2,25%	1,16%	4,52%	3,83%	≤ 5%	1,71%	
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Kejadian kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian operasi salah pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian salah tindakan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Tidak ada kejadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	an tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 %	0 %	0 %	0 %											
6.	Ketidaklengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7.	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Angka ketidaklengkapan inform consent	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
9.	Kejadian ketidaksiharian diagnosa pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
10.	Kejadian tidak dilaksanakan anjannya pengisian surgical safety checklist sesuai standar	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
11.	Angka ketidaklengkapan laporan operasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan
3.	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan

N o.	Indikator	Stan dar	Bulan												Stan dar	Ra ta- rata	Keteran gan
			J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s			
4.	Kejadian efek samping selama sedasi moderat	0 keja dian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertah ankan
5.	Kejadian tidak dilakukan nya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 keja dian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertah ankan
6.	Kejadian tidak dilakukan nya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 keja dian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertah ankan

MATERNITAS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,86%	96,13%	96,67%	97,42%	98,46%	96,55%	97,24%	96,00%	96,13%	95,33%	95,48%	100%	96,77%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,48%	94,48%	98,06%	97,90%	98,66%	93,08%	98,62%	98,71%	97,93%	100%	100%	100%	100%	97,74%	PDSA
3	Kepuasan pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	80%	≥ 80%	93,33%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	88,32%	88,52%	91,04%	94,21%	86,32%	97,27%	93,27%	90%	89,81%	94,50%	84,92%	81,91%	≥ 80%	90,01%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap	92,8	100%	93,3	100%	83,3	87,5	85,7	92,8	93,33%	82%	83,33%	100%	≥ 80%	91,19%	Dipertahankan



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
	p SC Cito	6 %		3 %		3 %	0 %	1 %	6 %							
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	60 %	50 %	66 %	92,7 %	86,6 %	95 %	99,26 %	85 %	96,88 %	-	≥ 80 %	81,29 %	Desember CP tidak terisi
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	Perdarahan 0 % Pre-eklampsia 0 % Sepsis ≤ 0 %	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Dipertahankan
2	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	100 %	100 %	100 %	96,38 %	97,95 %	100 %	93,27 %	100 %	98,56 %	97,82 %	97,10 %	81,91 %	100 %	96,92 %	PDSA
4	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan	97,83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,82 %	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
	n SBAR															

PONEK

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	1000%	1000%	1000%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	1000%	1000%	1000%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh tim ponek yang terlatih	1000%	1000%	1000%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kejadi an kematian ibu karen a persalinan	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre eklampsi ≤ 0%	Dipertahankan

[illegible]

NEONATOLOGI

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Tahun 2024

[illegible]



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	pencegahan resiko pasien jatuh															
3	Kepuasan pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	≥ 80 %	100 %	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	100 %	100 %	100 %	95,19 %	97,27 %	97,98 %	97,25 %	96,55 %	97,75 %	95,74 %	93,59 %	96,20 %	≥ 80 %	97,29 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
2	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	8,40 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,70 %	Dipertahankan
3	Kejadian tidak	1 kej	3 Kej	2 kej	2 kej	5 Ke	8 kej	12 kej	5 kej	6 kej	6 kej	5 kej	6 kej	0 kej	5 kej	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	k dilak uka n IMD pad a bayi baru lahir	a di a n	a di a n	a di a n	adi an	jad ian	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	
4.	Keti dak patu han pera wat terh ada p kom unik asi efek tif men ggu nak an SBA R	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertaha nkan

ICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kep atuh an ident ifika si pasi en	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Dipertah ankan
2	Kep atuh an upay a penc egah an resik o pasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Dipertah ankan



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	en jatuh															
3	Kepuasan pasien	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 80%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	71,43%	100%	90,63%	71,43%	53,19%	60%	73,33%	86,67%	62,50%	68,52%	86,21%	72,97%	≥ 80%	74,74%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3,23%	≤ 3%	0%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pengisian pengkajian dokumen kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan	100%	100%	100%	97,56%	100%	96,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBA R	0 %	0 %			0 %	7 %	0 %								

RADIOLOGI

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Tahun 2024

N o.	Indik ator	Bulan												Sta nd ar	Ra ta-rat a	Ketera ngan
		Ja n	Fe b	M ar	A pr	M ei	Ju n	Jul	Ag s	S ep	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kep atuh an ident ifikas i pasi en		10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0%	10 0 %	10 0 %	-	-	-	10 0%	10 0%	Belum diisi bulan Desem ber
2	Kep atuh an upay a penc egh an resik o pasi en jatuh		10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0%	10 0 %	10 0 %	-	-	-	10 0%	10 0%	Belum diisi bulan Desem ber
3	Kep uasa n pasi en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80 %		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Wakt u tung gu hasil pelay anan thora x foto		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	-	-	-	< 3%	-	Belum diisi bulan Desem ber

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Ra ta-rat a	Ketera ngan
		Ja n	Fe b	Ma r	A pr	Me i	Ju n	Jul	Ag s	S ep	Ok t	No v	De s			
	≤ 1 jam															
2.	Keja dian keluh an DPJ P atas pem baca an hasil radio logi		0 ke ja di an	0 ke ja di an	0 ke ja di an	0 Ke ja di an	0 K ej ad ia n	0 Kej adi an	0 Ke jad ian	0 K ej ad ia n	0 Kej adi an	0 Kej adi an	0 Kej adi an	0 ke ja di an	0 Kej adi an	Diperta hankan
3.	Angk a ketid aklen gkap an form ulir perm intaa n radio logi		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0%	Diperta hankan
4.	kejad ian kesal ahan cetak hasil radio logi		0 ke ja di an	0 ke ja di an	0 ke ja di an	0 Ke ja di an	0 ke ja di an	1 kej adi an	0 kej adi an	0 ke ja di an	0 kej adi an	0 kej adi an	0 kej adi an	0 ke ja di an	1 kej adi an	PDSA

LABORATORIUM

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Tahun 2024

N o .	Indikat or	Bulan												St an da r	Rat a- rat a	Keter anga n
		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatu han identi fikasi pasien	99, 91 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	99, 99 %	Dipert ahan kan
2	Pelapo ran nilai kritis ≤ 30 menit	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Dipert ahan kan
3	Kepua san pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80 %	-	
Indikator Mutu Prioritas-Unit																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Ok	No	Des			
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	97,62 %	99,2%	97,62 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,54 %	Dipertahankan
2.	Kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,83%	0,52%	0,83%	0,04%	0%	0,12%	0,40%	0,12%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0%	0,26%	PDSA
4.	Angka ketidaklengkapan formulir permintaan ke laboratorium	5,44%	5,46%	5,44%	4,09%	0%	4,86%	40,43 %	8,37%	5,95%	0%	21,35 %	19,95 %	0%	10,11 %	PDSA
5.	Kejadian kesalahan pemindahan hasil laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kejadian Ketidaktepatan waktu pemeliharaan alat KSO laboratorium oleh	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Ok	No	Des			
	teknisi dari vendor															
7.	Kejadian Keterlambatan Backup alat error dalam waktu 1x24 jam.	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium cito ≥ 30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
INDIKATOR MUTU PRIORITAS- UNIT BDRS																
9.	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	Dipertahankan
10.	Reaksi tranfusi darah	0%	0%	0%	0%	0%	1,8 9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	< 0,0 1%	0%	Dipertahankan
11.	Kejadian keterlambatan penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
12.	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

REHAB MEDIS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Tahun 2024

	Bulan			
--	-------	--	--	--

No.	Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Okt	Nov	Des	Standar	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	O F F	O F F	10 0%	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	10 0%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	O F F	O F F	10 0%	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	10 0%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	O F F	O F F	88 %	98 %	98 %	99 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	≥ 80 %	98, 20 %	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1.	Kejadian kesalahan tindakan fisioterapi	O F F	O F F	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Ketidakefektifan pengisian pengkajian medis & protokol pasien rehab medik	O F F	O F F	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Dipertahankan
3.	Ketidakefektifan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	O F F	O F F	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Dipertahankan

FARMASI

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																



1	Kepatuhan identifikasi pasien		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,43 %	97,6 %	96,36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,13 %	PDSA
2	Kepatuhan terhadap formulir umnasional		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien		-	-	81,13 %	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80 %	81,13 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit																
1	Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	-	-		65,64 %	65,88 %	89,25 %	87,04 %	68,42 %	56 %	73,98 %	56,80 %	69,03 %	100 %	70,23 %	PDSA
2	Waktu tunggu pelayanan Rasiikan ≤ 60 menit	-	-		80 %	85 %	95,45 %	87,50 %	90,91 %	90 %	91,67 %	80 %	91,67 %	100 %	88,02 %	PDSA
3	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat				0	0	1	1	3	4	0	3	1	0	1 kejadian	PDSA
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi		0 Kejadian	5 kejadian	89 kejadian	191 Kejadian	68 Kejadian	62 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	38 kejadian	31 kejadian	0 Kejadian	44 kejadian	PDSA
5	Kejadian pem		21 kej	15 kej	32 kej	26 Ke	20 kej	30 kej	13 kej	7 kej	13 kej	3 kej	51 kej	0 Kej	21 kej	PDSA

	beria n antibi otik profil aksis < 60 meni t sebel um insisi		adi an	adi an	adi an	jad ian	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	adi an	
6	Keja dian peru baha n pem beria n antibi otik profil aksis menj adi terau petik		33 Ke jad ian	11 kej adi an	18 kej adi an	11 Ke jad ian	13 Ke jad ian	27 Kej adi an	10 kej adi an	0 kej adi an	8 kej adi an	47 kej adi an	10 Kej adi an	0 Kej adi an	17 kej adi an	PDSA

GIZI

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Tahun 2024

No	Indikator	Bulan												Standar	Ratarata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	≥ 90 %	100 %	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	12%			19%			17%			17%			≤ 20 %	16 %	Triwulanan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka ketidaklengkapan pengisian	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%	0%	0%	0 %	Dipertahankan

	n asuhan gizi pasien rawat inap															
5 .	Kejadian ditemukan benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

REKAM MEDIS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Tahun 2024

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1 .	Ketidakterlengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	93,75 %	94,68 %	82,76 %	-	100 %	100 %	100 %	20 %	85 %	13 %	6%	3%	0%	63,47 %	PDSA
2 .	Kelengkapan informed consent tindakan	100 %	100 %	100 %	100 %	-	82,76 %	96,3%	98,90 %	94,17 %	95,69 %	94 %	88,51 %	100 %	95,48 %	PDSA
3 .	Kelengkapan general consent	100 %	100 %	100 %	74,73 %	88 %	93,10 %	97,59 %	96,04 %	100 %	100 %	100 %	98,84 %	100 %	95,69 %	PDSA
4 .	Kejadian nomor rekam medis ganda	4 kejadian	5 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 Kejadian	2 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	6 kejadian	7 kejadian	8 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
5 .	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6 .	Kelengkapan RM pasien rawat inap	62,50 %	93,42 %	-	-	-	-	82 %	63 %	78 %	55 %	63 %	72 %	100 %	7112 %	PDSA

	(nama, TTD, jam, tgl,)															
7	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	94,74 %	14,84 %	-	31,54 %	91 %	96,77 %	84,38 %	91,89 %	98,11 %	96,08 %	97 %	84,38 %	0%	80,07 %	PDSA

LIMBAH – K3RS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Oktober	Nov	Des			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD 11,51 mg/l b. COD 33,30 mg/l c. TSS 5.1 mg/l d. PH 7.5	.a. BOD 14,09 mg/l b. COD 40,62 mg/l c. TSS 13,7 mg/l d. PH 7.6	a. BOD 12,8 mg/l b. COD 36,96 mg/l c. TSS 5.1 mg/l d. PH 7.5	a. BOD 7,75 mg/l b. COD 30,14 mg/l c. TSS 5,3 mg/l d. PH 7,12	a. BOD 19,15 mg/l b. COD 43,70 mg/l c. TSS 5,1 mg/l d. PH 7,4	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	Dipertahankan	
2.	Pengelolaan limbah padat infeksi sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.	Angka ketidakpatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	16,74%												0%	16,74%	PDSA
4.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

SDM

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0 %	0 %	35 %	54 %	79,41 %	79,41 %	18,18 %	18,18 %	13,64 %	13,64 %	33,09 %	16,18 %	100 %	30,06 %	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	67%												≥ 60 % dalam 1 tahun	67 %	Dipertahankan

3	Angka turn over staf	12,81%												≤10 %	12,81 %	PDSA
4	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	31 Kejadian	15 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	3 Kejadian	1 kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	2 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	5 Kejadian	PDSA
5	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	1,22 %	2,68 %	0,67 %	2,71 %	1,79 %	1,33 %	0,48 %	0,91 %	13,03 %	10,73 %	34,45 %	17,05 %	0%	7,25 %	PDSA
6	Angka staff tersertifikasi khusus IGD: BLS/PPG D/G ELS/ALS PONEK: PPG D ICU HD IKO	1,31 %	33,5 %	33,5 %	33,5 %	34,15 %	33,98 %	34,47 %	34,95 %	61,65 %	63,68 %	63,67 %	100 %	38,49 %	PDSA	
7	Kepuasan karyawan	-	-	-			55,1 %	55,1 %	55,51 %	55,51 %	88 %	88 %	88 %	≥ 80 %	69 %	PDSA
8	Response time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan

KESEKRETARIATAN

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Oktober	Nov	Des			

															rat a	
1.	Tindak lanjut penyel esaian hasil pertemun direksi	87,50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,96 %	Dipert ahakan
2.	Ketepatan waktu pengumpul an laporan bulana n unit ke sekret ariatan	92,59 %	75 %	100 %	89,29 %	89,29 %	85,71 %	75 %	100 %	100 %	92,86 %	96,43 %	100 %	100 %	91,35 %	Dipert ahakan
3.	Ketepatan pendis tribusi an surat masuk	100 %	97,96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97,98 %	96,94 %	98,11 %	97,75 %	100 %	98,32 %	100 %	98,92 %	Dipert ahakan
4.	Ketepatan pendis tribusi an surat keluar	100 %	98,89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,82 %	98,84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,71 %	Dipert ahakan

DRIVER

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Tahun 2024

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rat a - rat a	Keteran gan
		J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	Sep	Ok t	No v	De s			
1.	Angka ketersedi an ambulan ce sesuai kebutuha n ≤30 menit									100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertah akan
2.	Kepuasa n penggun a ambulan ce													≥80 %		Belum Diisi
3.	Kepatuh an pelaksan aan dekonta									100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertah akan

	minasi ambulac e															
4.	Response time driver ambulance < 5 menit									97,65%	100%	100%	100%	100%	99%	PDSA

PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Tahun2024

N o.	Indikato r	Bulan												Sta nda r	Ra ta - rata	Ketera ngan
		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

ATEM – IPSRS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Tahun 2024

N o .	Indik ator	Bulan												Sta nda r	Rata - rata	Keter anga n
		J a n	F e b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Okt	No v	Des			
ATEM																
1 .	Wak tu tang gap keru saka n alat medi s non critic al 1x24 jam		1 0 0 %	83, 78 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	≥ 80 %	98,5 3%	Dipert ahank an
2 .	Wak tu tang gap keru saka n alat medi		8 6, 8 4 %	10 0 %	10 0 %	95 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	95, 65 %	100 %	100 %	97,9 5%	Dipert ahank an

	s critic al ≤ 15 meni t															
3.	Kete pata n wakt u pem eliha raan alat medi s		1 0 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100, 00%	Dipert ahank an
4.	Kete pata n kalib rasi alat sesu ai deng an jadw al		1 0 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipert ahank an
IPSRs																
1.	Wak tu tang gap keru saka n alat non medi s ≤ 15 meni t		8, 7 %	10, 10 %	11, 03 %	11, 99 %	13, 5 %	12, 20 %	13, 10 %	18, 84 %	9,3 9%	13, 78 %	12,8 0%	100 %	12,3 1%	PDSA
2.	Wak tu tang gap kesi apan fung si alat gens et ≤ 10 detik		1 0 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipert ahank an

LAUNDRY

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	Des			

1	Kejadian linen hilang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	46 Kejadian	45 kejadian	0 kejadian	8 kejadian	PDSA
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1x24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kejadian terdapat benda asing di linen	0 kejadian	7 kejadian	1 kejadian	5 kejadian	5 Kejadian	3 Kejadian	2 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	PDSA
4	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

CSSD

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1	Kejadian kehilangan set instrumen	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	standar															
3.	Waktu tunggu pelayanan steriliisasi steam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70%	100%	95%	PDSA
5.	Perse ntase set instrumen yang sudah dibersihkan dan tepat waktu dari unit yang dikembalikan ke CSSD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6.	Perse ntase hasil biological test negative pada BMH P reuse	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7.	Terpa sangnya label	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	ED pada instrumen															
8.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

CLEANING SERVICE

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Kepatuhan clening service dalam memberikan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤ 2/3 tempat sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Sta ndar	Ra ta-rata	Ketera ngan
		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
4.	Kepatuhan petugas dalam member sihkan area umum 2x dalam sehari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diperta hankan

KEAMANAN

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Tahun 2024

N o.	Indikator	Bulan												Sta ndar	Rat a-rata	Ket era ngan
		Jan	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag s	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kejadi an kehilangan barang milik pasien, peng gungj ung dan karya wan	5 kejadi an	0 ke ja dian	1 k ej a dian	1 k ej a dian	0 k ej a dian	3 k ej a dian	0 ke ja dian	1 kejadi an	1 keja dian	0 keja dian	0 keja dian	2 keja dian	0 keja dian	1 keja dian	PD SA
2.	Kepat uhan petug as keam anan mela ksan akan peng awas an kelilin g RS 2x dala m setia p shift	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dip erta han kan
3.	Kepat uhan jam berku njung sesu ai	62, 89 %	89 ,2 6 %	90, 6 5 %	84, 8 3 %	87, 9 0 %	89, 5 0 %	92 ,1 0 %	94 ,5 2 %	93,6 7%	95,1 6%	94 %	97,1 0%	100 %	89,3 0%	PD SA

	keten tuan																
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GUDANG UMUM

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	100%	97,44%	56,63%	40,58%	86,36%	46%	95,33%	95%	73,28%	87,88%	97,06%	100%	-	100%	79,60%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (Soda kartustock)	0%	1,03%	0,55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0,14%	PDSA
3.	Kejadiankompaindariser	0kejadian	2kejadian	0kejadian	0kejadian	0kejadian	0Kejadian	2kejadian	1Kejadian	1Kejadian	0kejadian	0kejadian	0kejadian	-	0kejadian	1kejadian	PDSA

4.	Kepatuhan pengajuan pengaduan ke PT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
----	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

PPI

Tabel 3.69 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Okt	Nov	Des			
1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	-	-	-	-	-	48,71%	56,25%	56,25%	56,25%	56,25%	56,25%	56,25%	Anggota Tim PPI yang terlatih 75%		PDSA
2.	Tersedia APD di setiap instalasi/depot		97,46%	100%	98,17%	96,9%	100%	98,99%	99,37%	99,56%	99,81%	100%	100%	60%	99,11%	PDSA
3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/H		54,19%	88,02%	57,76%	63,69%	74,86%	83,43%	75,27%	92,85%	17,46%	83,52%	54,29%	75%	67,76%	PDSA



No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	AI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)															
4.	Kepatuhan HH	75,36%	73,57%	73,20%	73,23%	67,79%	78,30%	77,18%	71,97%	74,54%	69,79%	77,63%	69,57%	≥ 85%	73,51%	PDSA
5.	Kepatuhan APD	91,78%	95,56%	93,68%	96,37%	90,09%	90,88%	96,59%	93,86%	93,13%	90,83%	93,68%	91,40%	≥ 80%	93,15%	Dipertahankan
6.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0%	0,53%	0%	0%	0,55%	0%	0,48%	0%	0%	0,54%	0,50%	0%	0,24%	PDSA
7.	Angka kejadian VAP pada pasien ICU	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan
8.	Angka kejadian infeksi pada pe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	De s			
	masan gan CV C pada pasien ICU															
9.	Angka phl ebit is		10,19%	0,72%	0,54%	1,23%	1,96%	0,86%	0,32%	0,41%	1,11%	1,15%	0,57%	≤ 1,5%	1,73%	PDS A
10.	Kepatu han pen em pat an pasien infe ksiu s		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,62%	100%	99,78%	PDS A

PKRS

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	Des			
1.	Angka ketidaku patuhan petug as dalam memb erikan eduka si kelompok	OFF	OFF	86,61%	77,68%	88%	42,86%	31,25%	42%	46%	39,29%	47,32%	57,14%	0%	55,82%	PD SA
2.	Kepat uhan petug as dalam pengis ian SBAR	OFF		50%	55,56%	63,64%	91,14%	98,08%	96%	100%	92,50%	100%	100%	100%	84,69%	PD SA
3.	Kepat uhan pelaks anaan	OFF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dip erta han kan

eduka si terinte grasi & kolabo rasi																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Verifikator pada Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Ok	Nov	Des			
1.	Kesesuaian coding diagnosis dan tindakan sesuai dengan INA-CBGS	100%	99,77%	99,94%	99,99%	99,96%	99,99%	99,98%	99,98%	100%	99,98%	100%	99,98%	99,94%	100%	99,96%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas terhadap penyeteroran rekam medis BPJS Kesehatan ≤ 24jam	100%	91,67%	90,72%	91,13%	91,58%	87,85%	85,11%	87,56%	87,89%	88,27%	89,39%	52,7%	74,76%	100%	84,88%	PDSA
3.	Kepatuhan DPJP dalam mengisi resume medis	100%	91,78%	95,17%	93,55%	92,67%	92,90%	92,67%	100%	92,67%	90,67%	89,33%	89,54%	87,74%	100%	92,39%	PDSA
4.	Ketidakefektifan berkas penunjang klaim pelayanan	0%	9,03%	2,07%	1,29%	4,00%	1,29%	2,00%	0%	2,67%	2,67%	2,67%	2,0%	3,87%	0%	2,80%	PDSA

HUMAS & MARKETING

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Kepuasan pelanggan	35,26 %	O F F	-	80,19 %	80,61 %	96,18 %	83,33 %	81,71 %	83,33 %	100 %	100 %	100 %	≥ 80 %	84,06 %	Dipertahankan
2.	Ketidapatuhan update dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	O F F	0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2,97%	0%	0%	0%	0,27%	PDSA
3.	Kenaikan jumlah pasien baru	58,33 %	O F F	20,28	22,27 %	26,43 %	30,99 %	26,82 %	19,14 %	20,77 %	23,20 %	29,98 %	21,32 %	10 % / bulan	27,23 %	Dipertahankan

CSO

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	Nov	Des			
1.	Respon time CSO <30 mnt (WA)	-	-	-	100 %	-	61,73 %	82,45 %	68,22 %	13,39 %	17,81%	17,38%	16,78%	100 %	47,22 %	PDSA

MOD-MPP

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1	Kepuasan pelanggan	82,26 %	75,61 %	61,11 %	80,19 %	80,61 %	96,18 %	97,30 %	86,92 %	89,15 %	97,87 %	96,15 %	89,66 %	≥ 80 %	88,35 %	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	Dipertahankan
3	Angka ketidakefektifan	0%	0%	0%	0%	0%	43,33 %	54,41 %	14,81 %	67,03 %	20,75 %	25,57 %	17,42 %	0%	20,28 %	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okta	Nov	Des			
	Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP															
4	Angka ketidakepatuhan form Discharge planning	0%	0%	0%	3,45%	35,77%	43,33%	59,09%	14,81%	67,03%	20,75%	25,57%	17,42%	0%	23,94%	PDSA

TB di IRJA

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB di IRJA pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okta	Nov	Des			
1	Ketidakepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak terpanjanya pasien TB oleh PIC TB	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan

KEUANGAN

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okta	Nov	Des			
1	Persentase selisih uang setoran kasir	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Oktober	Nov	Des			
	dengan LHK (Laporan harian kasir)															
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	<5%	0 %	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
4	Ketepatan waktu pembayaran kepada pihak rekana													100 %		Pihak Rekana di Urus oleh PT sehingga data tidak bisa diambil
5	Jumlah piutang ≥1m / bulan	1 %	0.3 %	1 %	17 %	27 %	29 %	17 %	3 %	22 %	11 %			0%	14 %	Jumlah piutang di bulan Desember 2024 tidak bisa diambil dikarenakan PT belum laporan

TIM HIV

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Oktober	Nov	Des			

1	Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian pasien drop out pengobatan HIV	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

KB

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Ketidakpatuhan pengisian kartu K4 KB		0 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %	Dipertahankan
2.	Terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca Keguguran		22 %	14,79 %	24,24 %	17,14 %	15,13 %	17,91 %	21,37 %	16,93 %	18,56 %	10,57 %	13,45 %	50 %	17 %	PDSA
3.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB		100 %	100 %	100 %	100 %	94,37 %	82,72 %	81,88 %	80,51 %	94,38 %	89,13 %	83,80 %	30 %	92 %	Dipertahankan

STUNTING

Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okto	Nov	Des			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi, pasien stunting dan wastening tiap 3 bulan sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	S e p	O kt	Nov	Des			
	waktu yang ditentukan															

IT - SIM RS

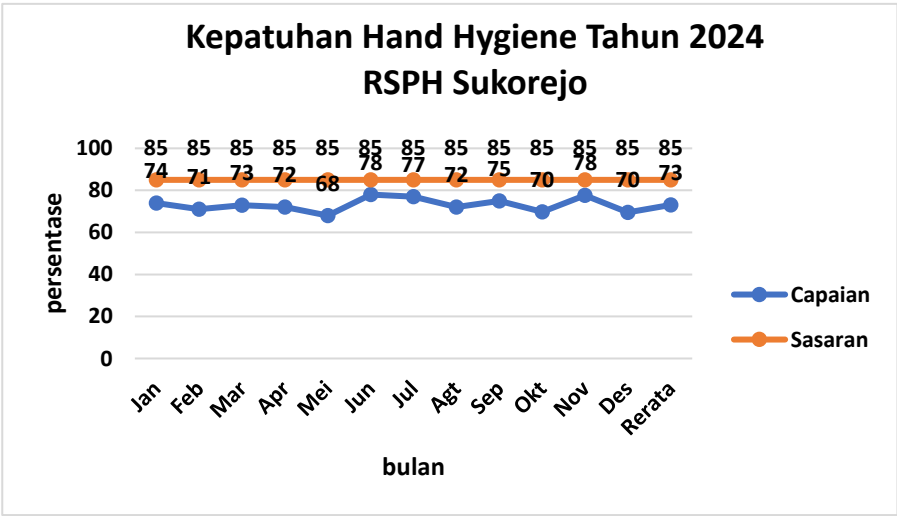
Tabel Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Tahun 2024

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	S e p	O kt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan 1 minggu sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	83,33%	78,95%	87,50%	84,62%	100%	100%	100%	91,67%	77,78%	100%	100%	90,91%	100%	91%	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan komputer < 10 menit	100%	33,33%	80%	83,33%	100%	100%	75%	85,71%	100%	90,91%	100%	100%	100%	87%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan komputer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	63,64%	87,84%	100%	100%	100%	46,15%	44,12%	57,45%	44,83%	45,45%	44,44%	33,33%	100%	64%	PDSA

3.6 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

I. Kepatuhan Kebersihan Tangan

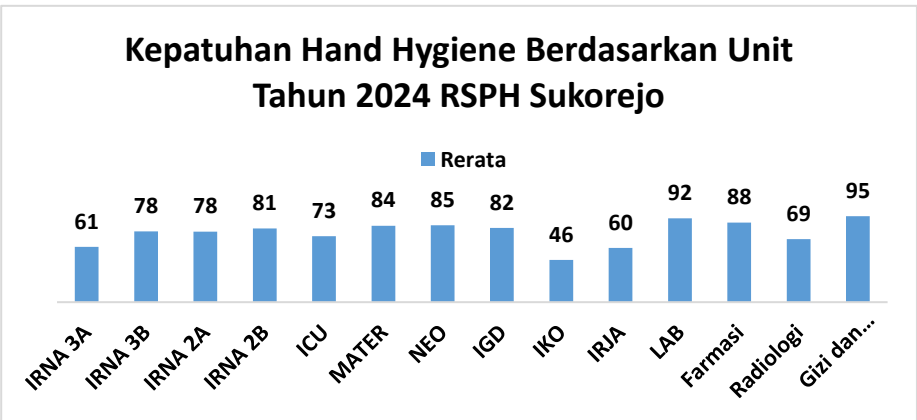
Gambar Grafik Kepatuhan Kebersihan Tangan Secara Total



Interpretasi : Pada gambar tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan *hand hygiene* di tahun 2024 stabil di 73% dibandingkan tahun sebelumnya, dan belum mencapai sasaran.

Kepatuhan per unit (pelayanan medis)

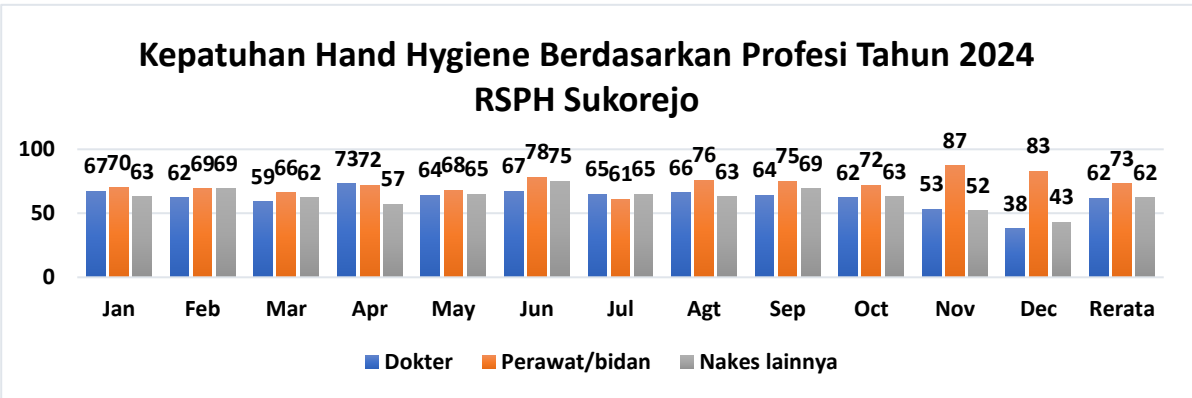
Gambar Grafik Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasrkan Unit



Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan *hand hygiene* berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah Neonatologi. Sedang unit dengan rerata kepatuhan terendah adalah unit IKO sebesar 46%.

Kepatuhan berdasarkan profesi

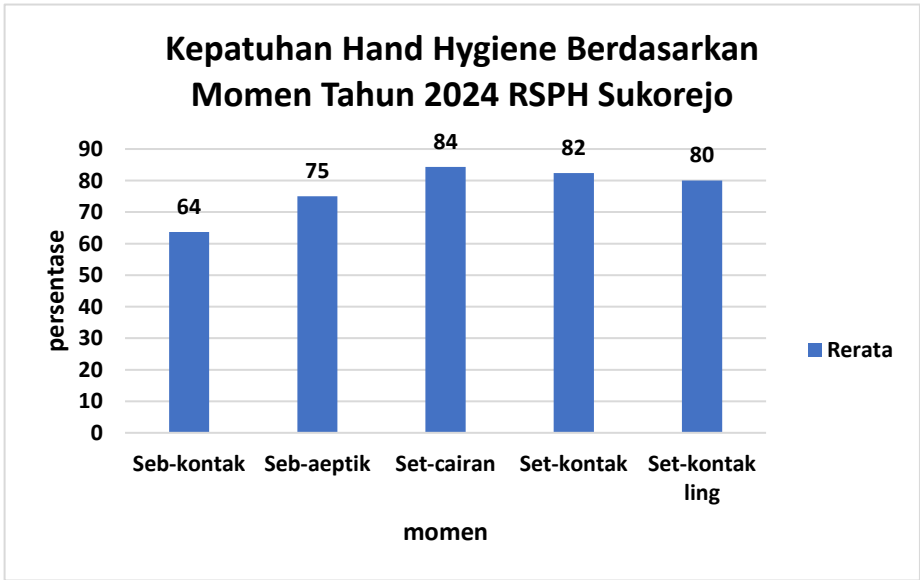
Gambar Grafik Kepatuhan *Hand Hygiene* Berdasarkan Profesi



Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan *hand hygiene* per profesi tertinggi adalah profesi perawat yaitu sebesar 73%, walaupun belum mencapai sasaran atau target.

Kepatuhan berdasarkan 5 momen

Gambar Grafik Kepatuhan Hand Hygien Berdasarkan Momen



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan *hand hygiene* berdasarkan 5 momen tahun 2024 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum menyentuh pasien sebesar 64%, sedangkan momen setelah menyentuh cairan tubuh pasien sudah mencapai 84%.

Kepatuhan fasilitas kebersihan tangan

Gambar Grafik Kepatuhan Fasilitas Hand Hygiene

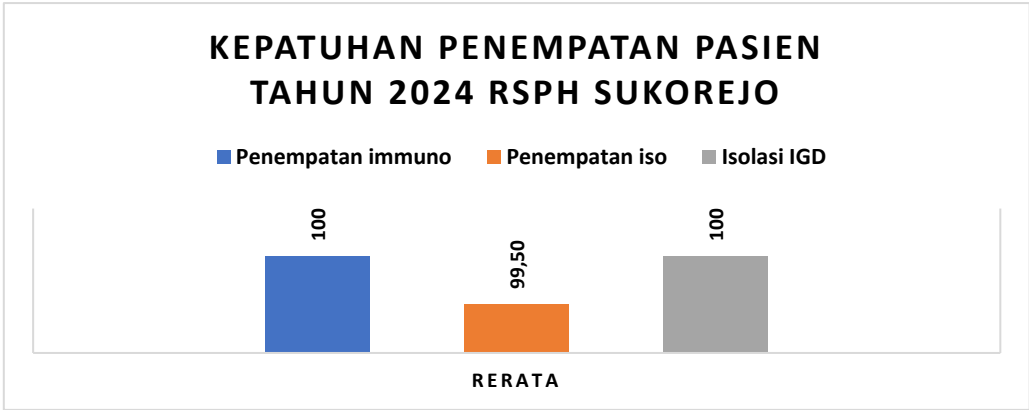


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata fasilitas kebersihan tangan tahun 2024 sebesar 89% belum mencapai 100%.

Tabel PDSA Fasilitas Kebersihan Tangan dan Kepatuhan *Hand Hygiene*

PROBLEM	Persentase kepatuhan <i>hand hygiene</i> tahun 2024 sebesar 73% dan belum memenuhi target $\leq 85\%$
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan <i>hand hygiene</i> secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk staf lama melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi.
DO	Kepatuhan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
STUDY	rerata kepatuhan <i>hand hygiene</i> di tahun 2024 stabil di 73% dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai sasaran. rerata kepatuhan <i>hand hygiene</i> berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah Neonatologi. Sedang unit dengan rerata kepatuhan terendah adalah unit IKO sebesar 46%. rerata kepatuhan <i>hand hygiene</i> per profesi tertinggi adalah profesi perawat yaitu sebesar 73% walaupun belum mencapai sasaran. rerata kepatuhan <i>hand hygiene</i> berdasarkan 5 momen tahun 2024 terendah adalah momen sebelum menyentuh pasien sebesar 64%, sedangkan momen setelah menyentuh cairan tubuh pasien belum mencapai 85%. rerata fasilitas kebersihan tangan tahun 2023 sebesar 89% belum mencapai 100%.
ACTION	Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar Kolaborasi dengan kabid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan Re-edukasi SPO <i>hand hygiene</i> berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Berikan feedback hasil audit dan monitoring Pemberian teguran saat melakukan supervisi <i>hand hygiene</i> .

Kepatuhan Penempatan Pasien
Gambar Grafik Kepatuhan Penempatan Pasien

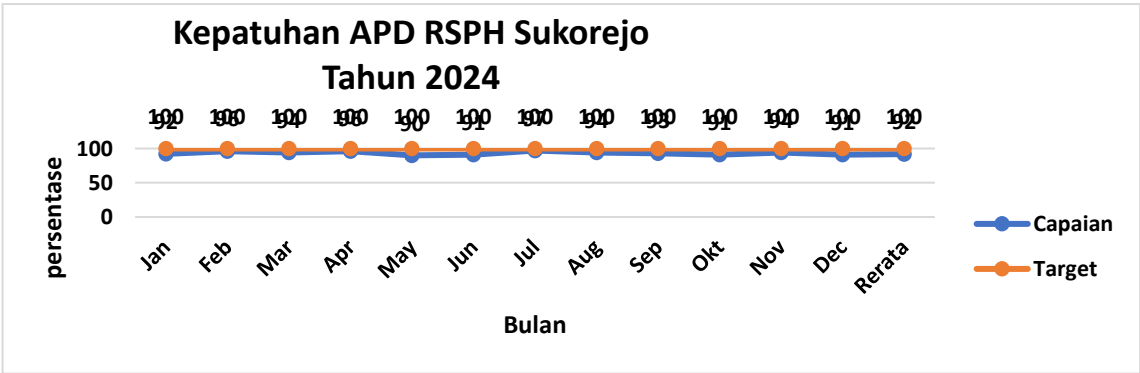


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien mencapai target 99.5% di tahun 2023.

Tabel PDSA Kepatuhan Penempatan Pasien

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien belum mencapai 100%.
STEP	Tetap menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait penempatan pasien dengan penularan transmisi untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam penempatan pasien di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit penempatan pasien di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penempatan pasien. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien di unit. Menghimbau unit IGD terkait skrining pertama pasien, jika ada gejala dengan penularan transmisi, pasien wajib diarahkan ke IGD pinere.
DO	Kepatuhan penempatan pasien mencapai 100%
STUDY	rerata kepatuhan penempatan pasien mencapai target 99.5% di tahun 2024 Masih ditemukan penunggu pasien isolasi TB yang tidak menggunakan masker, memasang tikar, dan membiarkan pasien dikunjungi banyak orang sehingga berisiko tinggi penularan pasien ke pengunjung. CS selalu melakukan disinfeksi permukaan ketika ruang isolasi maupun kohorting kosong untuk meminimalisir penularan ke pasien selanjutnya.
ACTION	Resosialisasi kepada staf terkait penempatan pasien Beri feedback pada hasil temuan. Beri teguran saat melakukan monitoring penempatan pasien di unit.

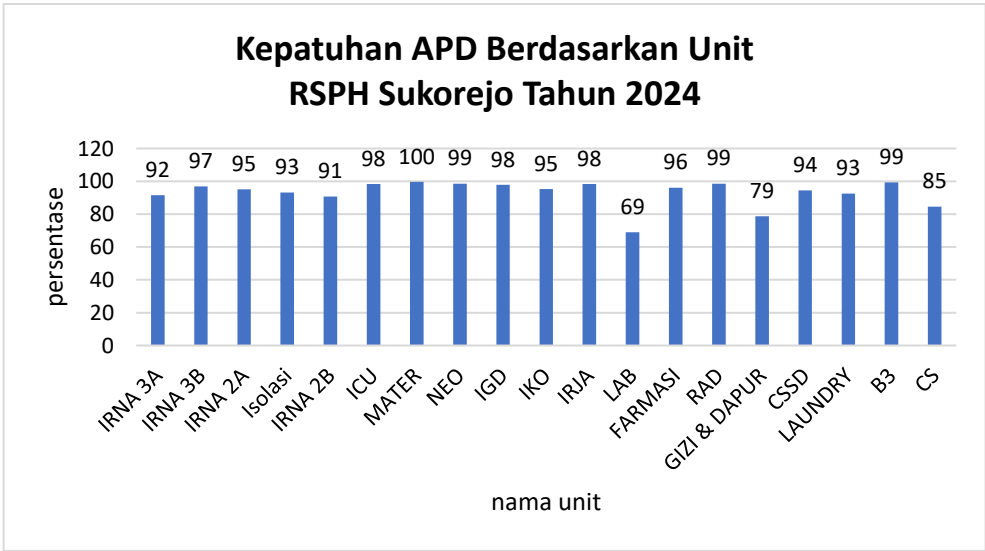
Penggunaan APD
Kepatuhan Penggunaan APD
Gambar Grafik Kepatuhan Penggunaan APD



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD pada tahun 2024 yaitu sebesar 92%, belum mencapai sasaran.

Kepatuhan Penggunaan APD Berdasarkan Unit

Gambar Grafik Kepatuhan Penggunaan APD Berdasarkan Unit



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD tahun 2024 yang terendah adalah unit LAB sebesar 69% dan tertinggi di unit pelayanan Maternitas yakni 100%.

Tabel PDSA Penggunaan APD

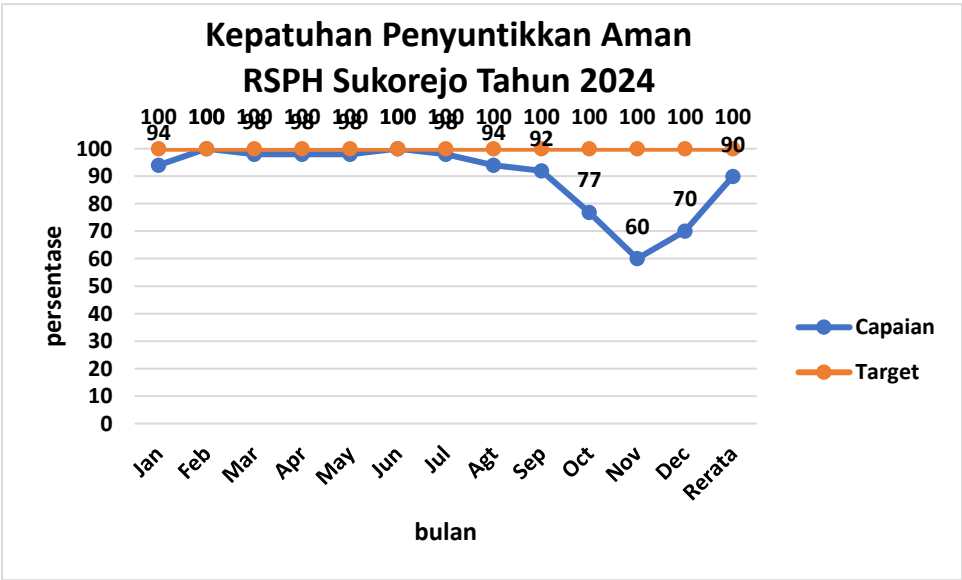
PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD secara tepat Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit. Koordinasi dengan Karu unit terkait kepatuhan staff dalam penggunaan APD untuk dimasukkan kedalam penilaian kinerja
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2024
STUDY	Rerata kepatuhan penggunaan APD pada tahun 2024 yaitu sebesar 92%, belum mencapai sasaran.

	Rerata kepatuhan penggunaan APD tahun 2024 yang terendah adalah unit LAB sebesar 69%. Ditemukan beberapa masalah seperti, Masih ditemukan CS yang menggunakan <i>handscoon</i> saat membuang limbah ke TPS. Masih ditemukan perawat yang menggunakan <i>handscoon</i> saat sebelum melakukan tindakan dan membawa troli dari <i>nurse station</i> Masih ditemukan CS tidak menggunakan sarungtangan saat melakukan pengambilan sampah di masing-masing unit Masih ditemukan petugas Lab tidak menggunakan gown di area sampling
ACTION	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. Beri feedback pada hasil temuan. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Kepatuhan penyuntikkan yang aman dan pencegahan pajanan benda tajam

Kepatuhan Penyuntikkan yang Aman

Gambar Kepatuhan Penyuntikan yang Aman



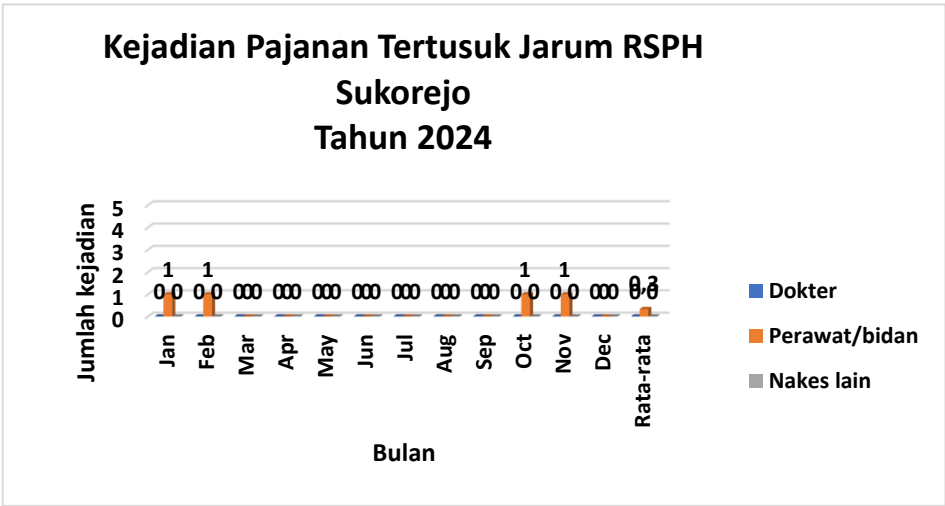
Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rerata kepatuhan penyuntikkan yang aman tahun 2024, sebesar 90% tidak mencapai sasaran 100%.

Tabel PDSA Kepatuhan Penyuntikan Aman

PROBLEM	Hasil audit menunjukkan penyuntikkan yang aman belum keseluruhan mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait kepatuhan penyuntikkan yang aman untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan

	pasien, serta mengurangi risiko tertusuk jarum bekas pakai
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam penyuntikkan yang aman di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai dan risiko tertusuk jarum dapat ditekan. Tindakan Melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penyuntikkan yang aman Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit.
DO	Mempertahankan kepatuhan penyuntikkan yang aman mencapai 100%
STUDY	Rerata kepatuhan penyuntikkan yang aman tahun 2024, sebesar 90% tidak mencapai sasaran 100%. Masih ditemukan petugas yang kurang menerapkan prinsip teknik <i>one hand</i> saat memasukkan obat dalam ampul ke spuit (all unit) Ditemukan petugas tidak melakukan kebersihan tangan saat akan melakukan penyuntikkan, karena sudah menggunakan handscoon, sedangkan kebutuhan handrub di bed pasien terpenuhi Ditemukan cairan WI yang digunakan untuk oplos obat digunakan lebih dari 1 kali dan dalam waktu yang lama tidak ditutup sehingga risiko terpapar kuman diunit IGD Ditemukan petugas cairan pelarut yang digunakan berulang pada jarak waktu yang agak jauh di IGD dan rawat inap, selain itu petugas tidak melakukan disinfeksi area injeksi dengan alcohol swab berulang
ACTION	Resosialisasi kepada staf terkait penyuntikkan yang aman Beri feedback pada hasil temuan. Beri teguran saat melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit.

Kejadian pajanan
Gambar Grafik Kejadian Pajanan Tertusuk Jarum



Interpretasi: Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kejadian pajanan tahun 2024 adalah 4 kejadian di bulan Januari, Februari, Oktober dan November.

Data Staff terpajan dapat di akses :

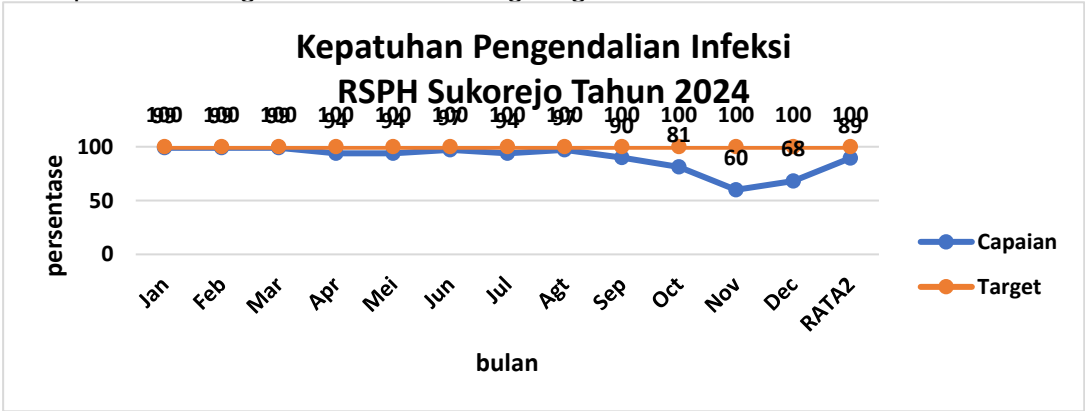
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Apgrc5ZAP_6CereOpfJG7GYMY9qnMD6p/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true

Tabel PDSA Kepatuhan penyuntikkan yang aman dan pencegahan pajanan benda tajam

PROBLEM	Di tahun 2024 masih ada kejadian tertusuk jarum. Namun, dari adanya pajanan tersebut terdapat alur pasca pajanna yang telah diperbarui.
STEP	Tetap menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait kejadian tertusuk jarum dan pelaporannya.
PLAN	Rencana: Meningkatkan kepatuhan pelaporan kejadian pajanan di unit. Harapan Seluruh staf patuh melaporkan kejadian pajanan di unit Tindakan Melakukan himbauan terkait pelaporan Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penyuntikkan yang aman Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit.
DO	Mempertahankan kejadian pajanan 0 kejadian dengan kepatuhan pelaporan 100%.
STUDY	Menurunnya kejadian pajanan bisa dikarenakan petugas sudah melaksanakan Teknik penyuntikkan yang aman dengan baik. Dapat dimungkinkan juga petugas tidak mengumpulkan form pajanan sesuai alur yang sudah dibagikan. Belum ada tindak lanjut yang dapat mengetahui efek jangka Panjang dari staf terpajan penyakit menular, hal ini dapat memungkinkan rendahnya pelaporan pajanan dari unit.
ACTION	Resosialisasi kepada staf terkait pelaporan kejadian pajanan Beri feedback pada hasil temuan. Berkoordinasi dengan K3RS dan SDM terkait tindak lanjut staf terpajan penyakit menular. Berkoordinasi dengan K3RS dan SDM terkait skrining penyakit menular melalui pengajuan TOR MCU serta vaksin HBsAg untuk staf yang berisiko tinggi. Beri teguran dan himbauan jika ada kejadian pajanan di unit.

Kepatuhan Pengendalian Infeksi Lingkungan

Gambar Grafik Kepatuhan Pengendalian Infeksi Lingkungan



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan tahun 2024 yaitu sebesar 89%, belum mencapai sasaran 100%.

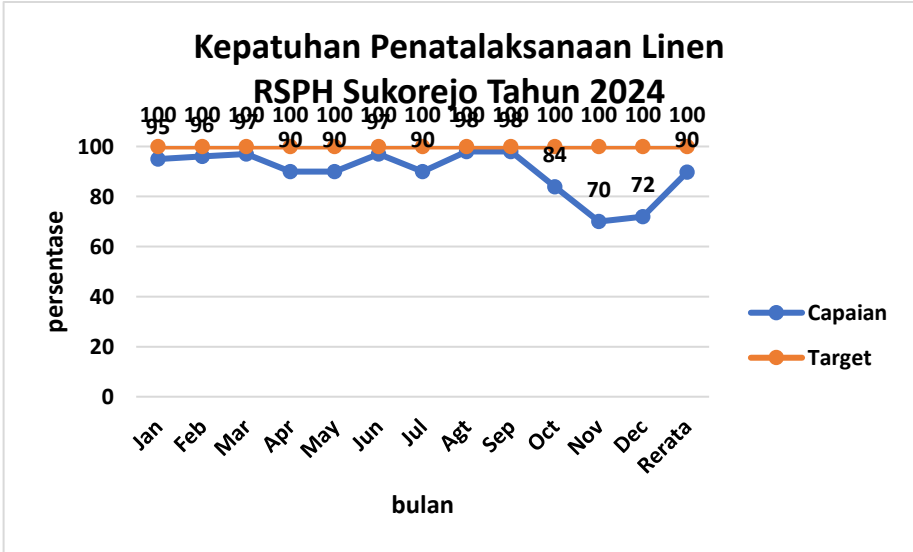
Tabel PDSA Kepatuhan Pengendalian Infeksi Lingkungan

PROBLEM	Persentase kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan belum mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	Rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan tahun 2024 yaitu sebesar 89%, belum mencapai sasaran 100%. Petugas belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Masih ditemukan pembersihan kamar pasien KRS tidak maksimal, terutama kamar kosong. CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau
ACTION	Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. Beri feedback pada hasil temuan.

	Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi
--	--

Kepatuhan Penanganan Linen

Gambar Grafik Kepatuhan Penanganan Linen



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penanganan linen tahun 2024 yaitu sebesar 90%.

Tabel PDSA Kepatuhan Penanganan Linen

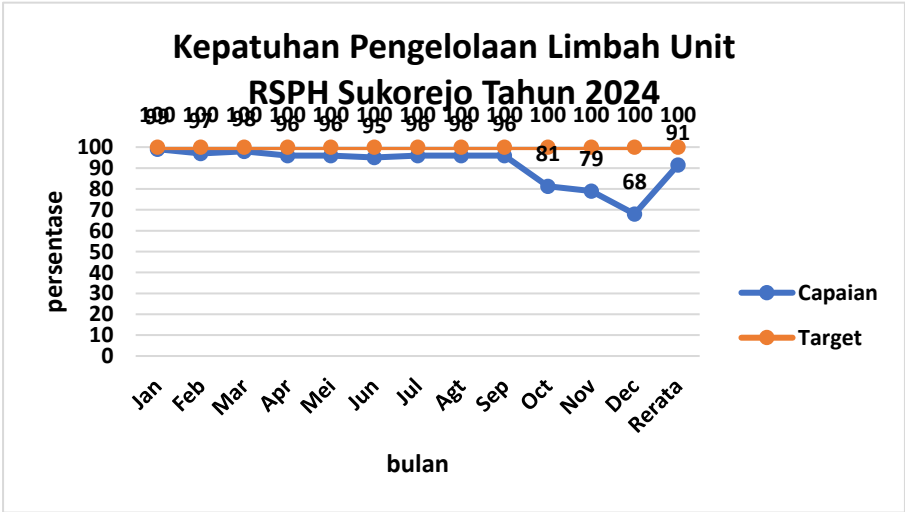
PROBLEM	Persentase kepatuhan penanganan linen belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit londri mengenai pentingnya penanganan linen untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan penanganan linen di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam penanganan linen di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit penanganan linen di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penanganan linen di unit laundry. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penanganan linen di unit. Berkordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai
DO	Kepatu Kepatuhan penanganan linen mencapai 100% di bulan berikutnya
STUDY	Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%.

	Kepatuhan penanganan linen mencapai 100% di bulan berikutnya. Masih ditemukan petugas yang tidak patuh terhadap prinsip area infeksius dan non infeksius. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD dengan tepat di area infeksius.
ACTION	Resosialisasi kepada staf terkait penanganan linen Beri feedback pada hasil temuan. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. Monitoring progress pembersihan ruangan

Kepatuhan Penanganan Limbah

Kepatuhan pemilahan limbah (infeksius dan non infeksius)

Gambar Kepatuhan Penanganan Limbah (Infeksius dan non infeksius)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan pemilahan sampah di unit tahun 2024 yaitu sebesar 91%, belum mencapai sasaran.

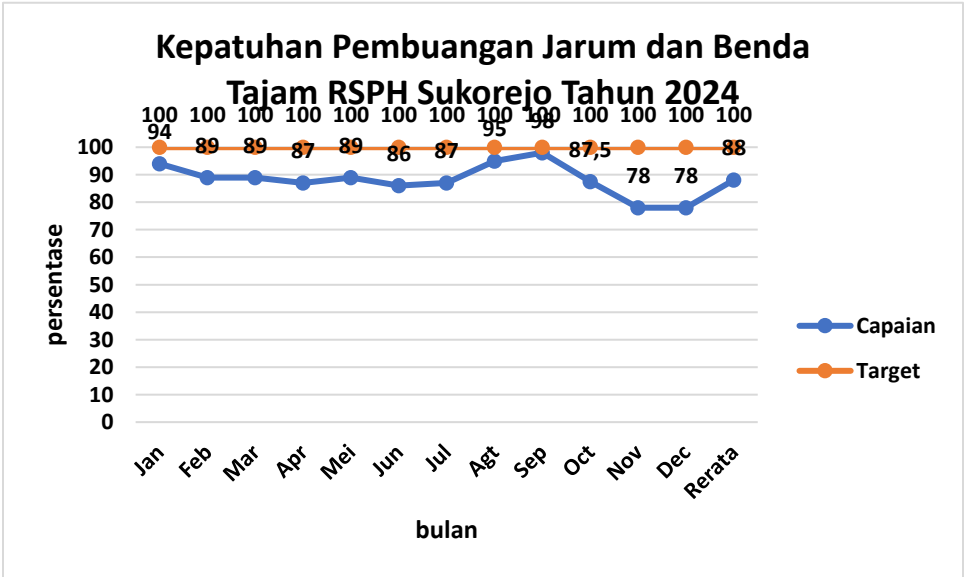
Tabel PDSA Kepatuhan Pemilihan Sampah (Infeksius dan Non Infeksius)

PROBLEM	Persentase kepatuhan pemilahan sampah di unit belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pemilahan sampah di unit baik infeksius maupun non infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam pemilahan sampah di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pemilahan sampah di unit.

	Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah di unit.
DO	Kepatuhan pemilahan sampah meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	Kepatuhan pemilahan sampah di unit stabil 92% belum mencapai 100%. Ditemukan limbah tidak segera dibuang diunit pelayanan terutama rawat inap. Ditemukan cara mengikat limbah infeksius belum tepat Ditemukan limbah yang penuh tidak segera diganti dikarenakan jam pembuangan limbah dari unit 1x
ACTION	Review pengelolaan limbah di unit kepada staf terutama staf cleaning service terkait pemilahan sampah di unit, motivasi petugas untuk patuh dalam pemilahan limbah di unit. Beri feedback pada hasil temuan. Jika ada sampah yang tercampur, follow up ke unit segera untuk dipilah Catat nama unit asal di limbah yang tidak terikat dengan baik sebagai hasil evaluasi kinerja.

Kepatuhan Pembuangan Limbah Benda Tajam

Gambar Grafik Kepatuhan Pembuangan Limbah Benda Tajam



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam tahun 2024 yaitu sebesar 88%, belum mencapai sasaran 100%.

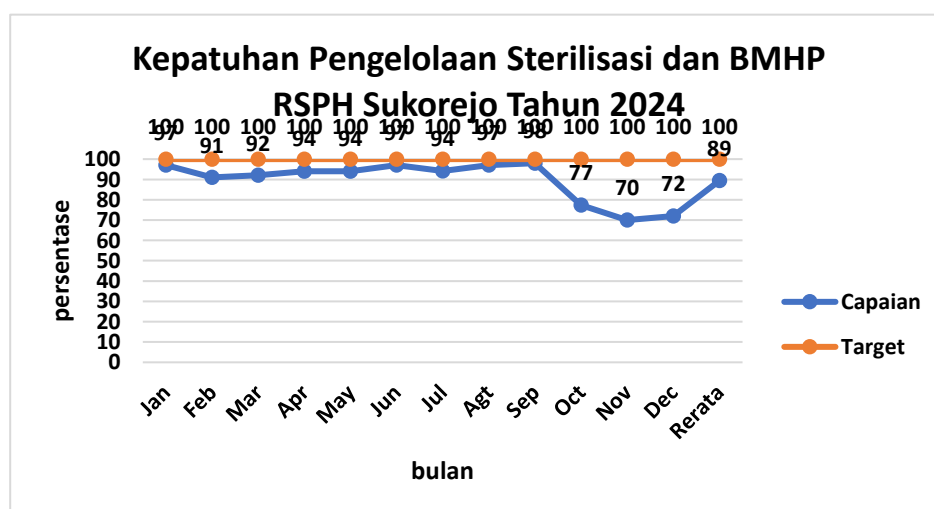
Tabel PDSA Kepatuhan Pembuangan Limbah Benda Tajam

PROBLEM	Persentase kepatuhan pembuangan limbah benda tajam belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan

	Harapan Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit.
DO	Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam tahun 2024 yaitu sebesar 88%, Masih ditemukan pengadaan Safety box tidak tahan tusukan dan mudah tembus air, dan tidak ada tutupnya. Ditemukan safety box yang tidak segera dibuang saat $\frac{3}{4}$ penuh dan tidak menggantung di unit pelayanan.
ACTION	Review kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam. Beri feedback pada hasil temuan. Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.

Kepatuhan Pemrosesan Peralatan Kesehatan (Dekontaminasi CSSD)

Gambar Grafik Kepatuhan Pemrosesan Peralatan Kesehatan (CSSD)



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan pemrosesan alat tahun 2024 yaitu sebesar 89%, belum mencapai sasaran.

Tabel PDSA Kepatuhan Pemrosesan Alat

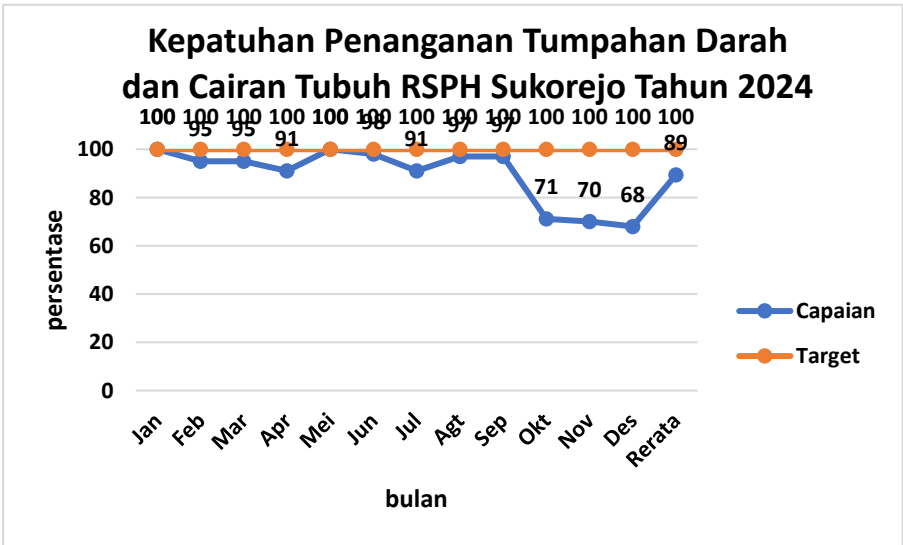
PROBLEM	Persentase kepatuhan pemrosesan alat mencapai 100%
STEP	Menghimbau semua staf di unit CSSD mengenai pentingnya pemrosesan peralatan kesehatan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan pada alat yang digunakan.
PLAN	Rencana:

	Mengetahui kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf patuh dalam pemrosesan peralatan kesehatan di unit CSSD sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit pemrosesan peralatan kesehatan di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pemrosesan peralatan kesehatan di unit CSSD. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit. Berkoordinasi dengan CSSD terkait peningkatan kepatuhan staf unit terkait pengambilan alat bersih maupun pengiriman alat kotor.
DO	Kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan mencapai 100%
STUDY	Kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit belum mencapai 100%. Ditemukan beberapa alat steril di unit tidak dilakukan monitoring oleh petugas CSSD sehingga ditemukan beberapa alat seperti JR, bagging dan set rawat luka sudah ED. Ditemukan beberapa peralatan seperti bengkok tampak kotor dan berkarat serta terdapat noda yang sulit dibersihkan.
ACTION	Motivasi petugas untuk mempertahankan kepatuhan Beri feedback pada hasil temuan. Monitoring kepatuhan pengiriman alat kotor dan pengambilan alat bersih sesuai jadwal.

Program Penunjang PPI

Kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh

Gambar Grafik Kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh



Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh tahun 2024 mencapai 89%, belum mencapai sasaran.

Tabel Data Penggunaan Spillkit Unit 2024

No	Area	Bulan Ke-												Penggunaan Spill Kit	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ya	Tidak
1	CS lt. 1	1		1						1				√	
2	CS lt. 2	7	1		5	2	4		4	1				√	
3	CS lt.3	19	3	2	5	1	1	1						√	
4	CS IGD	2	3	5	5			4	1	3	2			√	
5	CS IKO			4	4	5		5	5	4	5	6	4	√	

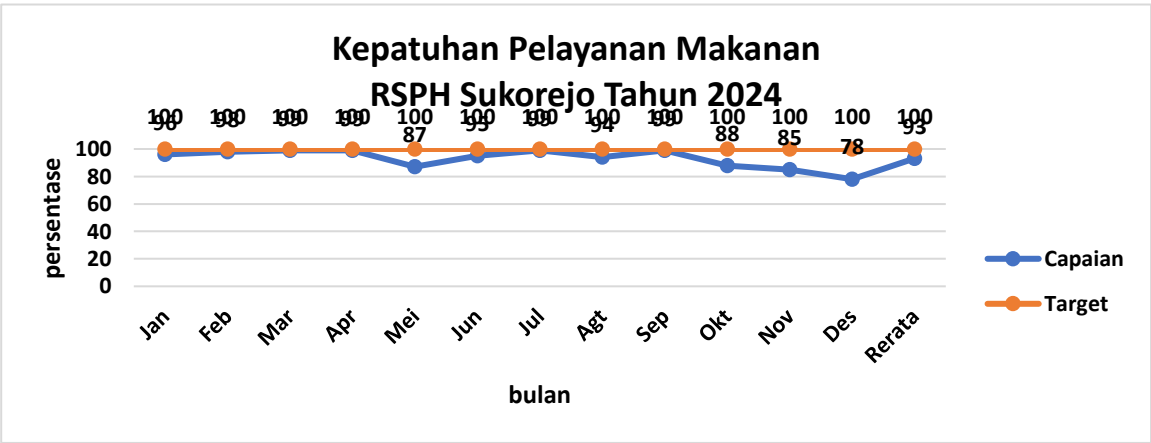
Atau dapat di lihat di link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJ2cYhxLEXF1gQeDar711ImA6H7SEFkAzLSRJgikxbo/edit?usp=sharing>

Tabel PDSA Kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh Pasien

PLAN	Meningkatkan kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh hingga mencapai target yaitu 100%.
DO	Monitoring kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh dilakukan menggunakan form supevisi Checklist supervise spilkit belum 100% berjalan.
STUDY	Rerata kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh tahun 2024 mencapai 89%, belum mencapai sasaran. Pelaporan tumpahan lengkap dilakukan oleh tim CS apabila ada tumpahan. Ditemukan tumpahan dan percikan darah di troli injeksi IRNA 2A
ACTION	Beri feedback hasil temuan. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Kepatuhan Pelayanan Makanan
Gambar Grafik Kepatuhan Pelayanan Makanan



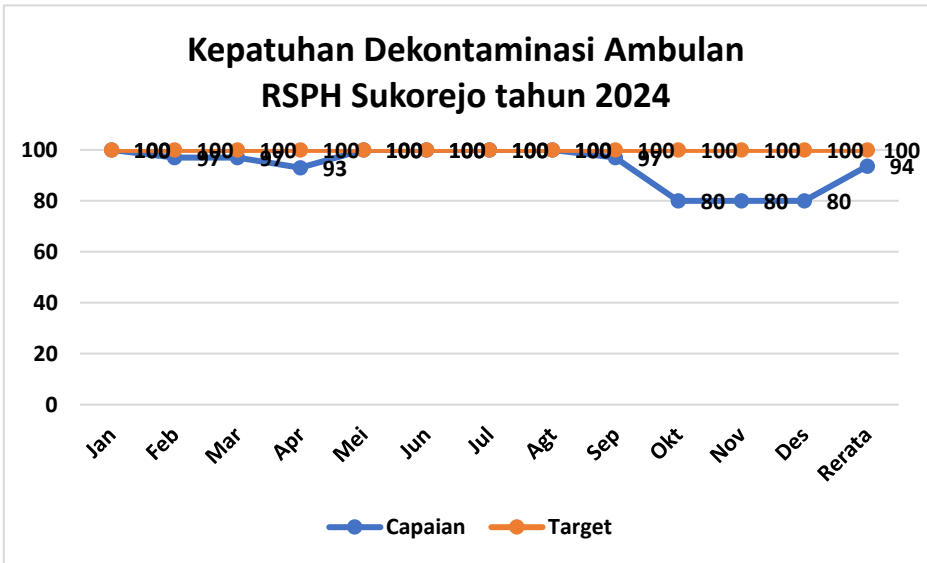
Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rerata kepatuhan pelayanan makanan tahun 2024 adalah 93%.

Tabel Kepatuhan Pelayanan Makanan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di rumah sakit hingga mencapai target 100%.
DO	Monitoring kepatuhan pelayanan makanan menggunakan form supervise Audit kebersihan tangan dan penggunaan APD menggunakan form audit
STUDY	rerata kepatuhan pelayanan makanan tahun 2024 adalah 93%. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD dengan tepat. Ditemukan makanan yang sudah masak, tidak ditutup. Ditemukan barang-barang siap olah di gudang makanan tertempel di dinding dan tidak ada jarak rak dan dinding Ditemukan hewan rodent di area dapur
ACTION	Beri feedback hasil temuan Koordinasi dengan CS pantry terkait kebersihan ruang dapur dan gizi Monitoring kebersihan tangan dan penggunaan APD di dapur

Dekontaminasi Ambulan

Gambar Grafik Dekontaminasi Ambulan



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan dekontaminasi ambulan tahun 2024 mencapai 94%.

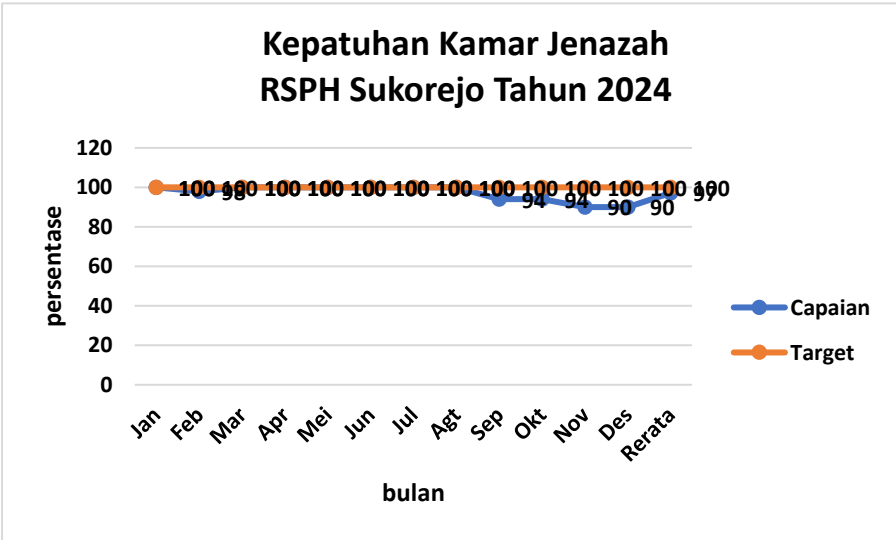
Tabel PDSA Kepatuhan Dekontaminasi Ambulan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan dekontaminasi ambulan 100%
DO	Monitoring dan supervisi yang telah dilakukan terhadap dekontaminasi ambulan menggunakan form supervise
STUDY	kepatuhan dekontaminasi ambulan tahun 2024 mencapai 94% Pemenuhan fasilitas seperti sprayer sudah dilakukan, namun ketika setelah transfer pasien dengan penyakit menular, tidak segera dibersihkan total Ditemukan BHP dari unit rawat inap tertinggal didalam ambulan

	Petugas tidak menggunakan APD yang sesuai ketika membersihkan ambulan
ACTION	Beri feedback hasil temuan. Koordinasi dengan koordinator driver terkait SPO pembersihan ambulan terutama setelah transportasi pasien infeksi menular.

Kepatuhan Penatalaksanaan Kamar Jenazah

Gambar Grafik Kepatuhan Kamar Jenazah



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah mencapai 97%.

Tabel PDSA Kepatuhan Penatalaksanaan Kamar Jenazah

PLAN	Meningkatkan kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah 100%
DO	Monitoring dan supervisi yang telah dilakukan terhadap penatalaksanaan kamar jenazah menggunakan form supervisi
STUDY	Rerata Kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah mencapai 97% Monitoring kebersihan ruangan perlu dipertahankan, serta kesiapan perlengkapan petugas pemulasaran. Pencatatan pelaporan harus dipertahankan.
ACTION	Koordinasi dengan petugas untuk pembersihan kamar jenazah secara rutin Tingkatkan supervisi pencatatan terkait serah terima jenazah.

Kesehatan karyawan

Tabel Data Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
Jumlah		-	-	-	-	-	Sisa staf yang belum MCU = 82	
	Januari	-	-	-	-	-	-	
	Februari	-	-	-	-	-	Dilakukan swab rectal pada 10 staf dapur dengan hasil dianalisa RTL : Konsultasi dengan DPJP dr. Dimas, Sp. Pd KIE personal hygien pada petugas dengan bakteri yang teranalisis	4 staf dapur dengan salmonella sp 1 staf dapur dengan klebsiella ozaenae
	Maret	-	-	-	-	-	-	
	April	-	-	-	-	-	-	
	Mei	23	23	23	23	23	Dari 32 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 23 orang	
	Juni	57	57	-	57	57	Dari 71 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 57 orang, ditemukan 1 staf IGD HBsAg +	
	Juli	72	72	72	72	72	Dari 92 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 72 orang	
	Agustus	58	58	-	58	58	Dari 60 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 58 orang.	

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
		-	-	-	-	-	Dilakukan swab rectal pada 9 orang staf dapur	
	September	97	44	53	97	97	Dari 159 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 97 orang	
	Oktober	69	66	3	69	69	Telah dilakukan MCU sebanyak 69 orang	
	November	2	2	-	2	2	Telah dilakukan MCU sebanyak 2 orang	
	Desember	-	-	-	-	-	-	

Analisis:

Berdasarkan data kesehatan karyawan diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa jumlah karyawan yang belum melakukan MCU dalam waktu 2024.

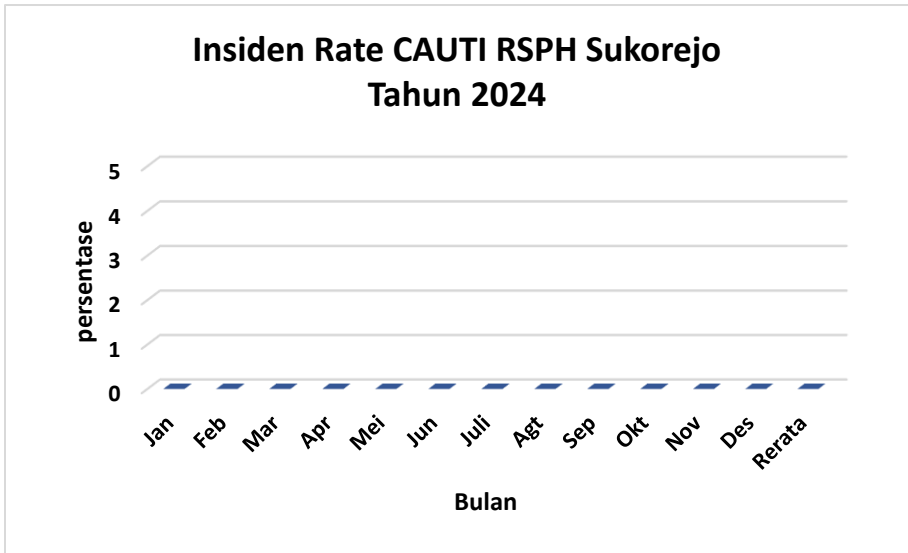
Rencana Tindak Lanjut:

- Koordinasi dengan Komite K3RS dan SDM terkait pelaksanaan MCU berikutnya.
- Koordinasi dengan staff terkait untuk melakukan cek kesehatan di ;uar rumah sakit dengan melakukan cek kesehatan di instansi pemerintah

Surveilans HAIs

Infeksi Saluran Kemih (CAUTI)

Gambar Grafik Surveilans HAI's Infeksi Saluran Kemih



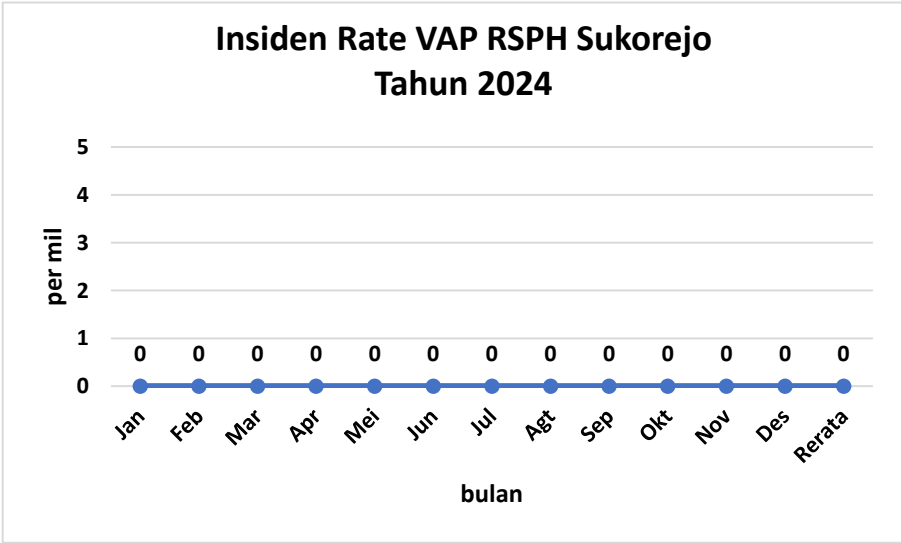
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2024 tidak ada kejadian ISK akibat pemasangan urine catheter di rumah sakit.

Tabel PDSA Surveilans HAI's Infeksiu Saluran Kemih

PLAN	Mempertahankan angka ISK yang sudah sangat baik.
DO	Untuk surveilans menggunakan form surveilans google spreadsheet yang diinput oleh IPCLN
STUDY	Jarangnya kejadian ISK pada unit perawatan dapat disebabkan karena pemakaian kateter yang tidak terlalu lama dan perawatan rutin oleh perawat ruangan serta penggantian rutin kateter setelah 7 hari pemasangan.
ACTION	Monitoring pelaksanaan bundles ISK di unit Koordinasi pelatihan pemasangan dan perawatan kateter pasien dengan komite keperawatan.

Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Gambar 3.3.10.2 Grafik Surveilans HAI's Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

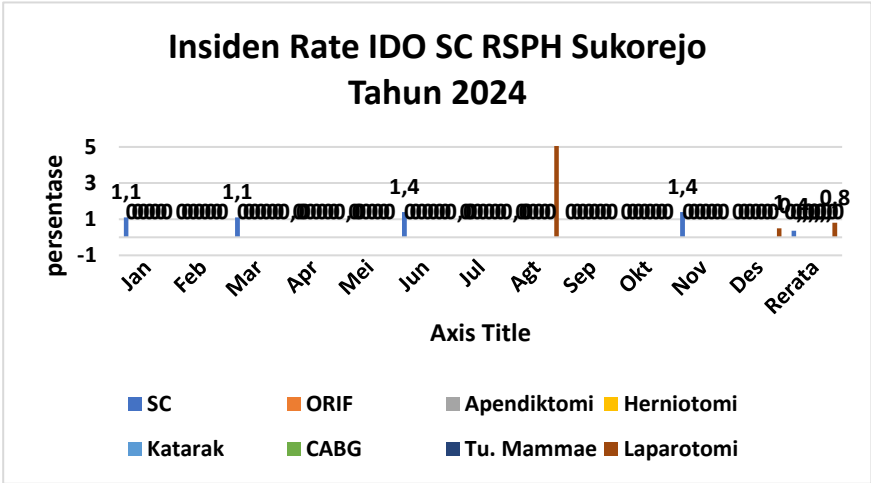


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa tahun 2024 tidak ada kejadian VAP akibat pemasangan ventilator di rumah sakit.

Tabel PDSA Surveilans HAI's VAP

PLAN	Melaksanakan bundles VAP sesuai SPO Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN Supervisi oleh IPCN Mempertahankan angka VAP sesuai standar yaitu 0 %.
DO	Surveilans VAP dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Ditemukan petugas tidak melakukan cuci tangan saat Tindakan pemasangan ventilator. Pemakaian ventilator banyak dilakukan di unit ICU dan pemakaiannya langsung dalam pantauan DPJP anastesi dan pemeliharaan alat langsung dilakukan oleh petugas IPSRS.
ACTION	Monitoring pelaksanaan bundles VAP di unit Koordinasi perawatan dan pembersihan alat dengan IPSRS

Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Data pasien IDO 2024 dapat di akses pada link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nuuy3Csnsc8uGIZnDJico6ZdWDhdFhH/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>

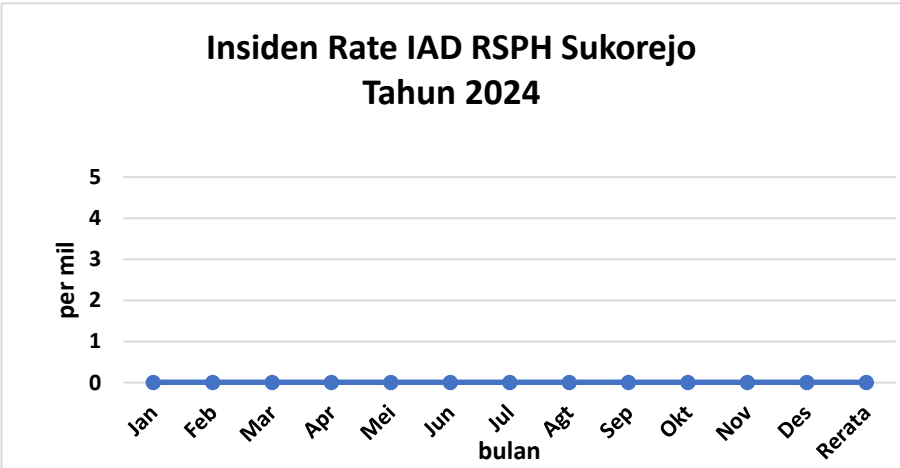
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2024 kejadian kejadian IDO sebesar 0,8% kasus operasi SC dan laparotomi, Hal ini bisa disebabkan karena : pembersihan R Ok yang kurang/masih belum rutin dilakukan, Mandi chlorin untuk H-1, pembersihan kamar Operasi saat pergantian pasien masih kurang maksimal.

Tabel PDSA Surveilans HAI's IDO

PLAN	Evaluasi bundles IDO pada tahap pre op, intra op, dan post op. Melaksanakan surveilans dan bundles IDO sesuai prosedur Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN Supervisi oleh IPCN
DO	Pemantauan Pengisian form audit bundles pre op yang diinput oleh tim Maternitas melalui google spreadsheet. Pemantauan Pengisian form surveilans IDO yang diinput oleh tim IKO melalui <i>google spreadsheet</i>
STUDY	Rerata kejadian IDO di tahun 2024 adalah sebesar 0,8% kasus operasi. Penyebab yang memungkinkan terjadinya IDO adalah karena kurang terjaganya personal hygiene pasien, kurang cukupnya asupan protein yang menyebabkan luka tidak segera mengering, kurangnya mobilisasi pasien, dan jadwal kontrol yang kadang melebihi waktu yang ditentukan oleh DPJP. Kurang kuatnya edukasi petugas terhadap bundles IDO fase post op.
ACTION	Beri feedback hasil temuan Monitor pelaksanaan bundles IDO pada saat prosedur operasi maupun pada saat prosedur perawatan luka. Tingkatan edukasi perawatan pasien pasca operasi untuk menghilangkan mitos-mitos masyarakat tentang operasi. Koordinasi dengan pengadaan farmasi terkait cairan antiseptik untuk mandi pasien yang akan operasi serta alat cukur yang lebih berisiko rendah untuk cedera. Koordinasi dengan dokter operator dan tim IKO lainnya terkait berjalannya bundles operasi.

Infeksi Aliran Darah (IAD)

Gambar 3.3.10.4 Grafik Surveilans HAI's IAD



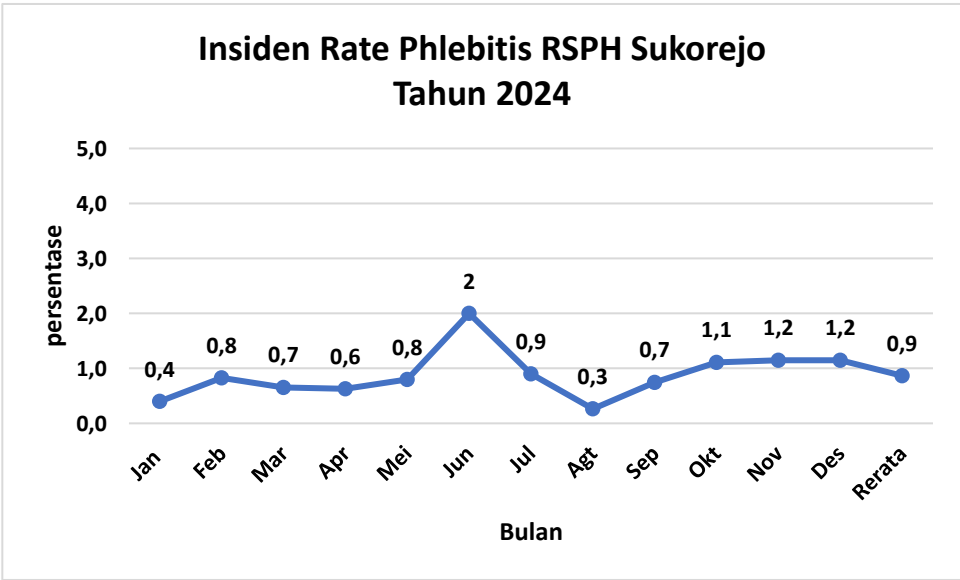
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa tahun 2024 tidak ada kejadian IAD akibat pemasangan IVL/CVC di rumah sakit.

Tabel PDSA Surveilans HAI's IAD

PLAN	Melaksanakan bundles IAD sesuai SPO Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN Supervisi oleh IPCN
DO	Surveilans IAD dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Pemasangan CVC hanya pada unit ICU dengan diagnosa tertentu, sehingga pengawasan bundles insersi maupun maintenance lebih focus terhadap pasien. Pemasangan CVC lebih sering tidak lebih dari 3 hari tergantung kondisi pasien.
ACTION	Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang bundles insersi dan maintenance IAD Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan CVL dan PVL

Surveilans Phlebitis

Gambar Grafik Survilans HAI's Phlebitis



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata angka phlebitis pada tahun 2024 tetap di angka 0,9%.

Tabel Data Phlebitis 2024

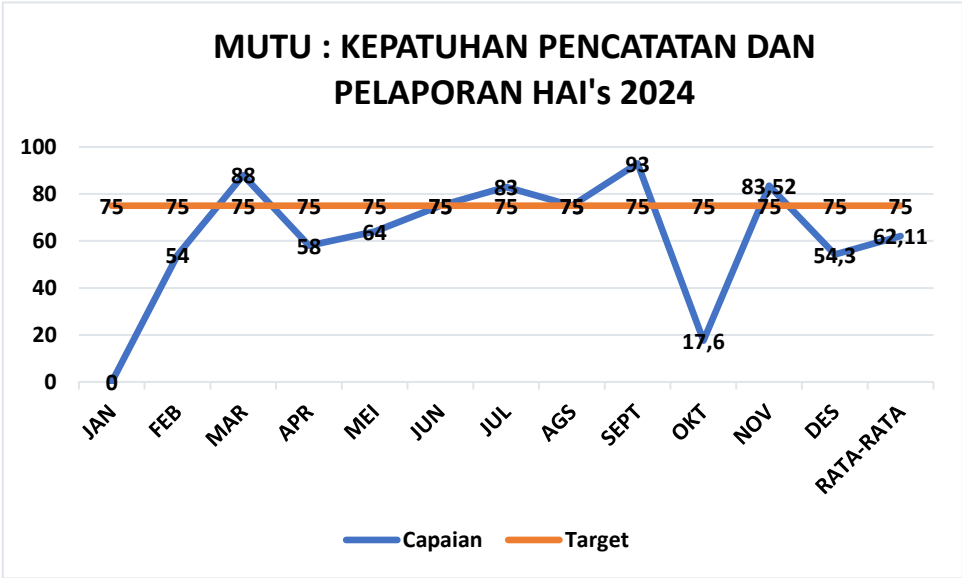
No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B	4 3 1
4	April	IRNA 3B IRNA 2A	1 4
5	Mei	IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B	1 3 11
6	Juni	IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B	1 1 19
7	Juli	IRNA 2A IRNA 2B	1 8
8	Agustus	IRNA 2B	5
9	September	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2B	1 4 1
10	Oktober	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2B	1 12 4
11	November	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2B NEO	1 7 5 5
12	Desember	IRNA 3B IRNA 2B	4 4
TOTAL			112

Tabel PDSA Surveilans HAI's Phlebitis

PLAN	Melaksanakan bundles phlebitis sesuai SPO Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN Supervisi oleh IPCN
DO	Surveilans phlebitis dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Ketidakpatuhan kebersihan tangan sebelum melakukan Tindakan dan Teknik aseptik yang tidak tepat menjadi penyebab rendahnya kepatuhan bundles insersi phlebitis. Kenaikan kasus phlebitis dikarenakan meningkatnya proses perawatan luka infus oleh petugas dan dari sisi internal pasien sendiri yang menjaga agar lokasi infus tidak bengkak. Risiko pembengkakan area insersi meningkat karena semakin tingginya penggunaan obat seperti furosemid, dobutamin, dan nicarpidin yang dimasukkan ketubuh pasien melalui syringe pump serta kondisi fisik pasien (ada penyakit penyerta seperti DM, gagal jantung dll).
ACTION	Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang bundles insersi dan maintenance phlebitis. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan infus serta prosedur perawatan luka infus.

Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

Gambar 3.4.1 Grafik Kepatuhan Pencatatan dan Pelaporan HAI's 2024



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan pencatatan dan pelaporan HAI's tahun 2024 dengan rata-rata 62,11% dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 75%.

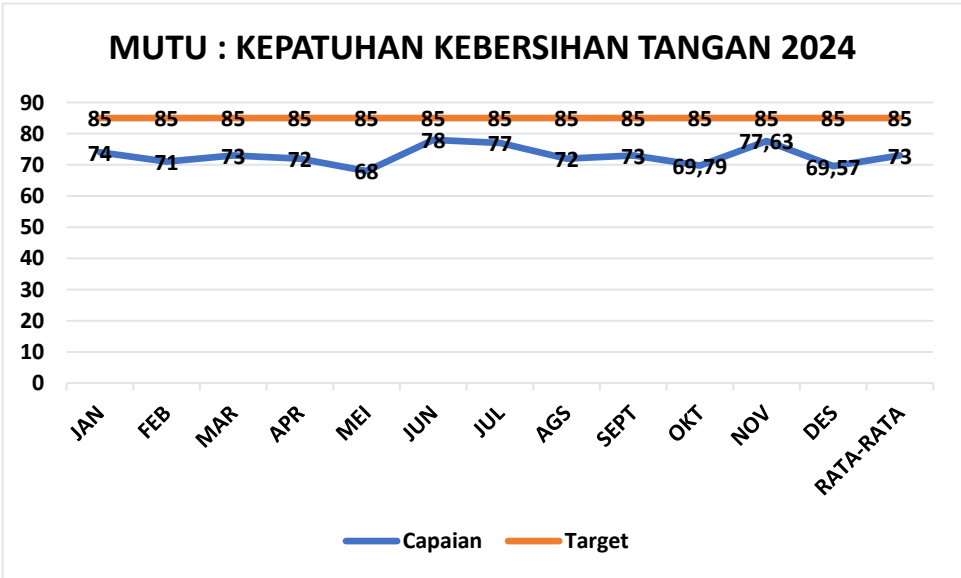
Tabel 3.4.1 PDSA Kepatuhan Pencatatan dan Pelaporan HAI's 2024

PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan pencatatan dan pelaporan HAIs tahun 2024 mencapai 62,11%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pencatatan dan pelaporan HAIs dalam mencegah dan mengendalikan terjadinya infeksi diarea rumahsakit.
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan pencatatatn dan pelaporan HAIs secara <i>real time</i> Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit patuh dalam melakukan pencatatan dan pelaporan HAIs sehingga target kepatuhan dapat tercapai sesuai standart Tindakan Melakukan audit pencatatan dan pelaporan HAIs pada staf di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pencatatan dan pelaporan HAIs Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan pencatatan dan pelaporan HAIs
DO	Monitoring dan audit pencatatan dan pelaporan HAIs menggunakan form audit.
STUDY	Rata-rata kepatuhan pencatatan dan pelaporan HAIs tahun 2024 mencapai 62,11%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%.

	Rata-rata pencatatan dan pelaporan HAIs tidak patuh dikarenakan unit melaporkan secara tidak <i>real time</i> (pelaporan di rapel di akhir bulan).
ACTION	Review dan evaluasi hasil pencatatan dan pelaporan HAIs pada staf. Beri feedback pada hasil temuan. Kolaborasi dengan Karu unit untuk monitoring pencatatan dan pelaporan HAIs Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Beri teguran saat melakukan monitoring pencatatan dan pelaporan HAIs yang tidak <i>real time</i> di unit.

Kepatuhan Kebersihan Tangan (INM)

Gambar 3.4.2 Grafik Kepatuhan Kebersihan Tangan (INM)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan tahun 2024 dengan rata-rata 73% dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 85%.

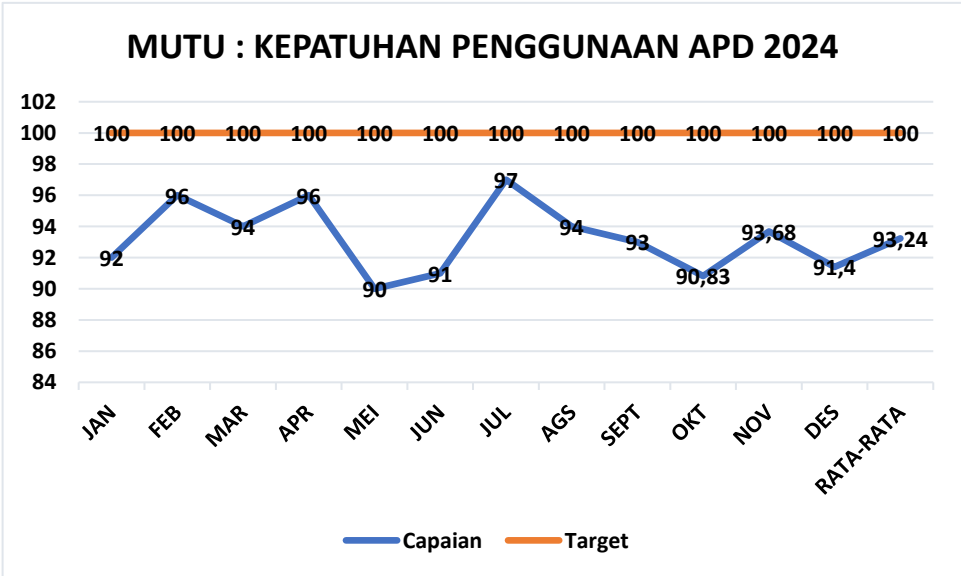
Tabel 3.4.2 PDSA Kepatuhan Kebersihan Tangan 2024

PROBLEM	Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan di tahun 2024 mencapai 73%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu 85%.
STEP	Menganalisis masalah: staf yang tidak patuh, dikarenakan merasa tidak diawasi dan belum menyadari pentingnya kebersihan tangan Buat rencana tindak lanjut
PLAN	Rencana: Mengetahui kepatuhan <i>hand hygiene</i> secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk staf lama

	membuat edukasi baik secara berkelompok atau individu dengan sasaran keluarga/pengunjung pasien yang dibuktikan dengan video
DO	Monitoring dan audit menggunakan form audit kebersihan tangan oleh WHO.
STUDY	Rata-rata kepatuhan total kebersihan tangan di tahun 2024 mencapai 73%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu 85%. Ditemukan beberapa staff tidak patuh dalam melakukan dan menerapkan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan dengan tepat
ACTION	Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar Kolaborasi dengan kabid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan Reedukasi SPO <i>hand hygiene</i> berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Berikan feedback hasil audit dan monitoring Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

Kepatuhan Penggunaan APD (INM)

Gambar 3.4.3 Grafik Kepatuhan Penggunaan APD (INM)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD tahun 2024 dengan rata-rata 93.24% dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

Tabel 3.4.1 PDSA Kepatuhan Pencatatan dan Pelaporan HAI's 2024

PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan penggunaan APD pada tahun 2024 mencapai 93,24%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	Rencana:

	Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. Tindakan Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
DO	Monitoring dan audit kepatuhan penggunaan APD menggunakan form audit.
STUDY	Rata-rata kepatuhan penggunaan APD tahun 2024 mencapai 93,24%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%. Ditemukan staff tidak patuh dalam penggunaan APD seperti CS menggunakan <i>handscone</i> untuk mengambil sampah di unit, perawat menggunakan <i>handscone</i> saat melakukan TTV, perawat tidak menggunakan <i>handscone</i> saat melakukan tindakan invasif.
ACTION	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. Beri feedback pada hasil temuan. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Capaian Edukasi PIC PPI 2024

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
Januari					
1	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2B	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
Februari					
1	IRNA 3B	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3A	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung



		2	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2B	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRJA	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
5	Maternitas	2	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
Maret					
1	IRNA 2B	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
2	Neonatologi	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRJA	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
April					
1	Neonatologi	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
3	Maternitas	1	5	Lapbul PPI	Staf
4	IRJA	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
5	IRNA 2A	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
6	IRNA 2B	2 (tanpa link)	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
7	IRNA 3A	1 (tanpa link)	5	Infus phlebitis	Pasien/pengunjung
		1 (tanpa link)	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
8	IRNA 3B	1 (tanpa link)	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1 (tanpa link)	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1 (tanpa link)	5	Infus phlebitis	Pasien/pengunjung
Mei					
1	IRNA 3A	1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
3	RM & pdf	1	5	Hand hygiene	Staf
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
4	IRJA	1	5	Hand hygiene	Staf



		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
Juni					
1	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
3	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
5	Neonatologi	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
6	RM & Pendaftaran	1	5	Hand hygiene	Staf
		1	5	Hand hygiene	Staf
7	IRNA 3A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	IRJA	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
9	Gizi dan dapur	1	5	Hand hygiene	Staf
		1	5	Etika batuk	Staf
Juli					
1	IRNA 2A	1	7	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	4	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi post op	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
4		1	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
5	IRNA 3B	1	10	Phlebitis	Pasien/pengunjung
6	ICU	1	4	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	3	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
7	Neonatologi	1	11	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	RM & PDF	1	7	Hand hygiene	Staf
9	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
Agustus					
1	Gizi & dapur	1	7	Penggunaan spilkit	Staf



2	Neonatologi	1	12	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1		Hand hygiene	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2B	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
4	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
5	IRNA 2A	2	6	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1		Phlebitis	Pasien/pengunjung
6	IRNA 3A	2	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
			6	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
7	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
		1		Hand hygiene	Pasien/pengunjung
September					
1	IRNA 2A	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
2	Neonatologi	2	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
3	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
4	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
5	IRNA 2B	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
6	IRNA 3A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
8	IRNA 3B	1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
Oktober					
1.	Neonatologi	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	10	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2.	IRNA 2B	1	6	Infus Phlebitis	Pasien/pengunjung
3.	IGD	1	8	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
4.	IRNA 2A	1	6	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
5.	IRNA 3B	1	3	Hand hygiene	Pasien/pengunjung

6.	IRNA 3A	1	4	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	4	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7.	RM & PDF	1	8	Hand hygiene	Staf
8.	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
November					
1.	Neonatologi	1	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	6	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2.	IRNA 2B	1	6	Infus Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3.	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
4.	IRNA 2A	1	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	7	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
5.	IRNA 3B	1	12	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
6.	IRNA 3A	1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	6	Hand hygien	Pasien/pengunjung
7.	RM & PDF	1	8	Hand hygiene	Staf
8.	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
9.	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
Desember					
1.	Neonatologi	1	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2.	IRNA 2B	1	6	Infus Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		1	6	Pencegahan infeksi pasien post op	Pasien/pengunjung
3.	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
4.	IRNA 2A	1	7	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
6.	IRNA 3A	1	6	Hand hygien	Pasien/pengunjung

		1	6	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	6	Hand hygien	Pasien/pengunjung
		1	7	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7.	RM & PDF	1	12	Hand hygiene	Staf
8.	ICU	1	6	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
9.	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi pasien post op	Pasien/pengunjung

3.7. KINERJA PRODUKTIFITAS TIM PKRS

Kinerja Produktivitas PKRS Tahun 2024

No	Hal	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Produksi Leaflet baru	2x/bln		3 buah	1buah	2 buah	1 buah	1 buah	2 buah	1 buah	1 buah	-	1 buah	1 buah
2.	Produksi Poster/Flyer	4x/bln		4x	4x	14 buah	9 buah	9 buah	4 buah	4 buah	5 buah	10 buah	5 buah	4 buah
3.	Pembuatan Video	1x/bln		1x	1x	-	-	-	-	2	2	2 buah	1 buah	4 buah
4.	Pembuatan Podcast/ Audio edukasi	2x/bln		-	-	-	-	-	-	-	-	2 buah	1 buah	1 buah
5.	KIE Massa Radio Central	25x/bln tiap hari		3x putar	4x putar	10x putar	10x putar	10x putar	10x putar	10x putar	10x putar	9x putar	10x putar	1x putar
6.	KIE WAG Komunitas	25x/bln tiap hari		3	3	5	5	6	6	6	5	7	5	2
7.	Edukasi di sosmed (IG, FB)	25x/bln tiap hari		3	3	6	6	6	4	4	5	7	5	4
8.	Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	4x/bln		4	1	1	5	4	4	4	4	4	5	4
9.	Pemberdayaan Komunitas (DOLINA)	2x/bln		1	1	-	1	1	2	2	1	2	2	1

Analisis :

- Pembuatan podcast pada bulan desember hanya 1x. dijadwalkan kembali di tahun 2025.
- Komunitas Dolina pada bulan desember belum sesuai target.
- Edukasi di sosmed hanya dilakukan dengan memposting poster belum terlaksana live Instagram.
- Rencana Tindak Lanjut :
- Buat jadwal bulanan terkait program podcast dan pembuatan video, audio edukasi
- (Jadwalkan tiap DPJP wajib mengisi 1 menit edukasi sesuai PHBK poli)
- Lakukan koordinasi dengan kepala ruang dan pic PKRS unit untuk menjadwalkan edukasi melalui sosmed dan edukasi langsung menggunakan audio central.
- (tiap unit diminta untuk membuat rekaman edukasi)
- Evaluasi tim dolina dan menjadwalkan lagi petugas, agar aktif ikut serta dalam pelaksanaan dolina.

Tabel Hasil Kinerja KIE Kelompok tiap Unit di RSPHS pada bulan Desember 2024

No	Unit	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	IRNA 2A	8x/bln	-	1			-	8x	-	5x	8x	8x	5x	1

2.	IRNA 2B	8x/bln	-	1	7	8x	7x	8x	8x	8x	8x	8x	8x	8x
3.	IRNA 3A	8x/bln	-	2	8	6x	5x	8x	8x	9x	8x	8x	8x	6x
4.	IRNA 3B	8x/bln	-	-		3x	-	4x	2x	2x	1x	1x	2x	2x
5.	ICU	8x/bln	-	-			-	-	8x	8x	8x	8x	8x	8x
6.	MATERNITAS	8x/bln	-	1		8x	-	8x	8x	8x	8x	9x	8x	8x
7.	PERINATOLOGI	8x/bln	-	1			-	3x	1x	5x	3x	-	7x	3x
8.	IRJA	8x/bln	-	5			-	-	-	-	-	-	-	-
9.	IGD	8x/bln	-	2			-	3x	-	1x	3x	2x	8x	8x
10.	GIZI	8x/bln	-	3			1x	-	-	2x	1x	-	2x	1x
11.	LABORATORIUM	8x/bln	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RADIOLOGI	8x/bln	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
13.	FARMASI	8x/bln	-	3			-	1x	-	-	2x	-	3x	-
14.	IKO	8x/bln	-	-			-	-	-	-	2x	-	-	2x

Analisis :

1. Petugas cenderung tidak melaksanakan edukasi sesuai target, hanya beberapa unit yang melaksanakan sesuai target
2. Rencana Tindak Lanjut :
3. Beri feedback dan followup petugas
4. Menindaklanjuti karu dan pic pkrs yang bertugas
5. Menjadwalkan tiap minggu edukasi
6. Membuatkan jenjang peringkat agar petugas lebih semangat lagi untuk edukasi
7. Catat nama petugas/ unit yang tidak patuh dalam melakukan edukasi.

Tabel Hasil Kinerja KIE Kelompok, Radio dan Medsos tiap Unit materi terkait program PPI RSPHS pada bulan Desember Tahun 2024

No	Unit	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	IRNA 2A	2x/bln	2			1	-	1	1	2	2	1	2	1
2.	IRNA 2B	2x/bln	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3.	IRNA 3A	2x/bln	3	4	1	1	3	2	2	2	4	2	2	2
4.	IRNA 3B	2x/bln		1		3	-	-	-	2	1	1	1	-
5.	ICU	2x/bln				-	-	-	2	2	1	1	1	3
6.	MATERNITAS	2x/bln	1	2		1	-	1	-	2	1	2	1	1
7.	PERINATOLOGI	2x/bln		1	1	1	-	2	2	2	2	2	2	2
8.	IRJA	2x/bln		1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-
9.	IGD	2x/bln				-	-	1	1	1	1	1	4	2
10.	GIZI	2x/bln				-	-	-	2	2	-	-	-	-
11.	LABORATORIUM	2x/bln				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RADIOLOGI	2x/bln				-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	FARMASI	2x/bln				-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	IKO	2x/bln				-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	RM & PDF	2x/bln				1	1	2	1	-	-	1	1	-

Analisis :

1. Ketidapatuhan petugas dalam melakukan edukasi program PPI

- Masih banyak petugas yang tidak melaksanakan langkah cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar
- Pelaporan edukasi terkait materi PPI terkadang tidak dilaporkan ke pj PPI (Form Edukasi PPI) hanya terlapor di form edukasi PKRS.

Rencana Tindak Lanjut :

- Followup pj pkrs dan pj ppi dan menjadwalkan edukasi baik sosmed maupun langsung
- Koordinasi dengan komite PPI untuk melakukan followup kepada petugas unit yang belum melaksanakan dan menerapkan etika batuk dan cuci tangan.
- Koordinasi dengan komite PPI untuk mensikronkan absensi di form edukasi baik edukasi terkait ppi ataupun pkrs.
- Catat ketidakpatuhan sebagai bahan evaluasi kinerja

3.8 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPRA

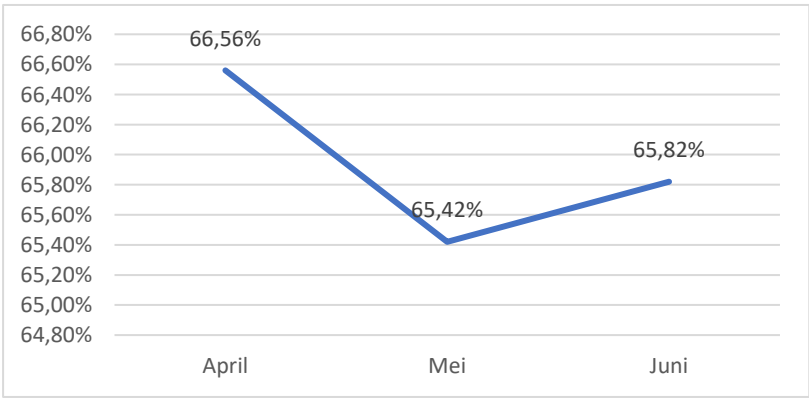
Pencapaian Mutu dan Keselamatan Pasien PPRA Triwulan II

Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

Tabel Surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

No.	Bulan	Prosentase
1	April	66,56 %
2	Mei	65,42 %
3	Juni	65,82 %

Grafik surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo



Analisa surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

Penggunaan antibiotik pada bulan April sebesar 66,56 %, pada bulan Juni sebesar 65,82 %, dan pada bulan Mei sebesar 65,42 %.

Belum ada target atau standar penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.

Pengambilan data berdasarkan SIMRS.

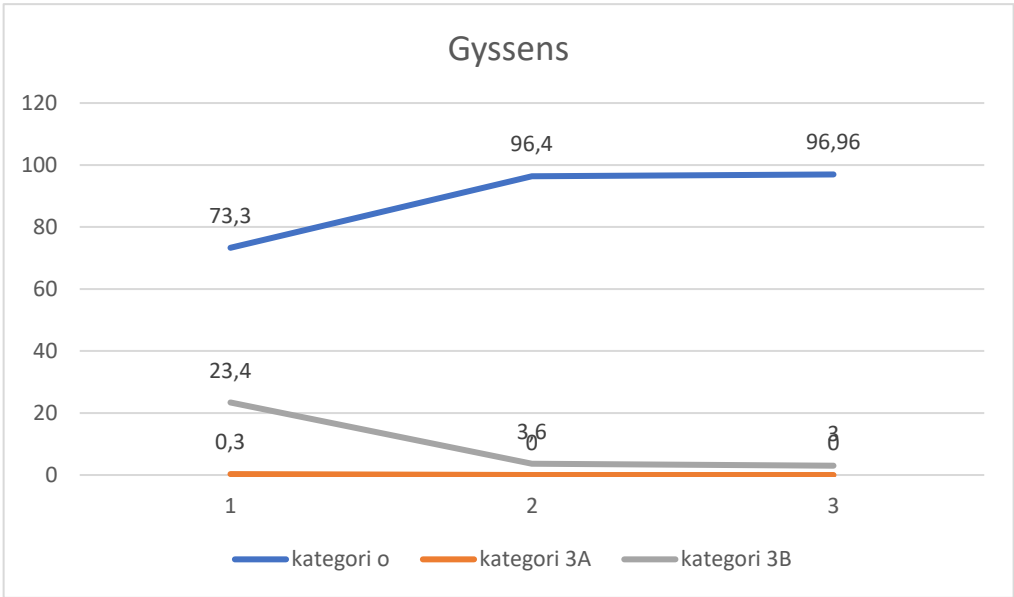
Audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)

Tabel audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			April (%)	Mei (%)	Juni (%)
1	Katagori 0	≥ 50	73,3	96,4	96,96
2	Katagori 1	0	0	0	0
3	Katagori 2A	0	0	0	0
4	Katagori 2B	0	0	0	0
5	Katagori 2C	0	0	0	0
6	Katagori 3A	0	0,3	0	0
7	Katagori 3B	0	23,4	3,6	3
8	Katagori 4A	0	0	0	0
9	Katagori 4B	0	0	0	0
10	Katagori 4C	0	0	0	0
11	Katagori 4D	0	0	0	0
12	Katagori 5	0	0	0	0
13	Katagori 6	0	0	0	0

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kriteria Gyssens yang memiliki % nilai 0 (nol) untuk bulan April - Juni adalah Kategori 1, kategori 2A, kategori 2B, kategori 2C, kategori 4A, kategori 4B, kategori 4C, kategori 4D, kategori 5, dan kategori 6. Sehingga data penggunaan antibiotik bulan April - Juni yang dapat dibandingkan adalah kategori 0, kategori 3A, dan kategori 3B, yang ditunjukkan lebih lanjut pada grafik di bawah ini.

Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara Kualitatif (Gyssens)



Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

Pada triwulan II, nilai tertinggi pada kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Persentase tertinggi pada bulan Juni yaitu 96,96%.

Nilai tertinggi kedua pada Triwulan II adalah pada Kategori 3B, yaitu pemberian antibiotik terlalu singkat. Presentase tertinggi pada bulan April yaitu 23,4%.

Nilai tertinggi ketiga pada Triwulan II adalah kategori 3A, yaitu pemberian antibiotik terlalu lama. Presentase tertinggi pada bulan April yaitu sebesar 0.3%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, makaperlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Menargetkan presentase kategori 0 mencapai hasil stabil di atas standar ≥50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap penerapan PPAB, terutama pada penggunaan antibiotik kategori Watch dan Reserve.	1. Sosialisasi PPAB dilakukan kepada DPJP dengan target pemahaman >50%. 2. Monitoring penggunaan antibiotik di Rawat Inap dilakukan oleh apoteker Rawat Inap secara prospektif saat melakukan pelayanan farmasi klinis. Jika terdapat kasus penggunaan antibiotik irasional akan dilaporkan kepada Tim PPRA. 3. Melakukan pengkajian tentang penggunaan antibiotik irasional dengan berbagai pendekatan.	Kurangnya kepatuhan DPJP terhadap PPAB dan PPK, padahal kepatuhan tersebut berperan penting pada pelaksanaan PPRA di rumah sakit.	Meningkatkan kepatuhan DPJP pada penerapan PPAB, dengan cara : a. Sosialisasi dilakukan tepat sasaran dengan target pemahaman >50%. b. Monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik dilakukan secara berkala oleh tim PPRA.

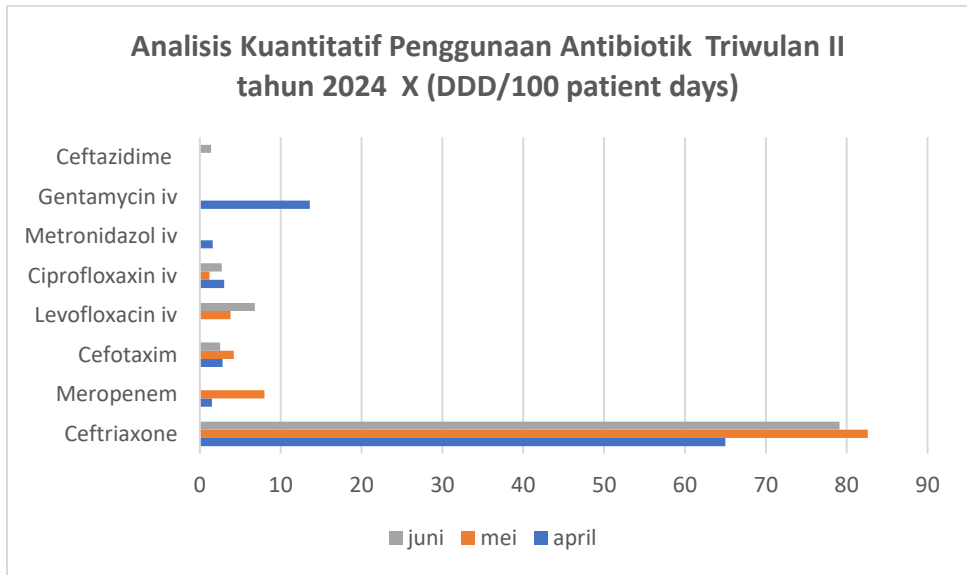
Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2024

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2024 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman

Tabel audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif Triwulan II

NO	KODE ATC	NAMA ANTIBIOTIK	BULAN (DDD/100 PATIENT DAYS)		
			APRIL	MEI	JUNI
1	J01DD04	Ceftriaxone	65	82,6	79,1
2	J01CG01	Ampicillin-Sulbactam	0	0	0
3	J01DH02	Meropenem	1,5	8	0
4	J01DD01	Cefotaxim	2,8	4,2	2,5
5	J01MA12	Levofloxacin iv	0	3,8	6,8
6	J01DD12	Cefoperazone	0	0	0
7	J01MA02P	Ciprofloxacin iv	3	1,2	2,7
8	J01XD01	Metronidazol iv	1,6	0	0
9	JO1GB03	Gentamycin iv	13,6	0	0
10	J01DD02	Ceftazidime	0	0	1,4

Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif triwulan II



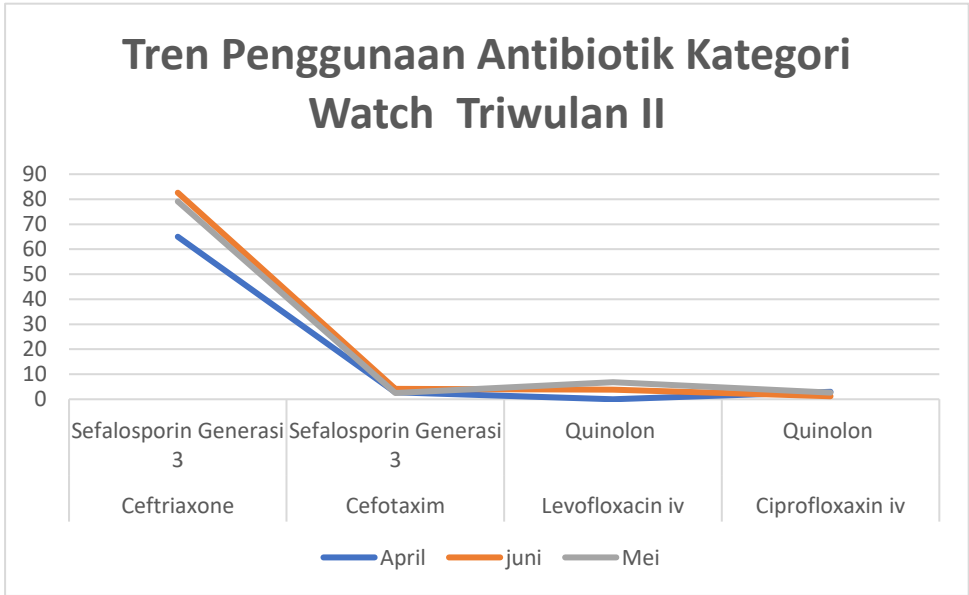
Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif

Pada Triwulan II tahun 2024, antibiotik paling banyak digunakan adalah antibiotik Ceftriaxone sebesar 65 ; 82,6; 79,1 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Sukorejo.

Tabel DDD/100 Patient Days Antibiotik Kategori *Watch*

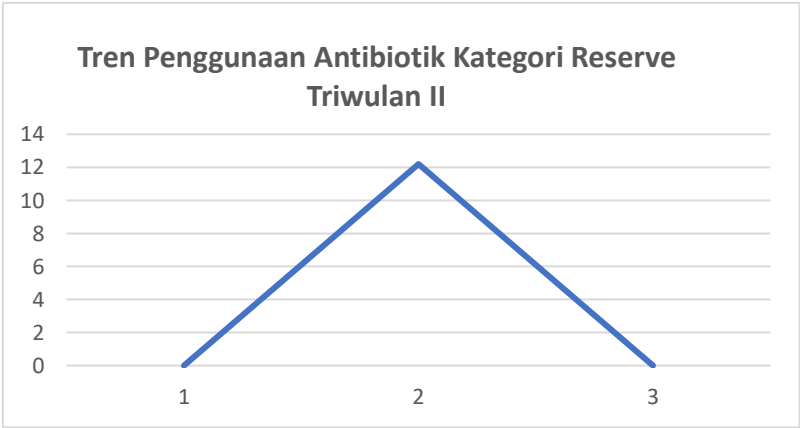
Nama Antibiotik	Golongan	Bulan (DDD/Patient Days)		
		April	Mei	Juni

Ceftriaxone	Sefalosporin Generasi 3	65	82,6	79,1
Cefotaxim	Sefalosporin Generasi 3	2,8	4,2	2,5
Levofloxacin iv	Quinolon	0	3,8	6,8
Ciprofloxacin iv	Quinolon	3	1,2	2,7



TREN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK KATEGORI RESERVE

Nama Antibiotik	Golongan	Bulan (DDD/Patient Days)		
		APRIL	MEI	JUNI
MEROPENEM	KARBAPENEM	1,5	8	0



3.9 Kinerja Produktifitas Komite keperawatan

Berjalan hanya kondisional saja, tidak pernah ada pelaporan

3.10 Kinerja Produktifitas Komite Medis

Berjalan hanya kondisional saja, tidak pernah ada pelaporan

3.11 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain

Tidak Berjalan

BAB IV. KINERJA KEUANGAN

4.1 PENDAPATAN TAHUN 2024

No	Jaminan	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PENDAPATAN	
		RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI
1	Umum	373.727.322	403.313.329	313.252.958	262.041.903	344.071.547	357.502.772	354.968.427	264.580.692	367.021.997	366.061.762	325.886.941	415.605.278	400.246.340	380.613.504	420.656.730	380.613.504	379.098.587	282.437.962	414.005.240	305.484.563	365.987.787	359.020.074	357.019.545	292.875.738	4.415.943.420	4.070.151.083
2	BPJS Kes	2.300.476.578	7.169.834.137	2.063.353.770	7.288.738.208	2.182.578.712	7.611.041.933	2.041.619.437	6.954.558.813	2.400.799.271	8.038.592.322	2.169.266.224	7.229.190.856	2.536.935.879	7.725.141.020	2.478.694.155	7.725.141.020	2.430.502.041	7.219.913.237	2.666.608.499	8.325.054.340	2.458.482.666	8.067.943.970	2.435.906.993	7.839.649.754	28.165.224.226	91.194.799.611
3	Obat Kronis	754.018.011	-	664.618.922	-	747.997.769	-	702.882.531	-	822.703.690	-	751.233.221	-	903.850.734	-	970.526.212	-	978.053.872	-	1.030.606.596	-	1.018.804.665	-	957.916.659	-	10.303.212.882	-
4	Lupis	-	-	-	-	385.000	-	1.154.997	-	3.464.991	-	4.234.989	-	4.619.988	-	5.967.485	-	2.483.417	-	7.039.487	-	6.033.057	-	5.017.375	-	-	40.400.786
5	BPJSTK	29.645.757	297.289.955	29.111.739	457.545.711	23.940.347	387.516.599	33.297.430	396.435.744	46.041.891	466.359.971	45.453.864	473.750.250	54.517.379	499.525.759	51.597.788	499.525.759	56.123.100	617.883.033	56.119.953	302.756.549	73.811.754	633.935.556	53.821.042	431.780.964	553.482.044	5.464.305.849
6	Jasa Raharja	2.162.351	153.816.212	7.566.074	233.537.090	5.275.386	315.233.743	4.278.549	163.928.272	3.715.158	263.649.267	2.951.289	442.949.569	5.944.970	491.488.030	7.839.466	491.488.030	10.716.250	293.970.275	3.976.293	467.239.484	3.477.238	200.599.390	2.883.067	357.709.983	60.786.090	3.875.609.345
7	Kemenkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Asuransi swasta admedika	23.551.161	58.857.924	24.917.713	71.041.961	19.843.952	25.851.804	28.005.647	25.953.910	29.412.834	88.379.482	23.458.564	36.528.295	29.128.104	35.859.658	37.260.307	35.859.658	34.870.107	73.612.134	47.885.256	71.637.434	34.585.531	76.661.048	49.781.556	39.154.975	382.700.732	639.398.283
9	Asuransi Swasta	43.662.274	179.967.093	49.189.186	141.031.835	50.868.395	162.960.201	47.355.212	177.443.538	57.541.487	129.953.025	47.168.574	148.913.595	52.655.638	182.805.397	53.753.118	182.805.397	49.520.311	157.284.262	59.185.002	177.972.747	53.626.551	243.811.456	40.807.213	71.990.514	605.332.960	1.956.939.062
10	Perusahaan	13.927.526	127.149.843	11.363.799	112.300.092	2.426.849	91.176.768	13.567.509	187.454.080	7.103.090	172.439.402	19.709.176	77.422.361	23.295.285	187.783.364	21.503.251	187.783.364	20.829.101	237.151.834	27.259.441	160.305.323	60.715.696	152.448.692	19.946.968	119.618.213	241.647.691	1.813.033.336
Total		3.541.170.980	8.390.228.493	3.163.374.161	8.566.236.801	3.377.002.957	8.951.668.820	3.225.974.742	8.171.510.047	3.734.339.417	9.528.900.223	3.385.127.853	8.828.595.194	4.006.574.329	9.507.836.720	4.041.831.026	9.509.184.217	3.959.713.370	8.884.736.155	4.305.646.279	9.817.489.927	4.069.491.888	9.740.453.243	3.918.083.043	9.157.797.514	44.728.330.045	109.054.637.354

Analisa :

1. Pendapatan terbesar RS Prima Husada Sukorejo 77,62% adalah BPJS Kesehatan termasuk obat kronis yang ditagihkan terpisah dari regular (rawat inap dan rawat jalan).
2. Pendapatan umum memiliki proposi 5,52% termasuk pemeriksaan penunjang dan termasuk jasa dokter.
3. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3,91%
4. Pendapatan lainnya adalah Jasa Raharja 2,56% yang memiliki tingkat pembayaran paling lancar dari asuransi lainnya.
5. Pendapatan asuransi swasta sebesar 2,33% dan perusahaan sebesar 1,34%, untuk penagihan di lakukan setiap minggu dalam 1 bulan.

No	PENDAPATAN	TOTAL PENDAPATAN	Prosentase
1	Obat - obatan	28.734.071.665	25,23%
2	Laboratorium	9.351.071.751	8,21%
3	Radiologi	6.154.116.266	5,40%
4	IKO	67.212.735.470	59,02%
5	MCU	821.633.015	0,72%
6	Ambulance	19.985.000	0,02%
7	Home Care	-	0,00%
8	Parkir	1.456.288.000	1,28%
9	Sewa ATM	17.345.844	0,02%
10	Lain - Lain	114.728.560	0,10%
Total		113.881.975.570	100,00%

Analisa :

1.

Pendapatan terbesar RS Prima Husada Sukorejo adalah IKO dengan presentase 59,02%.
2.

Pendapatan terbesar berikutnya adalah obat obatan/farmasi dengan nilai presentase 25,23%
3.

Berikutnya adalah Laboratorium memiliki nilai presentase 8,21%, radiologi 5,40%
4.

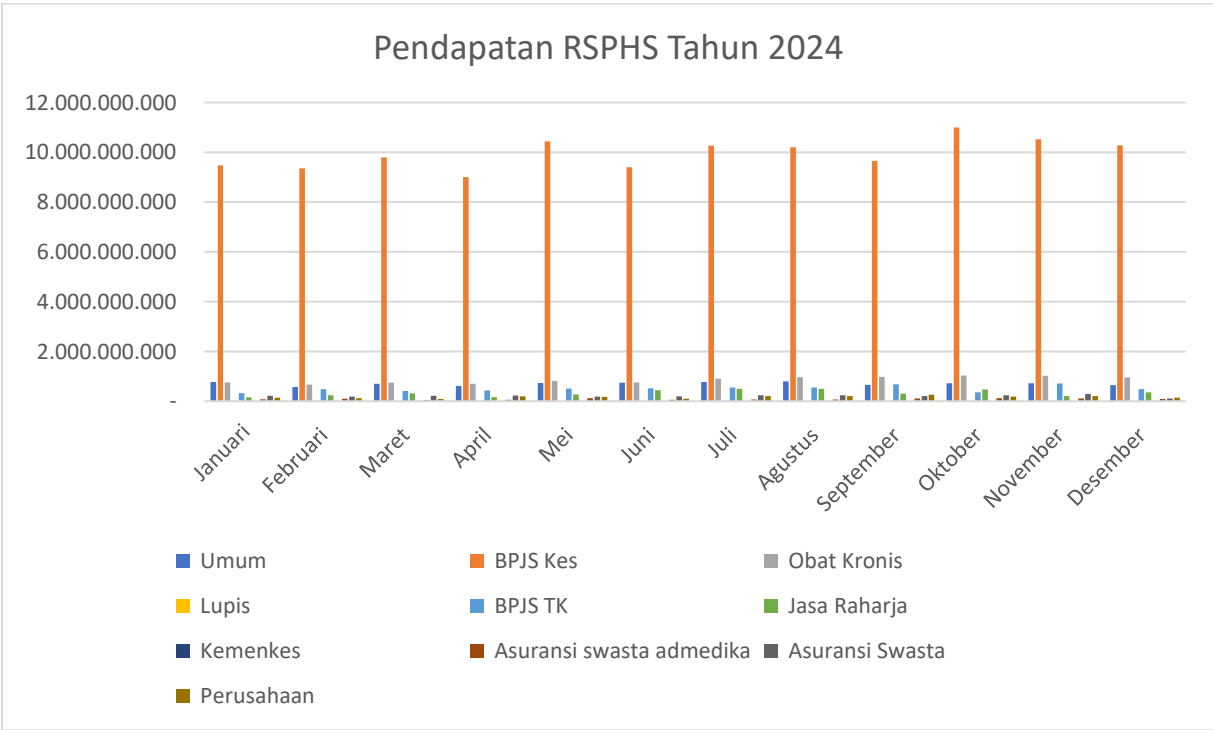
MCU memiliki nilai presentase 0.72%
5.

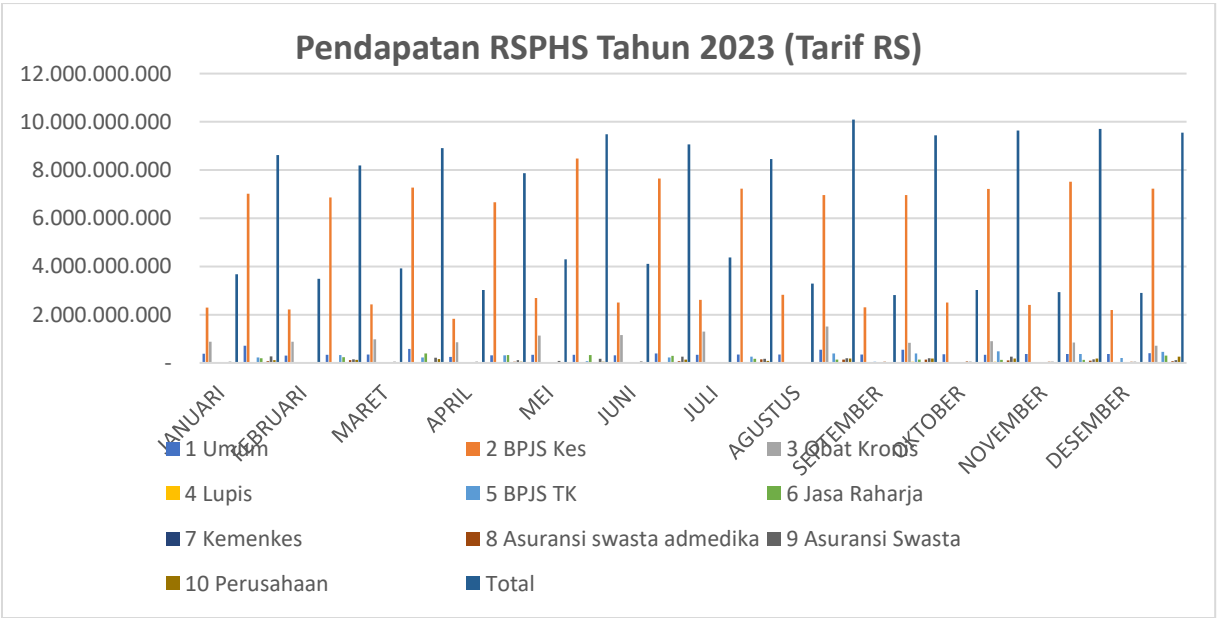
Pendapatan parker memiliki nilai presentase 1,28%
6.

Biaya sewa ATM memiliki nilai presentase 0.02%
7.

Biaya lain lain merupakan pendapatan yang terekap di setoran kasir memiliki nilai presentase 0,10%

Grafik pendapatan Tahun 2024 RS Prima Husada Sukorejo





Analisa :

Terdapat kenaikan pendapatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya 2023.

4.2 KINERJA PIUTANG RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NO	DESKRIPSI	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
1	Asuransi	178.717.518	53.161.784	-	-	3.343.321	235.222.623
2	Perusahaan	635.157.244	18.422.645	2.240.543	-	27.312.240	683.132.671
3	Mandiri Inhealth	27.780.723	10.478.804	-	-	-	38.259.527
4	Jasa Raharja	225.029.269	712.967	-	-	244.868	225.987.104
5	KANTIN	6.894.450	-	1.102.200	513.150	-	8.509.800
6	BPJS Ketenagakerjaan	537.074.934	448.887	-	505.037	1.793.875	539.822.732
		1.610.654.138	83.225.086	3.342.743	1.018.187	32.694.304	1.730.934.458

Analisa Progress Piutang :

1.

Piutang yang tersisa di diatas 120 hari untuk perusahaan merupakan piutang pelayanan pada tahun 2022
2.

Piutang Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan diatas 120 hari merupakan piutang yang terkendala eksternal dimana kelengkapan dari rumah sakit sudah sesuai dan menunggu pembayaran
3.

Piutang Asuransi diatas 120 hari yang belum terbayarkan ada kendala terkait kelengkapan pemberkasan yang diberikan

4.3 FPK ATAS TAGIHAN BPJS KESEHATAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2024

Jenis Pelayanan		Bulan Pelayanan	Nilai FPK	Tgl FPK	Tgl Bayar
Januari	RJ	Januari	2.528.699.500	26.02.2024	04.03.2024
Januari	RI		6.454.172.400	26.02.2024	04.03.2024
Pending 1	RJ		2.034.900	27.06.2024	08.07.2024
Pending 1	RI		623.842.228	27.06.2024	08.07.2024

Pending 2					
Pending 2					
Obat kronis			570.287.228	25.06.2024	05.07.2024
Ambulance			51.225.934	23.02.2024	05.03.2024
Alkes					
Februari	RJ	Februari	2.249.720.500	25.03.2024	03.04.2024
Februari	RI		6.712.308.600	25.03.2024	03.04.2024
Pending 1	RJ		3.885.000	27.06.2024	08.07.2024
Pending 1	RI		326.518.604	27.06.2024	08.07.2024
Pending 2					
Pending 2					
Obat kronis			547.941.289	25.07.2024	05.08.2024
Ambulance			39.227.770	05.05.2024	17.05.2024
Alkes					
Maret	RJ	Maret	2.330.019.400	20.04.2024	26.04.2024
Maret	RI		7.508.853.484	20.04.2024	26.04.2024
Pending 1	RJ		17.603.800	06.08.2024	14.08.2024
Pending 1	RI		326.498.500	06.08.2024	14.08.2024
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat kronis			571.803.263	04.09.2024	13.09.2024
Ambulance			42.845.096	05.05.2024	17.05.2024
Alkes			385.000	05.05.2024	17.05.2024
April	RJ	April	2.196.182.200	20.05.2024	05.06.2024
April	RI		6.279.591.824	20.05.2024	05.06.2024
Pending 1	RJ		8.092.200	06.08.2024	14.08.2024
Pending 1	RI		714.538.200	06.08.2024	14.08.2024
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat kronis			597.545.654	07.10.2024	18.10.2024
Ambulance			37.334.070	05.08.2024	16.08.2024
Alkes			1.154.997	05.08.2024	16.08.2024
Mei	RJ	Mei	2.607.232.900	27.06.2024	05.07.2024
Mei	RI		6.786.887.900	27.06.2024	05.07.2024
Pending 1	RJ		10.168.200	30.08.2024	09.09.2024
Pending 1	RI		1.092.669.500	30.08.2024	09.09.2024
Pending 2	RJ				

Pending 2	RI		1.939.100	13.10.2024	18.10.2024
Obat kronis			637.206.737	05.11.2024	13.11.2024
Ambulance			51.270.820	05.08.2024	16.08.2024
Alkes			3.464.991	05.08.2024	16.08.2024
Juni	RJ	Juni	2.315.342.800	20.07.2024	26.07.2024
Juni	RI		5.809.068.974	20.07.2024	26.07.2024
Susulan 1	RI		4.400.700	25.09.2024	04.10.2024
Pending 1	RJ		18.999.500	13.10.2024	18.10.2024
Pending 1	RI		1.033.834.100	13.10.2024	18.10.2024
Pending 2	RJ		382.000	16.12.2024	23.12.2025
Pending 2	RI		2.990.200	16.12.2024	23.12.2025
Obat kronis			571.846.234	08.11.2024	18.11.2024
Ambulance			47.236.458	05.08.2024	16.08.2024
Alkes			4.234.989	05.08.2024	16.08.2024
Juli	RJ	Juli	2.604.839.600	20.08.2024	26.08.2024
Juli	RI		6.068.279.977	20.08.2024	26.08.2024
Susulan 1	RJ		56.325.100	25.09.2024	04.10.2024
Susulan 1	RI		53.329.809	25.09.2024	04.10.2024
Pending 1	RJ		18.362.500	16.11.2024	22.11.2024
Pending 1	RI		1.306.612.727	16.11.2024	22.11.2024
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat kronis			699.360.057	13.11.2024	20.11.2024
Ambulance			51.261.292	01.12.2024	13.12.2025
Alkes			4.619.988	01.12.2024	13.12.2025
Agustus	RJ	Agustus	2.529.764.300	22.09.2024	27.09.2024
Agustus	RI		5.889.835.183	22.09.2024	27.09.2024
Susulan 1	RJ				
Susulan 1	RI		18.991.100	16.12.2024	20.12.2025
Pending 1	RJ				
Pending 1	RI				
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat kronis			715.647.906	01.12.2024	16.12.2025
Ambulance			42.473.785	01.12.2024	13.12.2025
Alkes			5.967.485	01.12.2024	13.12.2025
September	RJ	September	2.481.690.900	20.10.2024	25.10.2024

September	RI		5.531.277.882	20.10.2024	25.10.2024
Pending 1	RJ		30.050.400	16.12.2024	20.12.2025
Pending 1	RI		1.132.805.206	16.12.2024	20.12.2025
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat kronis					
Ambulance			34.381.337	01.12.2024	13.12.2025
Alkes			2.483.417	01.12.2024	13.12.2025
OKTOBER	RJ	OKTOBER	2.752.754.700	22.11.2024	25.11.2024
OKTOBER	RI		6.268.690.805	22.11.2024	25.11.2024
Susulan 1	RJ		2.867.600	16.12.2024	20.12.2025
Susulan 1	RI		38.959.200	16.12.2024	20.12.2025
Pending 1	RJ				
Pending 1	RI				
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat Kronis					
Ambulance			36.407.242	01.12.2024	13.12.2025
Alkes			7.039.487	01.12.2024	13.12.2025
NOVEMBER	RJ	NOVEMBER	2.590.080.100	16.12.2024	20.12.2025
NOVEMBER	RI		6.183.870.777	16.12.2024	20.12.2025
Pending 1	RJ				
Pending 1	RI				
Pending 2	RJ				
Pending 2	RI				
Obat Kronis					
Ambulance					
Alkes					

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Terjadinya peningkatan kunjungan yang signifikan pada seluruh bidang pelayanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Adanya pengembangan pelayanan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat
3. Penambahan kapasitas IGD memudahkan masyarakat untuk memperoleh penanganan darurat

5.2 Saran

1. Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan harus diimbangi dengan supervise berjenjang dan bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan pelayanan yang terstandart akreditasi
2. Pengembangan pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dari fasilitas kesehatan maupun SDMnya

**BAB VI.
PENUTUP**

Demikian laporan tahunan ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2024, peningkatan kunjungan serta penambahan layanan di tahun 2024 menunjukkan RSPH Sukorejo mampu bersaing dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat. Namun masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard, upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin untuk pemenuhan pelayanan sesuai standart di 2025.

Pasuruan, 01 Januari 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS